



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN SEPTEMBER
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang	2
2.1 Visi	2
2.2 Misi	2
2.3 Motto	2
2.4 7 Nilai Budi Utama	2
2.5 Struktur Organisasi	3
Bab III Laporan Kinerja Pelayanan	4
3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)	4
3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO	4
3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO	4
3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut	4
3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan	5
3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada	6
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan	9
3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik	9
3.3.2 Rawat Inap	11
3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)	19
3.3.4 High Care Unit (HCU)	20
3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD)	21
3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO)	22
3.4 Kinerja Bidang Penunjang	23
3.4.1 Instalasi Farmasi	23
3.4.2 Laboratorium	28
3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran	30
3.4.4 Radiologi	31
3.4.5 Gizi	35
3.4.6 CSSD - Laundry	36
3.5 Kinerja Umum dan Keuangan	40
3.5.1 SDM	40
3.5.2 MFK dan K3RS	46
3.5.3 Security	51
3.5.4 Parkir	54
3.5.5 Humas Marketing	55
3.5.6 Penjaminan	55
3.5.7 PIPP – MOD - MPP	59
3.5.8 <i>Cleaning Service</i>	69
3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum	72
3.6 Komite dan Tim	73
3.6.1 Komite Mutu	73
3.6.2 Komite PPI	102
3.6.3 Tim PKRS	114
3.6.4 Tim Prognas	116
3.6.5 Tim PPRA	157
3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT	159
3.7 Permasalahan Rumah Sakit	160
3.8 Profil SDM	158
Bab IV Kesimpulan dan Saran	170
Bab V Penutup	171
LAMPIRAN	172

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan September Tahun 2024 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



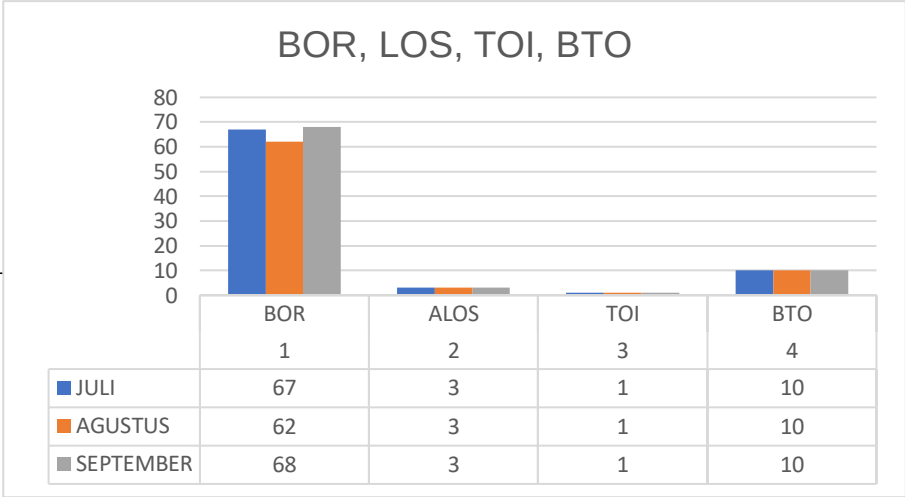
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

3.1.1 Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

NO	INDIKATOR	JULI	AGUSTUS	SEP
1	BOR	67	62	68
2	ALOS	3	3	3
3	TOI	1	1	1
4	BTO	10	10	10

3.1.2 Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO



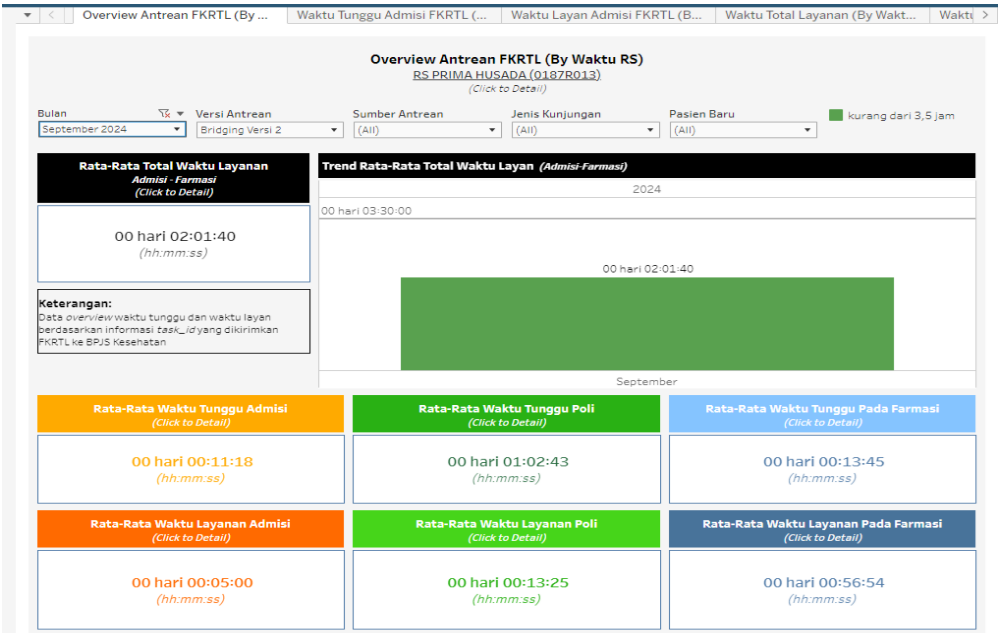
3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut

BOR mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 9% sejalan dengan peningkatan kunjungan pasien di IGD.

ALOS masih tetap berada pada rata-rata 3 hari, yang masih berada di bawah standar 6-12 hari. Hal ini disebabkan karena pasien dominan jaminan BPJS, dimana terdapat keterbatasan plafon sehingga pasien yang sudah stabil dapat dipulangkan pada hari rawat ketiga hingga empat.

TOI masih relative sama dengan bulan sebelum-sebelumnya. BTO atau frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode berada pada sepuluh kali sedang standardnya yaitu 40-50 kali.

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan



NO	KETERANGAN	BULAN			
		Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024	September
	Waktu Rata-Rata				
1	Total Waktu Layanan	02.32.53	01.56.32	01.47.49	02.01.40
2	Waktu Tunggu Admisi	00.06.00	00.07.29	00.09.10	00.11.18
3	Waktu Layanan Admisi	00.05.56	00.07.00	00.08.00	00.05.00
4	Waktu Tunggu Poli	01.05.56	01.02.53	01.05.15	01.02.43
5	Waktu Layanan Poli	00.18.20	00.16.25	00.17.00	00.13.25
6	Waktu Tunggu Farmasi	00.16.46	00.13.41	00.13.39	00.13.45
7	Waktu Layanan Farmasi	01.00.38	00.48.20	01.04.36	00.56.54

Analisis :
 Pada bulan September 2024, Total Waktu Layanan rata-rata meningkat, namun waktu rata-rata yang meningkat hanya pada aspek Waktu Tunggu Admisi (2 menit 8 detik) dan Waktu Tunggu Farmasi (6 detik). Sehingga tidak mewakili dalam total waktu layanan. Perlu adanya identifikasi dari programmer terkait hal ini.

Plan	Menyampaikan hasil evaluasi ke programmer PT Disa Prima Medika
Do	Koordinasi dengan unit terkait dan factor yang mempengaruhi.hasil dari identifikasi programmer
Study	Data rekap bulan sebelumnya yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi programmer 2. Monitoring evaluasi 3. Lakukan Tindak lanjut sesuai hasil Monev

NO	JENIS	Target	MAR 24	APR 24	MEI 24	JUNI 24	JULI 24	AGT 24
1	Sumber antrian melalui mobile JKN	>30%	34.86%	37.2%	34.88%	Tidak ada	37.82%	37.72%
2	Capaian pemanfaatan antrian (onsite dan online Mobile JKN)	>90%	94.57%	96.2%	94.62%	Tidak ada	94.9%	95.21%

Analisis :
 Pemanfaatan antrian online sudah mencapai target yang disyaratkan (>30%) dan (>90%)

Plan	Mempertahankan hasil > 30% dan meningkatkan untuk kinerja di bulan selanjutnya
Do	Sosialisasi ke unit terkait
Study	Data bulan-bulan sebelumnya sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki
Action	1. Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ untuk monitoring 2. Monitoring evaluasi <i>feedback</i> 3. Supervisi kabid

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRNA	Bimbingan Doa pada pasien IRNA	Sudah berjalan rutin 3x seminggu	Berjalan dengan baik dan respon pasien baik
2	IRNA	Senam hamil	Senam hamil berjalan rutin	-
3	IRJA	Poli Eksekutif	Jumlah pasien mengalami peningkatan dibanding Agustus	Belum ada pasien IPD dan Saraf Sakura, pasien umum di poli regular memang sedikit
4	IGD	Edukasi mengenai kriteria kegawatan menurut BPJS	Membuat video edukasi	Belum dibuat, kordinasi dengan Kabid umum dan PKRS
BIDANG PENUNJANG				
1	Depo Farmasi	1. Website Primantara	1. Presentasi MOCKUP oleh Programmer PT sudah dilakukan pada tanggal 23-09-2024 2. Proses penyelesaian oleh Programmer PT.	Dalam antrian programmer.
		2. Pengambilan obat dengan TTD elektronik	1. TTD elektronik untuk pengambilan obat rawat jalan sudah berjalan dan memudahkan untuk mengecek retriksi kelengkapan obat kronis, namun terkendala pada jaringan yang lemah. 2. TTD elektronik untuk pengambilan obat IGD rawat jalan dan pasien pulang rawat inap masih belum bisa dan tahap koordinasi dengan progamer.	Dalam antrian programmer. Monitoring dan evaluasi sistem elektronik.
		3. Fitur Iterisasi pada SIMRS	1. Fitur obat iter memudahkan untuk melayani resep iterisasi. 2. Melakukan rekap target resep ITER	Monitoring dan evaluasi sistem elektronik

			per DPJP. 3. Rekap jumlah pasien ITER per bulan : Agustus 2024 : 139. September 2024 : 141.	
		4. KPO elektronik (e-KPO)	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) menulis manual sehingga memperlama waktu tunggu obat rawat jalan. Pengajuan ke progamer untuk dibuatkan fitur e-KPO yaitu data obat di print dengan printer thermal kemudian di tempel ke KPO pasien.	Dalam antrian programmer.
		5. Pengadaan LAF sesuai dengan pedoman dasar dispensing sediaan steril.	Koordinasi dengan Kains Farmasi untuk melakukan pengajuan proposal ke PT terkait pemindahan ruang LAF, yaitu rencana diajukan di Lantai Maternitas (ex IKO Covid).	Dalam Proses.
2	Gudang Farmasi	1. Repack sediaan farmasi sharing dose.	Repack sudah berjalan, tarif repack sudah ada.	1. Tidak ada lemari asam, sehingga repack formalin ditiadakan. 2. Alcohol repack terlalu kecil tidak sesuai dengan kebutuhan. 3. Stardine repack fastmoving.
		2. Scan Barcode	1. Proposal scan barcode sudah diajukan ke PT. 2. Sudah dilakukan presentasi pada tanggal 04-10-2024.	Menunggu ACC.
3	Rekam Medis	1. Mengaplikasikan E-RM (IRJA dan IRNA).	Sudah terealisasi E-RM Rawat Jalan IGD dan IRJA. Rehab sudah berjalan mulai tanggal 01-05-2024. IRNA dalam proses tahap akhir, target pada	Kurang sinkron antara future perawat dan rekam medis, seperti : TTD tidak terisi, belum muncul pengkajian

			tanggal 19-10-2024.	fisioterapis di fitur rekam medis.
		2. Serah terima DRM menggunakan system digital.	Serah terima menggunakan spreadsheet (sudah berjalan).	Monitoring dan Evaluasi.
		3. Permintaan form menggunakan system digital.	Permintaan form dari unit menggunakan google form, sudah berjalan mulai Bulan Juni 2024.	Monitoring dan Evaluasi.
		4. Dokumentasi DRM lama	Melakukan scanning form kedalam SIMRS. Belum bisa melakukan tarikan data.	Koordinasi dengan Programmer. Pengajuan ke PT.
4	Radiologi	Menambahkan fitur hasil radiologi di SIMRS supaya hasil JPEG dapat diakses.	Sudah dirapatkan dengan Programmer untuk dibuatkan fitur tersendiri.	Dalam antrian programmer.
5	Laboratorium	1. Pengadaan LIS.	1. Hardware sudah terpasang di Laboratorium. 2. Software proses dikerjakan oleh Programmer dan Vendor.	Dalam antrian programmer.
		2. Pengadaan BDRS.	1. Proposal dan surat permintaan pelatihan sudah dibuatkan. 2. Sudah ada daftar kebutuhan pengadaan BDRS dan sudah diajukan, menunggu penawaran. 3. Penyekatan ruangan BDRS sudah dilakukan. 4. Legalitas dibantu pengurusan oleh Legal PT. 5. Review tarif disesuaikan dengan PHS.	Dalam Proses. Follow up PT.
6	Gizi	1. Pengaktifan Poli Gizi di Rawat Jalan.	1. Kolaborasi dengan Humas&Marketing. 2. Kolaborasi dengan pelayanan antar obat (PRIMANTARA), free MCU Gizi.	Monitoring dan evaluasi setiap bulan.
		3. MCU Gizi.	Rencana diajukan review tarif ke	Dalam Proses.

			Keuangan PT.	
		4. Prima Healthy Meal.	Sudah pengajuan TOR ke PT.	Menunggu ACC.
7	CSSD	1. Mengajukan mesin sterilitator (steam plasma).	Belum terealisasi.	Monitoring dan evaluasi permintaan sterilisasi alat semi critical sesuai kebutuhan sterilisasi instrument bedah syaraf.
		2. Perbaikan serah terima menggunakan digital form.	Sudah berjalan di Bulan Juli.	1. Kolom tidak terisi lengkap. 2. Monitoring Evaluasi oleh Karu dan Kabid.
8	Laundry	1. Mengajukan mesin cuci industry dengan kapasitas 30kg.	Belum terealisasi.	Monitoring dan evaluasi penggunaan mesin cuci industry utama.
		2. Membuat digital form untuk permintaan linen.	Rencana permintaan sehari 2 kali oleh unit sesuai dengan kebutuhan. Belum terealisasi.	Dalam proses.
		3. Pengadaan Bedcover untuk pasien VIP.	Rencana diajukan ulang dengan melampirkan keluhan pasien VIP.	Dalam Proses.

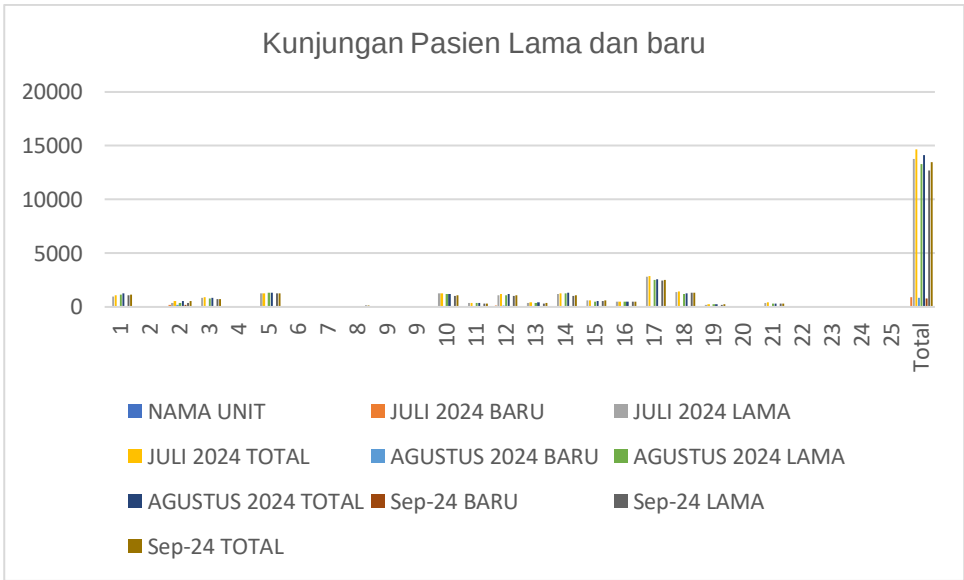
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.1.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

NO	NAMA UNIT	JULI 2024			AGUSTUS 2024			SEPTEMBER 2024		
		BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL
1	Klinik Anak	80	995	1075	97	1164	1261	58	1090	1148
2	Anak sakura	0	1	1	1	2	31	1	7	8
2	IGD	199	372	571	179	379	558	196	371	567
3	Klinik Bedah	55	869	924	48	775	823	44	710	754
4	Klinik Bedah Plastik	3	33	37	0	34	34	2	39	41
5	Klinik Fisioterapi	1	1255	1256	1	1309	1310	2	1257	1259
6	Klinik Gigi Periodonti	6	38	44	5	32	37	9	24	33
7	Klinik Gigi Spesialis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Gigi spesialis pedodontis	3	4	7	16	46	62	19	120	139
9	Gigi Ortodonti	6	17	23	4	15	19	5	11	16
9	Klinik Ibu dan Anak	0	13	13	0	6	6	0	15	15
10	Klinik Jantung	27	1242	1269	32	1181	1213	22	1051	1073
11	Klinik Jiwa	8	362	370	10	352	362	14	321	335
12	Klinik	127	1081	1208	127	1070	1197	97	1016	1113

	Kandungan									
13	Klinik Kulit dan Kelamin	53	399	452	42	373	415	34	334	368
14	Klinik Mata	67	1189	1256	56	1250	1306	61	1024	1085
15	Klinik Orthopedi	34	599	633	20	508	528	31	549	580
16	Klinik Paru	14	482	496	10	484	494	18	468	486
17	Klinik Penyakit Dalam	50	2796	2846	71	2508	2579	58	2442	2500
18	Klinik Syaraf	37	1387	1424	51	1231	1282	49	1303	1352
19	Klinik THT	55	204	259	52	225	277	49	189	238
20	Klinik Umum	29	21	50	20	10	30	15	13	28
21	Klinik Urologi	33	376	409	28	291	319	26	285	311
22	Gizi	1	17	18	1	0	1	0	0	0
23	Bedah Saraf	0	7	7	2	19	21	2	21	23
24	Obgyn Sakura	2	2	4	3	5	8	5	18	23
25	Penyakit dalam sakura	0	1	1	0	2	2	0	0	0
Total		884	13745	14650	874	13274	14148	817	12678	13495



Analisis :

1. Kunjungan 3 bulan terakhir total pasien garfiknya menurun untuk bulan september ini dikarenakan target PRB yang harus selesai sebelum pelaksanaan rekredensialing.
2. Jumlah pasien terbanyak ada di Poli penyakit dalam sebanyak 2500 pasien. Kunjungan tersebut menurun dari bulan sebelumnya sebanyak 2579 pasien, karena banyak pasien yang di PRB kan untuk mengejar target PRB bulan Oktober 2024
3. Kunjungan poli gigi ortodonti masih sedikit,sebesar 16 pasien,karena hanya menerima pasien umum saja, poli pedodontis anak meningkat 100% dibanding bulan sebelumnya, sebesar 139, dari yang sebelumnya yaitu 62 pasien
4. Kunjungan poli bedah syaraf dalam 3 bulan terakhir total pasien selalu meningkat,untuk bulan September terdapat 23 pasien dibandingkan bulan Agustus 2024
5. Kunjungan poli sakura mulai naik dari bulan sebelumnya karena adanya diskon yang berlaku di bulan September.

Rencana Tindak Lanjut :

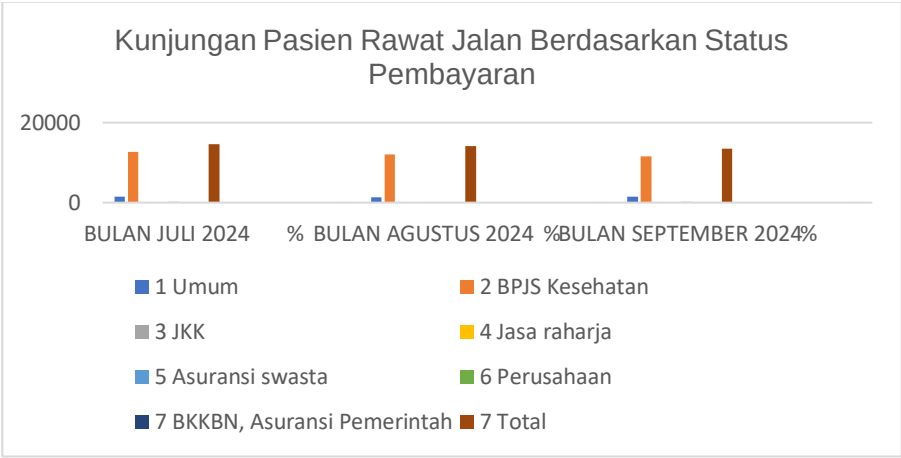
1. Koordinasi dengan pendaftaran penjangran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli sakura
2. Memisahkan pasien BPJS dengan pasien non BPJS. Pasien Non BPJS di dafrakan di poli Sakura.
3. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangran asuransi dan perusahaan.
4. Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
5. Koordinasi dengan humas marketing untuk rutin menampilkan promo di media sosial

6. Koordinasi dengan pendaftaran untuk sellau menanyakan pasien yang mendaftar apakah memiliki asuransi komersil.

5.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

NO	STATUS PEMBAYARAN	BULAN JULI 2024	%	BULAN AGUSTUS 2024	%	BULAN SEPTEMBER 2024	%
1	Umum	1499	10,23%	1287	9,65%	1536	11,38%
2	BPJS Kesehatan	12709	86,75%	12005	88,43%	11587	85,86%
3	JKK	150	1,02	150	0,82%	138	1,02%
4	Jasa raharja	6	0,04%	23	0,16%	15	0,11
5	Asuransi swasta	231	1,58%	156	1,14%	184	1,36%
6	Perusahaan	39	0,27%	19	0,23%	28	0,21
7	BKKBN, Asuransi Pemerintah	16	0,11	17	0,12	7	0,05%
	Total	14650	100%	14148	100%	13495	100%

5.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



Analisis :
Kunjungan pasien selama 3 bulan terakhir berdasarkan cara bayar menurun terutama pada bulan September 2024 menurun 4,8% penurunan 653 pasien dibandingkan Agustus 2024

Rencana Tindak Lanjut :
Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai asuransi, poli bedah saraf dan poli gigi anak

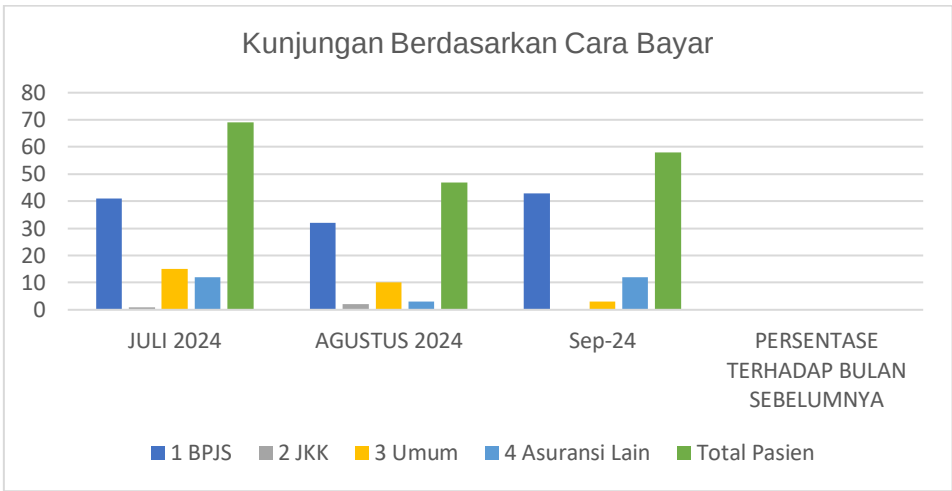
3.3.2 Rawat Inap

3.3.2.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.3.2.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli – September 2024)

NO	HAL	JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	41	32	43	34,37%↑
2	JKK	1	2	0	200%↓
3	Umum	15	10	3	223%↓
4	Asuransi Lain	12	3	12	300%↑
Total Pasien		54	69	47	58

3.3.2.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli-September 2024)



3.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

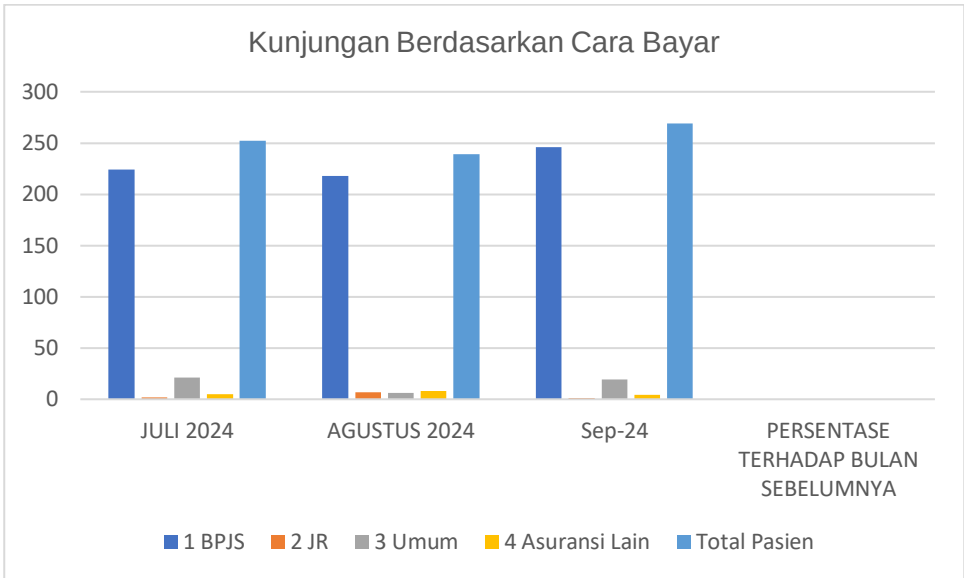
NO.	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Sep 2024	43	3	0	12	58
	Analisa	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan september mengalami peningkatan 34,37% (11 pasien)dari bulan agustus 2024	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan, untuk bulan september 2024 mengalami penurunan 223% (9 pasien)dari bulan agustus 2024	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan september mengalami penurunan 200% (2 pasien)	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir masih belum stabil untuk bulan september 2024 mengalami peningkatan 300% (9 pasien)	Total pasien bulan September mengalami peningkatan 23,40% (11 pasien)
	RTL	Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti paket alat, mandi, baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap,serta bekerjasama dengan marketing untuk meningkatkan pasien pasien asuransi terutama peusahaan perusahaan yang baru				

3.3.2.2 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.3.2.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli-September 2024)

NO	HAL	JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	224	218	246	↑11,3%
2	JR	2	7	1	↓85,7%
3	Umum	21	6	19	↑68%
4	Asuransi Lain	5	8	4	↓50%
Total Pasien		252	239	269	↑11,5%

3.3.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Juli-September 2024)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

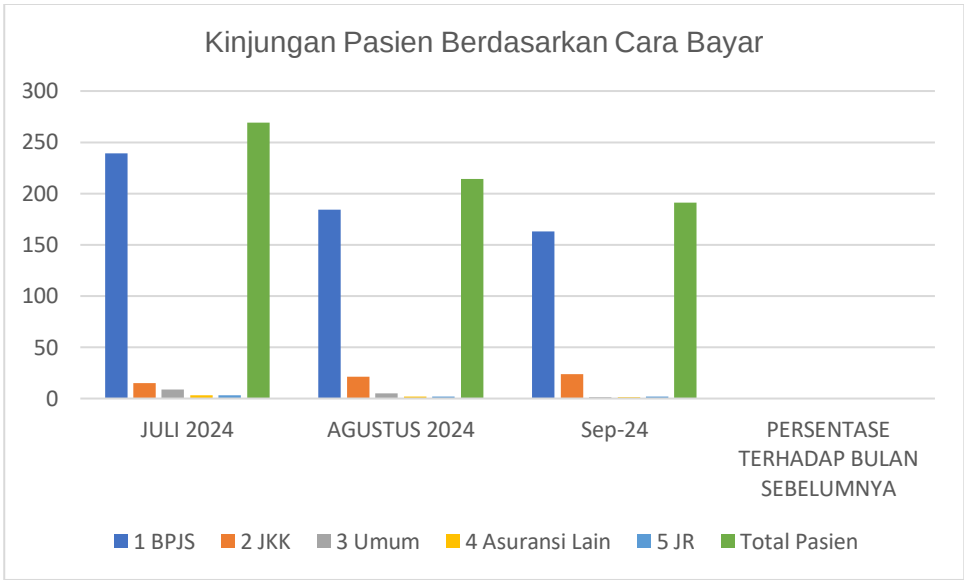
NO.	BULAN SEPTEMBER 2024	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JR	ASURANSI	
1	Analisis	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan dan penurunan untuk bulan september 2024 mengalami peningkatan dari bulan agustus sebesar 28 pasien (11,3%)	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan dan penurunan untuk bulan september 2024 mengalami peningkatan sebesar 13 pasien (68%)	Pasien JR dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan dan penurunan untuk bulan september 2024 mengalami penurunan 6 pasien (85,7%)	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan dan penurunan untuk bulan september 2024 mengalami penurunan 4 dari agustus pasien (50%)	Total keseluruhan bulan september mengalami peningkatan dari bulan agustus sebesar 30 pasien (11,5%)
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulanya 2. Memperbaiki setiap fasilitas yang ada di unit jika ada yang rusak 3. Promosi ruangan anak lewat media sosial ,tiktok dan IG				

3.3.2.3 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.3.2.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli-September 2024)

NO	HAL	JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	239	184	163	↓11,4%
2	JKK	15	21	24	↑14,2%
3	Umum	9	5	1	↓400%
4	Asuransi Lain	3	2	1	↓100%
5	JR	3	2	2	0%
Total Pasien		269	214	191	↓10,7%

3.3.2.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(Juli – September 2024)



3.3.2.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

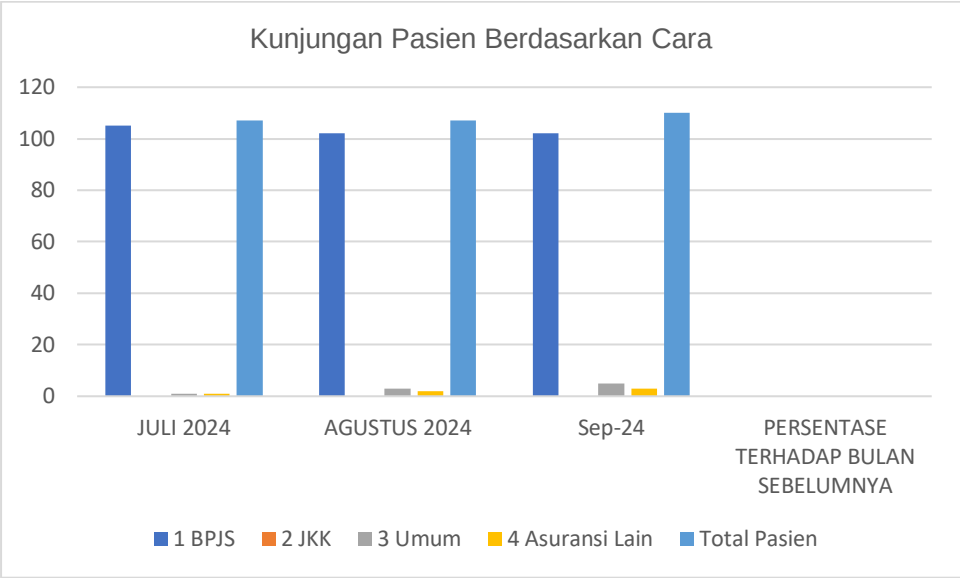
NO.	BULAN SEPTEMBER	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian September 2024	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan secara terus menerus untuk bulan september turun 11,4% (21 pasien) dari bulan agustus 2024	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan secara terus menerus untuk bulan september 2024 mengalami penurunan 400% (4 pasien) dari bulan agustus 2024	Pasien JKK 3 dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan secara terus menerus untuk bulan september 2024 mengalami peningkatan 14,2% (3 pasien) dari bulan agustus 2024	Pasien JR/Asuransi dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan september tetap 2 pasien	Total pasien di lantai 2,3,dan 4 mengalami penurunan untuk bulan september 10,7% (23 pasien)
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5.Meningkatkan kualitas fasilitas di unit				

3.3.2.4 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.3.2.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli - September 2024)

NO	HAL	JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	105	102	102	0
2	JKK	0	0	0	0
3	Umum	1	3	5	↑ 66,6%
4	Asuransi Lain	1	2	3	↑ 50%
Total Pasien		107	107	110	↑ 2,8%

3.3.2.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Juli – September 2024)



3.3.2.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

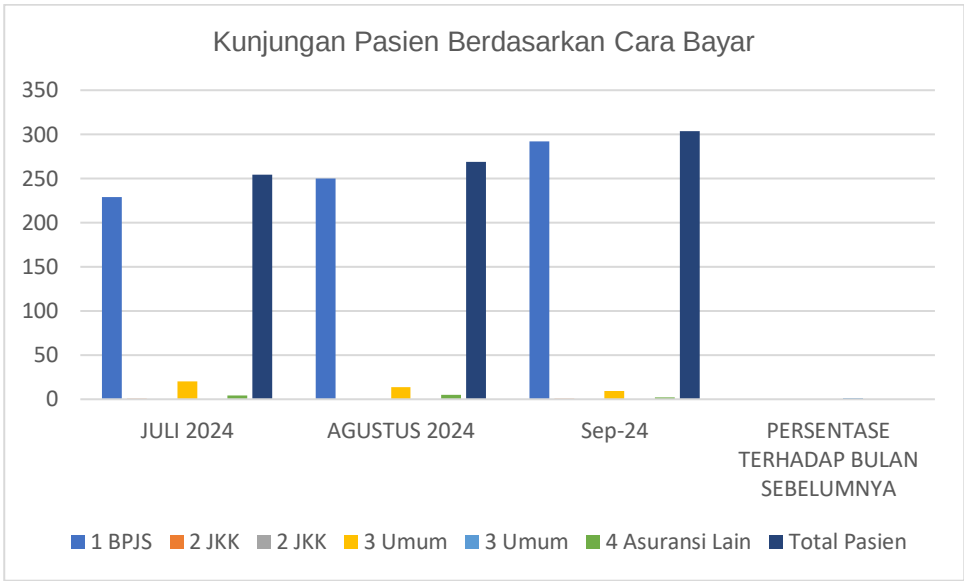
NO.	BULAN SEPTEMBER	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan september 2024 tetap di 102 pasien	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan september 2024 mengalami peningkatan 66,6%	Dalam 3 bulan terakhir tidak ada pasien JKK	Pasien Asuransi dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan september meningkat 50% (1 pasien)	Pada bulan september total pasien mengalami peningkatan 2.8% (2 pasien)
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5.Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6.Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan berkoordinasi dengan marketing untuk selalu koordinasi dengan faskes tentang pelayanan pasien TB di rumah sakit prima husada				

3.3.2.5 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.3.2.5.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli - September 2024)

NO	HAL	JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	229	250	292	↑16,8%
2	JKK	1	0	1	↑ 100%
3	Umum	20	14	9	↓35%
4	Asuransi Lain	4	5	2	↑60%
Total Pasien		254	269	304	↑13%

3.3.2.5.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli - September 2024)



3.3.2.5.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

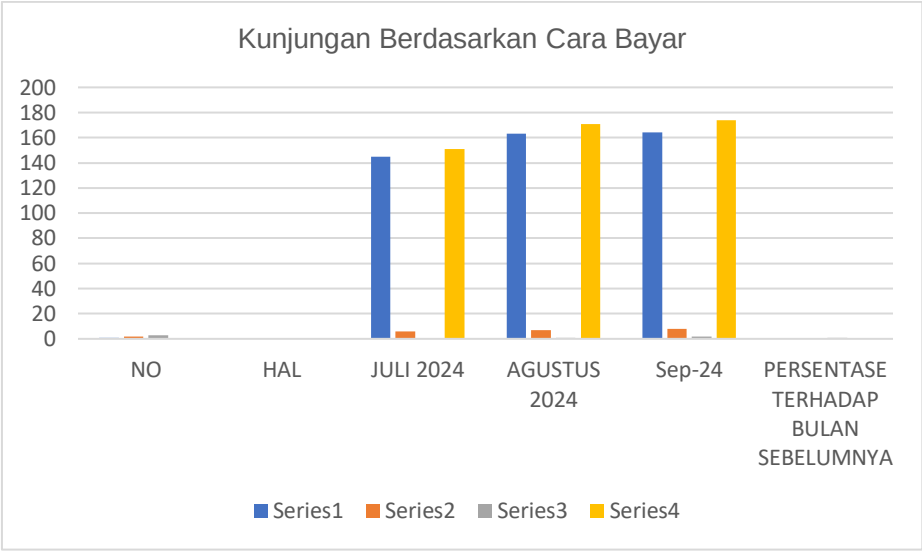
NO.	BULAN Septem ber	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan september 2024 mengalami peningkatan 16,8 % (42 pasien) dari bulan agustus 2024	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan,u ntuk bulan september mengalami penurunan 35% (5 pasien)dari bulan agustus 2024	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan dan penurunan untuk bulan september mengalami peningkatan 100% (1 pasien) dari bulan agustus 2024	Pasien Asuransi / JR mengalami dalam 3 bulan terakhir masih belum stabil untuk bulan september mengalami penurunan 60% (3 pasien) dari bulan agustus 2024	Total semua pasien mengalami peningkatan 13% (35 pasien) dari bulan agustus 2024
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5.Meningkatkan kualitas fasilitas di unit				

3.3.2.6 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.3.2.6.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli-September 2024)

NO	HAL	JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	145	163	164	↑ 0,61%
2	Umum	6	7	8	↑ 14,2%
3	Asuransi	0	1	2	↑100%
Total Pasien		151	171	174	↑1,7 %

3.3.2.6.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli-September 2024)



3.3.2.6.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

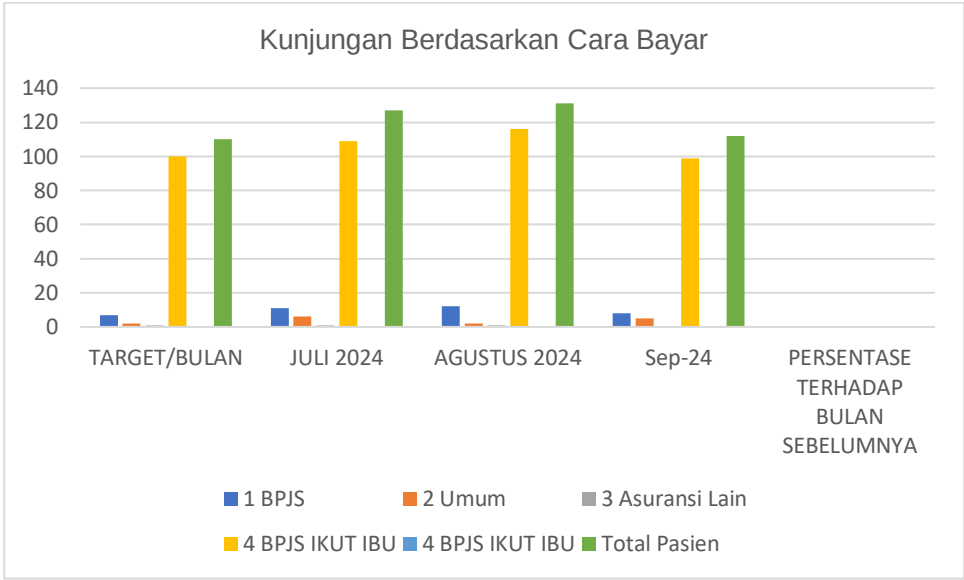
NO.	BULAN	RAWAT INAP			KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian Juli-September 2024	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan secara terus menerus untuk bulan september mengalami peningkatan 0,61% (1 pasien)dari bulan agustus 2024	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir selalu mengalami peningkatan secara terus menerus,untuk bulan september mengalami peningkatan 14,2% (1 pasien) dari bulan agustus 2024	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan september mengalami peningkatan 100% (1 pasien) dari bulan agustus 2024	Total pasien bulan september mengalami peningkatan 1,7% dari bulan agustus 2024 (3 pasien)
2	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan bekerja sama dengan humas marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan ,bekerjasama dengan humas marketing untuk posting di ig tentang pelayanan di maternitas	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan ,dan mengadakan corporate gatreing dengan perusahaan setiap 1 tahun sekali	

3.3.2.7 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli-September 2024)

NO	HAL	TARGET/BULAN	JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	11	12	8	↑33,3%
2	Umum	2	6	2	5	↑60%
3	Asuransi Lain	1	1	1	0	↓ 100%
4	BPJS IKUT IBU	100	109	116	99	↓ 14,6%
Total Pasien		110	127	131	112	↓14,5%

3.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli-September 2024)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

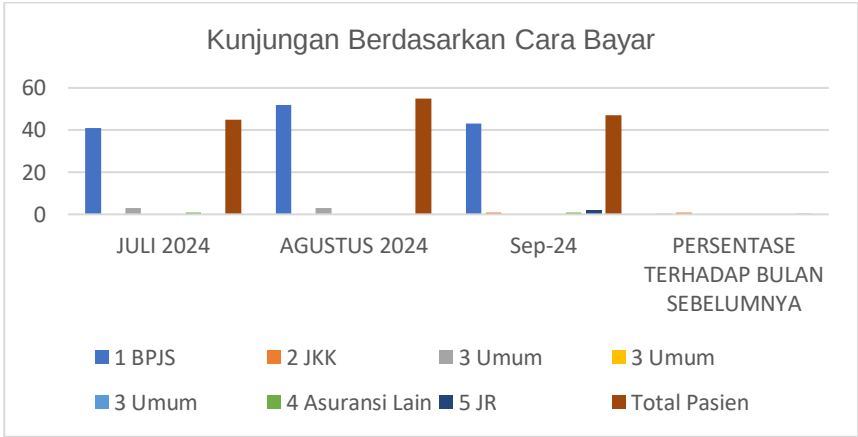
NO.	BULAN	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT IBU	Total Pasien
1	September 2024	8	5	0	99	112
	Analisa	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir masih belum stabil untuk bulan september mengalami penurunan dari bulan agustus sebanyak 33,3 % (4 pasien)	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan september mengalami peningkatan dari bulan agustus sebanyak 60% (3 pasien)	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan september mengalami penurunan 100% dari bulan agustus sbanyak 1 pasien	Pasien BPJS ikut ibu dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan september mengalami penurunan dari bulan agustus 14,6% (17 pasien)	Total pasien dalam bulan september 2024 mengalami penurunan dari bulan agustus 14,5% (19 pasien)
	RTL	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, dan berkoordinasi dengan marketing untuk menginformasikan ke bidan bidan jejaring	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasama dengan marketing, membuat program pelayanan baru seperti pijat bayi sehingga menarik banyak pasien	Meningkatkan pelayanan dan koordinasi dengan bagian marketing untuk meningkatkan pasien asuransi	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasama dengan marketing	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasama dengan marketing

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)

3.3.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli-September 2024)

NO	HAL	JULI 2024	AGUSTUS 2024	September 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	41	52	43	↓20%
2	JKK	0	0	1	↑100%
3	Umum	3	3	0	↓ 300%
4	Asuransi Lain	1	0	1	↑ 100%
5	JR	0	0	2	↓ 200%
Total Pasien		45	55	47	↓17%

3.3.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli-September 2024)



3.3.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

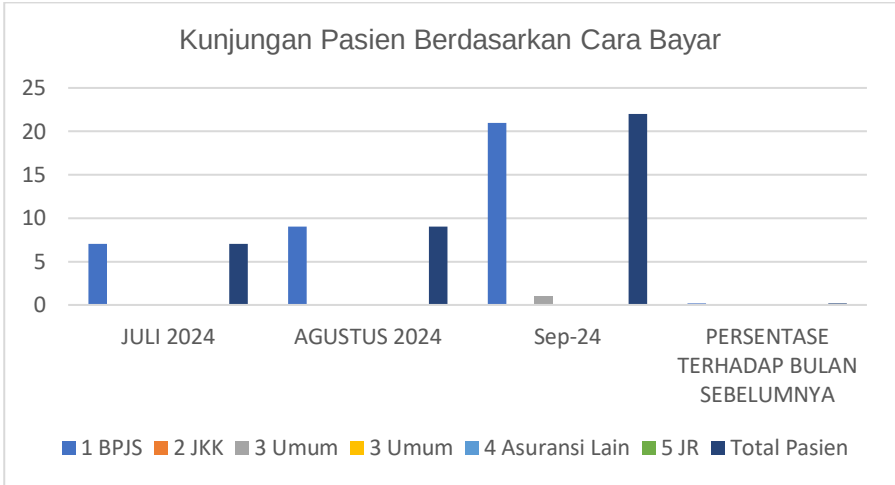
NO.	BULAN Septem ber	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan dan penurunan untuk bulan september mengalami penurunan 20% (9 pasien) dari bulan agustus 2024	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan september mengalami penurunan 300% (3 pasien) dari bulan agustus 2024	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan, untuk bulan september 20204 mengalami peningkatan 100% (1 pasien)dari bulan agustus 2024	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil,untuk bulan september 2024 mengalami peningkatan 300% (3 pasien) dari bulan agustus 2024	Pada 3 bulan terakhir jumlah total pasien yang ada di ICU mengalami peningkatan dan penurunan untuk bulan september mengalami penurunan 17% (8 pasien)
2	RTL	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	

3.3.4 High Care Unit (HCU)

3.3.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli-September 2024)

NO	HAL	JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	9	21	↑133%
2	JKK	0	0	0	0%
3	Umum	0	0	1	↑ 100%
4	Asuransi Lain	0	0	0	0%
5	JR	0	0	0	0%
Total Pasien		7	9	22	↑144%

3.3.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli-September 2024)



3.3.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

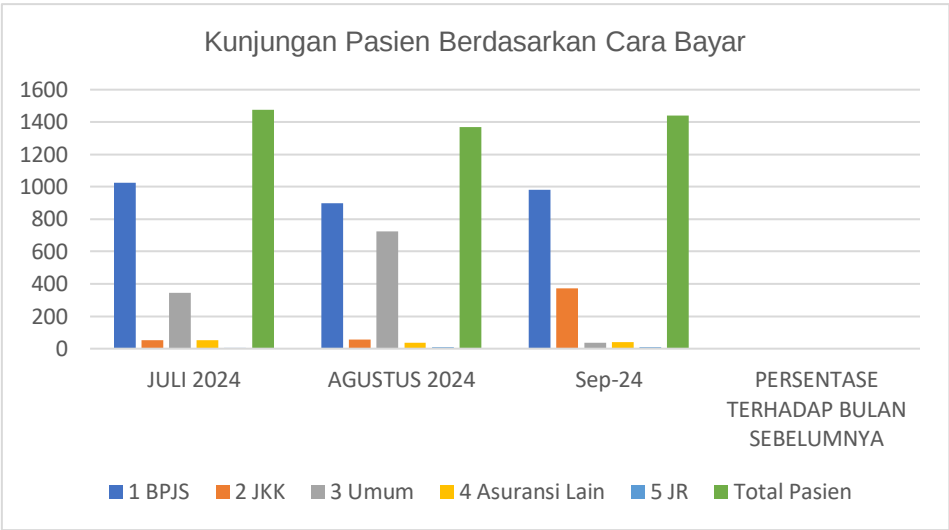
NO.	BULAN SEPTEMBER	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan september mengalami peningkatan 133% (12 pasien) dari bulan agustus 2024	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan september mengalami peningkatan 100%(1 pasien) dari bulan agustus 2024	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir masih belum ada pasien	Pada 3 bulan terakhir jumlah total pasien yang ada di HCU mengalami peningkatan 144 % (13 pasien) dari bulan agustus 2024
2	RTL	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	

3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.3.5.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli – September 2024)

NO	HAL	JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	1025	897	981	↑7,54%
2	JKK	52	57	38	↓33,3%
3	Umum	343	379	371	↓2,15%
4	Asuransi Lain	51	37	39	↑2,56%
5	JR	6	10	10	0%
Total Pasien		1477	1370	1439	↑3,33%

3.3.5.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli-September 2024)



3.3.5.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN SEPTEMBER	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis	Kunjungan pasien BPJS dari 3 bulan terakhir belum stabil ,untuk bulan september meningkat di bandingkan bulan agustus 20204 7,54% (84 pasien	Kunjungan pasien UMUM 3 bulan terakhir belum stabil,untuk bulan september menurun di bandingkan bulan agustus 2024 2,15% (8 pasien)	Kunjungan pasien dengan jaminan JKK dari 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan september mengalami penurunan di bandingkan bulan agustus 33,3% (18 pasien)	Kunjungan pasien dengan jaminan JR dan asuransi dalam 3 bulan terakhir masih belum stabil untuk bulan september mengalami 2,56% (2 pasien)	Total Kunjungan pasien IGD semua jaminan mengalami peningkatan di bandingkan bulan agustus 2024 3,33% (69 pasien)
2	RTL	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD dengan memperbaiki pelayanan dan mengurangi komplain serta	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan	Meningkatkan capaian kunjungan IGD jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama dengan pihak terkait (marketing,

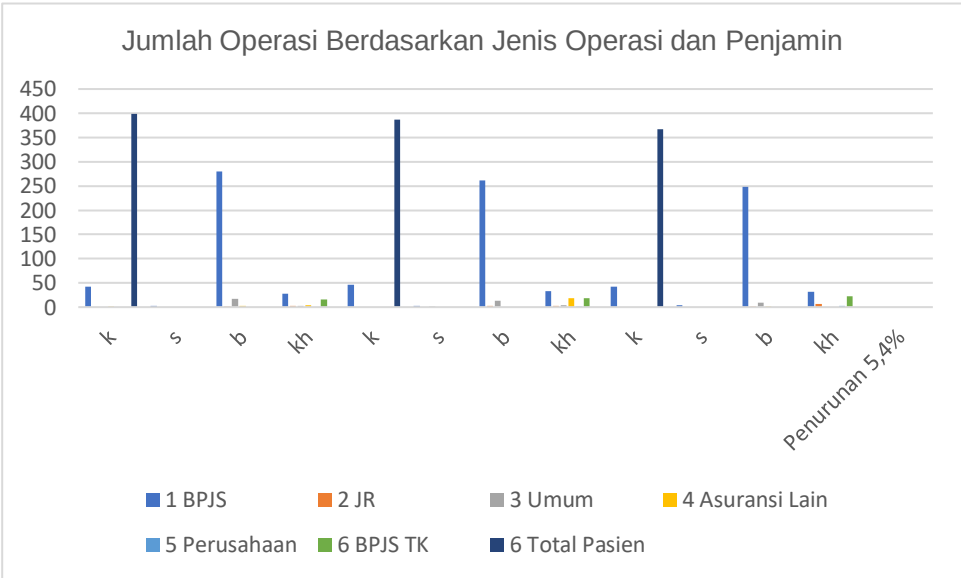
		bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang	yang prima dan maksimal	untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	dengan perusahaan asuransi	asuransi centre)
--	--	---	-------------------------	--	----------------------------	------------------

3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.3.6.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Juli-September 2024)

NO	HAL	JULI 2024				AGUSTUS 2024				SEPTEMBER 2024				PROSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
		k	s	b	kh	k	s	b	kh	k	s	b	kh	
1	BPJS	42	2	280	28	46	3	261	33	42	4	248	31	Penurunan 5,4%
2	JR	0	0	1	3	0	0	2	3	0	0	1	6	
3	Umum	0	0	17	2	0	1	13	4	0	0	9	0	
4	Asuransi Lain	1	0	3	4	0	0	0	18	0	0	1	0	
5	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
6	BPJS TK	0	0	0	16	0	0	0	18	0	0	0	23	
	Total Pasien	399				387				367				

3.3.6.2 Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Juli-September 2024)



3.3.6.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN SEPTEMBER	IKO					KESIMPULAN
		BPJS	BPJS TK	UMUM	PERUSAHAAN	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan,untuk u bulan september 2024 mengalami penurunan 5,5 % (18 pasien) dari bulan agustus 2024	Pasien BPJS TK dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan september mengalami peningkatan 27,7% (5	Pasien Umum operasi dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan ,untuk bulan september 2024 mengalami penurunan	Pasien perusahaan dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan,untuk bulan september 2024 mengalami peningkatan 100% (1 pasien)dari bulan agustus 2024	Pasien Asuransi / JR dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan september 2024 mengalami penurunan dari 187,5% (15 pasien)dari bulan agustus 2024	Total pasien untuk bulan september 367 pasien menurun di bandingkan bulan agustus 2024 5,4%

			pasien)dari bulan agustus 2024	100% (9 pasien) dari bulan agustus 2024			
2	RTL	1.Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan mengurangi pasien IDO sehingga pasien puas dengan pelayanan operasi di prima husada 2.Berkoordinasi dengan bagian marketing untuk ekspos ruangan IKO yang sudah di ganti vynil 3.Mengikuti pelatihan yang terbaru sehingga menunjang pelayanan yang terbaik di IKO					

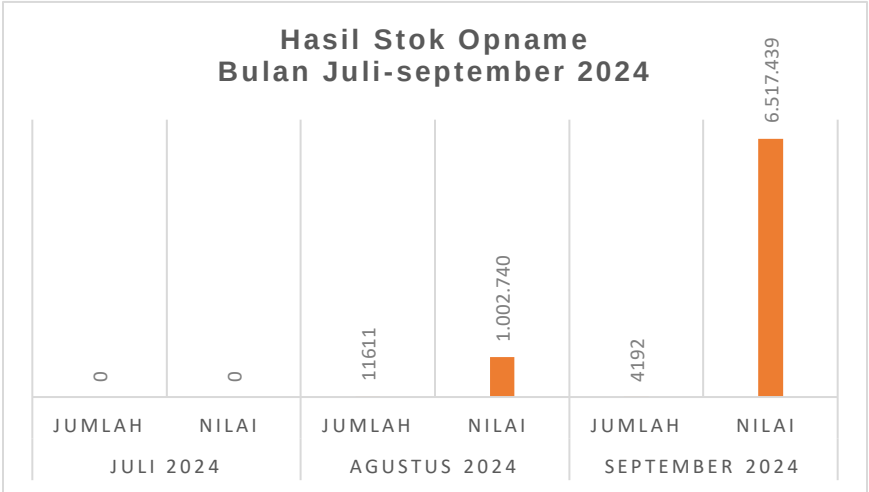
3.4 Kinerja Bidang Penunjang

3.4.1 Instalasi Farmasi

3.4.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Bulan Juli - September 2024

UNIT	JUMLAH STOK	JUMLAH SEDIAAN					
		JULI 2024		AGUSTUS 2024		SEPTEMBER 2024	
		JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
GUDANG	Fisik	0	0	732.380	2.267.670.139	733.807	2.350.377.739
	Sistem	0	0	732.927	2.285.414.509	734.059	2.350.612.541
	Selisih	0	0	547	-17.744.369	-252	-234.802
DEPO FARMASI	Fisik	0	0	147.379	519.778.015	141.256	513.820.725
	Sistem	0	0	136.326	510.064.361	136.874	508.681.432
	Selisih	0	0	11.053	+9.713.656	4.382	+5.139.293
IKO	Fisik	0	0	2.479	111.929.273	2.275	99.246.881
	Sistem	0	0	2.490	102.895.820	2.213	97.633.933
	Selisih	0	0	11	+9.033.453	62	+1.612.948
GUDANG RETUR	Fisik	0	0	0	0	0	0
	Sistem	0	0	0	0	0	0
	Selisih	0	0	0	0	0	0
Total Selisih		0	0	11.611	+1.002.740	4.192	+6.517.439

3.4.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Bulan Juli-September 2024



3.4.1.3 Analisis dan Tindak Lanjut

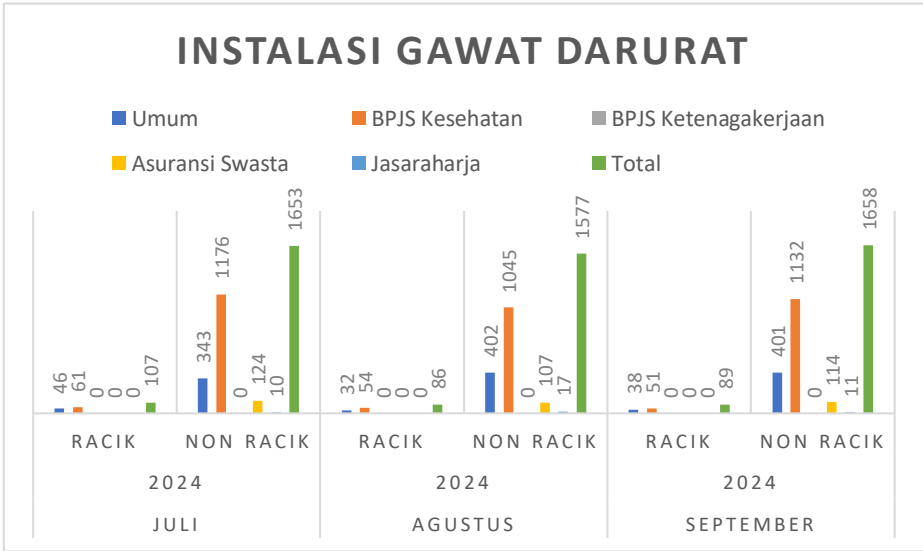
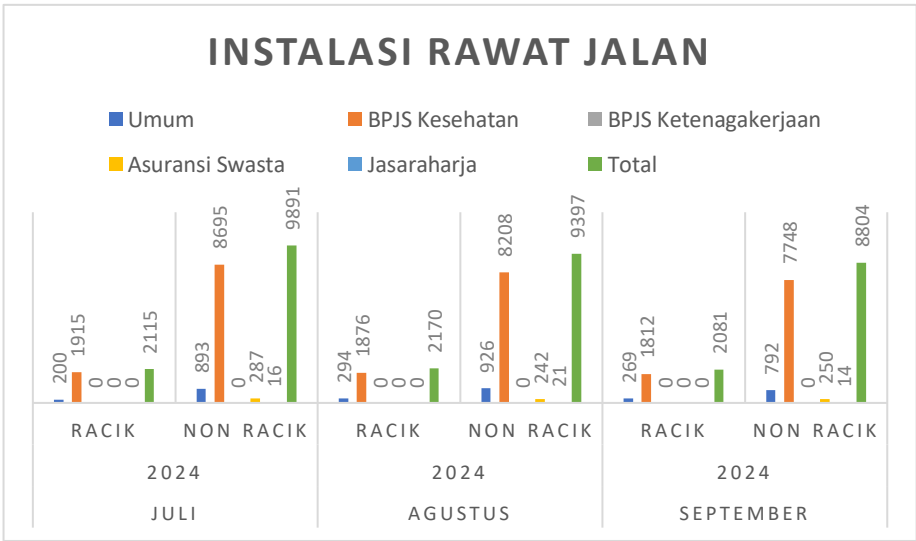
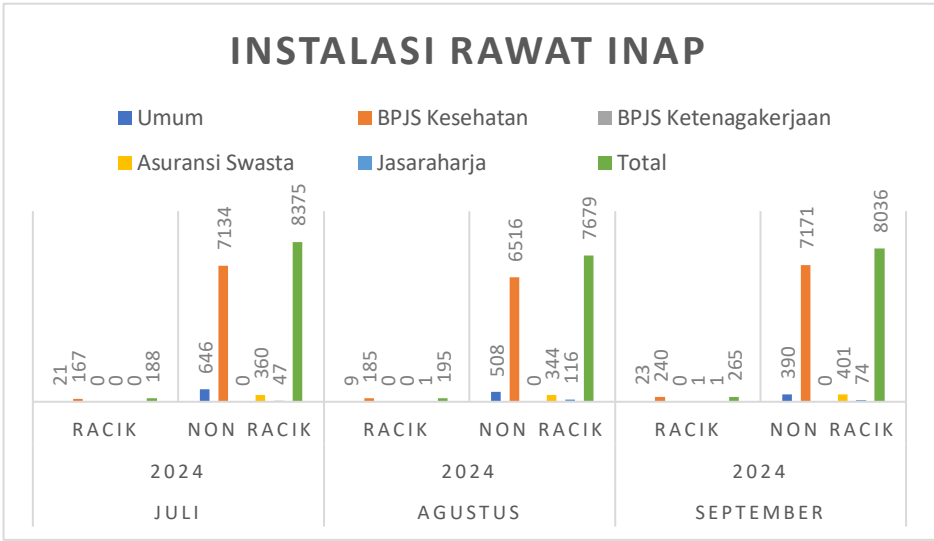
NO	ANALISA	RENCANA TINDAK LANJUT
Gudang Farmasi Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar -234.802 , hal ini disebabkan karena :		
1.	Terdapat ketidaksesuaian sistem dengan fisik - Cairan INF D5 1/2 NS 500 ML stok sistem 300, stok fisik 320. - Benang t-vio 2-0 10 pengeluaran ke depo tgl 13/09/24 12 pcs tidak ter release.	1. Meningkatkan ketelitian petugas dalam melakukan perhitungan. 2. Peningkatan ketelitian dalam melakukan pengeluaran barang. 3. Meningkatkan kedisiplinan petugas dalam menuliskan kartu stok. 4. Evaluasi kinerja staff.
2.	Kartu stok belum berjalan maksimal - Ada kartu stock hanya di update ketika SO aja. Contoh : Cairan INF D5 1/2 NS 500mg.	
Depo Farmasi Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar +5.139.293 , hal ini disebabkan karena :		
1.	- Kartu stok belum berjalan maksimal. - Kartu stok tidak di rekap setelah akhir shift. Contoh : Nupovel	1. Evaluasi kinerja staff. 2. Sisa stok ditulis setiap pengambilan obat. 3. Supervisi PJ setiap akhir shift.
2.	Tidak ada rak di SIMRS, sehingga tidak diinput SO. 1. ALBUNORM 25%. 2. TRIFLUOPERAZINE TAB 5mg.	Update kertas kerja di sistem dan master barang.
3.	Kesalahan perhitungan 3. Perbedaan jumlah pada kertas kerja dan saat dihitung ulang dikarenakan petugas ada yang terlewat tidak menulis pengeluaran di lembar kerja namun sudah ditulis di kartu stok. 4. Kurangnya pencatatan jika ada pengeluaran resep (pending). Pending resep adalah pasien BPJS yang maju kontrol sehingga farmasi tidak bisa simpan penjualan resep karena fitur no. apol wajib diisi dan tidak bisa input obat di apotek online No. apol diisi setelah input di apol. Contoh : haloperidol 0,5 mg	Saran jarak waktu selesai perhitungan dan input SO tidak terlalu jauh atau ditanggal yang sama sehingga meminimalisir tidak ditulisnya pengeluaran stok dari rentang waktu selesai perhitungan ke input SO. Semua inputan pendingan diinput tanpa no. apol (-) jika sudah tanggal input maka mengajukan pendingan resep untuk mengisi no. Apol.
4.	Perbedaan produsen dari fisik dengan master. Temuan : Fisik Acyclovir Cream (FM), Master Acyclovir Cream (Indofarma).	Master Acyclovir Cream (FM) tidak ada karena belum ditambahkan oleh PT pada saat mapping. Koordinasi antara Kains dengan Pengadaan PT.
5.	Penempatan barang. Temuan : Citicoline injeksi 250 mg/2ml terdapat 2 merek ditempatkan dalam satu rak dengan satu kartu stok.	Penyesuaian penataan barang sesuai rak.

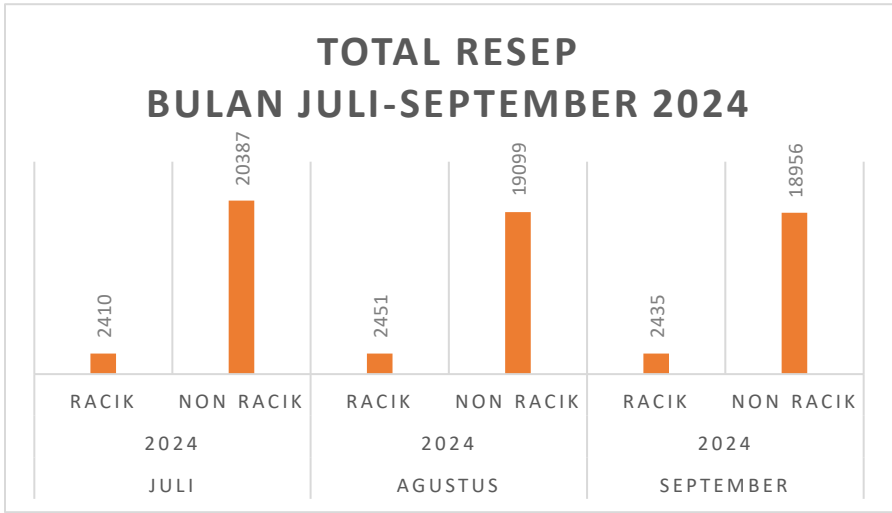
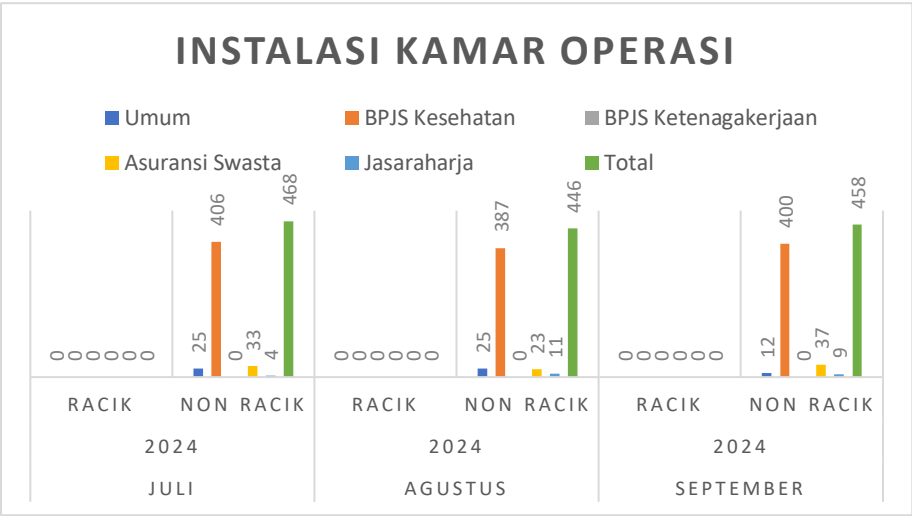
Instalasi Kamar Operasi		
Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar +1.612.948 , hal ini disebabkan karena :		
1.	Masih banyak ditemukan selisih barang di IKO.	5. Peningkatan ketelitian dalam penginputan barang yang digunakan agar tidak terjadi selisih barang saat stock opname. 6. Double cek dilakukan oleh TTK IKO.
2.	Sput pemakaian masih sharing use, perawat sering minta release barang di sistem tapi fisik lebih.	7. Dilakukan telusur koordinasi dengan Kains IKO. 8. Penginputan tidak sesuai dengan penggunaan sehingga ada sisa stok. 9. Koordinasi dengan Kabid Keperawatan.
3.	Pemakaian HS steril diinputan hanya 1, apakah HS yg pakai hanya DPJP.	Random stok IKO harian yaitu HS, Sput jika ada selisih langsung koordinasi dengan karu untuk input ke pasien.
4.	Resep hijau tidak dikumpulkan real time, seringnya resep manual dikumpulkan besoknya ke ruang FS, sehingga pasien sudah pindah ruangan.	Koordinasi dengan karu IKO untuk menertibkan pengumpulan resep manual secara real time.
Gudang Retur		
Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname sudah mencapai target, namun masih ada kendala saat stok opname yaitu :		
1.	Tidak terdapat rak Gudang Retur	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien dilakukan retur penjualan di Depo Farmasi dan tagihan di apotek online dihapus, sehingga stok langsung mutasi ke depo farmasi bukan gudang retur.

3.4.1.4 Tabel Jumlah Resep Menurut Jenis Pembayaran Juli-September 2024

NO	UNIT	PENJAMIN	BULAN/JENIS RESEP					
			JULI 2024		AGUSTUS 2024		SEPTEMBER 2024	
			RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK
1.	IRNA	Umum	21	646	9	508	23	390
		BPJS Kesehatan	167	7134	185	6516	240	7171
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	360	0	344	1	401
		Jasaraharja	0	47	1	116	1	74
Total			188	8375	195	7679	265	8036
2.	IRJA	Umum	200	893	294	926	269	792
		BPJS Kesehatan	1915	8695	1876	8208	1812	7748
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	287	0	242	0	250
		Jasaraharja	0	16	0	21	0	14
Total			2115	9891	2170	9397	2081	8804
3.	IGD	Umum	46	343	32	402	38	401
		BPJS Kesehatan	61	1176	54	1045	51	1132
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	124	0	107	0	114
		Jasaraharja	0	10	0	17	0	11
Total			107	1653	86	1577	89	1658
4.	IKO	Umum	0	25	0	25	0	12
		BPJS Kesehatan	0	406	0	387	0	400
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	33	0	23	0	37
		Jasaraharja	0	4	0	11	0	9
Total			0	468	0	446	0	458
Total Resep			2410	20387	2451	19099	2435	18956

3.1.1.1 Grafik Jumlah Resep Menurut Jenis Pembayaran Juli-September 2024





Analisis :

1. Hasil jumlah resep selama 3 bulan mengalami penurunan jumlah resep di Bulan September 2024.
2. Kunjungan pasien umum pada Bulan September 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Bulan Agustus 2024, dengan total resep yaitu : Bulan Agustus 2024 sebanyak 2196 resep umum dan Bulan September 2024 sebanyak 1925 resep umum. Salah satu penyebabnya adalah pasien dengan kunjungan pertama menggunakan umum memilih pengurusan BPJS Kesehatan karena dijadwalkan control rutin oleh DPJP.
3. Kunjungan pasien BPJS pada Bulan September 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Bulan Agustus 2024, dengan total resep yaitu : Bulan Agustus 2024 sebanyak 18271 resep BPJS dan Bulan September 2024 sebanyak 18554 resep BPJS.
4. Kunjungan pasien Asuransi Swasta dan Jasaraharja pada Bulan September 2024 mengalami peningkatan tidak signifikan jika dibandingkan dengan Bulan Agustus 2024, dengan total resep yaitu : Bulan Agustus 2024 sebanyak 882 resep Asuransi Swasta dan Jasaraharja, sedangkan Bulan September 2024 sebanyak 912 resep Asuransi Swasta dan Jasaraharja.
5. Secara keseluruhan total resep pada Bulan September 2024 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah kunjungan pasien rawat jalan ke RS, meskipun kunjungan rawat inap, IGD mengalami peningkatan.
6. Kunjungan rawat jalan mengalami penurunan dikarenakan DPJP mempunyai target PRB, dan sudah ada beberapa dokter yang mencapai target, seperti : dr Andy, Sp.P.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di social media RS agar kunjungan pasien meningkat.
- 2. Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi.
- 3. Menciptakan inovasi pengembangan pelayanan pengantaran obat dengan penambahan jumlah driver dan keaktifan admin primantara untuk promosi
- 4. Koordinasi dengan programmer menciptakan website primantara untuk memudahkan pendaftaran pasien.
- 5. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal.

3.1.2 Laboratorium

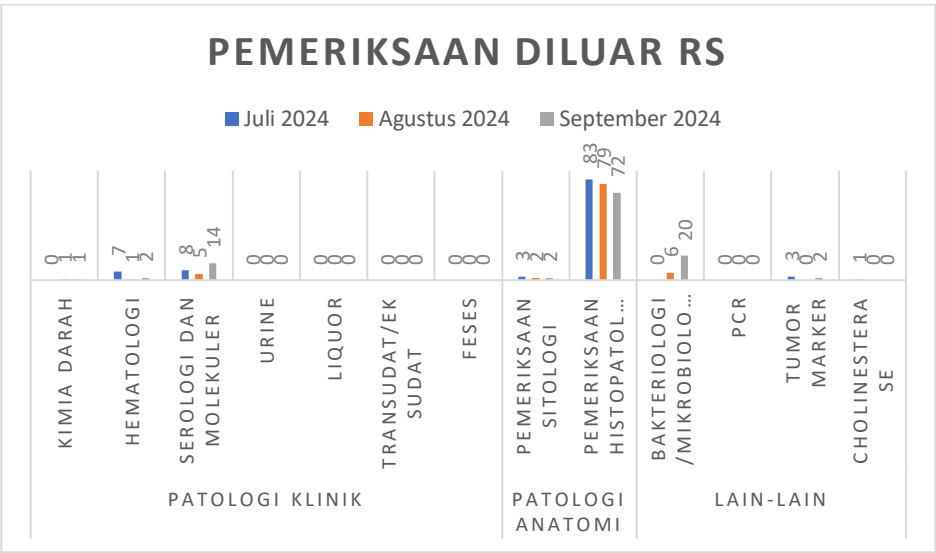
3.1.2.1 Tabel Daftar Pemeriksaan Laboratorium yang Dilakukan Didalam dan Diluar Juli - September 2024

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
Dilakukan di RS				
1.	Patologi Klinik			
	Kimia darah	4880	4799	5063
	Hematologi	2688	2444	2441
	Serologi dan Molekuler	523	453	522
	Urine	382	521	518
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Feses	22	32	19
2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	0	0	0
	Pemeriksaan Histopatologi	0	0	0
3.	Bakteriologi/Mikrobiologi	34	27	23
4.	Narkoba	57	35	21
5.	Covid-19	17	17	7
Dirujuk				
1.	Patologi Klinik			
	Kimia darah	0	1	1
	Hematologi	7	1	2
	Serologi dan Molekuler	8	5	14
	Urine	0	0	0
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Liquor	-	-	-
	Feses	0	0	0
2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	3	2	2
	Pemeriksaan Histopatologi	83	79	72
3.	Bakteriologi/Mikrobiologi	0	6	20
4.	PCR	0	0	0
5.	Tumor Marker	3	0	2
6.	Cholinesterase	1	0	0

3.1.2.2 Grafik Pemeriksaan Didalam Rumah Sakit Bulan Juli-September 2024



3.1.1.1 Grafik Pemeriksaan Diluar Rumah Sakit Bulan Juli-September 2024



Analisis :

- 1. Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi di Laboratorium luar masih mendominasi diantara pemeriksaan lainnya dalam 3 bulan terakhir, rincian Bulan September 2024 yaitu :
 - a) Patologi Anatomi : 74 sampel
 - b) Bakteri/Mikrobiologi : 22 sampel
 - c) Patalogi Klinik : 17 sampel
- 2. Terjadi peningkatan rujukan bakteri/mikrobiologi pada Bulan September 2024, yaitu Bulan Agustus 2024 sebanyak 6 pemeriksaan sedangkan Bulan September 2024 sebanyak 20 pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena DS Paru mengadvicekan pasien untuk melakukan pemeriksaan kultur sputum untuk melihat jenis bakteri dan menentukan penggunaan antibiotic yang tepat.

Rencana Tindak Lanjut

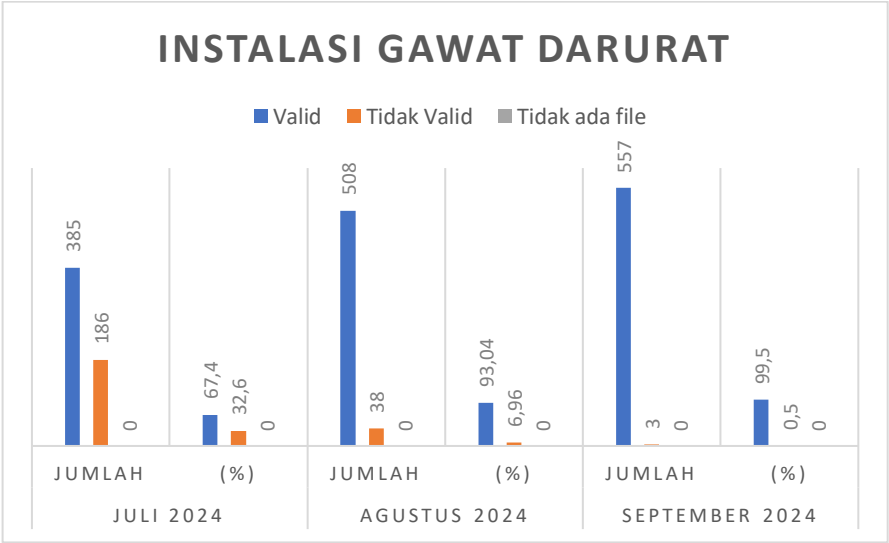
- 1. Perencanaan Tahun 2024 laboratorium mengadakan pengembangan pelayanan dengan mendirikan BDRS di RS Prima Husada Malang, untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu.
- 2. Proses pengembangan pelayanan dengan menggunakan LIS.
- 3. Perbaikan serah terima hasil laboratorium menggunakan system digital.
- 4. Melakukan pencatatan keluar masuk stok reagen pada kartu stok.

3.1.2 Rekam Medis – Pendaftaran

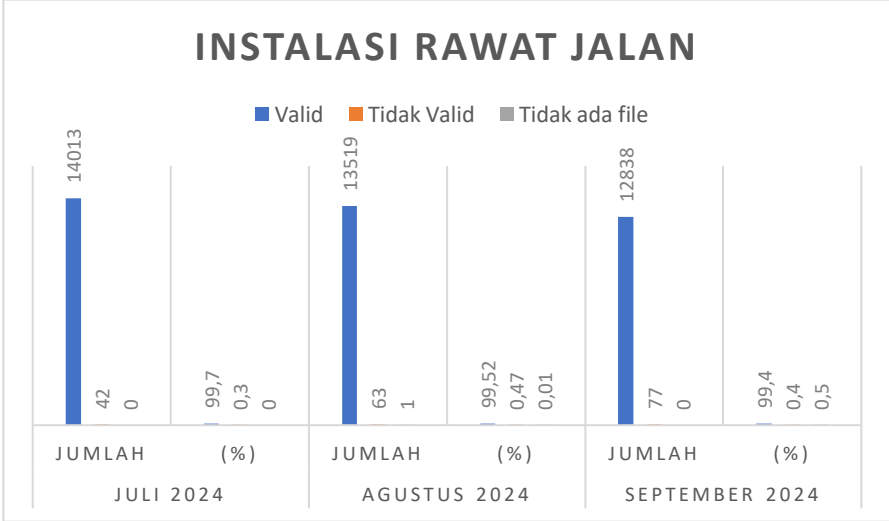
3.1.2.1 Tabel Validasi Data E-RM Bulan Juli-September 2024

NO	UNIT	KUALIFIKASI	BULAN					
			JULI 2024		AGUSTUS 2024		SEPTEMBER 2024	
			JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)
1.	IGD	Valid	385	67,4	508	93,04	557	99,5
		Tidak Valid	186	32,6	38	6,96	3	0,5
		Tidak ada file	0	0	0	0	0	0
Total			571		546		560	
2.	IRJA/POLI	Valid	14013	99,7	13519	99,52	12838	99,4
		Tidak Valid	42	0,3	63	0,47	74	0,4
		Tidak ada file	0	0	1	0,01	0	0,5
Total			14055		13583		12912	

3.1.2.2 Validasi data E-RM di IGD Bulan Juli-September 2024



3.1.2.3 Validasi data E-RM di IRJA/Poli Bulan Juli-September 2024



Analisis :

- 1. Terjadi kenaikan yang signifikan pada data valid di IGD sebanyak 560 Data E-RM dari 557 Data E-RM atau sebesar 99.5%, hal ini disebabkan adanya perubahan alur penyetoran data kunjungan pasien per hari ke Instalasi Rekam Medis oleh Karu IGD, sehingga memperbaiki angka capaian validasi data, meskipun belum mencapai 100%.
- 2. Masih ditemukan 0.5% Data E-RM tidak valid di IGD, hal ini disebabkan masih ditemui form yang belum sinkron antara form IGD dan rekam medis, setelah ditelusur sudah pengkajian awal IGD sudah diisi lengkap tetapi tidak terbaca, system bermasalah.
- 3. Pada Bulan September 2024 tidak ditemukan tarikan data yang tidak ada file, yaitu 0%.

Masalah :

- 1. Pengkajian awal medis gigi tidak bisa terbuka oleh rekam medis, sedangkan fitur tersebut muncul di SIMRS perawat.
- 2. Permasalahan di IGD tidak bisa diperbaiki langsung karena tidak bisa batal kunjungan, pembatalan harus melalui PT.
- 3. Berikut link permasalahan yang ditemui
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcmJm9ucywizoiEdYqeEaCRxvhVWELL7eKe8NQ_D_k/edit#gid=1732600455

Rencana Tindak Lanjut :

Ketidaklengkapan ERM sudah membaik dari pada bulan sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan alur terkait penyetoran berkas pasien per hari, yaitu :

- 1 Alur sebelumnya perawat menyetor berkas casemix ke kasir jaminan, mulai awal Bulan Juni 2024 perawat menyetor berkas ke rekam medis untuk dilakukan cek kelengkapan ERM oleh tim rekam medis.
- 2 Petugas rekam medis menandatangani lembar casemix sebagaibukti bahwa sudah dilakukan pengecekan dan dinyatakan lengkap dan valid.
- 3 Setelah selesai dilakukan validasi oleh petugas rekam medis, perawat meyetorkan berkas ke kasir jaminan.

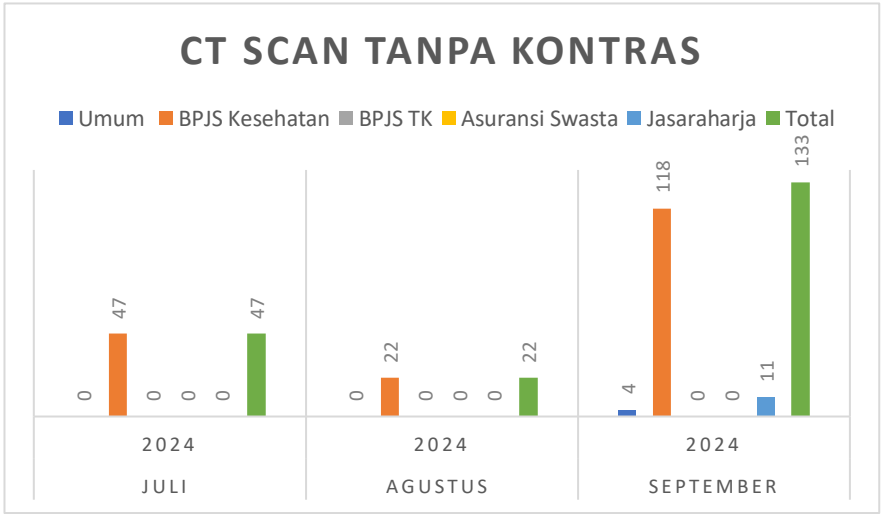
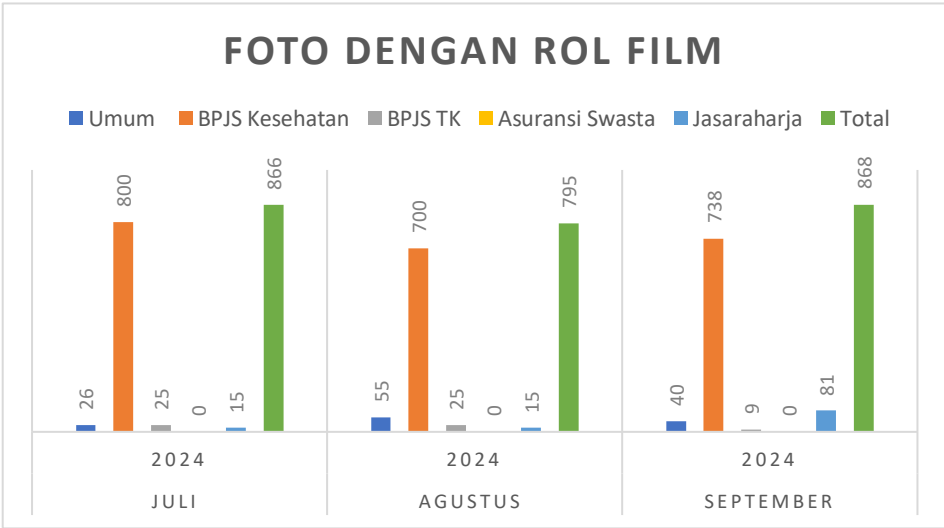
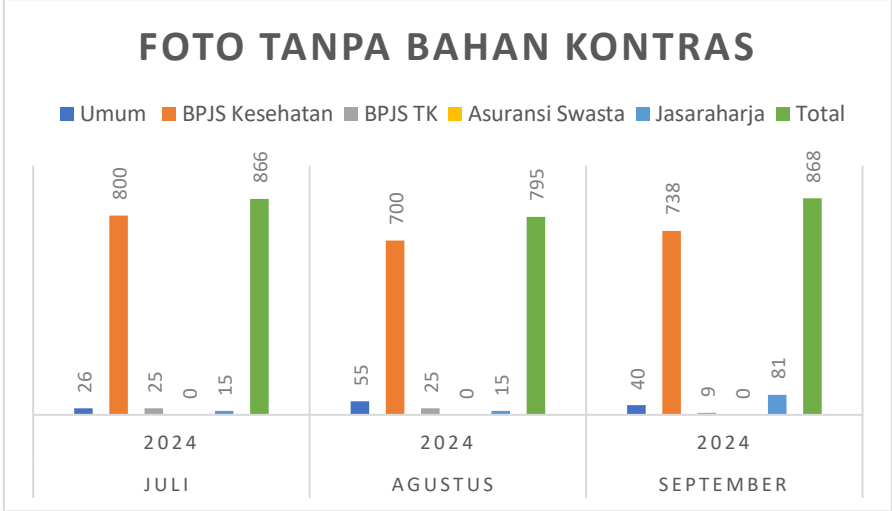
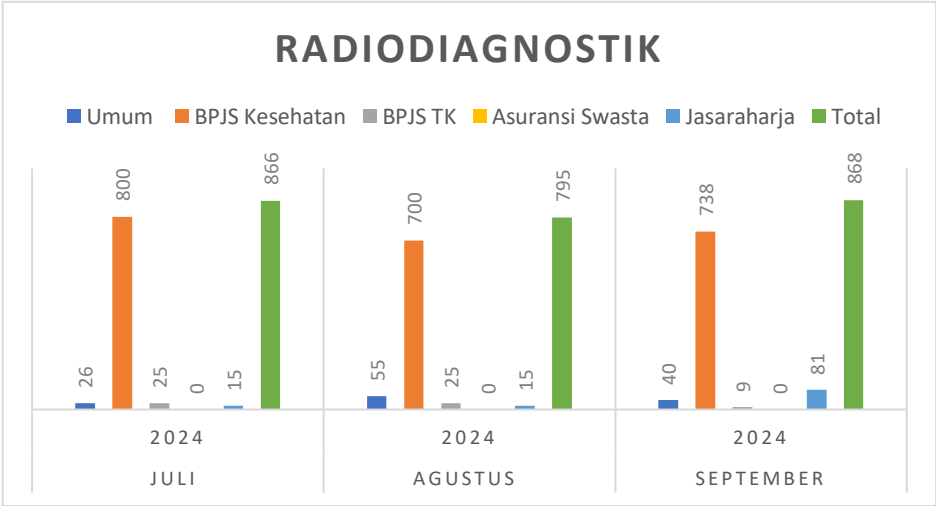
3.1.1 Radiologi

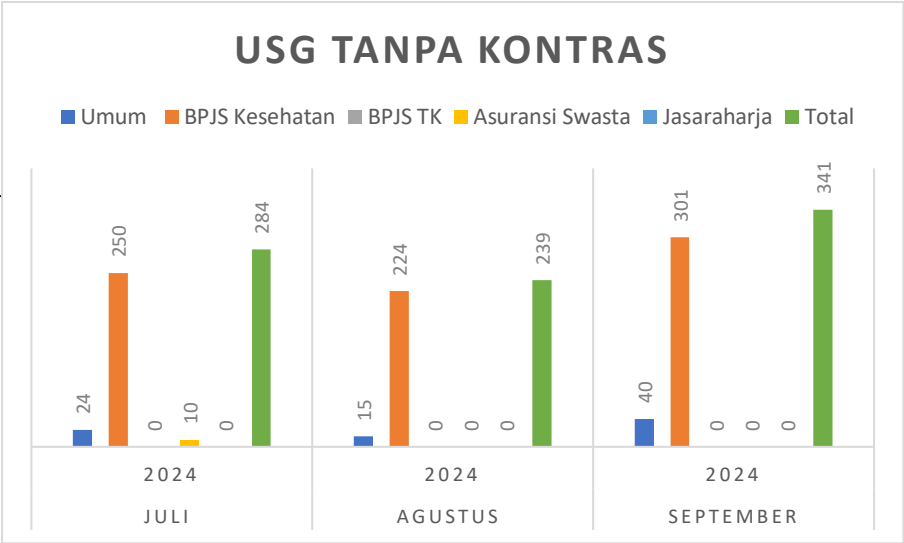
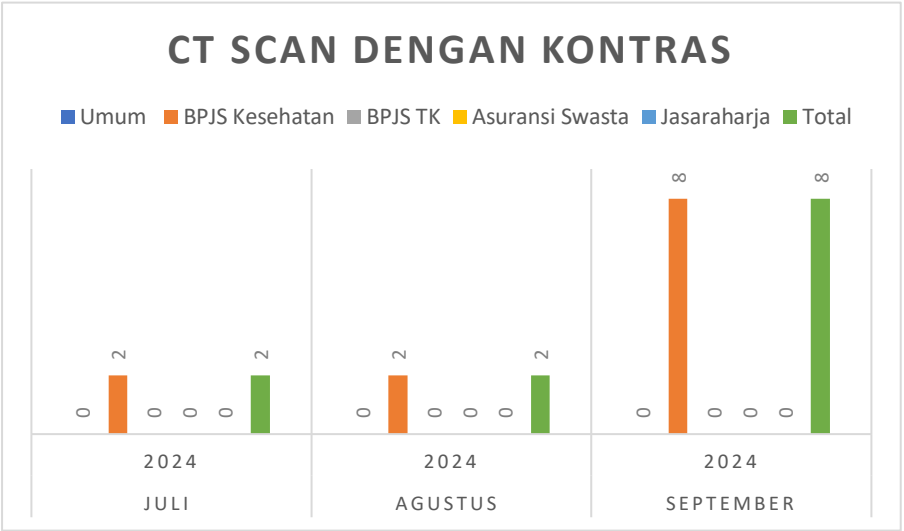
3.1.1.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi Juli-September 2024

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JENIS PEMBAYARAN	JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
1.	Radiodiagnostik	Umum	26	55	40
		BPJS Kesehatan	800	700	738
		BPJS TK	25	25	9
		Asuransi Swasta	0	0	0
		Jasaraharja	15	15	81
TOTAL			866	795	868
2.	Foto Tanpa Bahan Kontras	Umum	26	55	40
		BPJS Kesehatan	800	700	738
		BPJS TK	25	25	9
		Asuransi Swasta	0	0	0
		Jasaraharja	15	15	81
TOTAL			866	795	868

3.	Foto Dengan Rol Film	Umum	26	55	40
		BPJS Kesehatan	800	700	738
		BPJS TK	25	25	9
		Asuransi Swasta	0	0	0
		Jasaraharja	15	15	81
TOTAL			866	795	868
4.	CT Scan Tanpa Kontras	Umum	0	0	4
		BPJS Kesehatan	47	22	118
		BPJS TK	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	0	0
		Jasaraharja	0	0	11
TOTAL			47	22	133
5.	CT Scan Dengan Kontras	Umum	0	0	0
		BPJS Kesehatan	2	2	8
		BPJS TK	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	0	0
		Jasaraharja	0	0	0
TOTAL			2	2	8
6.	USG Tanpa Kontras	Umum	24	15	40
		BPJS Kesehatan	250	224	301
		BPJS TK	0	0	0
		Asuransi Swasta	10	0	0
		Jasaraharja	0	0	0
TOTAL			284	239	341

3.1.1.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi Juli-September 2024





Analisis :

- Pelayanan pemeriksaan dalam 3 bulan terakhir meliputi Radiodiagnostik, USG dan CT Scan, terbagi menjadi pasien UMUM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Swasta dan Jasaraharja.
Pada 3 bulan terakhir pemeriksaan terbanyak, yaitu :
 - Radiodiagnostik : 868
 - USG Tanpa Kontras : 341
 - CT Scan Tanpa Kontras :13
- Pada Bulan September 2024 pemeriksaan CT Scan mengalami peningkatan secara signifikan, hal ini disebabkan karena alat CT Scan yang rusak sudah bisa digunakan kembali mulai tanggal 11 September 2024.
- Terjadi peningkatan pada pemeriksaan USG Tanpa Kontras, sebanyak 341 pasien atau 42%.

Rencana Tindak Lanjut :

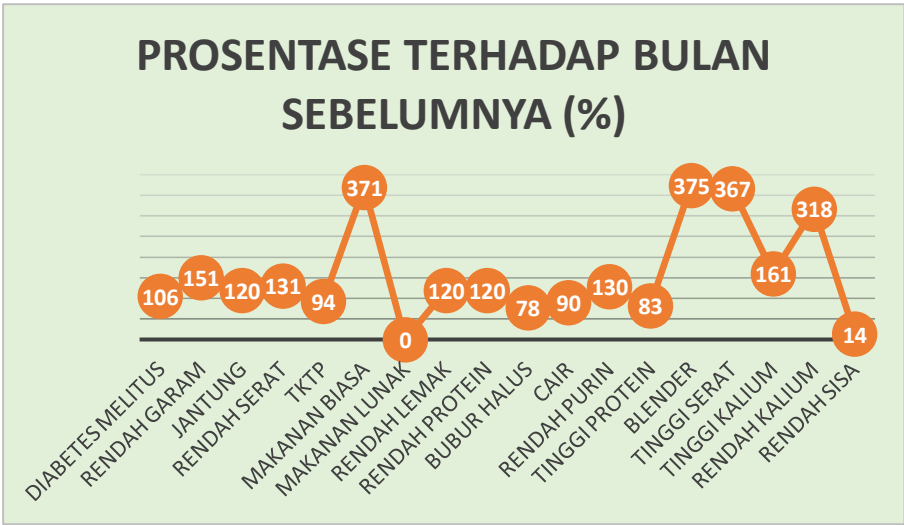
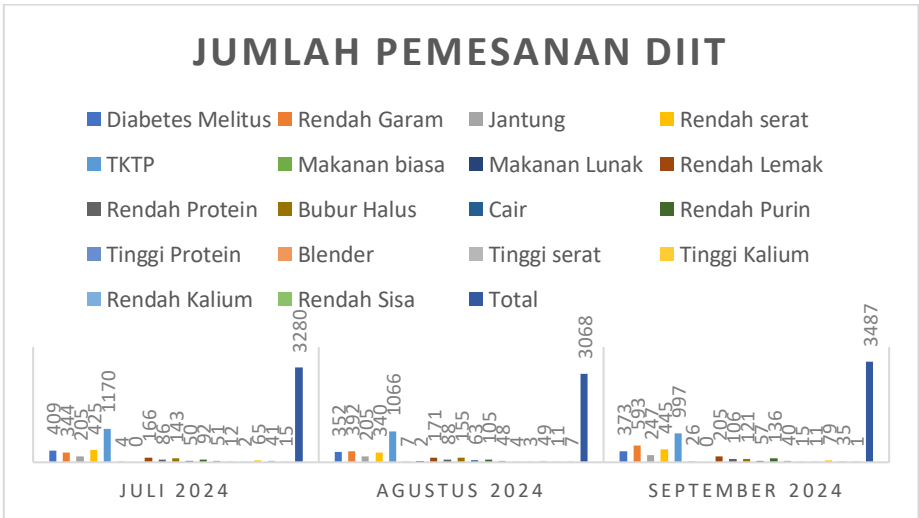
Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk melakukan kerja sama dengan RS yang belum memiliki CT Scan untuk meningkatkan pendapatan.

4.4.5 Gizi

4.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit Juli-September 2024

NO	NAMA DIIT	JUMLAH PESANAN DIIT			PRESENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA (%)
		JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024	
1.	Diabetes Melitus	409	352	373	106
2.	Rendah Garam	344	392	593	151
3.	Jantung	205	205	247	120
4.	Rendah serat	425	340	445	131
5.	TKTP	1170	1066	997	94
6.	Makanan biasa	4	7	26	371
7.	Makanan Lunak	0	2	0	0
8.	Rendah Lemak	166	171	205	120
9.	Rendah Protein	86	88	106	120
10.	Bubur Halus	143	155	121	78
11.	Cair	50	63	57	90
12.	Rendah Purin	92	105	136	130
13.	Tinggi Protein	51	48	40	83
14.	Blender	12	4	15	375
15.	Tinggi serat	2	3	11	367
16.	Tinggi Kalium	65	49	79	161
17.	Rendah Kalium	41	11	35	318
18.	Rendah Sisa	15	7	1	14
TOTAL		3280	3068	3487	114

4.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit Juli-September 2024



Analisis :

Dari grafik jumlah pemesanan diit diatas, jumlah pemesanan meningkat dari bulan sebelumnya. Jenis diit fluktuatif menyesuaikan kebutuhan pasien sesuai dengan advice DPJP dan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pasien rawat inap pada Bulan September 2024.

Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan tidak ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan.

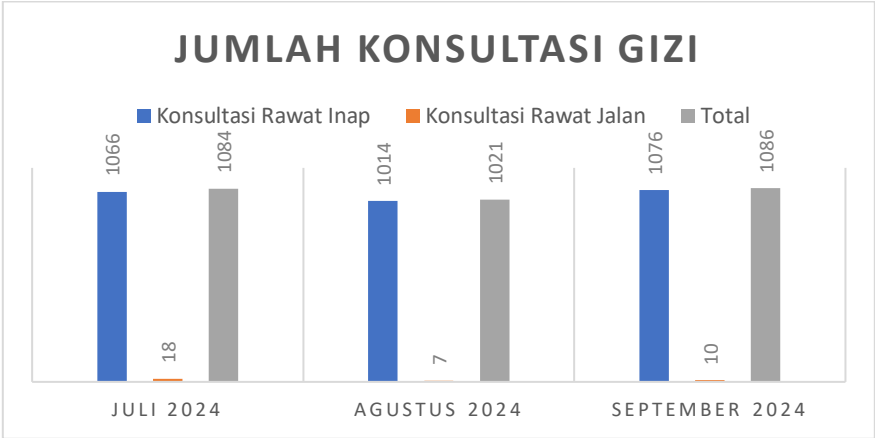
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan.
- 2. Mengajukan pelayanan catering makanan untuk pemulihan pasien saat pulang rawat inap.
- 3. Kolaborasi dengan layanan primantara (pengantaran obat) untuk MCU Gizi gratis sebagai reward.

4.4.5.3 Jumlah Konsultasi Gizi Juli-September 2024

NO	INDIKASI	BULAN		
		JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
1.	Konsultasi Rawat Inap	1066	1014	1076
2.	Konsultasi Rawat Jalan	18	7	10
Total		1061	1084	1021

4.4.5.4 Grafik Jumlah Konsultasi Gizi Juli-September 2024



Analisis :

- 1. Data jumlah konsultasi gizi pada pasien rawat inap terjadi peningkatan, berbanding lurus dengan kenaikan jumlah kunjungan pasien rawat inap.
- 2. Data jumlah konsultasi gizi pada rawat jalan mengalami kenaikan yang tidak signifikan, yaitu 10 pasien.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Koordinasi dengan dokter DPJP agar sering merujuk pasien nya untuk ke poli gizi dan lebih baik lagi jika ada dokter spesialis gizi.
- 2. Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengadakan MCU Gizi.
- 3. Menjalankan Prima Health Meals.
- 4. Kolaborasi dengan layanan primantara (pengantaran obat) untuk MCU Gizi gratis sebagai reward dan menarik pasien supaya bisa merasakan layanan MCU Gizi terlebih dulu.

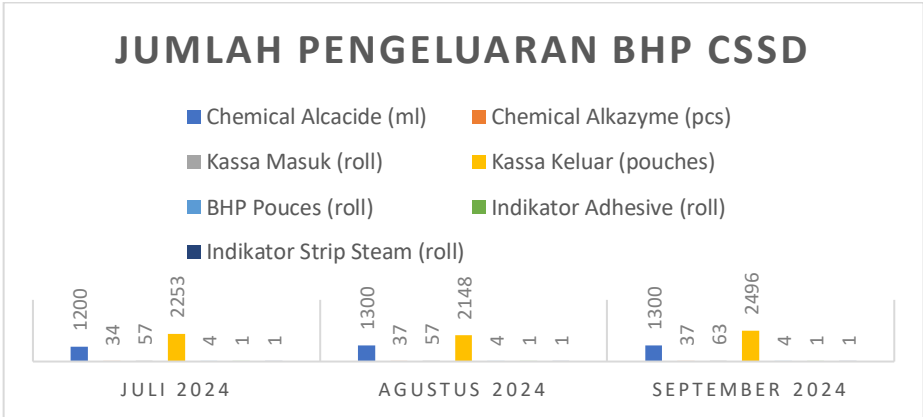
4.4.6 CSSD – Laundry

4.4.6.1 CSSD

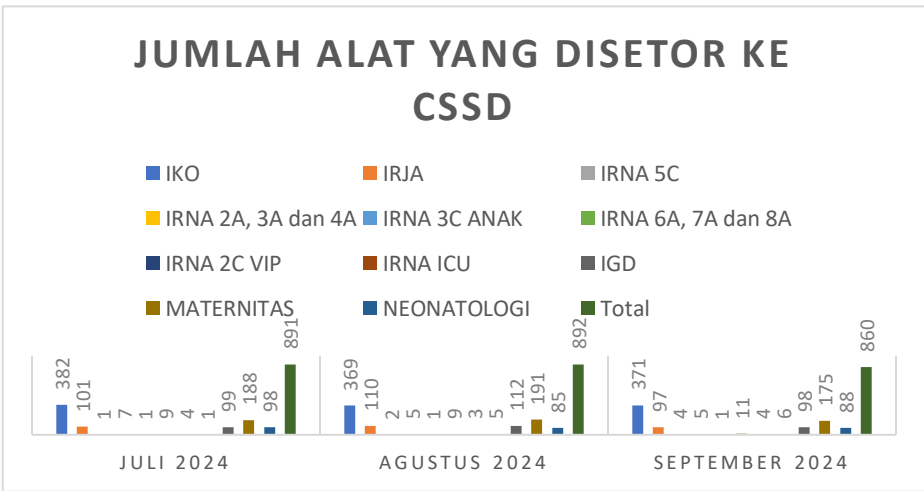
4.4.6.1.1 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSSD di Bulan Juli-September 2024

NO	HAL	BULAN		
		JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
BHP				
1.	Chemical Alcacide (ml)	1200	1300	1300
2.	Chemical Alkazyme (pcs)	34	37	37
3.	Kassa Masuk (roll)	57	57	63
4.	Kassa Keluar (pouches)	2253	2148	2496
5.	BHP Pouces (roll)	4	4	4
6.	Indikator Adhesive (roll)	1	1	1
7.	Indikator Strip Steam (roll)	1	1	1
Alat yang disetor (set)				
8.	IKO	382	369	371
9.	IRJA	101	110	97
10.	IRNA 5C	1	2	4
11.	IRNA 2A, 3A dan 4A	7	5	5
12.	IRNA 3C ANAK	1	1	1
13.	IRNA 6A, 7A dan 8A	9	9	11
14.	IRNA 2C VIP	4	3	4
15.	IRNA ICU	1	5	6
16.	IGD	99	112	98
17.	MATERNITAS	188	191	175
18.	NEONATOLOGI	98	85	88
Jumlah		891	892	860

4.4.6.1.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai CSSD di Bulan Juli-September 2024



4.4.6.1.3 Grafik Jumlah Alat Yang disetor ke CSSD di Bulan Juli - September 2024



Analisis :

- 1. Jumlah alat yang disterilisasi paling banyak dari Unit IKO dengan jumlah setor alat dalam 3 bulan terakhir yaitu sejumlah 1.122 set, diikuti dari Unit Maternitas 554 set dan IGD 309 set. Dimana dari ketiga unit tersebut paling sering melakukan tindakan.
- 2. Dengan perbaikan pencatatan menggunakan google spreadsheet data yang diambil valid, namun penggolongan kategori alat tidak seragam, seperti gunting talpus terhitung 1 alat dan set partus juga terhitung 1 alat.
- 3. Terjadi peningkatan penggunaan alat di IKO, karena operasi bedah saraf sudah mulai berjalan, dan instrument alat lebih banyak dari operasi lainnya.
- 4. Terjadi peningkatan produktifitas kinerja dalam pembuatan kasa steril, hal ini disebabkan adanya tambahan petugas (perbantuan) dari perawat ruangan.

Rencana Tindak Lanjut :

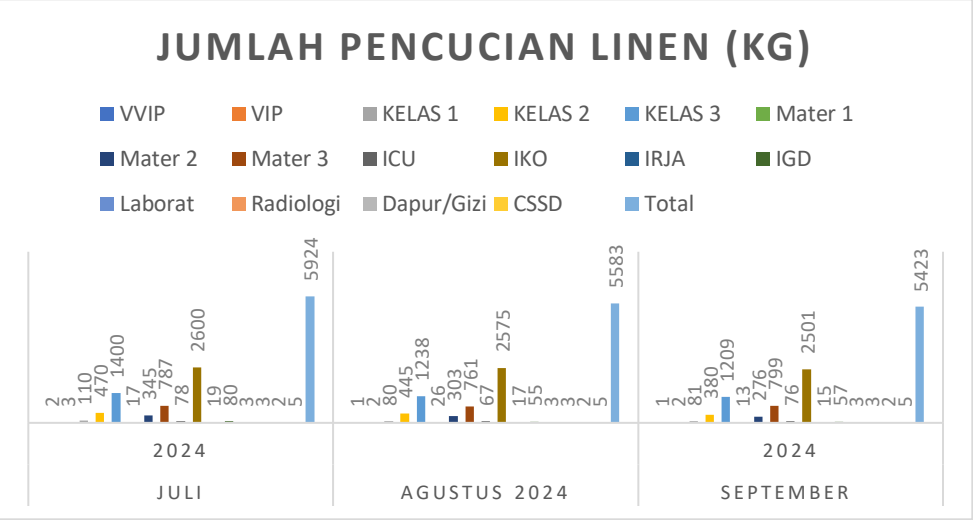
- 1. Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor per bulan dengan kesepakatan alat yang dihitung.
- 2. Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.
- 3. Monitoring dan Evaluasi pencatatan digital.

4.4.6.2 Laundry

4.4.6.2.1 Tabel Jumlah Pencucian Linen di Laundry Bulan Juli-September 2024

NO	ASAL UNIT	JUMLAH PER BULAN (KG)		
		JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
1.	VVIP	2	1	1
2.	VIP	3	2	2
3.	KELAS 1	110	80	81
4.	KELAS 2	470	445	380
5.	KELAS 3	1400	1238	1209
6.	Mater 1	17	26	13
7.	Mater 2	345	303	276
8.	Mater 3	787	761	799
9.	ICU	78	67	76
10.	IKO	2600	2575	2501
11.	IRJA	19	17	15
12.	IGD	80	55	57
13.	Laborat	3	3	3
14.	Radiologi	3	3	3
15.	Dapur/Gizi	2	2	2
16.	CSSD	5	5	5
TOTAL		5924	5583	5423

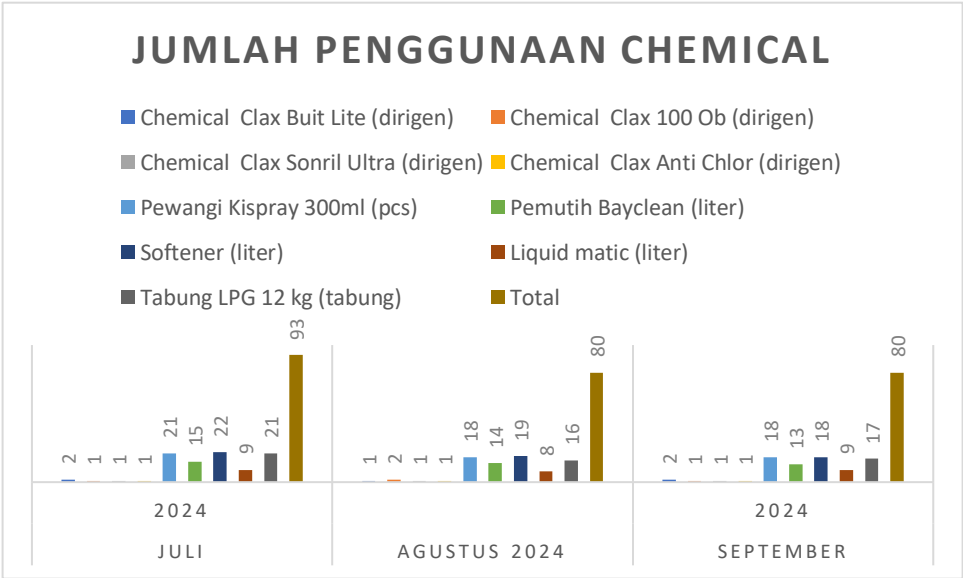
4.4.6.2.2 Grafik Jumlah Pencucian Linen di Laundry Bulan Juli-September 2024



4.4.6.2.3 Jumlah Penggunaan Chemical Laundry Bulan Juli-September 2024

NO	ASAL UNIT	JUMLAH PER BULAN		
		JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
1.	Chemical Clax Buit Lite (dirigen)	2	1	2
2.	Chemical Clax 100 Ob (dirigen)	1	2	1
3.	Chemical Clax Sonril Ultra (dirigen)	1	1	1
4.	Chemical Clax Anti Chlor (dirigen)	1	1	1
5.	Pewangi Kispray 300ml (pcs)	21	18	18
6.	Pemutih Bayclean (liter)	15	14	13
7.	Softener (liter)	22	19	18
8.	Liquid matic (liter)	9	8	9
9.	Tabung LPG 12 kg (tabung)	21	16	17
TOTAL		93	80	80

4.4.6.2.4 Grafik Jumlah Penggunaan Chemical Laundry Juli - September 2024



Analisa :

- 1. Terdapat penurunan jumlah pencucian linen tetapi tidak signifikan dari bulan sebelumnya yaitu sebanyak 160kg, tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat inap, tetapi sebanding dengan penggunaan chemical yang tidak mengalami penurunan.
- 2. Pada Bulan September 2024, sudah tidak ditemukan benda asing didalam linen kotor dari

- ruang perawatan, sehingga menjadi salah satu penyebab berkurangnya berat linen kotor yang diterima.
- Pencatatan penimbangan linen menggunakan timbangan beras masih manual, resiko angka tidak terbaca dengan baik, sehingga jumlah yang dihasilkan kurang valid.

Rencana Tindak Lanjut :

- Rencana akan dilakukan permintaan linen bersih menggunakan digital form per unit, dilakukan pendistribusian sehari 2 kali untuk memenuhi kebutuhan unit sesuai dengan permintaan.
- Rencana akan dilakukan pencatatan menggunakan google spreadsheet per hari nya.
- Rencana akan dilakukan stok opname setiap bulan.

4.5 Kinerja Umum dan Keuangan

4.5.5 SDM

3.5.1.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	0	1	0
2	Kabid Pelayanan Medis	Dokter Umum	1	1	0	1	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
7	Dokter Ruangan	Dokter Umum	1	1	0	1	0
8	Farmasi	S1 Apoteker	43	14	0	14	0
		S1 Farmasi		4	0	4	0
		S1 Analis Farmasi		1	0	1	0
		D3 Farmasi		16	4	12	0
		SMK		7	0	7	0
		S1 Akuntansi		1	0	1	0
9	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	11	1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	0	8	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		1	1	0	0
10	CSSD	D3 Keperawatan	5	2	1	1	0
		D3 Farmasi		1	0	1	0
		SMK		2	1	1	0
11	Fisioterapi	D3 Fisioterapi	5	4	1	2	1
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	1
12	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	0	2	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	0	2	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		2	2	0	0
13	Humas & Marketing	Profesi Ners	2	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	0	1	0

14	ICU dan HCU	Profesi Ners	11	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		7	0	7	0
15	IGD	Profesi Ners	26	11	1	10	0
		D3 Keperawatan		10	0	10	0
		D4 Kebidanan		3	0	3	0
		D3 Kebidanan		2	0	2	0
16	IKO	Profesi Ners	12	7	2	5	0
		D3 Keperawatan		4	1	3	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
17	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
18	IPSRs	S1 Teknik Elektro	6	1	0	1	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	0	1	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	0	3	0
19	IRJA	Profesi Ners	27	6	3	3	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		16	6	10	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
20	IRNA 2C	Profesi Ners	7	4	1	3	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		2	0	2	0
21	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	20	16	1	15	0
		D3 Keperawatan		4	0	4	0
22	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	16	6	0	6	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		8	0	8	0
		D3 Kebidanan		1	0	1	0
23	IRNA 5C Anak	Profesi Ners	9	2	0	2	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		6	0	6	0
24	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	24	8	0	8	0
		D4 Keperawatan		4	0	4	0
		D3 Keperawatan		12	0	12	0
25	Maternitas	Profesi Kebidanan	12	2	0	2	0
		D4 Kebidanan		2	0	2	0
		D3 Kebidanan		8	0	8	0
26	Neonatologi	Profesi Ners	8	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	1	4	0
		D3 Kebidanan		1	0	1	0
27	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	3	3	0	0
		S1 Akuntansi		2	1	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		3	3	0	0
		SMA		1	0	1	0
28	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	10	2	0	2	0
		D3 Analisis Kesehatan		8	0	8	0
29	Laundry	SMK	5	1	0	1	0
		SMA		3	0	3	0

		SMP		1	0	1	0
30	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	10	10	4	6	0
31	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	18	1	1	0	0
		S1 Ilmu Sosial		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	0	1	0
		D4 Destinasi Wisata		1	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	2	4	0
		SMK		5	0	5	0
		SMA		1	1	0	0
32	PIPP & MPP	Profesi Ners	6	2	1	1	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		2	1	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
33	PMKP	Profesi Ners	1	1	0	1	0
34	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	0	7	0
35	SDM	S1 Psikologi	2	2	0	2	0
36	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	0	1	0
37	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	0	3	0
38	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
39	Cleaning Service	SMK	45	25	5	20	0
		SMA		15	0	15	0
40	Security	SMK	12	7	4	3	0
		SMA		5	2	3	0
41	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	0	1	0
		SMA		2	0	2	0
		SMP		2	0	2	0
42	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
43	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
44	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
45	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
46	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
47	Dokter Spesialis Bedah Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan	Pendidikan Dokter	3	3	0	3	0

	Pembuluh Darah	Spesialis					
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
66	Dokter Umum	Pendidikan Profesi Dokter	8	8	1	7	0
Total			470				

Keterangan :
 Pada bulan September terdapat penggantian di unit Cleaning Service 1 orang, penggantian Dokter Spesialis Anestesi 1 orang.

3.5.1.2 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGAN	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi
2	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1		Posting informasi lowongan pekerjaan ke LinkedIn RS Prima Husada Malang
3	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1	0	1		
4	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1		Dibutuhkan yang perempuan

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

NO	TANGGAL	JENIS ORIENTASI	NAMA STAF	PENDIDIKAN	PROFESI	SPMJ (TANGGAL MASUK)	KETERANGAN
1	17 September 2024	Orientasi Khusus	Irwindi Neila Fitria, S.Tr.Kes	D4 Terapi Wicara	Terapis Wicara	17 September 2024	-

Keterangan : Pada bulan September 2024 terdapat orientasi khusus staf baru

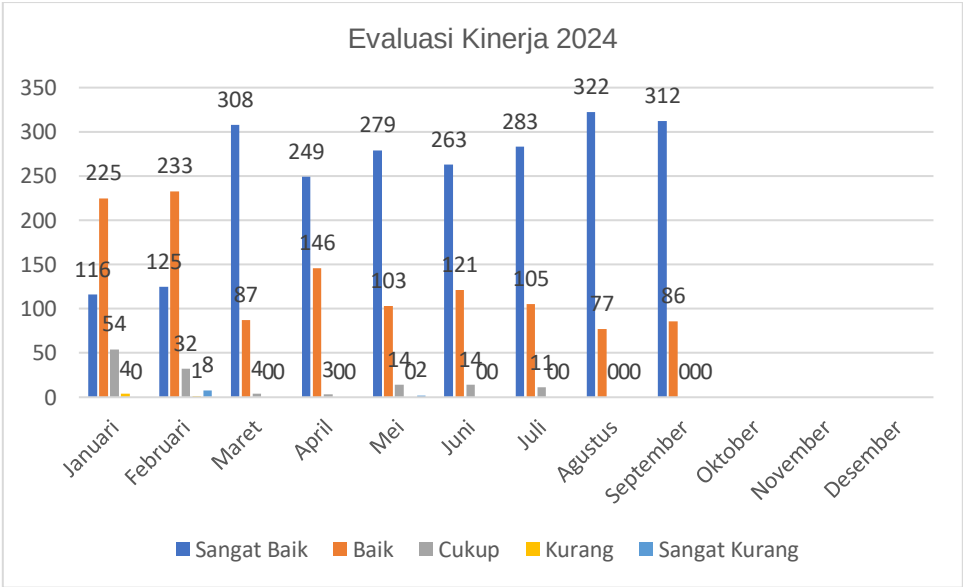
3.5.1.4 Diklat

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	JENIS DIKLAT	JUDUL DIKLAT	SASARAN	KETERANGAN	RTL
1	06 September 2024	Inhouse Training	Pelatihan Hipnoterapi PT Disa Prima Medika	SDM, Kabid Keperawatan, Karu Rawat Inap, Komite Mutu, Komite PPI	Undangan dihadiri oleh 14 karyawan dari RS PHM	Arahan dari pemateri untuk mempraktikkan kepada pasien
2	14 September 2024	Inhouse Training	Pelatihan Hipnoterapi PT Disa Prima Medika	SDM, Kabid Keperawatan, Karu Rawat Inap, Komite Mutu, Komite PPI	Undangan dihadiri oleh 10 karyawan	Arahan dari pemateri untuk mempraktikkan kepada pasien
3	06 September 2024	Internal	Sosialisasi Aplikasi Deteksi Dini Jantung Cepat dan Akurat (DETA C)	Seluruh staf RS PHM	Sosialisasi disampaikan oleh dr. Miryanti Cahyanityas, Sp.JP	Seluruh karyawan diarahkan untuk menginstal aplikasi DETAK C
4	11 September 2024	Internal	Inhouse Training TBC	PJ TBC tiap unit pelayanan dan keperawatan	Sosialisasi disampaikan oleh dr. Fiona Paramitha, Sp.A	Diharap perawat bisa memahami dan menerapkan ilmu terkait pencegahan TBC pada anak
5	12 September 2024	Internal	Inhouse Training TBC	PJ TBC tiap unit pelayanan dan keperawatan	Sosialisasi disampaikan oleh dr. Yunita, Sp.P dan dr. Zoraida Dwi Wahyuni, Sp.PD	Diharap perawat bisa memahami dan menerapkan ilmu terkait pencegahan dan penanganan TBC pada pasien
6	24 September 2024	Internal	Drill Emergency Maternal & Neonatal	Bidan RS PHM	Diklat dilaksanakan secara roleplay	Diharap bidan RS PHM dapat menerapkan yang telah dipraktikkan dengan baik kepada masien
7	20 September 2024	Inhouse Training	Refreshment Training Management Stres	Seluruh direksi dan manajerial RS	Diklat dihandle oleh PT DPM	-
8	24 September 2024	Demo Produk	Pelatihan Pemasangan Infus	Perawat PJ Unit	Pelaksanaan pelatihan tidak sesuai dengan yang diinformasikan oleh PT DPM.	Demo produk dihadiri oleh Kabid Penunjang dan Kains Farmasi untuk dipertimbangkan dan dievaluasi.
9	23 September 2024	Inhouse Training	Sosialisasi Penggunaan Salbutamol Sebagai Bronkolidator	Perawat PJ Unit	Diklat dihadiri oleh perawat PJ Unit	Diharapkan perawat pelaksanan memahami penggunaan salbutamol dengan tepat

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

NO	KATEGORI	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1	Sangat Baik	116	125	308	249	279	263	283	322	312
2	Baik	225	233	87	146	103	121	105	77	86
3	Cukup	54	32	4	3	14	14	11	0	0
4	Kurang	4	1	0	0	0	0	0	0	0
5	Sangat Kurang	0	8	0	0	2	0	0	0	0

3.5.1.5.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



Analisis :

Penurunan pada kategori “sangat baik”, dari bulan sebelumnya sebesar 10 orang namun masih diatas rata-rata dan nominal kategori “cukup”, “kurang”, “sangat kurang” adalah 0

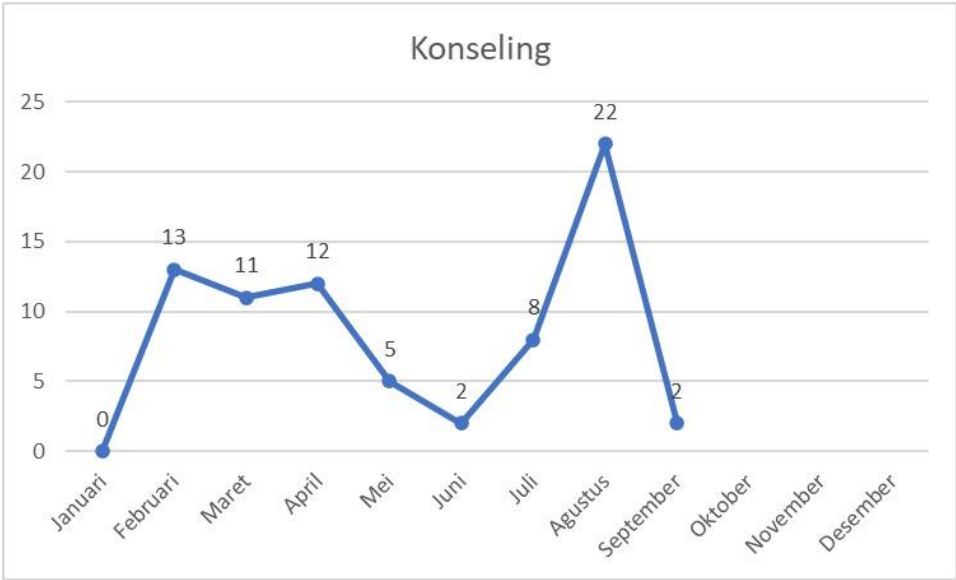
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
- 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
- 3. Mempertahankan staf yang masih terlambat

3.5.1.6 Konseling

3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling Perbulan Tahun 2024

NO	JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPETMBER
1	Konseling	0	13	11	12	5	2	8	20	2



Analisis :
2 konseling adalah tentang kontrak N-ED.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

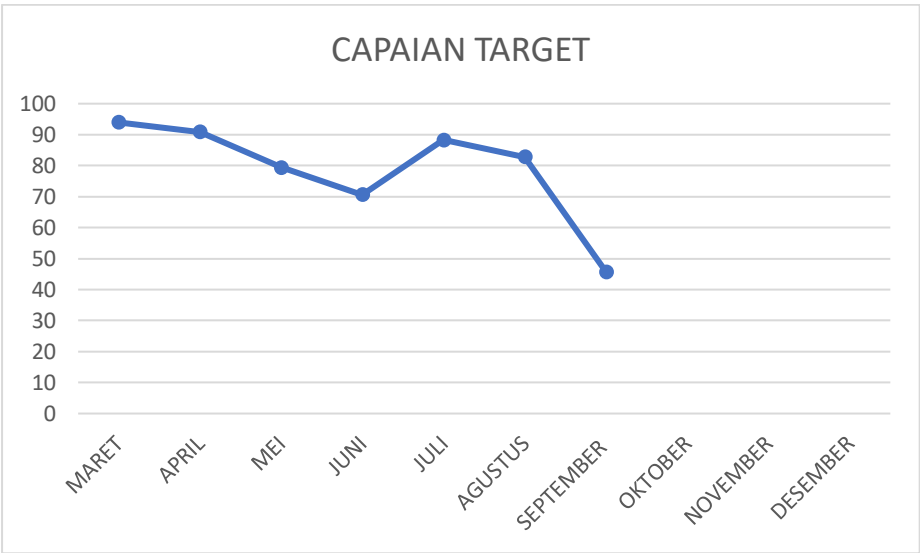
3.5.2 MFK dan K3RS

3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintenance Alat Medis

NO	KET	TARGET	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP
1	Capaian Maintenance	90%	93,94	90,91	79.41	70.59	88.24	82.85	45,71%



Analisis :
Beberapa faktor yang menyebabkan fluktuatif antara lain : alat medis masih dipakai oleh pasien, ruangan atau unit masih ada tindakan pasien, perbantuan perbaikan alat medis klinik Mutiara sehat. Pada bulan September 2024 terdapat

agenda kalibrasi tahunan sebanyak 290 alat sehingga capaian atem mengalami penurunan karena adanya pendampingan. Namun saat kalibrasi juga di observasi ada atau tidaknya kerusakan/ketidaksesuaian alat medis.

Rencana Tindak Lanjut :
Koordinasi dengan PT untuk ATEM sesuai ABK

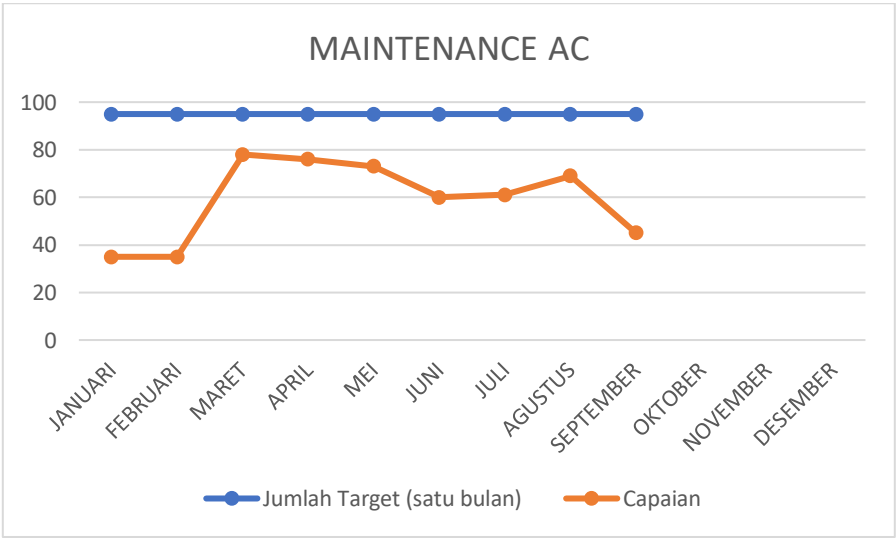
3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.5.2.2.1 Air Conditioner

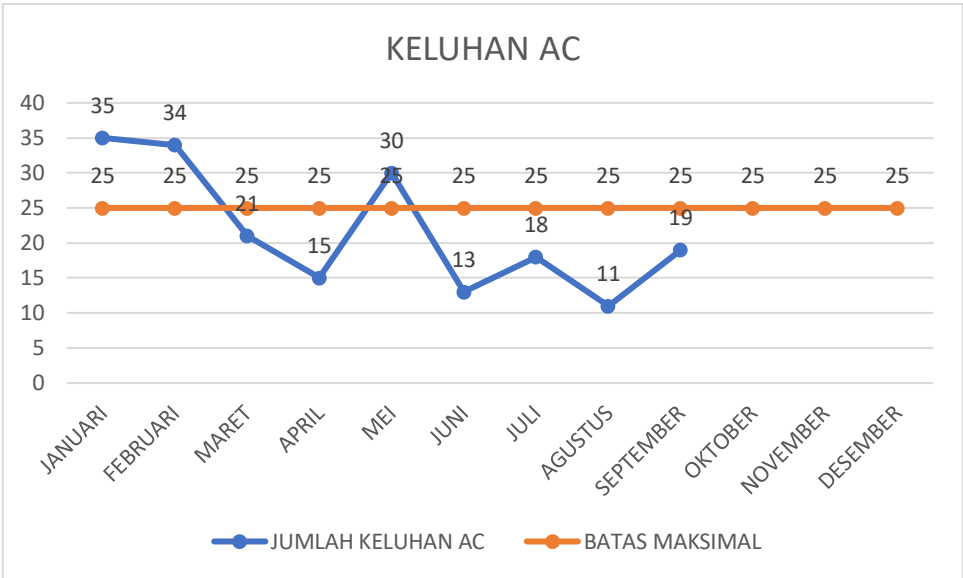
3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	JANUARI	95	54	57%	BELUM MENCAPAI TARGET
2	FEBRUARI	95	69	73%	BELUM MENCAPAI TARGET
3	MARET	95	94	99%	BELUM MENCAPAI TARGET
4	APRIL	95	61	64%	BELUM MENCAPAI TARGET
5	MEI	95	94	99%	BELUM MENCAPAI TARGET
6	JUNI	95	89	94%	BELUM MENCAPAI TARGET
7	JULI	95	60	63%	BELUM MENCAPAI TARGET
8	AGUSTUS	95	69	72%	BELUM MENCAPAI TARGET
9	SEPTEMBER	95	45	47%	BELUM MENCAPAI TARGET

3.5.2.2.1.2 Grafik Target Capaian Maintanance AC



3.5.2.2.1.3 Grafik Keluhan AC Split dari Unit



Analisis :
Pada bulan ini berada pada angka 19 laporan keluhan, masih dibawah batas maksimal yaitu 25 keluhan, sehingga progress bulan ini mengalami penurunan sehingga perlu perhatian pada bulan Oktober agar grafik tidak meningkat.

Beberapa penyebab yang mengakibatkan target maintenance masih tidak tercapai :

- 1. Adanya tugas insidental diluar jadwal IPSRS RSPHM
- 2. AC ruangan masih terdapat pasien / dalam pemakaian

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Monitoring dan evaluasi terutama terkait sistem pencatatan dan target perbulan.
- 2. Pembuatan aplikasi local IPSRS sebagai reminder

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
7	Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
8	Agustus	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
9	September	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :
Pada bulan ini, pemeliharaan genset dilakukan 4x dan sudah terlapor dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.5.2.2.4.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	3x/bulan	2x/bulan	67%	Sudah mencapai target
4	April	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
7	Juli	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
8	Agustus	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
9	September	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :

Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D dilakukan 3x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target. Berdasarkan hasil supervise, petugas sudah berkeliling dan melakukan dokumentasi.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen

1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

September 2024							
Tanggal	Stok Liquid	Sebelum pengisian	Penggunaan	Satuan	keterangan	pengiriman	
01/09/2024	1368	1134	234	MMHG			
02/09/2024	1134	927	207	MMHG	Sebelum pengisian		
02/09/2024	927	2660		MMHG	Sesudah pengisian	1733	
03/09/2024	2660	2540	120	MMHG			
04/09/2024	2540	2325	215	MMHG			
05/09/2024	2325	1945	380	MMHG			
06/09/2024	1945	1630	315	MMHG			
07/09/2024	1630	1373	257	MMHG			
08/09/2024	1373	1222	151	MMHG			
09/09/2024	1222	1015	207	MMHG			
10/09/2024	1015	704	311	MMHG	Sebelum pengisian		
10/09/2024	704	2271		MMHG	Sesudah pengisian	1567	
11/09/2024	2271	2165	106	MMHG			
12/09/2024	2165	1963	202	MMHG			
13/09/2024	1963	1586	377	MMHG	Sebelum pengisian		
13/09/2024	1586	3200		MMHG	Sesudah pengisian	1614	
14/09/2024	3200	3056	144	MMHG			
15/09/2024	3056	2913	143	MMHG			
16/09/2024	2913	2756	157	MMHG			
17/09/2024	2756	2468	288	MMHG			
18/09/2024	2468	2309	159	MMHG			
19/09/2024	2309	2103	206	MMHG			

20/09/2024	2103	1890	213	MMHG			
21/09/2024	1890	1506	384	MMHG			
22/09/2024	1506	1306	200	MMHG			
23/09/2024	1306	1134	172	MMHG	Sebelum pengisian		
23/09/2024	1134	2758		MMHG	Sesudah pengisian	1624	
24/09/2024	2758	2650	108	MMHG			
25/09/2024	2650	2496	154	MMHG			
26/09/2024	2496	2263	233	MMHG			
27/09/2024	2263	1954	309	MMHG	Sebelum pengisian		
27/09/2024	1954	3369		MMHG	Sesudah pengisian	1415	
28/09/2024	3369	3071	298	MMHG			
29/09/2024	3071	2940	131	MMHG			
30/09/2024	2940	2724	216	MMHG			
			0	MMHG			
Jumlah total pemakaian oksigen bulan ini			6156	MMHG			
Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini						7953	MMHG
Rata-rata penggunaan oksigen per hari			410,4	MMHG			
Rata- rata pengisian liquid per bulan ini						2651	MMHG

Analisis :
 Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL
 1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP
1	Pemeliharaan IPAL	1x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
 Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.7 Filter Air

3.5.2.2.7.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT
1	Pemeliharaan filter air	2x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.8 Lift

1.5.2.2.8.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP
1	Pemeliharaan lift	2x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.9 UPS

1.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP
1	Pemeliharaan UPS	2x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

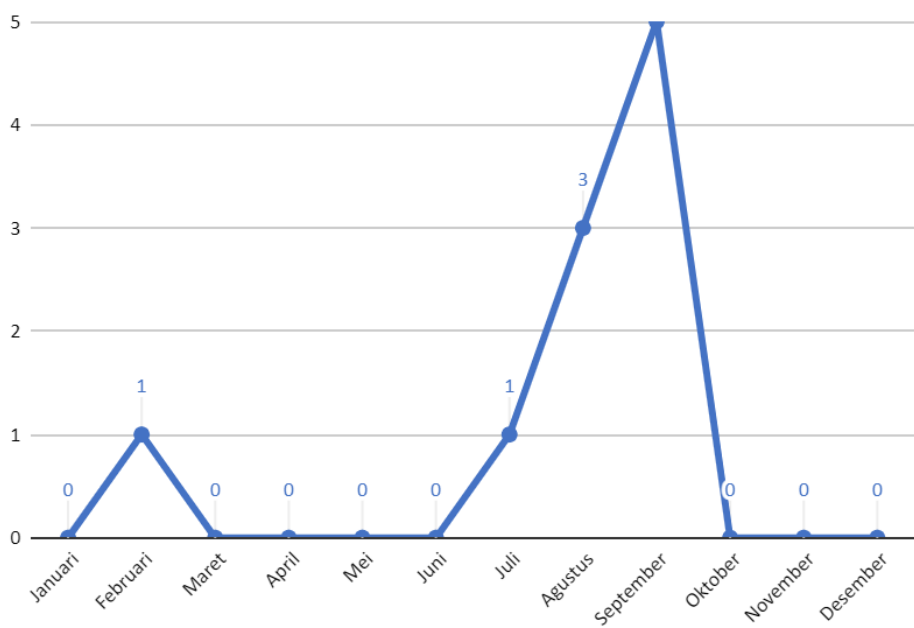
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.3 Security

3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP
1.	Angka kejadian kehilangan barang	0	0	0	0	0	0	1	1	0

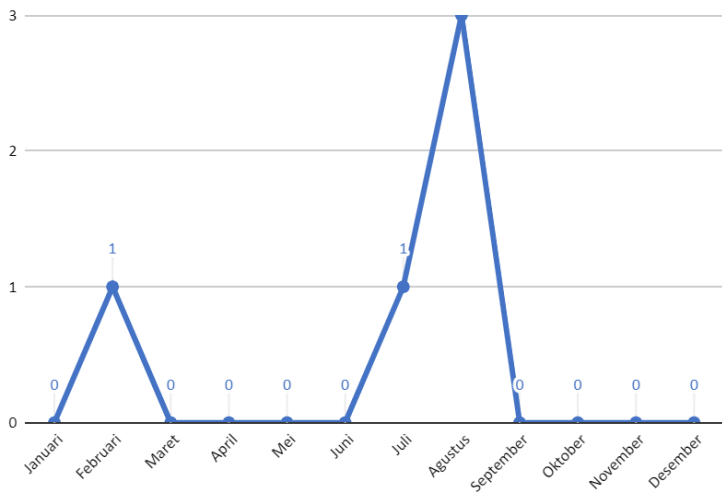
3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



3.5.3.3 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP
1	Angka kejadian kehilangan barang	0	1	0	0	0	0	1	3	5

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



Analisis :

Barang hilang sudah dikembalikan ke pemilik. Alur berjalan baik. Pencatatan telah dilakukan dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

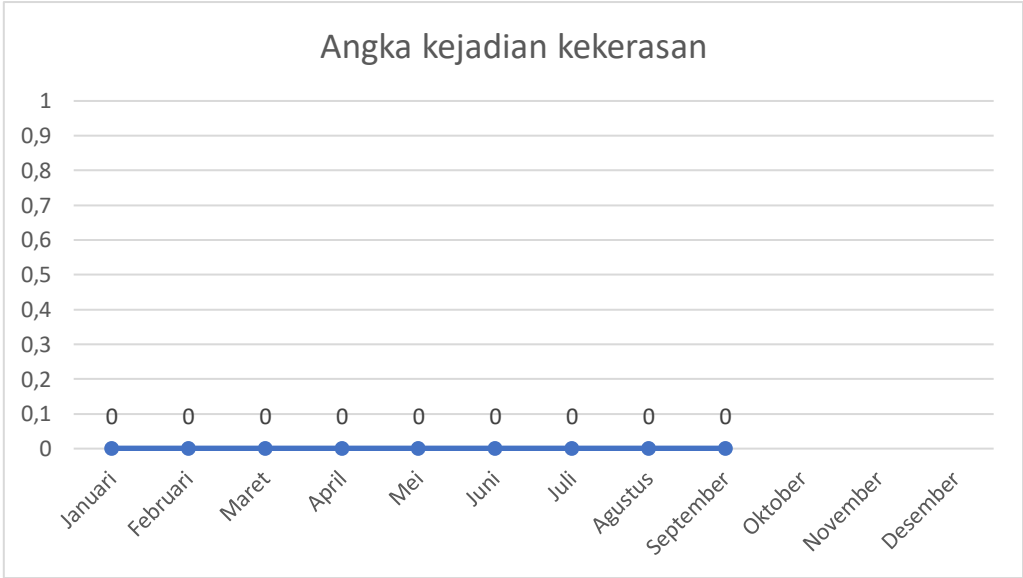
ANGKA KEJADIAN BARANG BERPOTENSI HILANG		
TANGGAL	KETERANGAN	RTL
04 – 09 – 2024	Ditemukan dompet berisi identitas pasien warna hitam di bawa tulisan pos dpm	telah di kondisikan oleh pemilik

17 – 09 – 2024	Ditemukan kunci mobil di loket kasir terkondisikan di pos IGD	telah di kondisikan oleh pemilik
20 – 09 – 2024	Telah ditemukan stnk & bpjs milik pasien terkondisikan di pos IGD	telah di kondisikan oleh pemilik
25 – 09 – 2024	Telah ditemukan hp milik pasien di area pos poli terkondisikan di pos IGD	telah di kondisikan oleh pemilik
28 – 09 – 2024	Telah di temukan dompet di depan kasir atas nama Firda Ratna Safitri dompet di pos IGD	telah di kondisikan oleh pemilik

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan

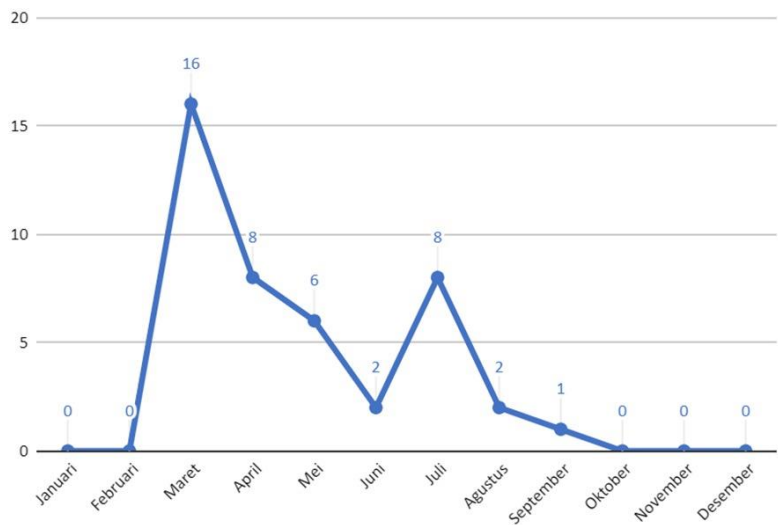


Analisis :
 Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusakan.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

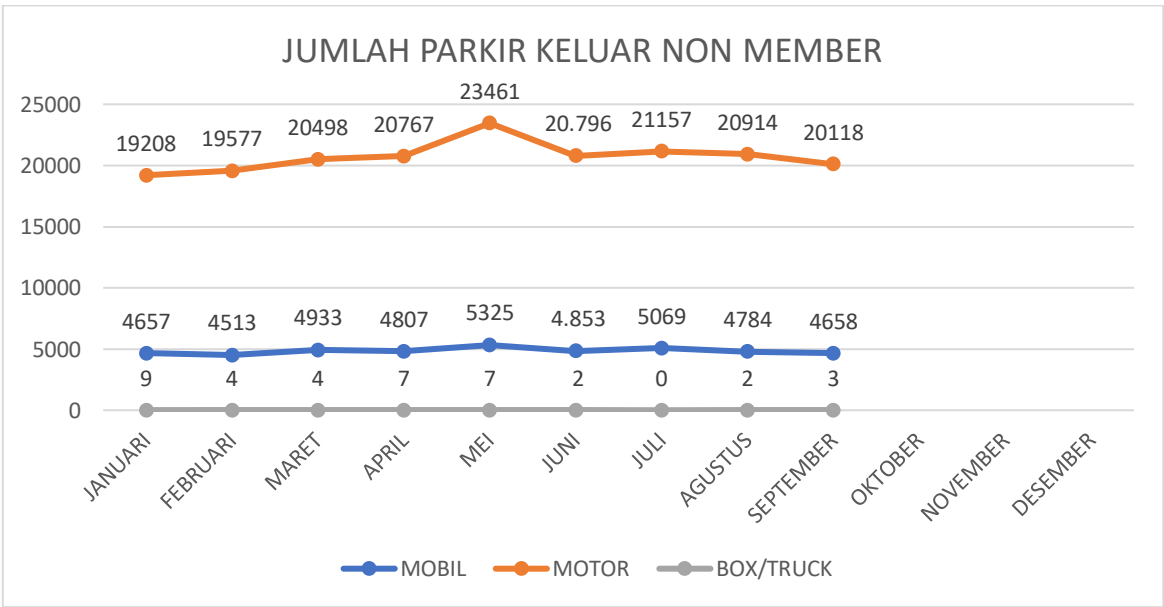
NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	Tidak tercatat	Tidak tercatat	16	8	6	2	8	2	1



- Analisis :**
- Angka kejadian merokok mengalami kenaikan pada bulan ini. Beberapa faktor yang mengakibatkan:
1. Karakter pasien berbeda-beda setiap bulannya
 2. Tanda dilarang merokok tidak terlihat dengan baik
 3. Ruang dibelakang Samator menjadi tempat yang tertutup untuk istirahat dan merokok

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.4 Parkir
3.5.4.1 Grafik Jumlah Parkir Keluar Non Member



- Analisis :**
- Penurunan jumlah parkir di Bulan September diakibatkan adanya penurunan jumlah pasien di rawat jalan
- Rencana Tindak Lanjut :**
Monitoring dan evaluasi

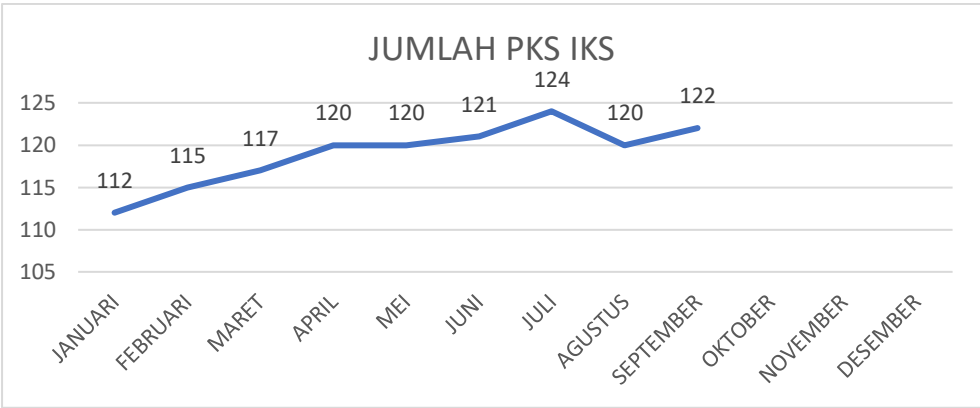
3.5.5 Humas Marketing

3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

3.5.5.1.1 Tabel Jumlah PKS-IKS Aktif

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP
1	Jumlah PKS IKS AKTIF	112	115	117	120	120	121	124	120	122

3.5.5.1.2 Grafik Jumlah PKS – IKS



3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru Bulan September 2024

NO	NAMA PKS	PROGRES PENGURUSAN	KENDALA
1	PT Pesta Pora Abadi	Review pihak kedua	-
2	PT Tentrem Sejahtera	Review pihak kedua	-
3	PT Ustegra	Review pihak kedua	-
4	PT Randi Cones Indonesia	Review pihak kedua	-
5	PT Kharisma Selaras	Review pihak kedua	-
6	RS Universitas Brawijaya	Review ulang oleh RSUB	Ada beberapa notice terkait kesepakatan
7	PT New Minatex	Review pihak kedua	-
8	CV Barokah Plywood	Review Pihak Kedua	-
9	PT Indostar Building Material	Review Pihak kedua	-
10	PT Enak Jaya Makmur (Enak Eco)	Review Pihak kedua	-
11	PT Indonusa Algaemas Prima	Review Pihak Kedua	-
12	PT Duta Kharisma Sentosa	Review Pihak Kedua	-
13	PT Mahadaya Karya Sentosa	Review Pihak Kedua	-
14	PT Bangun Sarana Wreksa	Review Pihak Kedua	-
15	Rajawali Plastik	Review Pihak Kedua	-
16	PT Indonesian Tobacco	Review Pihak Kedua	-

Analisis :

- 1. Pada bulan September, PKS baru dengan instansi lain masih dalam progress
- 2. MOU masih dalam tahap review oleh pihak kedua

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua

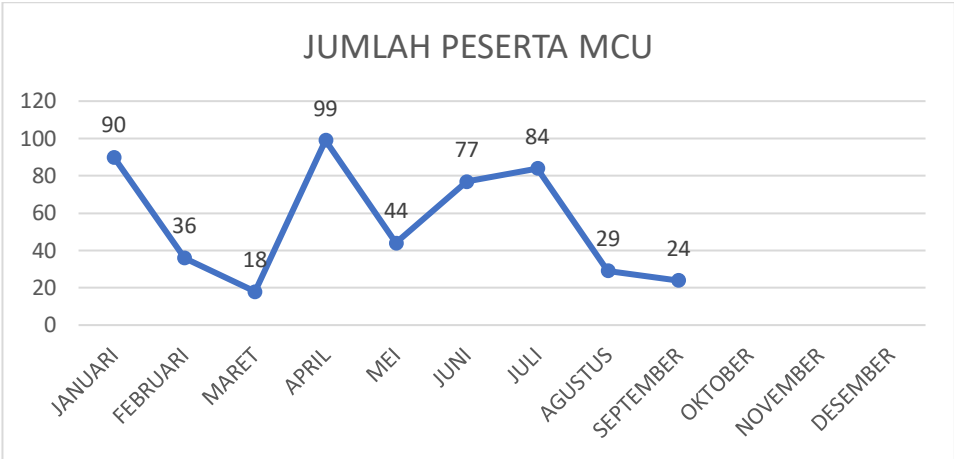
- Mengajukan surat permohonan PKS kepada Instansi Perusahaan, BPM, DPM, Klinik kesehatan, yang belum bekerjasama dengan RS Prima Husada Malang

3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

3.5.5.2.1 Tabel Jumlah Peserta MCU

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP
1	JUMLAH PESERTA MCU	90	36	18	99	37	50	84	29	24

3.5.5.2.2 Grafik Jumlah Peserta MCU



NO	BULAN	JUMLAH PASIEN	REVIEW
1	Januari	90	Analisis : Berdasarkan data tersebut, jumlah pasien Medical Check Up menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Review hasil kunjungan dengan PDSA Plan - Meningkatkan kunjungan ke Perusahaan dan universitas - Mempromosikan program MCU - Mereview tarif/biaya pemeriksaan Do - Mempromosikan program MCU setiap kali melakukan kunjungan ke instansi Perusahaan dan universitas - Koordinasi dengan bagian keuangan terkait review tarif MCU agar bisa bersaing dengan vendor lain Study - Harga MCU mempengaruhi jumlah kunjungan MCU. - Perusahaan dan universitas memilih harga MCU paling murah diantara vendor. - Banyak perusahaan memilih MCU yang ditawarkan secara
2	Februari	36	
3	Maret	18	
4	April	37 62 Free	
5	Mei	37 7 (PT Indonesian Marine)	
6	Juni	50 8 (PT Magicsoft Technology Indonesia 19 (BBIB)	
7	Juli	46 38 (PT Indonesian Marine)	
8	Agustus	29	
9	September	24	

			gratis dari klinik rekanan BPJS kesehatan karena hanya sebagai syarat pemenuhan dari Disnaker terkait kesehatan karyawan. Action 1. Pengajuan MCU ke berbagai Perusahaan untuk calon karyawan baru dan ke Institusi Pendidikan untuk calon Mahasiswa baru 2. Review harga pemeriksaan khusus untuk MCU
--	--	--	---

3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP
1	Jumlah Kunjungan	6	10	19	4	7	17	16	4	4

3.5.5.2.3.2 Grafik Jumlah Kunjungan Marketing Eksternal



Analisis :

Penurunan kunjungan berkurang karena focus marketing pada followup dan maintenance mitra melalui jarak jauh

Rencana Tindak Lanjut :

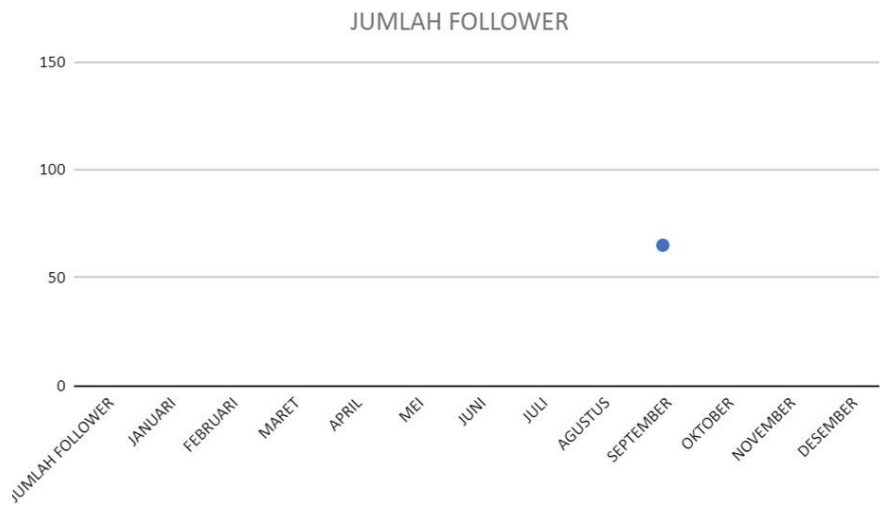
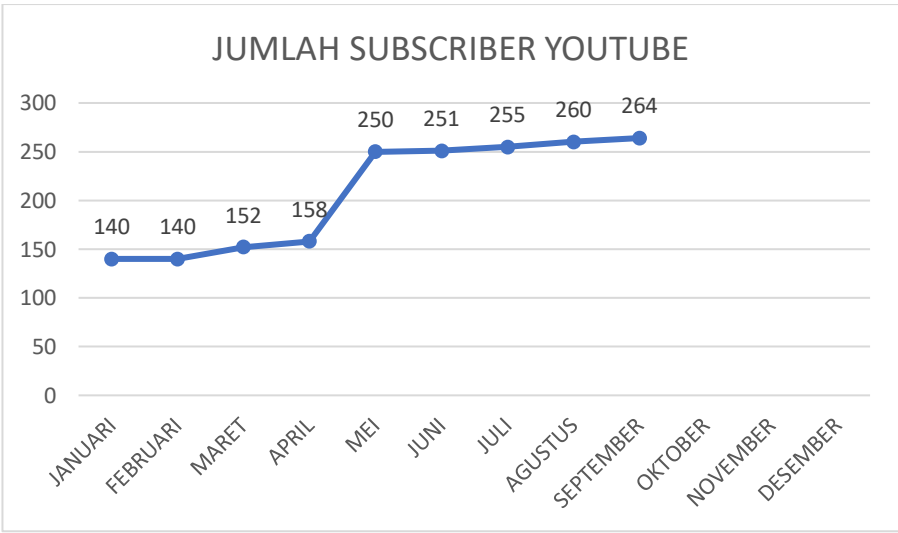
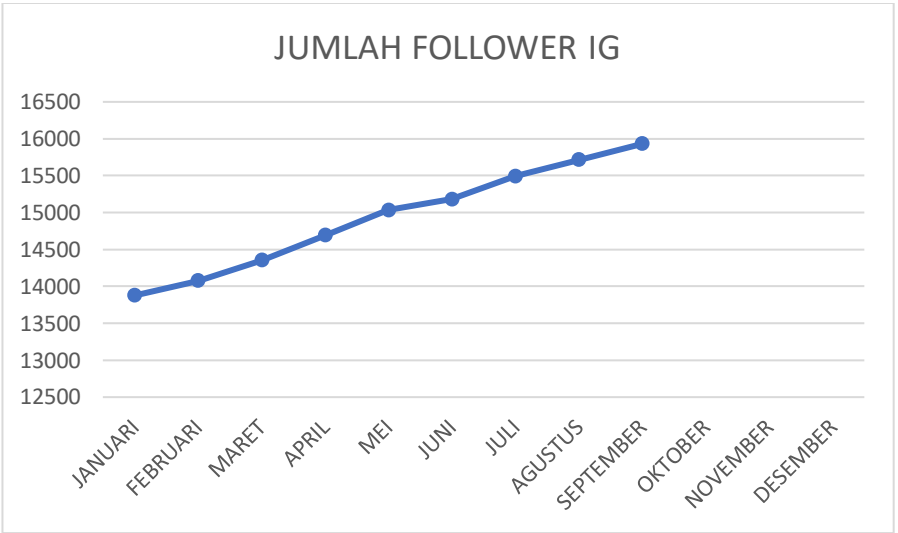
Monitoring dan evaluasi berkala.

3.5.5.2.4 Digital Marketing

3.5.5.2.4.1 Tabel Follower Media Sosial yang Dikelola RS Prima Husada Malang

BULAN	FOLLOWER			UNFOLLOW		
	INSTAGRAM	OUTUBE	TIKTOK	INSTAGRAM	YOUTUBE	TIKTOK
Januari	13877	140	-	265	0	-
Februari	14076	140	-	22	0	-
Maret	14353	152	-	22	0	-
April	14692	158	-	18	0	-

Mei	15034	250	-	29	0	-
Juni	15181	251	-	31	0	-
Juli	15493	255	-	13	0	-
Agustus	15716	260	-	8	0	-
September	15931	264	65	30	0	-
Analisis : 1. Digital marketing untuk mengelola Youtube belum ada masih menjadi satu di PT. 2. Follower Instagram meningkat karena tim PKRS aktif melakukan upload dan promosi di media sosial. 3. Akun baru Tiktok RSPH membantu dalam digital marketing						



3.5.6 Penjaminan

3.5.6.1 Piutang

3.5.6.1.2 Tabel Piutang BPJS Kesehatan (FPK dan Pengajuan Reguler September 2024

REKAPITULASI FPK BPJS KESEHATAN							
NO	PERIODE LAYANAN	TARIF FPK/ PENGAJUAN	TGL FPK	TGL BAYAR	REALISASI PEMBAYARAN	SELISIH AUDIT DAN ADM BANK	SALDO PIUTANG FPK
PELAYANAN 2023							
							-
1	OBAT KRONIS SEPT 23	435.837.336	18.01.2024	29.01.2024	435.837.336		-
2	FPK REG UTAMA DES 23	6.189.055.000	18.01.2024	29.01.2024	6.189.055.000		-
5	FPK 'OBAT KRONIS OKT 23	493.809.876	18.02.2024	26.02.2024	493.809.876		-
6	FPK LUPIS NOV 23 AMBULANCE	6.650.000	22.02.2024	28.02.2024	6.650.000		-
7	FPK LUPIS NOV 23 ALKES	6.215.000	22.02.2024	28.02.2024	6.215.000		-
8	FPK LUPIS DES 23 AMBULANCE	7.210.000	22.02.2024	28.02.2024	7.210.000		-
9	FPK LUPIS DES 23 ALKES	6.710.000	22.02.2024	28.02.2024	6.710.000		-
10	FPK OBAT KRONIS NOV 2023	465.212.636	21.03.2024	01.04.2024	465.212.636		-
11	FPK PEND DES 23	607.514.500	06.03.2024	18.03.2024	607.514.500		-
12	FPK OBAT KRONIS DES 2023	469.804.704	25.03.2024	03.04.2024	469.804.704		-
13	FPK OBAT KRONIS Pend Des 23	10.367.860	08.05.2024	20.05.2024	10.367.860		-
PELAYANAN 2024							
1	FPK Januari 2024	7.006.082.092	18.02.2024	28.02.2024	6.967.698.792	38.383.300	-
	FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE	6.015.000	20.03.2024	16.04.2024	6.015.000		-
	FPK LUPIS JAN 24 ALKES	12.485.000	20.03.2024	16.04.2024	12.485.000		-
	FPK OR Januari 2024	516.543.814	08.05.2024	20.05.2024	516.543.814		-
	FPK Pending Januari 2024	468.390.779	08.05.2024	20.05.2024	468.390.779		-
2	FPK Februari 2024	7.215.241.743	20.03.2024	28.03.2024	7.215.241.743		-
	FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE	7.740.000	20.03.2024	16.04.2024	7.740.000		-
	FPK LUPIS JAN 24 ALKES	3.795.000	20.03.2024	16.04.2024	3.795.000		-
	FPK OR Februari 2024	498.722.702	08.05.2024	20.05.2024	498.722.702		-
	FPK PEND REGULER FEBRUARI	373.212.100	10.06.2024	19.06.2024	373.212.100		-
	FPK PEND II FEB 2024	58.112.500	09.07.2024	17.07.2024	58.112.500		-
3	FPK Maret 2024	7.372.267.949	26.04.2024	08.05.2024	7.350.598.749	21.669.200	-
	FPK AMBULANCE MARET 24	5.280.000	14.06.2024	10.06.2024	5.280.000		-
	FPK ALKES MARET 24	3.465.000	14.06.2024	10.06.2024	3.465.000		-
	FPK OR MARET 24	471.764.386	15.07.2024	22.07.2024	471.764.386		-
	FPK PEND MARET 2024	383.291.100	09.07.2024	17.07.2024	309.918.000	73.373.100	-
	FPK PEND MARET 2 2024	90.791.600	20.08.2024	29.08.2024	90.791.600		-
4	FPK April 2024	6.926.723.374	20.05.2024	29.05.2024	6.901.742.874	24.980.500	-
	FPK OBAT KRONIS APRIL 2024	477.096.910	26.07.2024	05.08.2024	477.096.910		-
	FPK AMBULANCE APRIL 24	3.270.000	14.06.2024	10.06.2024	3.270.000		-
	FPK ALKES APRIL 24	3.630.000	14.06.2024	10.06.2024	3.630.000		-
	FPK Pending April 2024	289.580.800	07.08.2024	19.08.2024	289.580.800		-
	FPK Pending II April 2024	125.899.300	10.09.2024	18.09.2024	125.899.300		-
	FPK Obat Pend April 2024	5.989.571	06.09.2024	17.09.2024	5.989.571		-
5	FPK MEI 2024	7.537.333.400	23.06.2024	01.07.2024	7.493.109.800	44.223.600	-
	FPK OBAT KRONIS MEI 2024	487.109.484	26.07.2024	12.08.2024	487.109.484		-
	FPK Alkes Mei 2024	3.465.000	24.07.2024	07.08.2024	3.465.000		-
	FPK Ambulance Mei 2024	5.145.000	24.07.2024	07.08.2024	5.145.000		-
	FPK Obat Pend Mei 2024	10.593.498	06.09.2024	17.09.2024	10.593.498		-
	FPK PEND MEI 2024	334.480.400	23.09.2024	30.09.2024	296.561.200	37.919.200	-
6	FPK JUNI 2024	6.959.035.980	24.07.2024	31.07.2024	6.868.943.180	90.092.800	-
	FPK Alkes Juni 2024	8.470.000	24.07.2024	07.08.2024	8.470.000		-
	FPK Ambulance Juni 2024	6.945.000	24.07.2024	07.08.2024	6.945.000		-
	FPK Obat Kronis Juni 2024	468.625.741	15.09.2024	23.09.2024	468.625.741		-
7	FPK JULI 2024	7.160.148.298	20.08.2024	29.08.2024	7.122.971.498	37.176.800	-
	FPK Alkes Juli 2024	6.655.000	25.09.2024				6.655.000
	FPK Ambulance Juli 2024	8.085.000	25.09.2024				8.085.000
8	FPK Reguler Agustus 2024	6.671.460.900	25.09.2024	02.10.2024	6.662.482.200	8.978.700	-
	FPK Alkes Agustus 2024	6.160.000	25.09.2024				6.160.000
	FPK Ambulance Agustus 2024	6.510.000	25.09.2024				6.510.000
9	BELUM FPK SEPTEMBER 2024	7.426.128.600					7.426.128.600
		78.130.128.933			70.299.793.133	376.797.200	7.453.538.600

3.5.6.1.3 Tabel Saldo Pending BPJS Kesehatan

REKAP KLAIM DAN PENDING BPJS KESEHATAN							
NO	PERIODE LAYANAN	JENIS	JML KLAIM	FPK	Tidak Layak	JML PEND	% PEND
1	APRIL 24	RJ	11.384	11.366	2	4	0,0%
		RI	1.082	990	-	33	3%
2	MEI 24	RJ	12.641	12.628	3	13	0,1%
		RI	1.098	1.026	-	72	7%
3	JUNI 24	RJ	11.095	11.090	-	5	0,0%
		RI	1.024	922	-	102	10%
4	JULI 24	RJ	12.691	12.682	-	9	0,1%
		RI	995	924	-	71	7%

3.5.6.1.4 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG				JUMLAH PIUTANG
		a	b	e	f	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	Total
	PERIODE SEPTEMBER 2024 :										
1	Asuransi	42.599.307	6.031.288	239.245.554	91.443.984	181.605.418	155.112.293	420.000	21.507.218	2.920.000	181.605.418
2	Perusahaan	93.845.596	51.881.245	240.971.024	42.436.720	239.734.984	203.446.662	7.200.732	19.903.133	-	239.734.984
3	Mandiri Inhealth	372.039	-	61.845.771	-	62.217.811	61.845.771	-	372.039	-	62.217.811
4	Jasa Raharja	554.408	554.408	312.590.371	202.184.715	110.405.659	110.405.659	-	-	-	110.405.659
5	Lain lain	-	-	1.229.294	-	1.229.294	1.229.294	-	-	-	1.229.294
6	BPJS Ketenagakerjaan	1.416.296.004	36.377.580	621.252.935	-	2.001.171.391	1.744.212.393	254.549.436	-	352.000	2.001.171.391

- Keterangan :
- 1. Cutt OF Piutang per 30 September 2024 Rp 2.001.171.391
 - 2. Piutang Asuransi proses verifikasi rencana pembayaran oktober 2024
 - 3. Piutang Perusahaan PT Karya Bina Sentausa Proses verifikasi oleh auditor internal
 - 4. BPJS TK proses verifikasi sudah konfirmasi PIC Bu Tutus.

3.5.6.2 Klaim Pending

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
1.	Lampiran SHK pada pasien persalinan	Klaim Pending	Tindakan USG pada Rawat Jalan
2	Penggunaan kode O809 pada pasien persalinan 73.59 9other manually asisted delivery)	Klaim Pending	Tindakan USG pada Rawat Jalan
3	Hypovolaemic shock (R57.1) Diminta resleksi R57,9 (Shock, unspecified) tata laksana loading cairan	Klaim Pending	Tindakan USG pada Rawat Jalan
4	konfirmasi sesuai dengan Berkas terlampir DU l11.0 (CHF+HT) . Reseleksi kode diagnosa	Klaim Pending	Tindakan USG pada Rawat Jalan
5	Rujukan internal pada hari yang berbeda namun jadwal DPJP ada pada hari yang sama	Klaim Pending	Menjawab konfirmasi pending

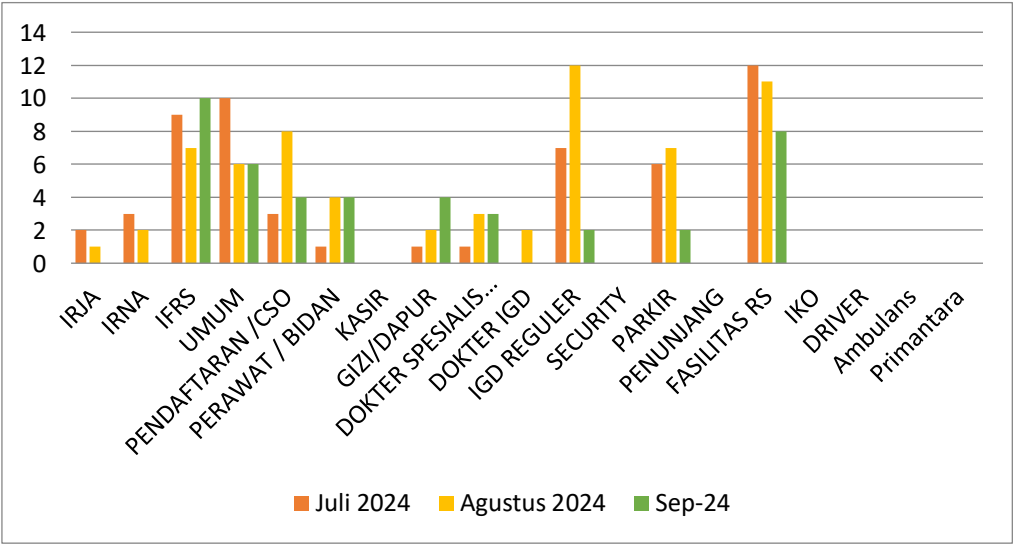
3.5.7 PIPP – MOD – MPP

3.5.7.1 Laporan Komplain Pasien

3.5.7.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan Agustus 2024

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	JULI 2024	AGT 2024	SEP 2024
1.	IRJA	2	1	0
2.	IRNA	3	2	0
3.	IFRS	9	7	10
4.	UMUM	10	6	6
5.	PENDAFTARAN	3	8	4
6.	PERAWAT / BIDAN	1	4	4
7.	KASIR	0	0	0
8.	GIZI/DAPUR	1	2	4
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	1	3	3
10.	DOKTER IGD	0	2	0
11.	IGD REGULER	7	12	2
12.	SECURITY	0	0	0
13.	PARKIR	6	7	2
14.	PENUNJANG	0	0	0
15.	FASILITAS RS	12	11	8
16.	IKO	0	0	0
17.	DRIVER	0	0	0
18.	Ambulans	0	0	0
19.	Primantara	0	0	0
Total		54	65	43

3.5.7.1.2 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit September 2024



Analisis :

Jumlah pasien komplain selama Bulan September 2024 mengacu pada komplain pasien. Asal complain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.

1. Jumlah complain Pada bulan September 2024 menurun dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan juli menurun sebanyak 53 kasus complain, pada bulan Agustus naik menjadi 65 kasus komplan, Sedangkan pada bulan September 2024 sebanyak 43 kasus komplain
2. Komplain terbanyak pada bulan September 2024 yaitu dari Farmasi sebanyak 10 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
3. Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 10 jenis komplain dengan rincian :
 - 1) Fasilitas RS sebanyak 7 kasus yang meliputi :
Toilet ada 2 jenis yaitu duduk dan jongkok, diberikan gordien di jendela gedung 3C agar tdk membuat silau pasien, sediakan air hangat di toilet pasien, setiap kamar di beri fasilitas TV untuk hiburan pasien, Fasilitas smoking area. Karena banyak smokers bertebaran di halaman rumah sakit, sediakan baskom untuk sikat gigi/cuci muka/basuh pasien, Tempat parkir motor penunggu diberikan atap biar terlindung dari panas dan hujan
 - 2) Parkir sebanyak 2 kasus terkait tarif dan luas lahan parkir yang meliputi :
Keluar masuk parkir pasien harusnya pembayaran 1 kali saja. Tiap kali keluar harus bayar foto kopi juga sulit, Perluas area parkir
 - 3) Umum sebanyak 1 kasus terkait masih banyaknya perokok di area Rumah Sakit Prima Husada Malang.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan September 2024

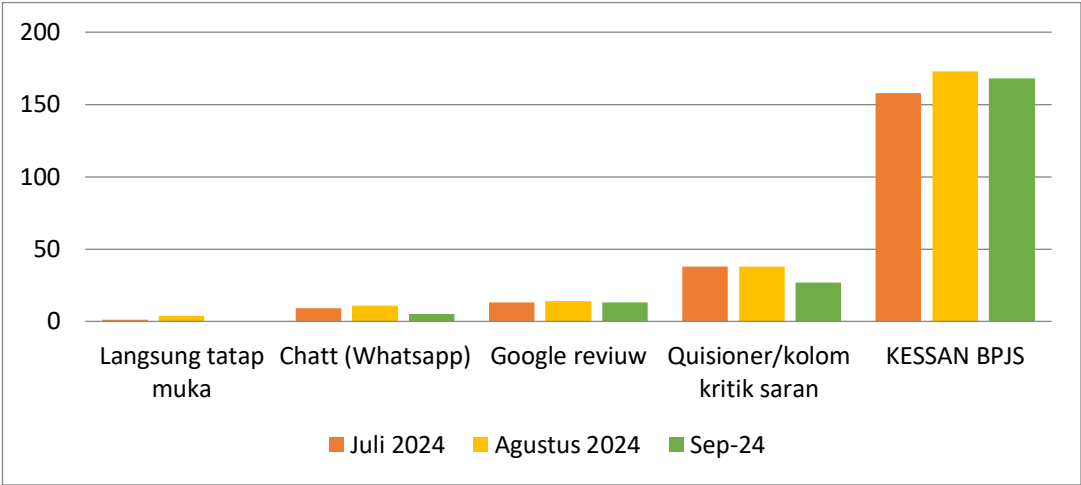
NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
1.	Langsung tatap muka	1	4	0
2.	Tidak Langsung :			
	a. Chatt (Whatsapp)	9	11	5
	b. Google review	13	14	13
3.	Quisioner/kolom kritik saran	38	38	27
4.	KESSAN BPJS	158	173	168

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

NO	KETERANGAN	BINTANG 1	BINTANG 2	BINTANG 3	BINTANG 4	BINTANG 5
1.	KESSAN BPJS	2	0	2	46	118

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan September 2024



Analisis :
Pada bulan September 2024 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari Quisioner yaitu sebanyak 27 kasus complain. Sedangkan terbanyak kedua yaitu dari google review sebanyak 13 kasus, chat WA sebanyak 5 kasus.

Rencana Tindak Lanjut :
Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan September 2024

NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	WAKTU TANGGAP		WAKTU PENYELESAIAN		< 3 HR MANAJERIAL RS	7 HR KE PT
		STANDARD < 5 '	PENCAPAIAN (DARI WAKTU TOTAL DIBAGI JML KOMPLAI ATAU RATA2 WAKTU TANGGAP)	STANDARD < 60 '	PENCAPAIAN		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	0	0	0
						100%	
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	5	0	0
					100%		
3.	Google review	100%	100%	100%	13	0	0
					96%		
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	27	0	10
					58%		42%
5.	KESSAN	100%	0	100%	168	0	0
					100%		

Analisis :
Waktu tanggap dan penyelesaian complain pasien pada bulan September 2024 masih

ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Kuisisioner dengan capaian 58% hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS dan parkir yang memerlukan diskusi dengan manajemen.

Jumlah komplain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 10 jenis complain dengan rincian :

- 1) Fasilitas RS sebanyak 7 kasus yang meliputi :
Toilet ada 2 jenis yaitu duduk dan jongkok, diberikan gordien di jendela gedung 3C agar tdk membuat silau pasien, sediakan air hangat di toilet pasien, setiap kamar di beri fasilitas TV untuk hiburan pasien, Fasilitas smoking area. Karena banyak smokers bertebaran di halaman rumah sakit, sediakan baskom untuk sikat gigi/cuci muka/basuh pasien, Tempat parkir motor penunggu diberikan atap biar terlindung dari panas dan hujan
- 2) Parkir sebanyak 5 kasus terkait tariff dan luas lahan parkir yang meliputi :
Keluar masuk parkir pasien harusnya pembayaran 1 kali saja. Tiap kali keluar hrus bayar foto kopi juga sulit, Perluas area parkir
- 3) Umum sebanyak 1 kasus terkait masih banyaknya perokok di area Rumah Sakit Prima Husada Malang.

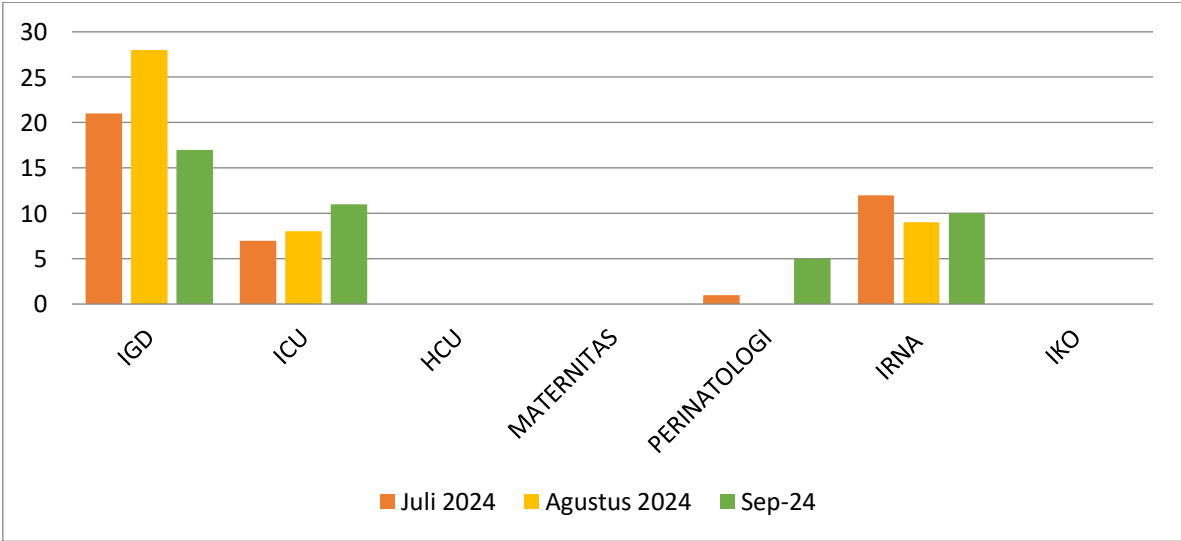
Rencana Tindak Lanjut :

Penyelesaian komplain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk
3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan September 2024

NO	UNIT PERUJUK	JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
1.	IGD	21	28	17
2.	ICU	7	8	11
3.	HCU	0	0	0
4.	MATERNITAS	0	0	0
5.	PERINATOLOGI	1	0	5
6	IRNA	12	9	10
7	IKO	0	0	0
Total		41	45	43

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan September 2024



NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	RS TUJUAN	ALASAN RUJUK	LAMA RAWAT	PLAVON HABIS
1	DJAITUN	IGD	ACUTE LIMB ISCHEMIA, AF, HHD, HT	dr. Yoga Sp.JP	RSSA	PRO PCI	1	Tidak
2	JUMANI	IGD	CKD, DM HIPERGLIKEMI	dr. Ardhi Sp.PD	RS Lavalette	Pro HD	2	Tidak
3	NY. SOLICHAH	IRNA	CVA ICH 10CC	dr. Farid Sp.S	RST Soepraoen	Pro Evakuasi	2	Tidak
4	NY. SANATI	IRNA	AKI ST 3 DD ACUTE ON CKD, OBSTRUCTIVE UROPATHY DT CA CERVIX, DM TYPE 2, HIPERKALEMIA	dr. Ardhi Sp.PD	RSSA	Pro HD	4	Tidak
5	NY. SRI ENDANG SUDJARWATI	IGD	STEMI ANTERIOR INFERIOR, KRISIS HIPERGLIKEMIA, RIWAYAT STROKE 3 KALI	dr. Mira Sp.Jp	RSSA	PRO PCI	1	Tidak
6	Tn. Sujiono	ICU	Contusio Pulmonum Dextra dt Close Fracture 3,4,5,6,7 Dextra,Close Fracture Scapula Dextra,Close Fracture Humerus Incomplete Dextra	dr. Zaki, Sp. B	RS Lavalette	Membutuhkan alat khusus	2	Tidak
7	Tn. ABDUL KHOLIK	IRNA	PERITONITIS PERFORASI GASTER, COLIC ABDOMEN,COLITIASIS, UAP, SHOK CARDIOGENIK	dr. Zaki, Sp. B	RSSA	Pro bedah digestif	7	Tidak
8	WIJI SANTOSO	IGD	Chest Pain, Obs Dyspnea, ADHF	dr. Ira, Sp. JP	RS UMM	PRO PCI	2	Tidak
9	ARIF EFRIADI	IRNA	Hematemesis, Anemia, AKI, Hiperleukositosis	dr. Ardhi Sp.PD	RSSA	Pro HD	4	Tidak
10	NY. ERNI TRISULAWATI	IRNA	RF, JAUNDICE, HIPERBILIRUBIN, HIPOALBUMIN, SEPSIS, CVA INFARK	dr. Farid SP. S Raber dr Heru Sp. An Raber dr Heri Sp.PD	RSSA	Pro Struk unit	14	Tidak
11	Tn Muhammad	ICU	Nstemi, Alo cardiogenic, heavy smoker	dr yunita sp P raber dr mira sp jp	RSSA	PRO PCI	2	Tidak
12	NY. JUMIATIN	IRNA	Abdominal pain ec colelitisias, Kista Liver, Anemia	dr. Anton, Sp. B	RSSA	Pro Pemeriksaan MRCP	2	Tidak
13	By. Ny. Anita Fitria	NEO	RDS OK HMD dd neonatal pneumonia	dr. Fiona Sp.A	RST Soepraoen	Pro Ventilator	2	Tidak
14	Tn. M Lukman Hadi	ICU	STEMI Anterior	dr. Ira, Sp. JP	RSSA	Pro PCI	2	Tidak
15	By. Ny. Farida	NEO	neonatal pneumonia dd MAS, Susp PJB Kritis dd PPHN, asfiksia,	dr. Ratih Sp.A	RSSA	Pro Ventilator	1	Tidak
16	Tn. SAMSUL ARIFIN	ICU	Hepatic encephalopathy	dr Ardhi, Sp.PD	RSSA	Pro tatalaksana terapi lanjutan encephalopathy	2	Tidak
17	Ny. WITDHAYATI	ICU	CKD st V + hiperkalemia	dr. Zoraida Sp.PD	RSSA	Pro HD	2	Tidak
18	Ny. Sumiati	ICU	STEMI inferior (blm tahu kanan dan posterior kena atau tdk)	DR Mira, Sp.JP	RS UMM	Pro revaskularisasi dan pemasangan temporary pacemaker	1	Tidak
19	Sdr. Nifa Atin	ICU	Gradual DOC dt Susp. ME TB dd susp cva	dr Farihma, Sp.N	RST Soepraoen	Pro unit stoke	2	Tidak
20	An. AYDA NAURI DWI AZZAHRA	IGD	COS , FR SKULL DEPRESSED ET LINIER TEMPORAL SINISTRA, CONTUSIO CEREBRI, HEMATOMA SUBGALEAL SINISTRA	dr. Fachry, Sp. BS	RST Soepraoen	Pro Craniotomy dan Penanganan lebih lanjut	2	Tidak
21	Tn. Syamsudin	IRNA	Abses Hepar, Hiponatremi, hepatoma	dr. Anton, Sp. B	RSSA	Pro MRI dan perawatan lanjutan	2	Tidak

22	Tn. SAYYID LINTANG PANJURA	IGD	COS + contusional hemorrhage temporal kanan et basal ganglia kanan et parietal kanan + edema cerebri	Dr Fachri, Sp.BS, DR Arianto, Sp.OT	RSSA	Pro trepanasi	1	Tidak
23	Ny.Ngingitin	ICU	PEB dengan G4P1202Ab000 uk 24-26 minggu THI, CKD, DM	dr.Heri.,Sp.PD konsul dr.humaira.,Sp.OG	RSSA	Pro Perawatan ICU untuk Ibu back up HD	4	Tidak
24	Tn Triyanto	IRNA	DOC DD SUSP STROKE DD SOL	dr Farid, Sp.N	RSSA	Pro exsici tumor	2	Tidak
25	By Ny Nadiya Faiqotussolichah	NEO	NP + BBLR + obs. distress napas ok neonatal pneumonia dd RDS +	dr Ratih, Sp.A	RSSA	tatalaksana distress napas dengan labiognatopalatoschizis (interface tidak tersedia di RS perujuk)	1	Tidak
26	Tn. Hendri Budiyanto	IGD	Acute ON CKD + hiperkalemia	dr. Ardhi B Sp.PD	RSUD Lawang	Pro HD	1	Tidak
27	Tn. Tri Laksono	IRNA	Acute ON CKD + hiperkalemia	DR Zora, Sp.PD	RSSA	Pro HD	5	Tidak
28	Tn. Abdoel djalil	ICU	Syok septic ec pneumonia	dr. Elvi sp.P konsul dr. Heri sp, Pd	RSSA	Pro ICU isolasi	4	Tidak
29	Ny. Almustafidah	ICU	CVA ICH	dr. Dewi Sp.S	RSSA	Pro Stroke Unit	2	Tidak
30	Tn. Harmanto	IGD	CVA ICH subkorteks	dr. Dewi Sp.S	RS Lavalette	Pro Stroke Unit	2	Tidak
31	NY.MISNI	IGD	Hemiparese Sinistra dt CVA ICH Temporal Dextra, HT	dr. Syahrir, Sp. N	RST Soepraoen	Pro Stroke Unit	1	Tidak
32	TN. MUHAMMAD ROFI	IRNA	Susp. Re ruptur ileum laparatomy ai peritonitis ileum obstruktive dng perlengketan luas viscera, jejunum ileum colon sd signoid susp ec intestine TB kp duplex	dr. Anton, Sp. B	RSUD dr. Soetomo	Pro Repair Laparatomy	11	Tidak
33	NY. JUMAINA	IGD	Nausea Vomiting, CKD, Volume Depletion	dr. Ardhi, Sp. PD	RSUD Lawang	Pro HD	1	Tidak
34	Tn. Abdul Rochman	IGD	Close fraktur cruris D, CF Clavicula D	dr. Arianto, Sp. OT	RSSA	Pro locking titan n c arm	2	Tidak
35	Tn. MUHAMMAD MAHRUS	IGD	Hematoschezia , Anemia, Hiponatremi	dr. Heri, Sp. PD	RSSA	Pro endoscopi	2	Tidak
36	TN. MISENAN	ICU	NSTEMI, ALO cardiogenik, Susp Pneumonia	dr. Andy Sp.P raber dr. Mira Sp.JP	RST Soepraoen	Pro PCI	2	Tidak
37	BY. NY INDRI DWI PERMANA	NEO	NEONATAL PNEUMONIA, feeding difficulty, Susp PJB	dr. Ratih, Sp. A	RS Lavalette	Gagal CPAP pro NIV, Pro Skrining PJB	3	Tidak
38	Tn. LEGIMIN	IGD	Anemia gravis, Hematemesis Melena, Bisitopenia, Susp Hematologic disorder ddx CLD	dr. Ardhi, Sp. PD	RSSA	pro tranfusi PRC dan TC dan penegakan diagnosis	1	Tidak
39	GATOT SUKARNO	IGD	STEMI anterior septal, UAP	dr. Ira, Sp. JP	RSSA	Pro PCI	1	Tidak
40	A FANANI	IGD	STEMI anteroposterior	DR Mira, Sp.JP	RS UMM	Pro PCI	1	Tidak
41	nn Nifa atin	IGD	Gradual DOC dt Susp ME Bakteri dd ME TB	dr Fahima, Sp.S	RSSA	pro Pemeriksaan EEG,MRI dan tatalaksana lanjutan	2	Tidak
42	By. Ny. Inda Putri Mauladani	NEO	Susp. PPHN	dr Fiona, Sp.A	RSSA	pro diagnostik utk echocardiografi	1	Tidak
43	Tn. Sujanto	IGD	TB susp pericarditis	dr Ira, Sp.JP	RSSA	pro diagnostik utk echocardiograf	1	Tidak

Analisis :

- Terjadi peningkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam 3 bulan terakhir, pada bulan Juli 2024 sebanyak 41 pasien, pada bulan agustus 2024 sebanyak 45 pasien Sedangkan pada bulan agustus sebanyak 43 pasien
- Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - Pro HD = 7 kasus
 - Pro unit stoke = 5 kasus

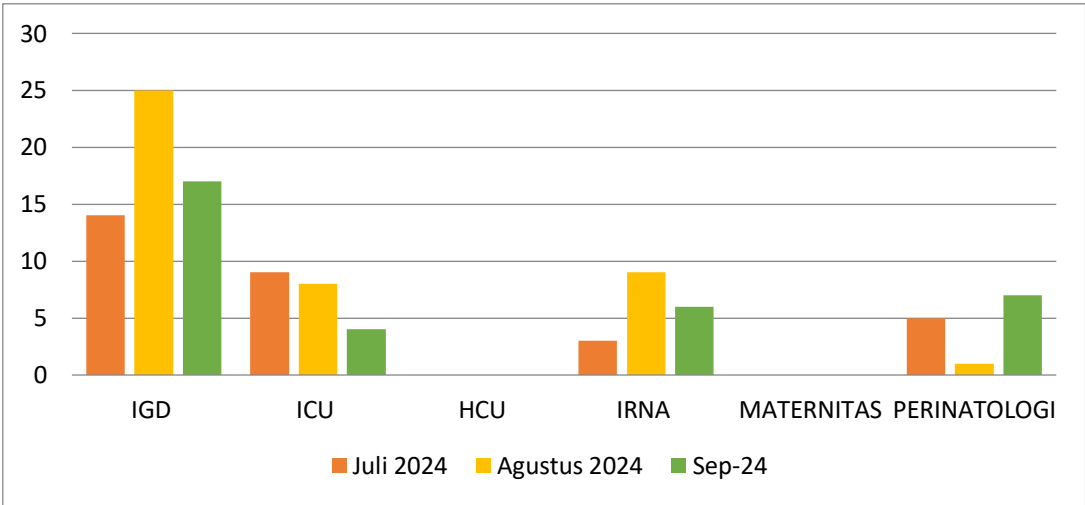
- c) Pro PCI = 8 kasus
 - d) Pro Bedah digestif = 1
 - e) Pro ventilator = 2
 - f) Pro ICU TB = 1
 - g) Pro ARV = 8
3. Alasan rujuk karena plavon habis menurun dari bulan sebelumnya bulan Agustus 2024 terdapat 2 pasien dengan jumlah total minus : Rp. 1.572.283
Sedangkan pada bulan September 2024 tidak diemukan plavon habis pasien

Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
- 2. Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.5.3 Jumlah Pasien Meninggal Bulan September 2024

NO	UNIT ASAL PASIEN MENINGGAL	JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
1.	IGD	14	25	17
2.	ICU	9	8	4
3	HCU	0	0	0
4.	IRNA	3	9	6
5.	MATERNITAS	0	0	0
6	PERINATOLOGI	5	1	7
Total		31	43	34



NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP
1	Tn. HERU JOKO SETYONO	IGD	SYOK KARDIOGENIK, VT	dr. Yoga Sp.JP
2	TN. JUDI PRASETYO	IRNA	ALO Cardiogenic, susp CA Nasofaring	dr. Heri Sp.PD
3	BY NY SITI ANISAH	NEO	PNEUMONIA, ASFIKSIA, BBLSR PREMATUR	dr. Dicky Sp.A
4	Tn. SUWARNO	IGD	Syok Kardiogenik, ca Nasofaring, gagal nafas.	dr. Heri Sp.PD
5	Ny. JUMA'IYAH	IGD	DOA	dr. yenni
6	Ny. Supiyah	ICU	RESPIRATORY FAILUR, CVA Infark	dr. farid, Sp. N

7	Tn. WAWAN PORI PURNAWANTO	IGD	NSTEMI, Alo kardiogenik, Asidosis metabolik, leukositosis, Kolik Abdomen, AKI	dr. Miryanti, Sp. JP
8	Tn. Lasim	IRNA	DOC, DM hiperglikemia, Susp encephalopati hipoksik	dr. Heri, Sp.PD konsul dr Syahrir, Sp.S
9	NY.DINA MARIANA	IGD	MULTIPLE MYLOMA	dr. Heri, Sp.PD
10	Ny. Farida	ICU	RF, CVA Infark, Hipoalbumin, Hiperkalemia,	dr. Farid Sp.S raber dr. Heru Sp.An
11	Tn. Mukti Santoso	IGD	Pneumonia, dd TB ulkus decubitus, DM, CVA Sequele	dr. Elvi Sp.P
12	Ny. Rupi'ah	IGD	NSTEMI	dr. Yoga Sp.JP
13	Tn. Ichsan	ICU	Syok Cardiogenic	dr. Yoga Sp.JP
14	An.Ahmad Yoga Pratama	IGD	COB	dr Yuniar Ardhi
15	By. Ny. DJUMAIDAH	NEO	IUFD	dr Humaira, SP.OG
16	Tn. Sholeh	IGD	Alo Cardiogenik	dr. mira sp,jp raber dr. heri sp,pd konsul dr. heru sp,an
17	Tn. MUCH. NAFI NISCHAL	IGD	DOA	dr Yuniar Ardhi
18	Tn. KUSNADI	HCU	ARDS, NSTEMI, COPD	dr Yoga, Sp.JP
19	An. AHMAD FAUZI AL AZIZ	NEO	PNEUMONIA, DYSPNEU , HEMATEMESIS , ANEMIA	dr. Dicky, Sp. A
20	Tn. SARIB	IRNA	Hepatoma, Hepatitis B	dr. Heri, Sp.PD konsul dr Syahrir, Sp.S
21	Ny. Kartini	IGD	DOA	dr. Yuniar Ardy
22	Tn. Sumarji	IGD	DOA	dr. Yuniar Ardy
23	By. Ny. Ela 1	NEO	Prematur BBLSR	dr. Humaira Sp.OG
24	By. Ny. Ela 2	NEO	Prematur BBLSR	dr. Humaira Sp.OG
25	Tn. Bahron Kamal	IRNA	CVA ICH, HT, HHD, OMI,	dr. Fahimma Sp.N
26	NY. MANIS	IRNA	AF, LV FAILURE, AR, TR, PH INTERMEDIATE, HIPOALBUMIN, HEMATEMESIS	dr Ira, Sp.JP
27	Ny. AMINUL MAGHFIROH	IGD	CKD st V	dr Heri, Sp.PD
28	by NY Evi ekawati	NEO	Imatur, BBLSR	dr. Humaira Sp.OG
29	NY.ROKAYAH	IRNA	SYOK HIPOVOLEMIK, GERD, GENERAL WEAKNESS	dr Heri, Sp.PD
30	Tn. Tohir Tobe	IGD	COB	dr. Yenni
31	N MU'ALIMIN	IGD	COB	dr. Yenni
32	By.Ny.Indri	NEO	NEONATAL PNEUMONIA, feeding difficulty, Susp PJB	dr. Ratih,Sp. A
33	Tn. Paimin	IGD	DOA	dr Nur Rohman
34	Ny. Sunarti	IGD	DOA	dr Nur Rohman

Analisa :

1. Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan September 2024 sebanyak 34 pasien
2. Jumlah terbanyak yaitu dari IGD sejumlah 17 pasien, ICU sebanyak 4 pasien, IRNA 6 pasien, dan Neonatologi sebanyak 7 asien.
3. Pada bulan September 2024 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 6 kasus.
4. Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

4.5.7.1 Laporan MPP

4.5.7.1.1 Tabel Rekap Berdasarkan Skrining Pasien

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN	BULAN / JUMLAH		
		JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
1	Usia lanjut	319	372	370
2	Kasus penyakit kronis / terminal katastropik	516	620	723
3	Riwayat penggunaan alat bantu (kursi roda, walker, tongkat, dll)	6	4	0
4	Perkiraan biaya tinggi	184	142	132
5	Kemungkinan sistem pembiayaan yang kompleks (2 asuransi)	8	34	40
6	Pasien dengan fungsi kognitif rendah	0	1	0
7	Potensial komplain tinggi	24	42	58
8	Kasus yang melebihi rata-rata lama rawat	615	751	756
9	Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangannya	77	146	105
10	Berisiko membutuhkan kontinuitas pelayanan	795	964	1011
11	Berpotensi masalah hukum	0	0	0
12	Naik kelas pelayanan	15	15	40
13	Lain - lain	176	115	79

4.5.7.1.2 Jumlah Lain-Lain (Permasalahan Cara Bayar)

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN LAIN-LAIN (PERMASALAHAN CARA BAYAR)	BULAN / JUMLAH		
		AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER
1	Habis PKS	43	11	
2	BPJS status Denda	22	30	
3	BPJS status Premi	9	7	
4	BPJS status Denda dan Premi	21	12	
5	BPJS status Usia lebih dari 21 tahun	6	0	
6	BPJS status keluar atas kemauan sendiri	4	4	
7	BPJS status penangguhan pembayaran	1	0	
8	Rencana pengurusan BPJS	1	3	
9	BPJS status tidak ditanggung	8	3	
10	BPJS tidak aktif akhir bulan	-	6	
11	BPJS peralihan Mandiri ke PBI	-	3	

3.5.8 Cleaning Service

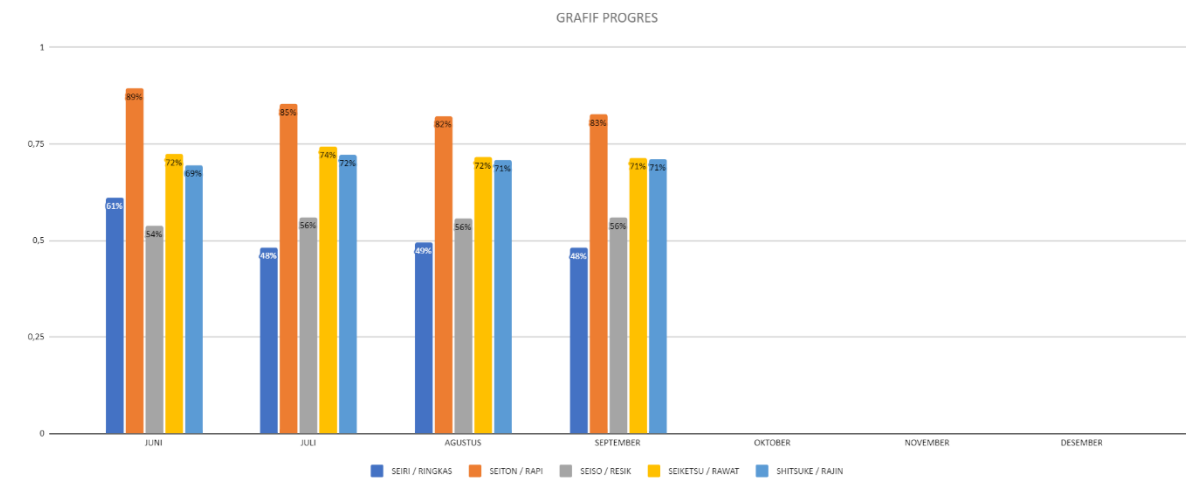
3.5.8.1 Indikator Kerja Cleaning Service

SEIRI / RINGKAS	DESKRIPSI
Penempatan Alat Kebersihan di Janitor	Alat kebersihan ditempatkan dan ditata dengan rapi di Janitor. Namun bagi ruangan yang tidak memiliki Janitor, peralatan kebersihan ditempatkan ppada suatu tempat tertentu dalam kondisi bersih dan rapi
Penempatan alat kebersihan di Trolley	Alat kebersihan ditempatkan dan ditata dengan rapi di Trolley. Namun bagi ruangan yang tidak memiliki Trolley, peralatan kebersihan ditempatkan pada suatu tempat tertentu dalam kondisi bersih dan rapi
Kondisi bak pembersih / kereta peras	Kondisi bahan pembersih yang ada di bak pembersih / ketreta peras tidak kotor. Maksimal 2x penggantian. Jika sebelum 2x sudah kotor amaka harus diganti. Pel harus dalam kondisi bersih

SEITON / RAPI	
Kerapian baju petugas CS	CS menggunakan baju sesuai seragam dengan rapi dan bersih
Penggunaan ID card	CS Menggunakan id card sesuai aturan
Penanganan sampah Medis dan Non Medis	
Penempatan sampah medis dan nonmedis	tempat sampah diberi kantong plastik sesuai warna dan fungsinya. Sampah medis dan nonmedis tidak boleh tercampur.
Penempatan plastik	Tempat sampah dilapisi kantong plastik sesuai jenis limbah, tidak penuh, tidak kotor, tidak ada sampah berceceran
SEISO / RESIK	
Lantai	Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, tidak bau, nat lantai bersih, dan sudut lantai harus bebas noda.
Langit – Langit / Plafon	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Kaca Luar – Dalam	Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, bebas noda, dan mengkilap.
Jendela / Tralis	Jendela / tralis bersih, tidak berdebu, dan tidak bernoda.
Tirai (vertical blind, gordyn)	Bersih, tidak berdebu, tidak kotor, dan rapi.
Lampu	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Saklar & stopkontak	Tidak berdebu, tidak bernoda, dan tidak basah.
Sarana pemadam kebakaran	Bersih, tidak berdebu, tidak kotor, dan tidak digunakan untuk menyimpan barang.
Objek Berbahan Stainless	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, tidak berminyak, dan tidak ada lawa – lawa.
Dinding	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Wastafel dan eye wash	Pembuangan mengalir lancar, tidak ada noda, tidak ada bercak air disekelilingnya, tidak bau, kering, kaca cermin bersih, bening, tidak berdebu, tidak bernoda, kran tidak berkarat, tidak basah, dan tidak kusam.
Kamar Mandi	Kebersihan dan bau
Ruangan	Tidak bau amis, pesing, dan anyir.
Plafon/langit-langit	Bebas dari kotor, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Kasa nyamuk	Bersih, tidak bernoda, tidak ada lawa – lawa, dan tidak berdebu.
Dinding Keramik	Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, dan nat dinding bersih.
Closed	Mengalir lancar, tidak ada noda, tidak ada percakan air disekelilingnya, dan tidak bau.
Kran	Tidak berkarat, tidak basah, dan tidak kusam.
Pintu	Bersih, tidak ada noda, dan mengkilap.
Urinoir	Bersih, tidak ada noda, tidak bau, dan tidak berkarat.
Bak Mandi	Tidak menguning karena lumut, tidak kotor, dan tidak ada jentik.
Ember dan Gayung	Bersih dan tidak berlumut.
Lantai	Bersih, tidak ada debu, tidak ada sampah, tidak bau, dan sudut lantai harus bebas noda.
Keset	Tidak berdebu, tidak basah, tidak bau, dan tidak ada sampah.

Tempat Sampah	Dilapisi kantong plastik sesuai jenis limbah, tidak penuh (terisi kurang dari 2/3 bagian), tidak kotor, dan tidak ada sampah berceceran
Tangga	Bersih dan bebas sawang
Railing	Tidak berdebu, tidak ada noda, dan bila diusap tidak membekas.
Lantai (anak tangga & Bordes)	Tidak berdebu, tidak ada sampah, tidak basah, dan tidak bau.
Dinding	Tidak berdebu, tidak ada noda, dan tidak ada bercak.
Plafon	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Lift	Lantai dan dinding tidak berdebu, tidak bernoda, mengkilat, harum, dan sudut lantai harus bebas noda.
Dek Level	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa / sampah / daun kering.
Pagar	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Spoel hock/Dapur	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Pembersihan Tempat Sampah / Trolly	Pembersihan tempat sampah / trolly dilakukan secara rutin, kondisi tidak berdebu, dan ada jadwal pembersihannya juga.
SEIKETSU / RAWAT	
Poles lantai di ruangan	Sudah dilakukan dan/atau dijadwalkan poles lantai, baik basah dan atau kering maksimal 1x/bulan
Pemakaian APD	APD masker, sepatu, sarung tangan
Penandaan alat kebersihan	Hijau strip 1 (-) : kantor, Hijau strip 2 (=) : dapur, Biru (selasar), kuning (r. perawatan/pelayanan, merah : kamar mandi
Kebersihan Diri Petugas	Pakaian bersih, Badan bersih, Tidak berbau tidak sedap
SHITSUKE / RAJIN	
Kompetensi CS Memperagakan Cuci tangan dengan benar	Dapat mempraktekan lengkap sesuai SOP cuci tangan
Kompetensi CS dalam menanggapi response keluhan	Segera di TL dan dilaporkan dalam grup
Kompetensi CS dalam mengikuti arahan kordinator	Segera di TL dan dilaporkan dalam grup

JENIS	TARGET	CAPAIAN JUNI	CAPAIAN JULI	CAPAIAN AGUSTUS	CAPAIAN SEPTEMBER
SEIRI / RINGKAS	30	61%	48%	49,38%	48%
SEITON / RAPI	40	89%	85%	82,21%	83%
SEISO / RESIK	330	54%	56%	55,67%	56%
SEIKETSU / RAWAT	40	72%	74%	71,51%	71%
SHITSUKE / RAJIN	60	69%	72%	70,74%	71%



Analisis :

Produktifitas Unit CS dalam penilaian ini masih fluktuatif namun tidak signifikan.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.9

Pengadaan dan Gudang Umum

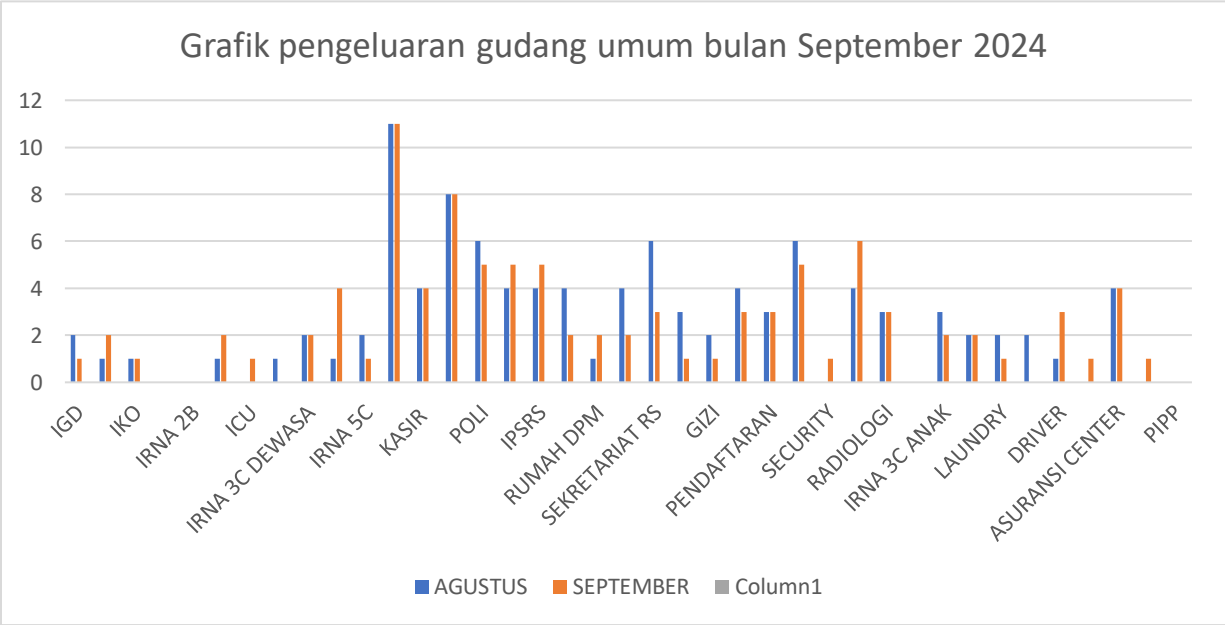
3.5.9.1

Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

NO	UNIT ASAL	JUMLAH BARANG		PERSENTASE
		AGUSTUS	SEPTEMBER	
1	IGD	2	1	↓50%
2	MATERNITAS	1	2	↓-50%
3	IKO	1	1	↓0%
4	IRNA 2A	0	0	↓0%
5	IRNA 2B	0	0	↓0%
6	IRNA 2C	1	2	↓-50%
7	ICU	0	1	↓0%
8	IRNA 3A	1	0	↑0%
9	IRNA 3C DEWASA	2	2	↓0%
10	IRNA 4C+4A	1	4	↓-100%
11	IRNA 5C	2	1	↓50%
12	MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS	11	11	↑0%
13	KASIR	4	4	↓0%
14	DAPUR	8	8	↓ 0%
15	POLI	6	5	↓16,66%
16	CLEANING SERVICE	4	5	↓-25%
17	IPSRS	4	5	↓-25%
18	GUDANG FARMASI	4	2	↑50%
19	RUMAH DPM	1	2	↓-50%
20	SEKRETARIAT PT	4	2	↑50%
21	SEKRETARIAT RS	6	3	↑50%
22	CSSD	3	1	↑66,66%
23	GIZI	2	1	↓50%
24	REKAM MEDIS	4	3	↑25%
25	PENDAFTARAN	3	3	↓0%
26	DEPO FARMASI	6	5	↓16,66%
27	SECURITY	0	1	↓0%

28	LABORATORIUM	4	6	↑-50%
29	RADIOLOGI	3	3	↑0%
30	FISIOTERAPI	0	0	↓0%
31	IRNA 3C ANAK	3	2	↓33,33%
32	NS NICU	2	2	↓0%
33	LAUNDRY	2	1	↑100%
34	LANTAI 6A,7A,8A	2	0	↑100%
35	DRIVER	1	3	↓-100%
36	SIMRS	0	1	↑0%
37	ASURANSI CENTER	4	4	↓0%
38	DPW	0	1	↑0%
39	PIPP	0	0	↑0%

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang



Analisis :
 Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara Sehat dan dapur,poli

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
 3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.6 Komite dan Tim

3.6.1 Komite Mutu

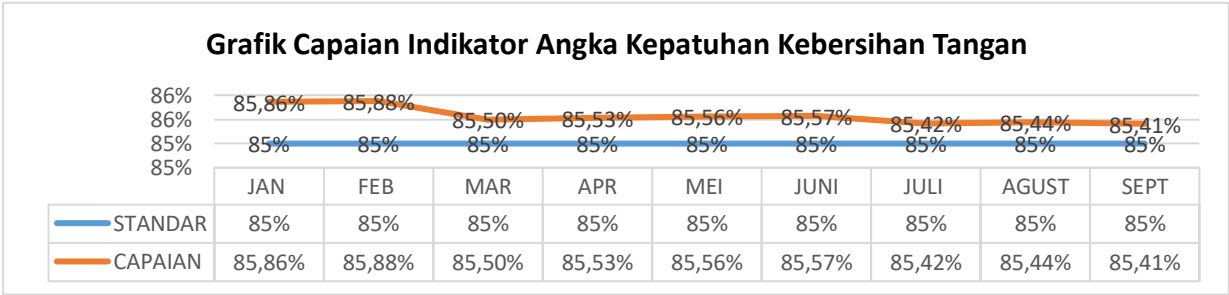
3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Juli '24	Agust '24	Sep '24
INDIKATOR MUTU NASIONAL											
1	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,86%	85,88%	85,5%	85,53%	85,56%	85,57%	85,42%	85,44%	85,41%

2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	93,04%	93,15%	93,3%	93,52%	93,73%	93,8%	93,92%	93,24%	92,15%
3	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,9%	81,2%	98,78%	100%	99,99%	99,95%	99,93%	99,96%	99,99%
4	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	95,2%	91,7%	95,74%	52,7%	63,8%	72,8%	80,97%	85,74%	88,65%
6	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	76,19%	79,08%	79,28%	78,06%	76,32%	78,47%	78,3%	79,04%	77,89%
8	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	98,69%	98,8%	98,46%	97,5%	98,9%	99,69%	100%	100%	100%
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	63,8%	71,62%	67,56%	66,7%	100%	92,5%	100%	100%	100%
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	98,47%	97,47%	99,54%	99,67%	95,86%	96,51%	98,64%	98,72%	95,94%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	93,15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	100%	91,89%	99,63%	99,82%	99,63%	100%	100%	99,38%	99,81%

3.6.1.1.1 Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

3.6.1.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

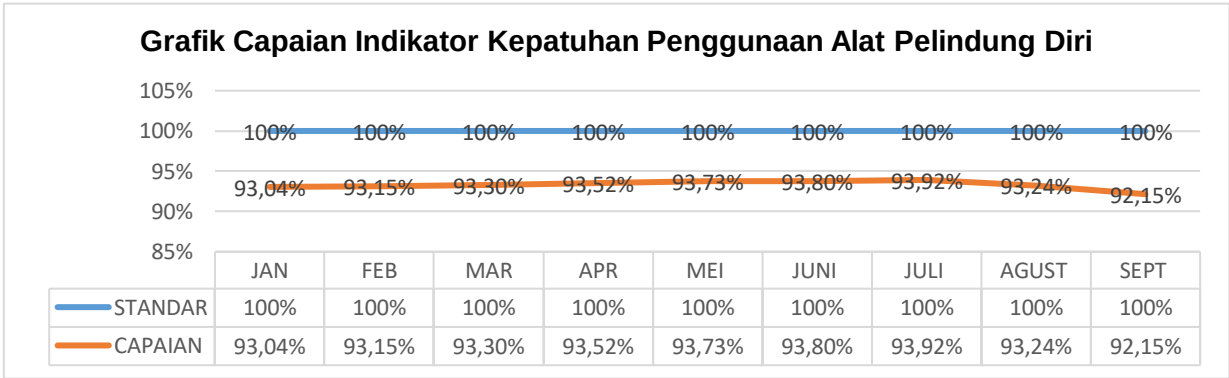


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.				
DO	1. Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit. 2. Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya. 3. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan. 4. Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan. 5. Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,41%, meskipun sedikit menurun dari bulan lalu. Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Selain itu, dari hasil supervise fasilitas kebersihan tangan masih ditemukan bed pasien atau troli tindakan yang tidak dilengkapi dengan handrub. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk Memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi DPJP.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-	1. Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan.	Seluruh petugas yang melakukan	Satu bulan

		masing diatas 85%.	2. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 3. Memberikan reward-pembelajaran. 4. Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.	pelayanan di RS.	
--	--	--------------------	---	------------------	--

3.6.1.1.2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

3.6.1.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

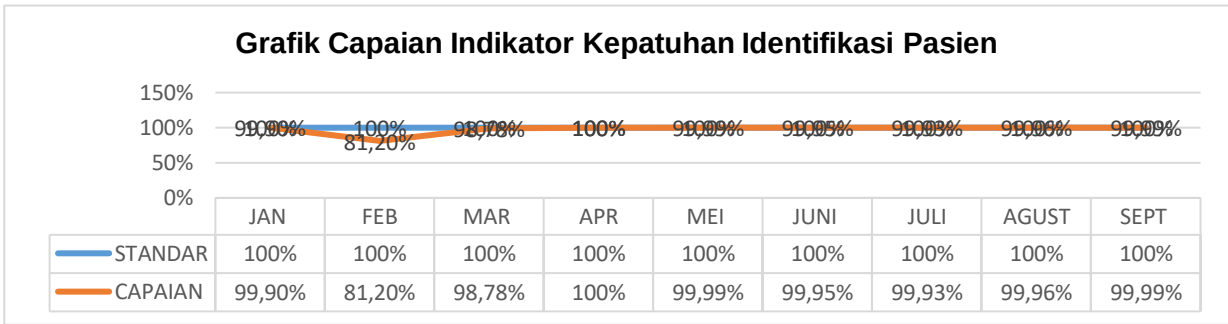


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.				
DO	1. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Menegur dan melakukan sosialisasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Menegur kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 5. Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 92,15% menurun dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, penggunaan APD oleh petugas nakes non dokter sudah cukup baik. Peningkatan APD juga ada pada unit CS Dimana petugas sudah tertib memakai sarung tangan kerja, tidak memakai handscoon saat membersihkan ruangan.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD unit minimal meningkat 2% pada bulan berikutnya.	1. Melakukan sosialisasi antar staf tentang penggunaan APD. 2. Menegur staf yang salah dalam penggunaan APD dan memberikan metode pembelajaran dengan mendata ketidak patuhan teman-teman di unitnya. 3. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

			bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. 4. Berkolaborasi dengan perawat untuk tidak memberikan handscoon jika CS meminta handscoon. Selain itu kolaborasi dengan Karu CS untuk menyediakan stok sarung tangan sesuai nama petugas dan 1 stok tiap ruangan untuk menanggulangi sarung tangan yang cepat rusak. 5. Menjadikan kebiasaan pemakaian APD sesuai dengan jenis transmisi penyakit dan tindakan yang akan dilakukan.		
--	--	--	---	--	--

3.6.1.1.3 Kepatuhan Identifikasi Pasien

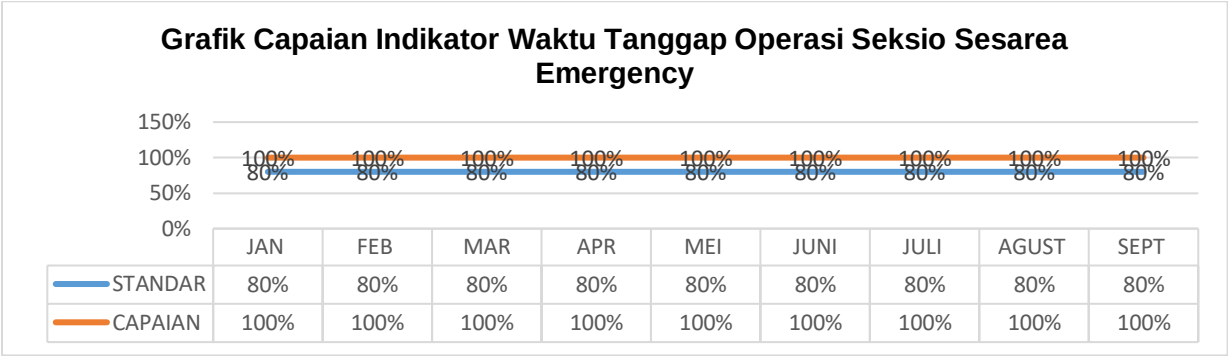
3.6.1.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024. Pada bulan April tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%. Pada bulan Mei hingga Juli capaian kembali menurun karena ditemukan kejadian insiden keselamatan pasien yang dilakukan oleh petugas pendaftaran yang salah mendaftarkan pasien karena tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien. Pada bulan September, capaian meningkat dari bulan Agustus walaupun masih belum mencapai standart 100%.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.4 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

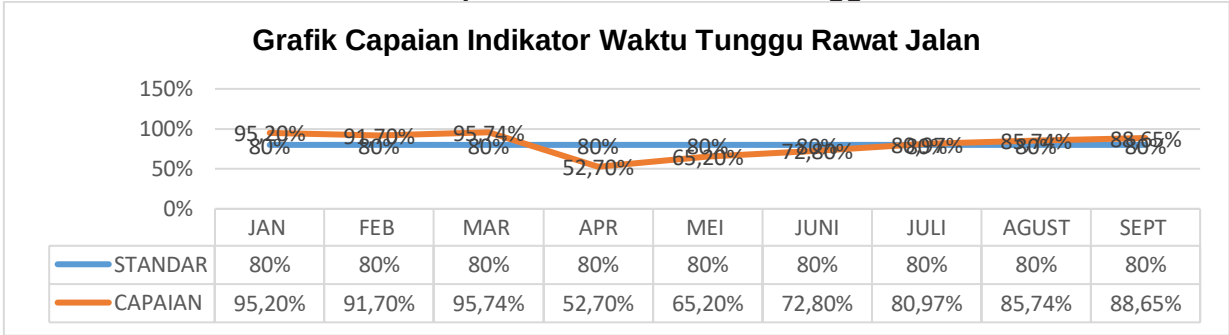
3.6.1.1.4.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Analisa Capaian :
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase waktu tanggap operasi seksio sesarea emergency pada bulan Januari hingga September tahun 2024 juga capaian indikator waktu tanggap operasi seksio sesarea Emergency telah mencapai standart. Tim IGD dan IKO melakukan koordinasi dan tindakan secara tepat dan cepat sehingga operasi bisa dilaksanakan.

3.6.1.1.5 Waktu Tunggu Rawat Jalan

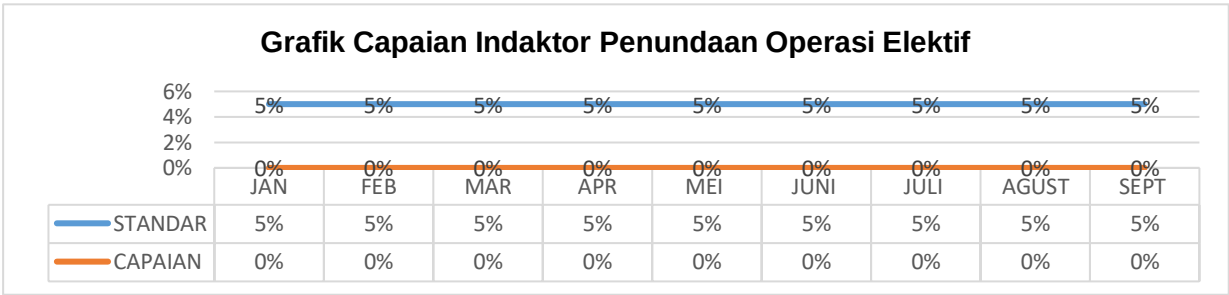
3.6.1.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator waktu rawat jalan hingga mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan teguran kepada DPJP yang sering datang terlambat.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024 telah mencapai standart jika dilihat dari input mutu pada SIMRS, tetapi nilai tersebut tidak sesuai dengan hasil supervisi dan juga keluhan terkait keterlambatan dokter untuk praktek poli. Berdasarkan hal tersebut, mutu melakukan penilaian dengan observasi langsung dan juga mengevaluasi keterlambatan DPJP. Pada bulan Mei tahun 2024 diketahui prosentase waktu tunggu rawat jalan 65,2%, bulan Juni 72,8%, bulan Juli 80,97%, bulan Agustus 85,74%, bulan September 88,65%. 1. Dpjp tepat waktu : dr. Aida, Sp.OG, dr. Akhmad Syahrir, Sp.N, dr. Ardhi Bustami, Sp. PD, dr, Dewi Maharani, Sp.S, dr. Dicky, Sp.A, dr.Vita, Sp.KK, dr.Humaira, Sp.OG, dr.Ira, Sp.JP, dr.Miryanti, Sp.JP, dr.Nimim, Sp.THT.KL, dr.Pradana,Sp.U, dr.Yoga, Sp.JP, dr.Zora, Sp.PD , dr Viona Sp.A, dr.Elvi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S 2. Dpjp Tidak tepat waktu : dr.Andi,Sp.B, dr.Andy,Sp.P, dr.Iwan,Sp.B, dr.Nurhadi,Sp.M, 3. Dpjp dengan tindakan lama : dr. Anton, Sp.B, dr.Huda, Sp.KJ, dr.Didid, Sp.KJ, dr.Eko, Sp.KFR.				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan.	Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan.	Waktu tunggu rawat jalan <80%	Mengevaluasi dpjp yang sering terlambat dan juga memberikan teguran melalui komdik dan SDM.	Manajemen RS	4. Satu bulan

3.6.1.1.6 Penundaan Operasi Elektif

3.6.1.1.6.1 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif

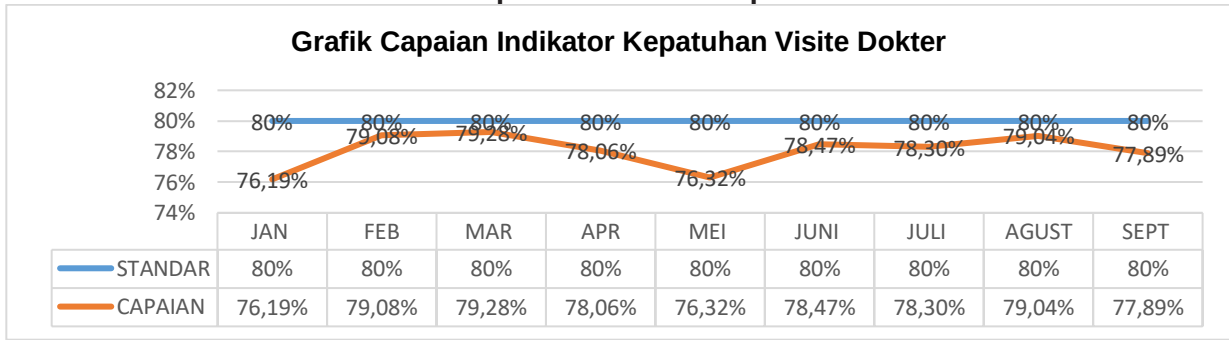


Analisa Capaian :

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa selama bulan Januari hingga September tahun 2024 tidak ada penundaan operasi elektif.

3.6.1.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

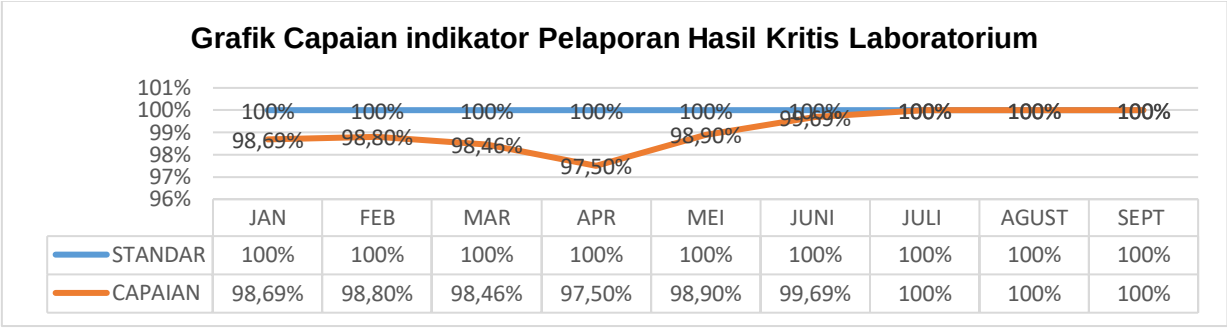
3.6.1.1.7.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan teguran kepada DPJP yang melakukan visite lebih dari jam 14.00				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari hingga September tahun 2024 belum mencapai standart. Dari hasil supervisi didaparka.nnya Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS lain karena RS Prima Husada tidak memiliki Dokter tetap. Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr, dr. Dicky,Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og, dr. Aida, Sp.Og, dr. Nimim, Sp.THT.KL, dr. Dokter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu)				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Mengevaluasi hasil setelah memberikan teguran kepada DPJP dan memberikan surat peringatan kepada DPJP yang masih visite di atas jam 14.00	Manajemen RS	Satu bulan

3.6.1.1.8 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

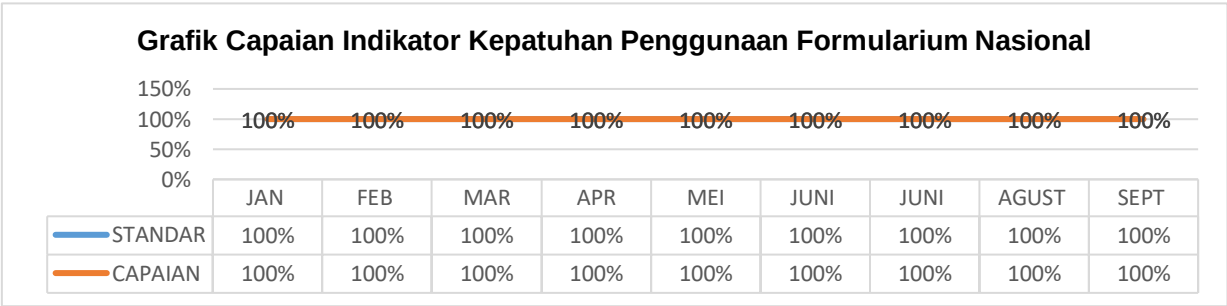
3.6.1.1.8.1 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan supervisi baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari hingga Juni tahun 2024 masih belum mencapai standart. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap. Capaian meningkat pada bulan Juli hingga September, pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Juli dan Agustus mencapai standart 100%.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	1. Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor 2. Memberikan teguran secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap.	1. Komite mutu 2. Kepala instalasi laboratorium	Satu bulan

3.6.1.1.9 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

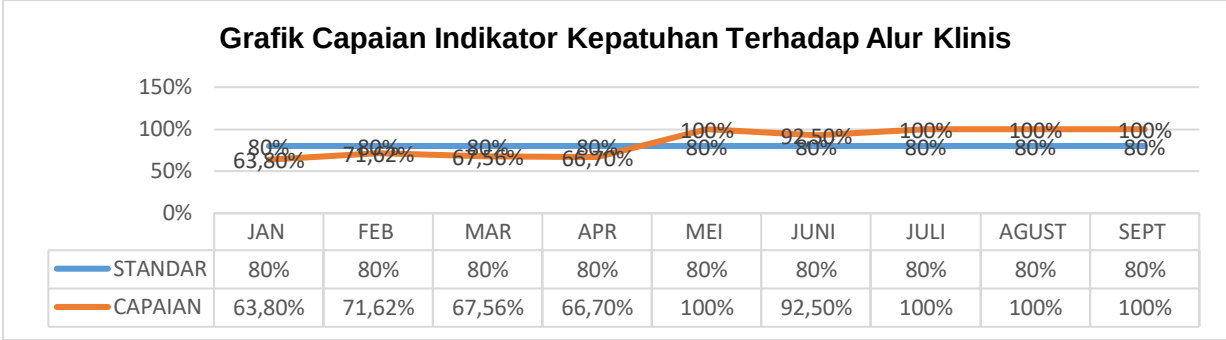
3.6.1.1.9.1 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Analisis Capaian :
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kepatuhan penggunaan Formularium Nasional pada Bulan Januari hingga September Tahun 2024 telah mencapai standart.

3.6.1.1.10 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

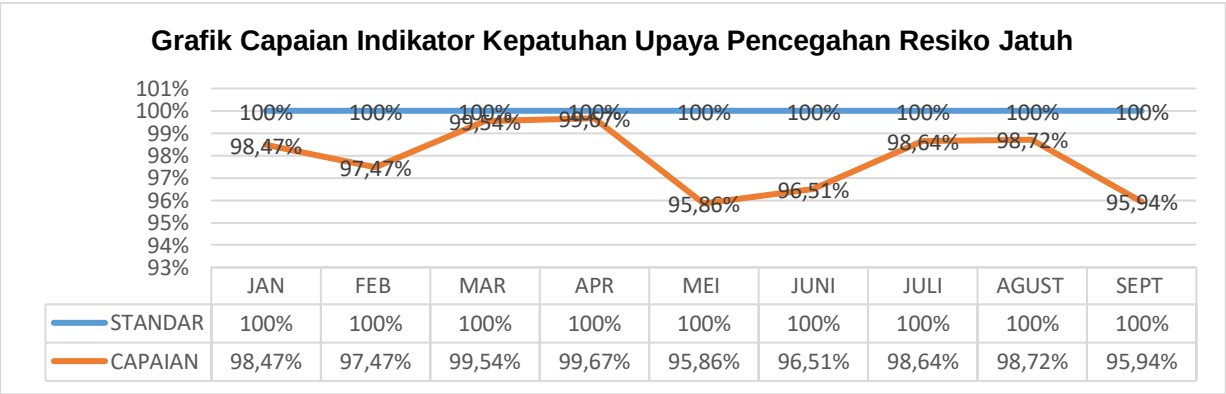
3.6.1.1.10.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis hingga mencapai standart 80%.				
DO	Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai dengan yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadap alur klinis dapat dianalisa.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator kepatuhan terhadap alur klinis masih belum stabil. Masih ditemukan profesi yang tidak memberikan asuhan sesuai dengan CP yang telah disepakati.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	Capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis bisa mencapai standart 80%.	Melibatkan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai dengan yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadap alur klinis dapat dianalisa.	Komite mutu	Satu bulan

3.6.1.1.11 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

3.6.1.1.11.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

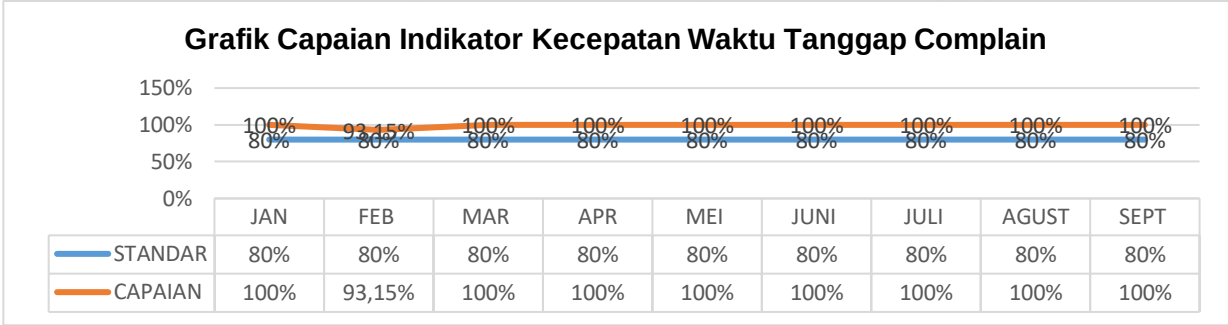


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga September tahun 2024 belum mencapai standart. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalumemasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.

ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	Satu bulan

3.6.1.1.12 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

3.6.1.1.12.1 Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

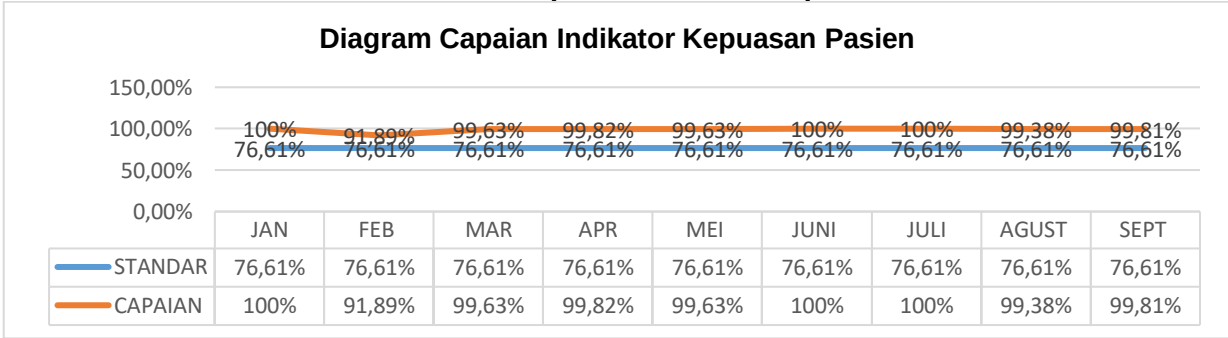


Analisis

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase kecepatan waktu tanggap komplain pada bulan Januari tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%, PIPP dan bidang terkait telah menanggapi dan menyelesaikan complain kurang dari 24 jam.

3.6.1.1.13 Kepuasan Pasien

3.6.1.1.13.1 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Analisis :

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa persentase kepuasan pasien pada bulan Januari hingga September tahun 2024 sudah mencapai standar

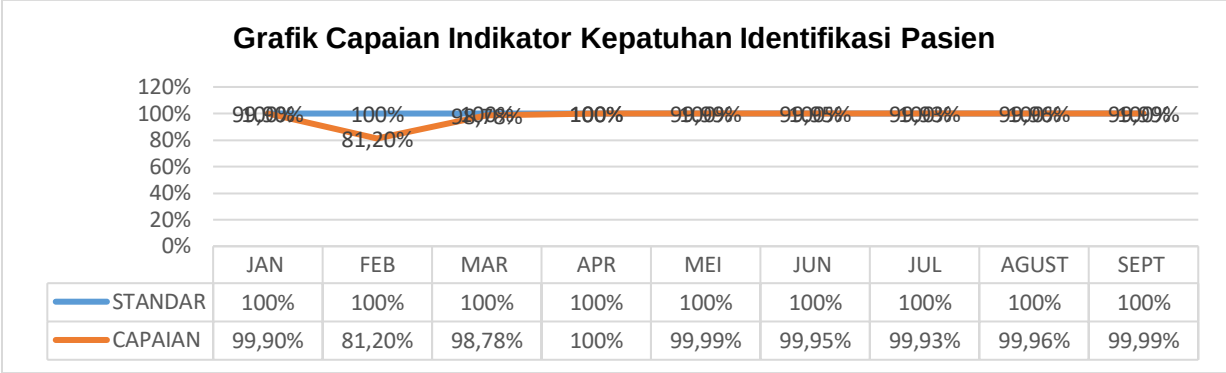
3.6.1.2 Indikator Mutu Prioritas

3.6.1.2.1 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGUST '24	SEP '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,9%	81,2%	98,78 %	100%	99,99 %	99,95 %	99,93 %	99,96%	99,99%
2	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	85,86%	85,88 %	85,5%	85,53 %	85,56 %	85,57 %	85,42 %	%	85,41%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	98,47%	97,47 %	99,54 %	99,67 %	95,86 %	95,51 %	98,64 %	98,72%	95,94%

3.6.1.2.1.1 Kepatuhan Identifikasi Pasien

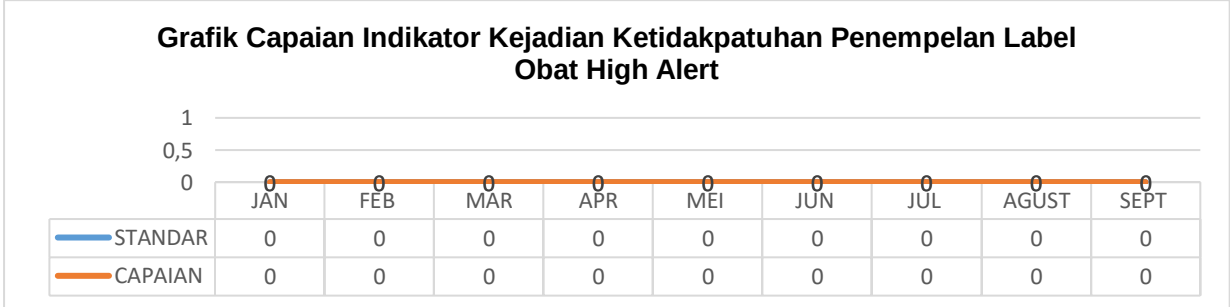
3.6.1.2.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024. Pada bulan April tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%. Pada bulan Mei hingga Juli capaian kembali menurun karena ditemukan kejadian insiden keselamatan pasien yang dilakukan oleh petugas pendaftaran yang salah mendaftarkan pasien karena tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien. Pada bulan September, capaian kembali meningkat menjadi 99,99%.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.2.1.2 Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

3.6.1.2.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

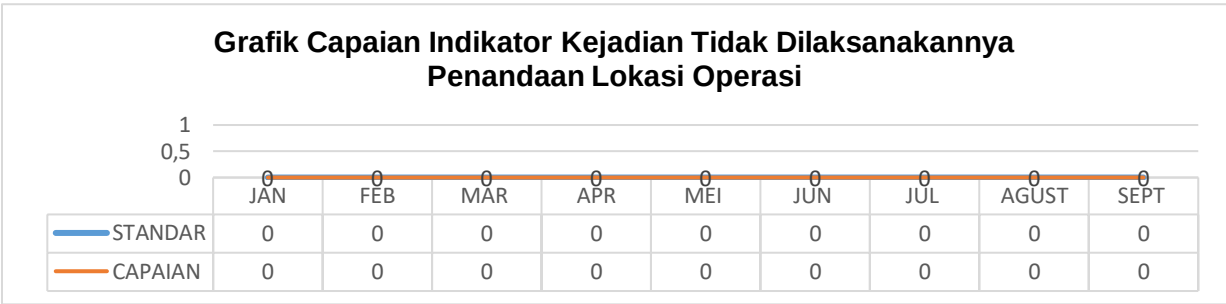


Analisis

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui persentase ketidakpatuhan penempelan label obat high alert pada bulan Januari hingga September tahun 2024 telah mencapai standar.

3.6.1.2.1.3 Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi

3.6.1.2.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi

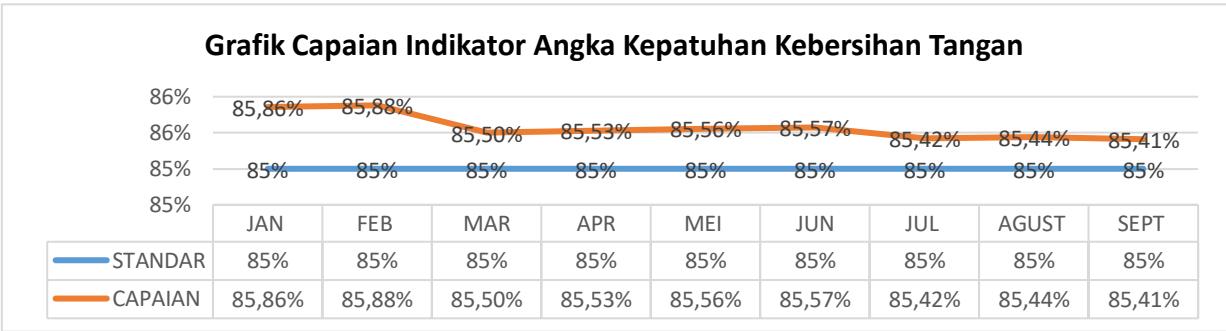


Analisis :

Berdasarkan data diatas dapat diketahui persentase tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi pada bulan Januari hingga September tahun 2024 telah mencapai standar.

3.6.1.2.1.4 Kepatuhan Kebersihan Tangan

3.6.1.2.1.4.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

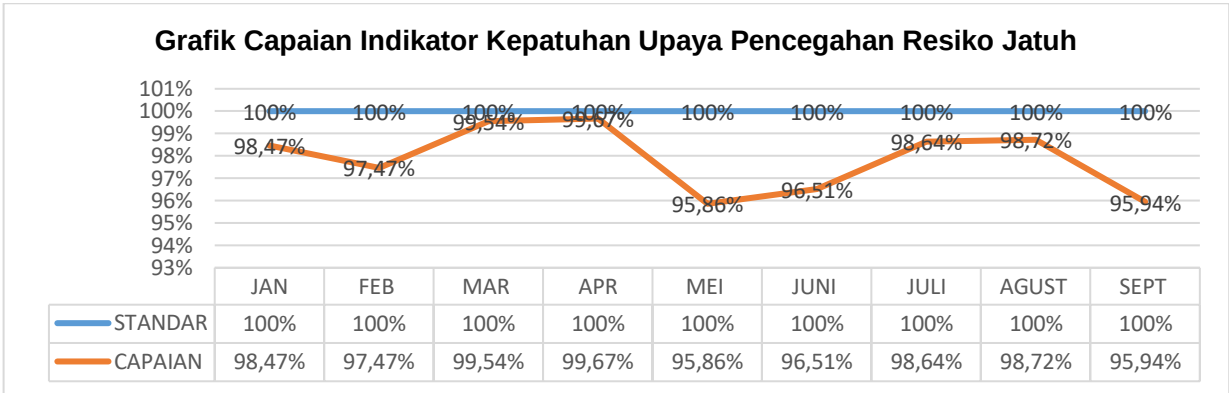


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan ± 5% setiap bulannya.				
DO	1. Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit. 2. Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya. 3. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan. 4. Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan. 5. Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,41%. Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Selain itu, dari hasil supervise fasilitas kebersihan tangan masih ditemukan bed pasien atau troli tindakan yang tidak dilengkapi dengan handrub. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk Memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi DPJP.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	1. Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan. 2. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 3. Memberikan reward-pembelajaran.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

			4. Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.		
--	--	--	---	--	--

3.6.1.2.1.5 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

3.6.1.2.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga September tahun 2024 belum mencapai standart. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalumemasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	Satu bulan

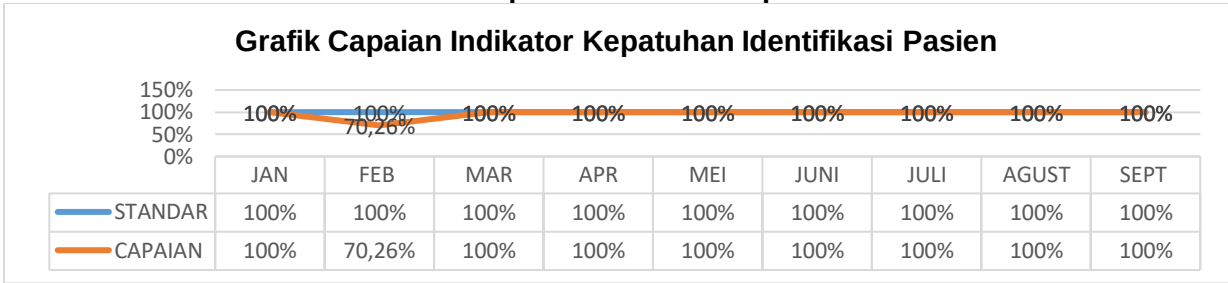
3.6.1.2.2 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

NO	JUDUL	STAN D	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	70,26 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,81 %	69,59 %	73,43 %	79,11 %	78,13 %	74,88 %	71,82 %	72,73 %	76,95%

6	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	41,48 %	50,77 %	56,18 %	61,29 %	58,52 %	54,92 %	50,64 %	53,25 %	59,94%
7	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
8	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kekosongan stok farmasi	0%	0,27%	0,36%	0,53%	0,7%	0%	0%	0%	0%	0%

3.6.1.2.2.1 Kepatuhan Identifikasi Pasien

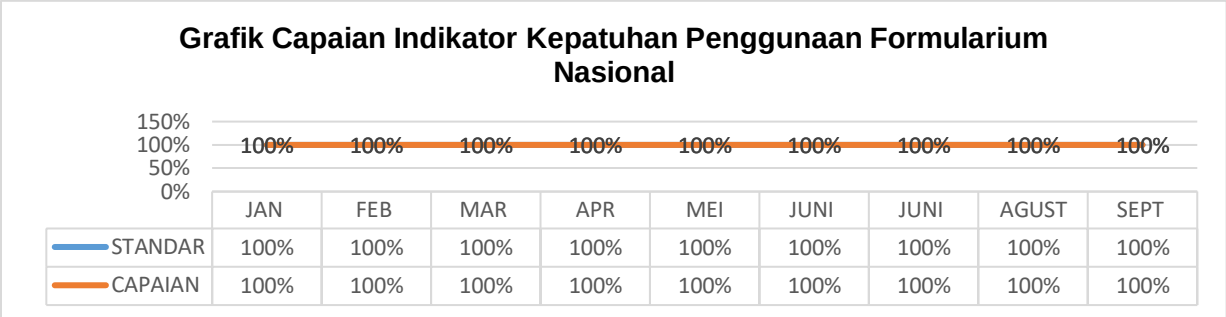
3.6.1.2.2.1.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien masih belum mencapai standart di bulan Februari, pada bulan Januari hingga September capaian telah mencapai standart 100%. Dari hasil supervisi didapatkan masih ditemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat ketika akan melakukan tindakan. Misalnya Ketika keluarga pasien mengambil obat dan tidak tahu tanggal lahir pasien beberapa petugas tetap memberikan obat tersebut dan juga masih ada IKP kesalahan pemberian obat karena petugas tidak melakukan identifikasi dengan benar.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Meningkatkan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.1.2.2.2 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

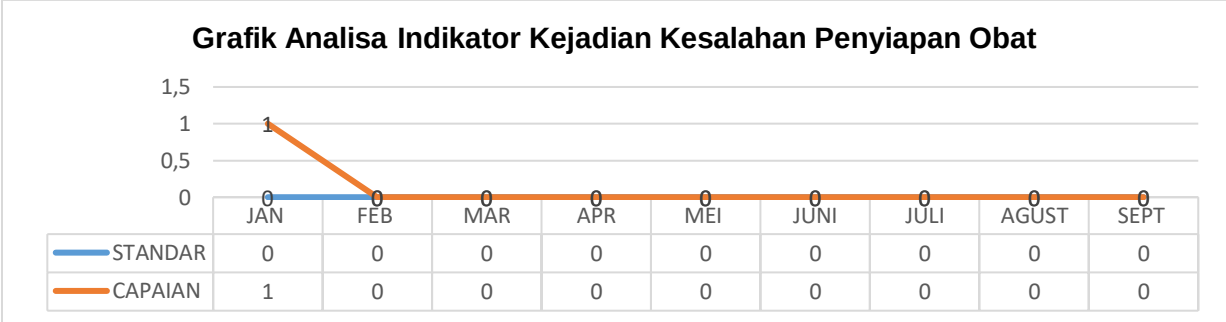
3.6.1.2.2.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Analisis Capaian :
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa persentase kepatuhan penggunaan formularium nasional pada bulan Januari hingga September tahun 2024 telah mencapai standart.

3.6.1.2.2.3 Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat

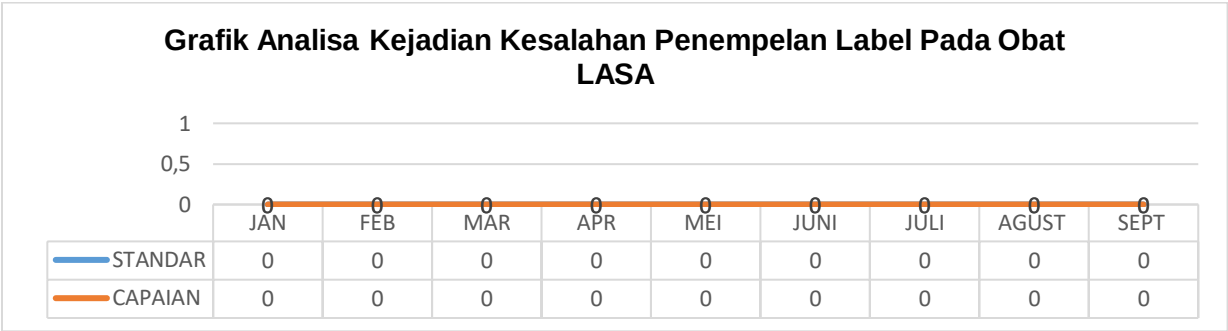
3.6.1.2.2.3.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat yang pada bulan ini telah mencapai standart.				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit farmasi secara berkelanjutan 2. Kepala unit farmasi harus menindaklanjuti anggota yang melakukan kesalahan penyiapan obat 3. Memberikan proses pembelajaran untuk petugas yang melakukan kesalahan pemberian obat				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa kesalahan pemberian obat masih terjadi pada bulan Januari tahun 2024. Kesalahan pemberian obat terjadi karena petugas tidak teliti dalam melakukan penyiapan obat. Pada bulan Februari hingga September tahun 2024 diketahui tidak ada kejadian kesalahan penyiapan obat.				
ACTION/R TL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKS ANA	WAKTU
Mempertahan kan capaian kejadian kesalahan pemberian obat	Mempertahan kan capaian kejadian kesalahan pemberian obat	Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat	1. Meningkatkan supervisi pada petugas di unit farmasi secara berkelanjutan 2. Kepala unit farmasi harus menindaklanjuti anggota yang melakukan kesalahan penyiapan obat 3. Memberikan proses pembelajaran untuk petugas yang melakukan kesalahan pemberian obat	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.1.2.2.4 Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA

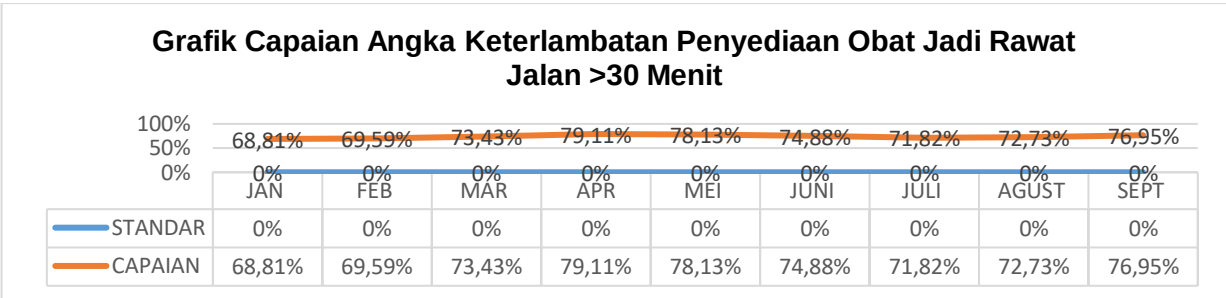
3.6.1.2.2.4.1 Grafik Analisa Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA



Analisis Capaian :
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan tidak ditemukan kejadian kesalahan penempelan pada obat LASA pada bulan Januari hingga September tahun 2024

3.6.1.2.2.5 Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit

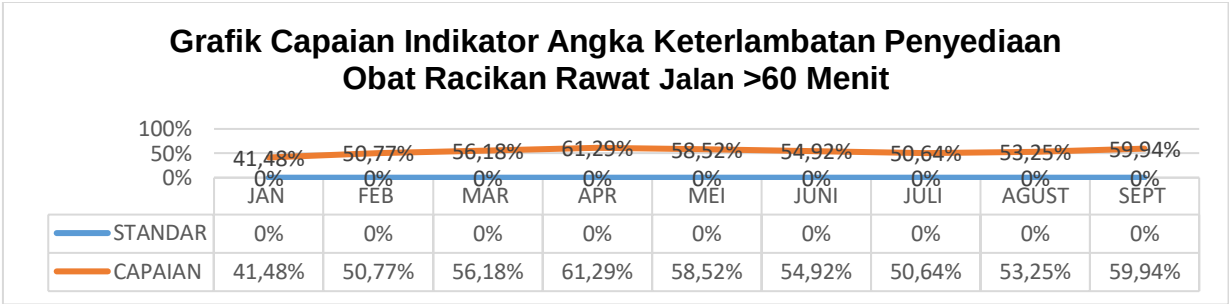
3.2.1.2.2.5.1 Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat jadi rawat jalan >30 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.				
DO	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena : 1. Pasien cenderung naik beberapa hari. 2. Tanda tangan elektronik diperlakukan untuk semua resep, termasuk rawat jalan IGD dan rawat jalan non kronis sehingga petugas farmasi memerlukan waktu untuk menyesuaikan				
ACTION/RT L	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 30 menit .	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.1.2.2.6
Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit

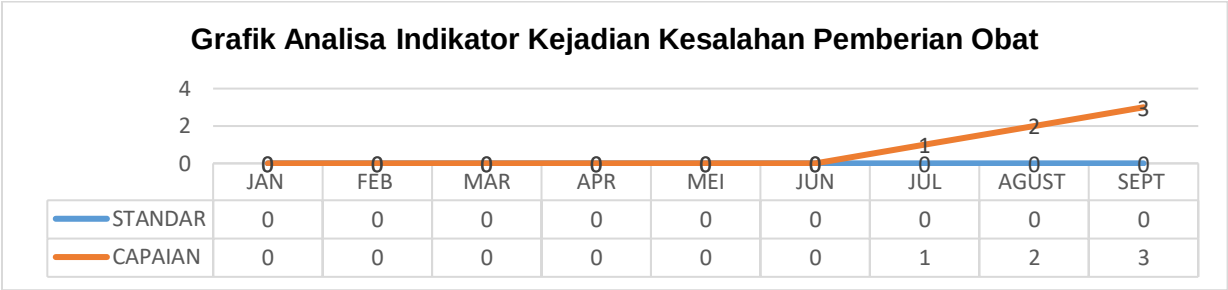
3.6.1.2.2.6.1
Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat racikan rawat jalan >60 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.				
DO	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena : 1. Pasien cendereung naik beberapa hari 2. Tanda tangan elektronik diperlakukan untuk semua resep, termasuk rawat jalan IGD dan rawat jalan non kronis sehingga petugas farmasi memerlukan waktu untuk menyesuaikan				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit.	Mengurangi angka keterlambat an penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit.	Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 60 menit .	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.1.2.2.7 Kejadian Kesalahan Pemberian Obat

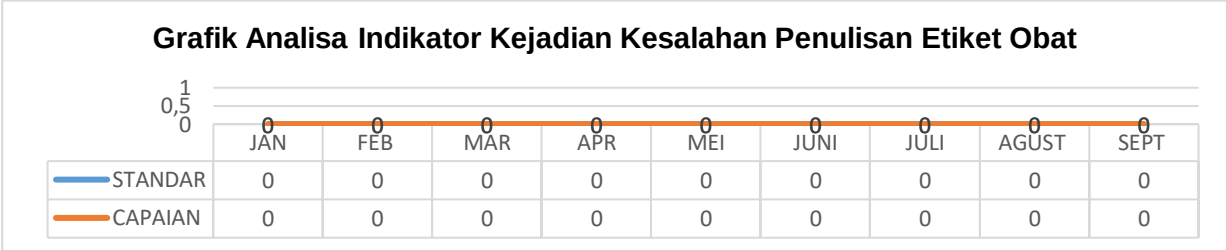
3.6.1.2.2.7.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Pemberian Obat



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka kejadian kesalahan pemberian obat hingga mencapai standart yaitu 0 kejadian				
DO	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien yang mendapatkan resep 2. Melakukan rapat berasama kepala instalasi farmasi guna melakukan supervisi terkait kepatuhan identifikasi pasien dalam proses pemberian obat.				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa selama bulan Januari hingga Juni tahun 2024 tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat. Pada bulan Juli tahun 2024 ditemukan 1 kejadian kesalahan pemberian obat, pada bulan Agustus ditemukan 2 kejadian kesalahan pemberian obat dan pada bulan September terjadi 3 kejadian kesalahan pemberian obat. Kesalahan pemberian obat disebabkan karena petugas tidak teliti mulai proses penyiapan hingga pemberian obat ke pasien.				
ACTION/R TL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka kejadian kesalahan pemberian obat	Mengurangi angka kejadian kesalahan pemberian obat	Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 60 menit .	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak melakukan identifikasi dengan benar.	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.1.2.2.8 Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat

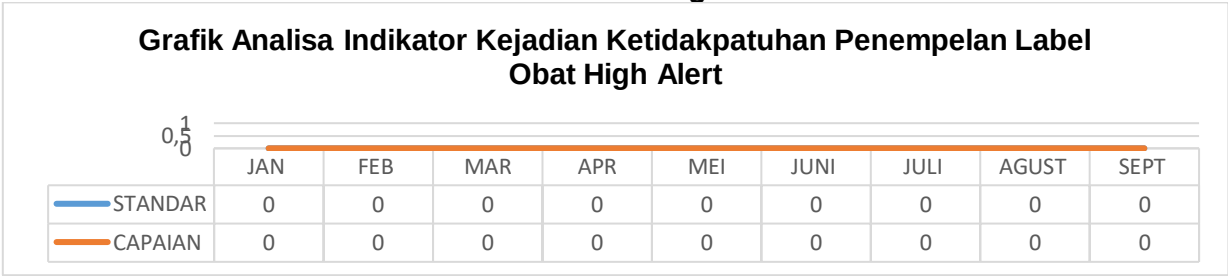
3.6.1.2.2.8.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat



Analisis :
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian kesalahan penulisan etiket obat sejak bulan Januari hingga September tahun 2024.

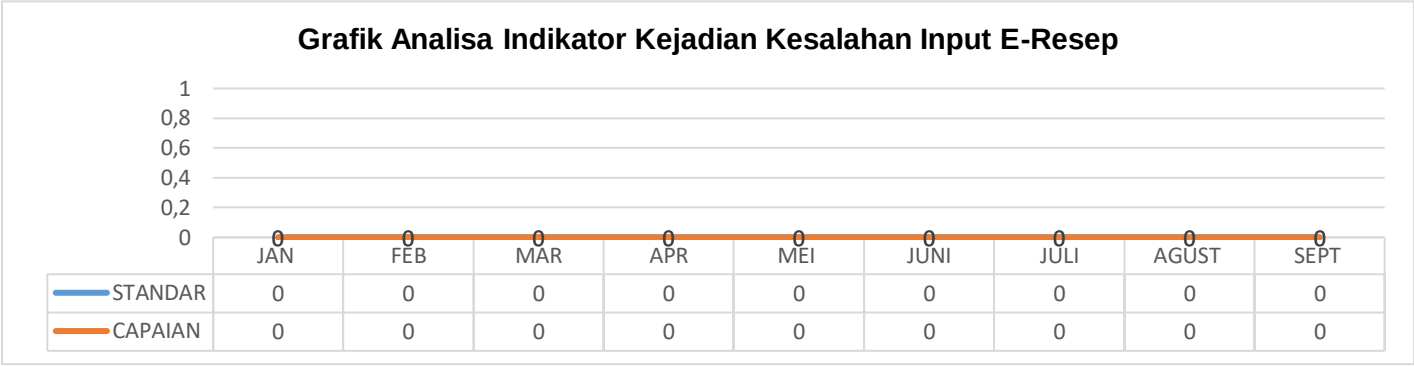
3.6.1.2.2.9 Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

3.6.1.2.2.9.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert



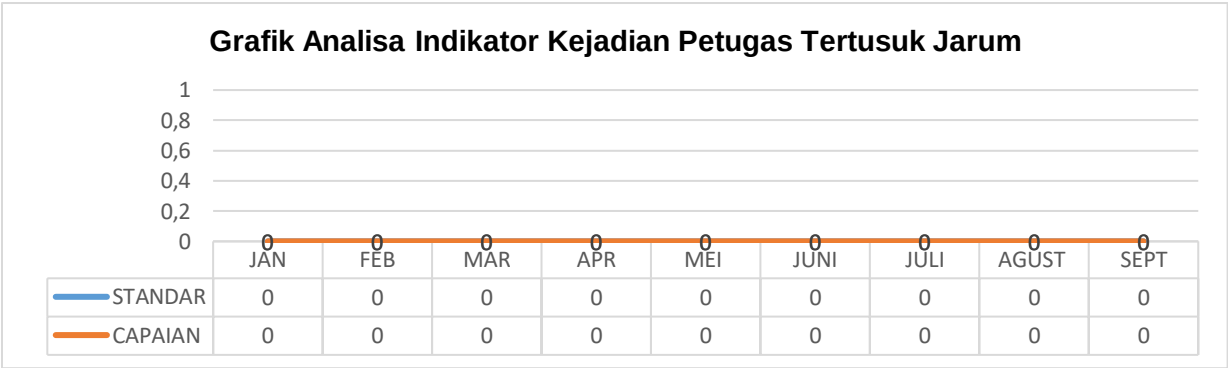
Analisis:
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidakpatuhan penempelan obat high alert sejak bulan Januari hingga September tahun 2024.

3.6.1.2.2.10 Kejadian Kesalahan Input E-Resep
3.6.1.2.2.10.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Input E- Resep



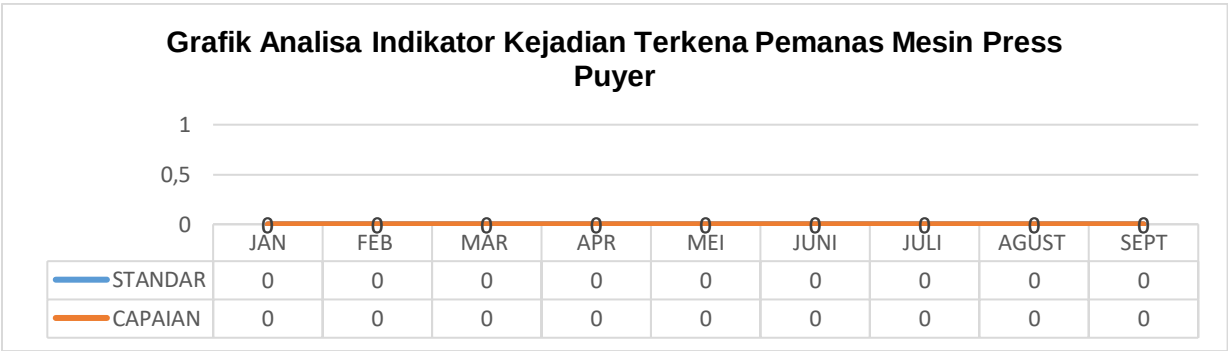
Analisis :
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian kesalahan input e-resep pada bulan Januari hingga September tahun 2024.

3.6.1.2.2.11 Kejadian Petugas Tertusuk Jarum
3.6.1.2.2.11.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum



Analisis:
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian petugas tertusuk jarum sejak bulan Januari hingga September tahun 2024.

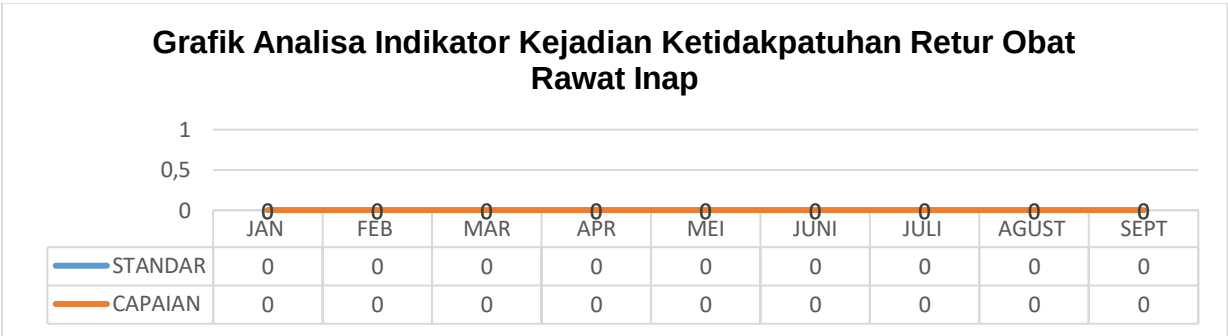
3.6.1.2.2.12 Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer
3.6.1.2.2.12.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer



Analisis :
Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian terkena pemanas mesin press puyer sejak bulan Januari hingga September tahun 2024.

3.6.1.2.2.13 Kejadian Ketidapatuhan Retur Obat Rawat Inap

3.6.1.2.2.13.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidapatuhan Retur Obat Rawat Inap

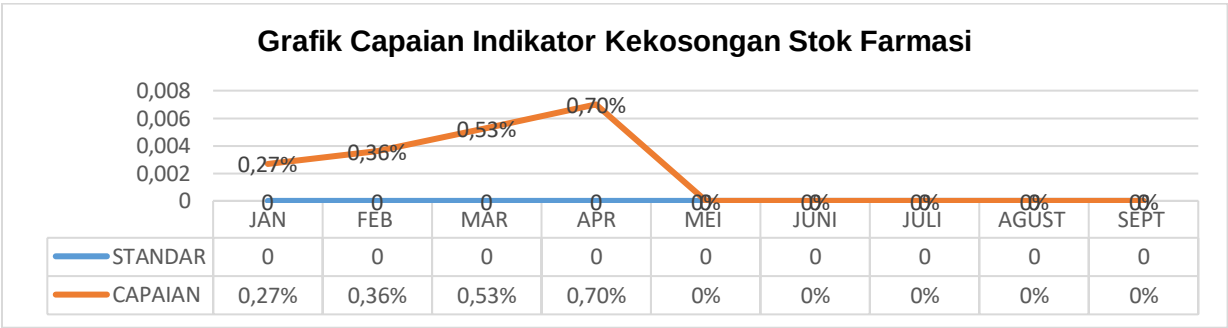


Analisis Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidapatuhan retur obat rawat inap sejak bulan Januari hingga bulan September tahun 2024.

3.6.1.2.2.14 Kekosongan Stok Sediaan Farmasi

3.6.1.2.2.14.1 Grafik Capaian Indikator Kekosongan Stok Farmasi

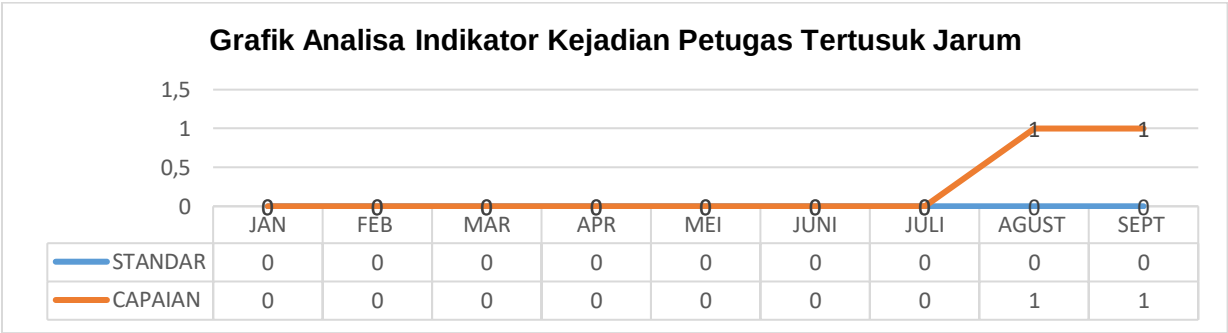


PLAN	Kami berencana Menurunkan angka kekosongan stok farmasi				
DO	Melakukan Analisa perhitungan waktu pengajuan hingga barang datang dengan kebutuhan, sehingga petugas dapat memperkirakan sediaan yang harus segera diinput pada pengadaan.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui masih terjadi kekosongan stok farmasi pada bulan Januari hingga April. Pada bulan Mei hingga September masih ada kekosongan obat teratasi dengan adanya substitusi sehingga tidak mengganggu pelayanan. Kekosongan obat farmasi disebabkan karena : - Barang yg sudah dipesan di pbf belum dikirim karena : - Barang sedang kosong distributor - Sp yg dikirim ke salesman belum terinput di data pemesanan pbf - Barang memang sedang kosong nasional karna bahan baku tidak ada - Human eror, bisa jadi terselip di defecta jd belum minta ke pengadaan - Barang yg awalnya slow moving, tiba2 jd fast moving. Banyak dipakai oleh dpjp ybs, padahal sebelumnya jarang sekali - Ada barang tertentu yg sedang dilakukan penyesuaian harga bpjs jadi belum bisa di jual oleh pbf - Ijin edar obat tertentu belum di setuju bpom, seperti kasus per sirup an kemarin				
ACTION/R TL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka kekosongan stok farmasi	Mengurangi angka kekosongan stok farmasi	Tidak ada kekosongan stok obat di farmasi	Memperbaruhi surat perjanjian kerjasama yang berisi tentang ketepatan waktu pengiriman obat setelah gudang farmasi order.	1. Kepala Instalasi Farmasi 2. Pengadaan Farmasi PT	Satu bulan

3.6.1.2.3 Manajemen Resiko

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

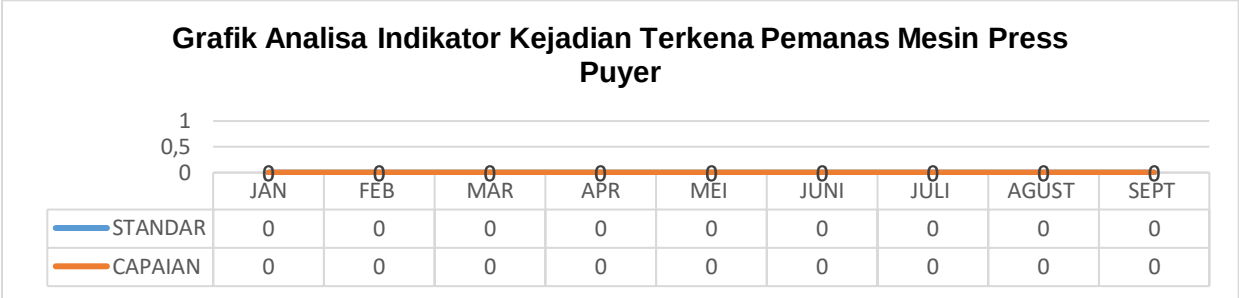
3.6.1.2.3.1 Kejadian Petugas Tertusuk Jarum
3.6.1.2.3.1.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum



PLAN	Kami berencana untuk menurunkan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan) seminimal mungkin (0).				
DO	1. Menginputkan laporan pada surveilans SIMRS dan kolaborasi dengan K3RS dan SDM. 2. Mengevaluasi keadaan luka pasien dan kondisi penyakit sumber pajanan. 3. Melakukan supervise terkait pengolahan benda tajam dan penyuntikan yang aman. 4. Melakukan supervise terkait penggunaan APD yang benar sesuai transmisi dan tindakan yang akan dilakukan.				
STUDY	Pada bulan Agustus terdapat 1 kejadian petugas tertusuk jarum dan pada bulan September terdapat 1 kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Melakukan penyuntikan aman.	Mempertahankan capaian kejadian pajanan 0 kejadian.	Tercapainya standar pajanan 0 kejadian setiap bulannya.	1. Mempertahankan kegiatan penyuntikan yang aman karena sudah meminimalisir kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien. 2. Supervisi petugas terkait pembuangan jarum bekas pasien.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.2.3.2 Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer

3.6.1.2.3.2.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer



Analisis:
Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian terkena pemanas mesin press puyer sejak bulan Januari hingga bulan September tahun 2024.

3.6.1.3 Mutu Unit

3.2.1.3.1 Instalasi Gawat Darurat

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	96,25 %	100%	100%	100%	100%	97,35 %	100%	100%
2	Angka Tidak Terpasangnya Gelang Identitas Pasien IGD	0%	0%	0,17%	0%	0,28%	0,15%	0,67%	0,15%	0,29%	5,2%
3	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,08%
4	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,7%	0,85%	0,61%	0,73%	0,5%	2,61%	1,62%	1,82%	2,82%
5	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergenci	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.2.1.3.2 IRNA 2A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%					97,64%	100%	100%	-	-
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%					45,54%	76,92%	90%	-	-
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%					-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%					100%	100%	100%	-	-
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%					0%	0%	0%	-	-
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%					100%	100%	100%	-	-
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%					100%	100%	100%	-	-

3.2.1.3.2 IRNA 2C

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	93,41 %	100%	97,22 %	100%	100%	100%	100%	100%	94,32%
2	Kepatuhan Waktu Visite	≥80%	80%	73,53	74,84	73,57	73,23	62,6%	62,6%	62,6%	81,55%

	Dokter			%	%	%	%				
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%	-	-	0%	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	96,8%	100%	95,93 %	100%	93,75 %	100%	100%	100%	87,5%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	1,03%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	94,7%	100%	100%	97,14 %	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	86,49 %	86,36 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.3 IRNA 3A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	93,18 %	89,4%	91,28 %	80,29 %	87,79 %	91,45 %	86,99 %	84,21%	82,22%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,61 %	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,75 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	84,96 %	87,65 %	82,43 %	83,94 %	89,17 %	91,45 %	93,15 %	92,11%	86,67%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.4 IRNA 4A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	94,84 %	78,23 %	86,54%	86,84 %	89,19 %	95%	95%	92,86%	90,16%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	71,83 %	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1,85%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	100%	90,75 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.5 IRNA 3C ANAK

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100 %	100%	100%	100%	97,4%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0,37%	0%	0,39%	0%	0,94%	0,43%

6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.6 IRNA 5C

NO	JUDUL	STAN D	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	62,07 %	66,86 %	64,86 %	55,35 %	67,48 %	67,48 %	66,67 %	68,42%	75,76%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,33 %	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,54%	0,55%	0,74%	0%	0%	0%	0%	0,52%	0,52%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	99,13 %	97,75 %	93,02 %	96,38 %	95,58 %	95,58 %	94,59 %	96,33%	95,99%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	86,49 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.7 IRNA 6A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85,71 %	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	61,11 %	79,63 %	84,92 %	83,21 %	82,79 %	76.47 %	71,01 %	79,69%	77,27%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,39%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,7%	3,57%	3,85%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.8 IRNA 7A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	97,92 %	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	58,2 2%	76,67 %	75%	84,56 %	76,74 %	63,78 %	72,73 %	72,44%	69,54%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	96,6 7%	100%	100%	100%	97,12 %	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0,7%	0%	0,9%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100 %	86,52 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	91,09 %	100%	100%	100%

3.2.1.3.2.9 IRNA 8A											
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	92,21 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	54,39%	78,49 %	81,45 %	84,56%	71,76%	75,93 %	82,14%	89,23%	90,14%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	99,15 %	100%	100%	96,72%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	98,91 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2.10 ICU											
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '23	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	98,2%	100%	100%	100%	100%	100%	98,5%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	98,7%	100%	100%	94,4%	98,8%	97,2%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%									
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	81,8 %	92,53 %	86%	90,4%	100%	100%	80%	90,2%	73,7%
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	83,33%	100%
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU.	100%	100%	100%	100%	100%	90,7%	95,4%	94,4%	100%	100%
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	-	0%	0%	0%	0%	0%	100%	-	0%

3.2.1.3.2.11 HCU											
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-		
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	96,3%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk HCU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	%	0%

3.2.1.3.2.12 IRJA											
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,75 %	100%	95,71 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Waktu tunggu rawat jalan	≥80%	95,2%	91%	95,74 %	52,7%	63.8%	72,8%	80,97 %	85,74%	88,65%
3	Ketepatan Waktu Jam	100%	84,42	82,35	84,04	84,04	70,04	81,72	81,72	81,88%	81,79%

	Praktek Dokter		%	%	%	%	%	%	%		
4	Angka rujukan horizontal FKRTL	0%	0%	0%	0%	0%	37,03 %	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.13 Maternitas

NO	JUDUL	STAN D	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	99,44 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,63 %	100%	94,67%	100%
6	Kejadian keterlambatan operasi sectio caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	Angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	Kejadian perdarahan post partum	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
10	Kejadian partus lama	0	1	0	0	0	0	3	4	1	0
11	Kejadian eklamsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian pre eklamsi	0	3	1	0	0	0	0	0	4	5
13	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Angka ketidaklengkapan 10T pada ANC	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
15	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	3,82 %	0,83%	3,6%	8,49%	6,41%	5,69%	10,85 %	11,38%	5,77%
16	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	3,82 %	0,83%	3,6%	8,49%	6,41%	5,69%	10,85 %	11,38%	5,77%
17	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0,73%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.14 NICU

NO	JUDUL	STAN D	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥80%	85,92 %	90,63 %	84,72 %	90,8%	84,82 %	82,35 %	88,79 %	81,01%	84,81%
5	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	4,17%	3,26%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kematian Bayi	0%	0%	0%	0%	0%	3,7%	1,28%	4,55%	0%	7,41%
7	Kejadian tidak dilakukannya IMD (inisiasi menyusui dini) pada bayi baru lahir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.15 IKO											
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10
5	Kejadian konversi tindakan anestesi dari local/regional ke general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kejadian tidak dilaksanakannya asesmen pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kejadian tidak dilaksanakannya pemantauan diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kejadian tidak lengkapnya asesmen pra bedah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kejadian ketidaklengkapan formulir penandaan pasien operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Angka ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC (indikator baru 2024)	0%	0%	0%	23,08 %	0%	0%	20,3 %	20,96 %	23,81 %	0%

3.2.1.3.2.16 Laboratorium											
NO	JUDUL	STAN D	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	98,69 %	98,8 %	98,48 %	97,5%	98,9%	99,68 %	100%	98,03 %	100%
3	Kejadian Pengulangan Phlebotomi Saat Sampling	0	3	2	4	2	2	12	15	11	4
4	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5	Waktu Tunggu Hasil Laboratorium >140 menit (Indikator baru 2024)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.17 Radiologi

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,54 %	100%	100%	100%
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	3,72%	3,61%	2,65%	3,81%	3,81%	1,63%	0%	0%	0%
3	Kejadian Ketidakpatuhan persiapan pasien USG (Indikator baru 2024)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.1.3.2.18 Gizi

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,76 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
3	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kejadian Pasien Tidak Mendapat Makan	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1

3.2.1.3.2.19 Farmasi

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100 %	70,26 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,8 1%	69,59 %	73,43 %	79,11 %	78,13 %	75,45 %	71,82 %	71,82%	76,95%
6	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	41,4 8%	50,77 %	56,18 %	61,29 %	58,52 %	54,92 %	50,64 %	50,64%	59,94%
7	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
8	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.20 Pengadaan Farmasi

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0,27%	0,36%	0,53%	0,7%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.21 PPI

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,24%	0,8%	0,27%	0 %	0,24 %	0 %	0,25 %	0,52%	0,54%
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,28%	0,22%	0,4%	0,25%	0,34%	0,15%	0,15%	0,04%	0,15%
6.	Angka Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,86%	85,88%	85,5%	85,53 %	85,62%	85,62%	85,42%	%	%
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,04%	93,05%	93,3%	93,52%	93,73%	93,73%	93,92%	93,24%	92,15%
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	91,91%	92,09%	92,22%	92,29%	92,19%	92,19%	92,18%	92,07%	91,94%
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

3.2.1.3.2.22 PIPP

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24
1	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Angk Terhubungnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Operasi Dengan Mobile JKN										
3	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	93,15 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepuasan Pasien	76,61%	100%	91,89 %	99,63 %	99,82 %	99,63 %	99,63 %	99,63 %	99,38 %	99,81%
5	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%	86,94 %	75,31 %	57,76 %	52,92 %	55,36 %	55,36 %	43,54 %	38,63 %	44,13%

3.2.1.3.2.23 SDM

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	98,99 %	98,97 %	99,14 %	98,76 %	95,9%	98,93 %	98,96 %	99,62%	98,66%
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	3,32%	3,34%	2,97%	14,3%	4,12%	5,09%	3,88%	3,48%	3,48%

3.2.1.3.2.24 Rekam Medis

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24
1.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.	Angka Kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap	0%	-	-	96,65 %	93,04 %	94,08 %	93,81 %	93,56 %	92,8%	91,52%
3.	Kejadian kendala pada SIMRS dalam upaya menunjang pelayanan rekam medis rekam medis elektronik (Indikator baru 2024)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien di SIMRS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%	0%	0%	7,06 %	9,44 %	7,88%	5,68 %	4,56 %	5,91%	8,35%

3.2.1.3.2.25 Keuangan

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24
1	Angka keterlambatan pembayaran klaim	0%	7,7%	6%	3,86 %	10,98 %	1,57 %	0,78 %	0,81 %	1,1%	0,9%
2	Kejadian piutang umum atas permintaan sendiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Angka keterlambatan pembayaran klaim BPJS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.26 K3RS

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.27 Asuransi Center

NO	JUDUL	STAN D	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24
1	Angka pending klaim BPJS	0%	1,07%	1,04 %	0,78 %	0,97 %	0,87%	0,62%	0,89 %	0,26%	0,26%
2	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	1,69%	1,04 %	2,17 %	1,66 %	2,55%	1,66%	1,31 %	2,21%	2,21%
3	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS (Indikator baru 2024)	100%	9,73%	0,57 %	0,44 %	0,42 %	0,47%	0,46%	0,55 %	0,26%	0,26%
4	Kejadian Pasien Tidak Di SEP	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1

3.2.1.2.28 IPSRS

NO	JUDUL	STAN D	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	100%	91%	89%	89,47 %	91,67 %	91,67 %	91,84 %	100%	100%

3.2.1.3.2.29 UMUM

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	3	7	4	3	6	6	2	2	3
2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	11	4	5	2	4	5	9	6	1

3.2.1.3.2.30 Cleaning Service

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	0,25 %	1,67 %	29,1 %	28,95 %	91,6 %	3,45 %	8,7%	18,75 %	0%

3.2.1.3.2.31 Kesekretariatan

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 5 setiap bulannya	0%	34,21 %	0%	20,69 %	78,38 %	48,72 %	26,67 %	36,59 %	42,5%	40%
2	Angka ketidaklengkapan	0%	25%	100%	62,5 %	71,83 %	56,25 %	41,67 %	0%	68,75 %	31,25 %

	pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja										
3	Angka tindaklanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	65%	-	60,71 %	86,21 %	22,73 %	17,86 %	0%	12,82 %	33,33 %

3.2.1.3.2.31 Laundry

NO	JUDUL	STAN D	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	0%	5,2%	1,95 %	4,19 %	1,35 %	1,48%	0,96 %	2,42%	2,29%
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.33 CSSD

NO	JUDUL	STAN D	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kejadian instrument kurang	0	1	0	1	1	1	1	2	1	0

3.2.1.3.2.34 Humas dan Pemasaran

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '34	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGT '24	SEP '24
1	Angka kunjungan rawat inap >80 pasien perhari	0%	99,17 %	90,88 %	100%	100%	100%	98,65 %	99,64 %	99,8%	100%
2	Angka kunjungan rawat jalan >300 pasien perhari	0%	93,71	100%	92,82 %	92,82 %	91,73 %	87,44 %	94,21 %	92,72%	90,69%

3.2.1.3.2.35 IT

NO	JUDUL	STAN	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1	Kejadian downtime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Respontime penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	96,97 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2.36 Kamar Jenazah

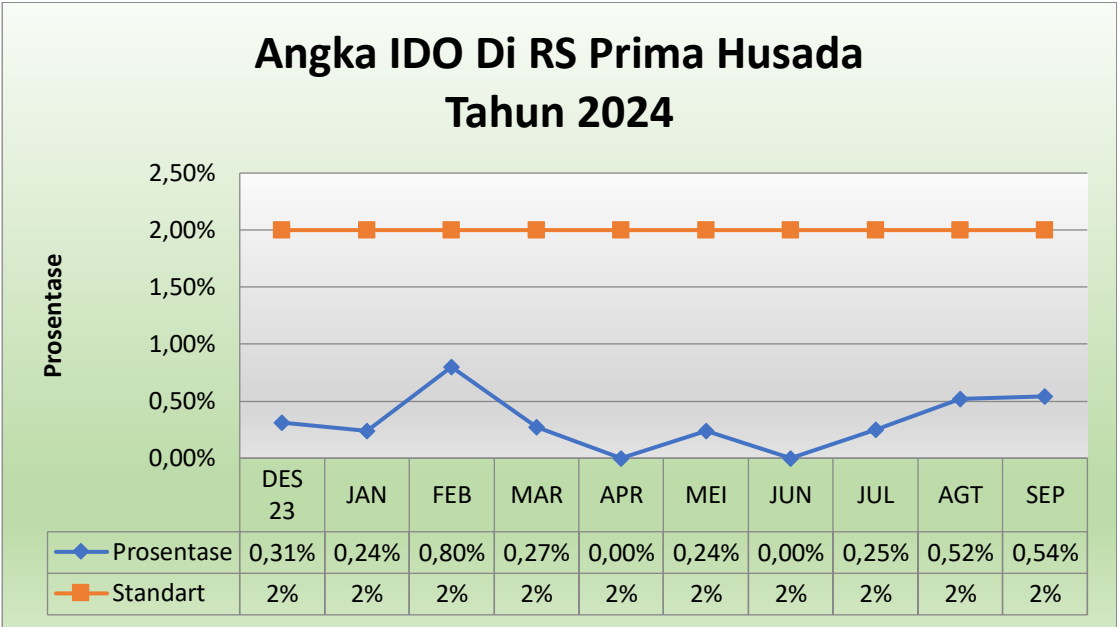
NO	JUDUL	STAN	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24	SEP '24
1.	Pencatatan kematian pasien di kamar mayat (registrasi) < 2jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.6.2 Komite PPI

3.6.2.1 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

3.6.2.1.1 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

3.1.1.1.1 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO):

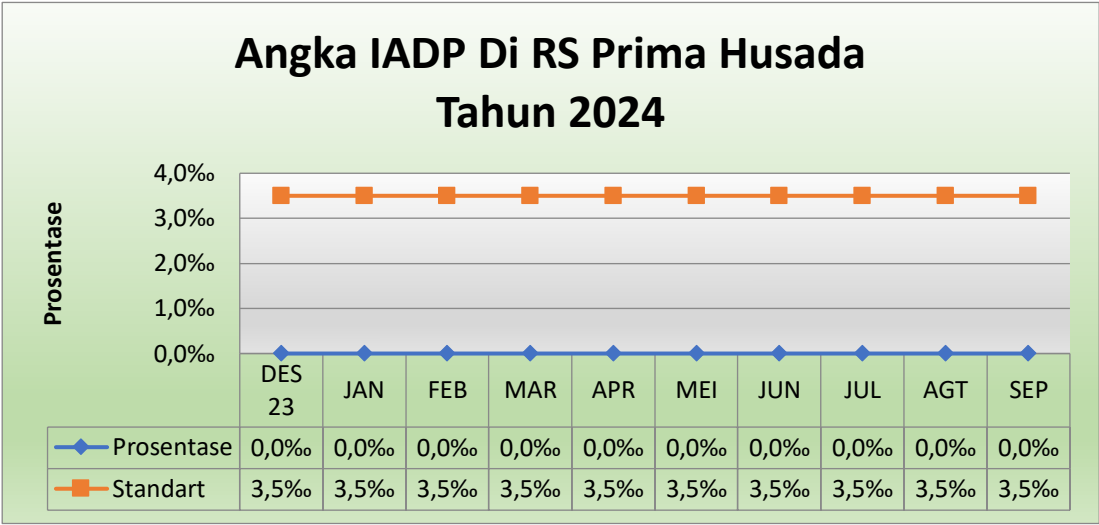


PLAN	Kami berencana untuk menurunkan angka IDO seminimal mungkin. (0%)				
DO	1. Melakukan koordinasi dengan tim Kamar operasi terkait penggunaan kamar operasi dan pembersihannya saat ada operasi estafet (memakai kamar operasi yang berbeda, jika kamar operasi lainnya kosong). 2. Melakukan koordinasi dengan petugas unit perawatan untuk tetap menjaga Teknik aseptic saat melakukan proses perawatan luka pasien. 3. Berkoordinasi dengan ahli gizi dan perawat unit untuk pemantapan proses edukasi pasien terutama diit pasien pada saat pasien dirawat atau akan KRS. 4. Monitoring pembersihan alat dan kebersihan ruang kamar operasi tetap dilakukan secara rutin. 5. Monitoring pelaksanaan audit bundle IDO sesuai SPO.				
STUDY	Ditemukan dua kasus IDO pada bulan ini pada 1 pasien post SC dan 1 pasien post laparotomy. Salah satu pasien post laparotomy memiliki riwayat leukositosis dengan kadar leukosit dalam darah 17.210, dan pada saat ke IGD, lukanya terbuka dan mengeluarkan darah segar. Diit pasien dirasa juga kurang karena pasien hanya makan biscuit dan susu saja karena pasien takut. Pasien mendapat urutan pertama operasi di OK 1 dengan bersamaan terdapat operasi lain di OK 2, dan setelahnya ada 8 pasien dengan jarak 1 jam yang mengantri pada 3 OK. Sedangkan pasien post SC, lukanya terdapat rembesan darah bercampur pus, pasien tersebut cyto dan jadwal operasinya tidak bersamaan dengan pasien lainnya (tidak estafet).  (post laparotomy);  (post SC)				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan bundle IDO.	Pertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IDO.	Kepatuhan audit bundle IDO meningkat 3% pada bulan berikutnya.	1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan. 2. Monitoring kepatuhan pemakaian handscon steril saat rawat luka. 3. Monitoring kepatuhan mandi	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

			dengan air sabun sebelum operasi. 4. Monitoring kepatuhan penggunaan alat cukur satu kali pakai dan pembersihan wadah alat cukur yang dipakai berulang. 5. Monitoring kepatuhan petugas dalam menjaga aseptik saat melakukan rawat luka/tindakan bedah.		
Evaluasi pemahaman pemberian edukasi diit pasien post operasi	Meminimalisir kesalahpahaman penangkapan terkait edukasi gizi pasien post operasi.	Penurunan kasus IDO karena diit pasien yang salah.	1. Koordinasi dengan ahli gizi terkait pemberian edukasi pasien post operasi dan saat pasien KRS. 2. Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien sudah mendapatkan edukasi terkait diit saat di rumah terlebih pada pasien dengan operasi saluran cerna. 3. Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti diit pasien tersebut. 4. Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien.	1. Perawat /Bidan 2. Ahli Gizi 3. Karu 4. IPCLN/PCN	Satu bulan
Evaluasi proses pembersihan kamar operasi	Meminimalisir risiko terjadinya infeksi daerah operasi.	Penurunan kasus IDO pada operasi estafet.	1. Koordinasi dengan Karu IKO terkait penjadwalan pasien operasi estafet. 2. Mendahulukan pasien operasi bersih (non infeksi) jika kamar operasi dipakai estafet. 3. Mengevaluasi proses pembersihan kamar operasi saat dilakukan operasi estafet.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCN 5. CS	Satu bulan

3.6.1.1.2 IADP

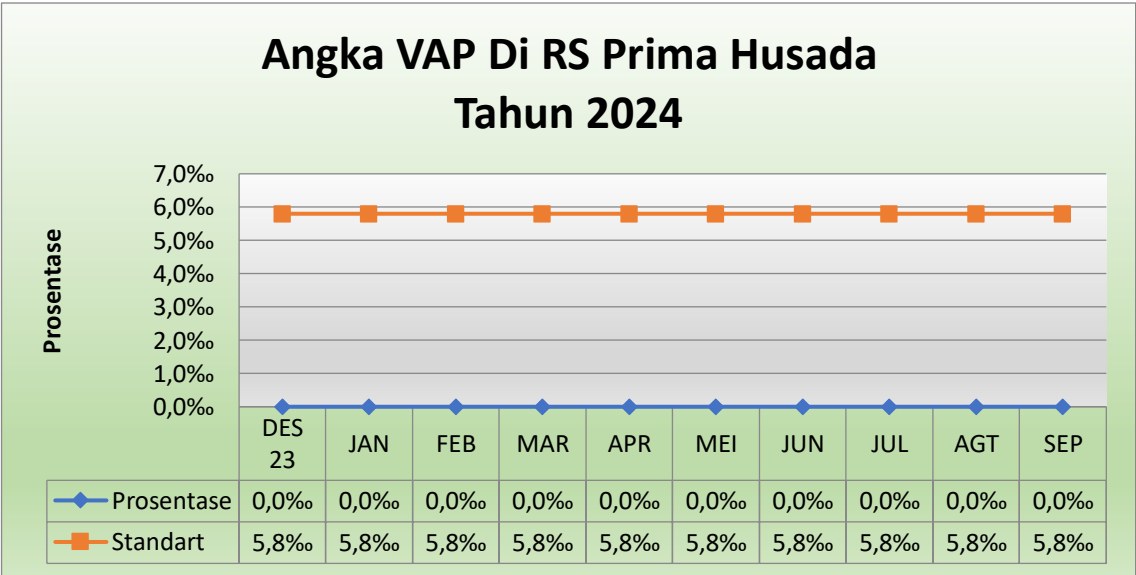
3.6.1.1.2.1 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka IADP sesuai standart seminimal mungkin. (0%)				
DO	Monitoring pelaksanaan audit bundle IADP sesuai standart.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP pada 91 hari total lama pemasangan CVC pada pasien bulan ini.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Kepatuhan bundle IADP tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan. 2. Monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Monitoring perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

1.6.1.1.3 VAP

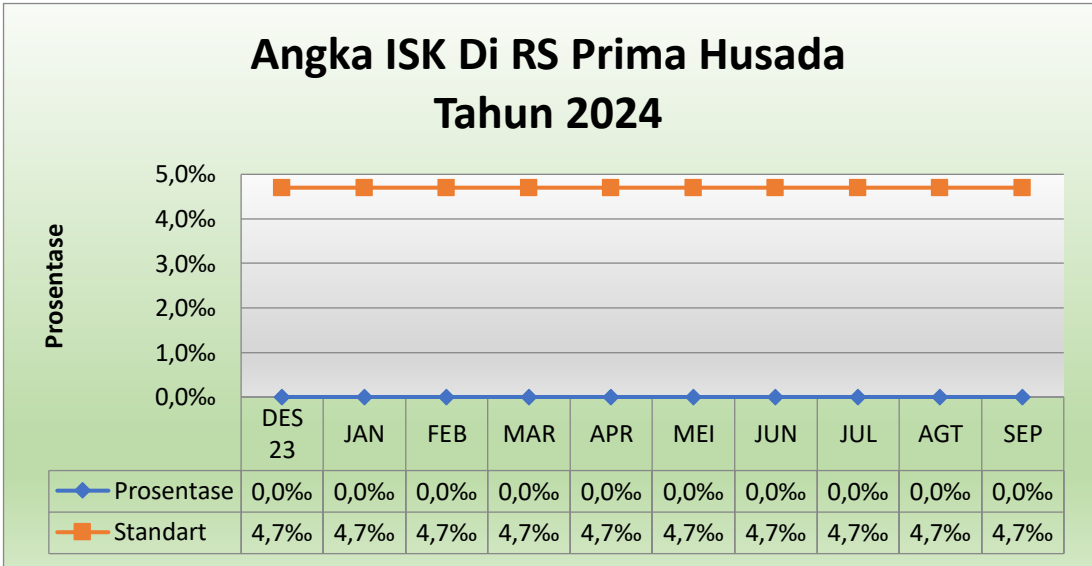
3.6.1.1.3.1 Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka VAP sesuai standart seminimal mungkin. (0‰)				
DO	Monitoring pelaksanaan audit bundle VAP sesuai SPO.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 92 hari lama pemasangan ventilator.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle VAP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP.	Kepatuhan bundle VAP tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan. 2. Monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. 3. Monitoring posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. 4. Monitoring perawatan pemasangan ventilator, pemberian profilaksis dan perawatan oral <i>hygiene</i> .	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCPN	Satu bulan

1.6.1.1.4 ISK

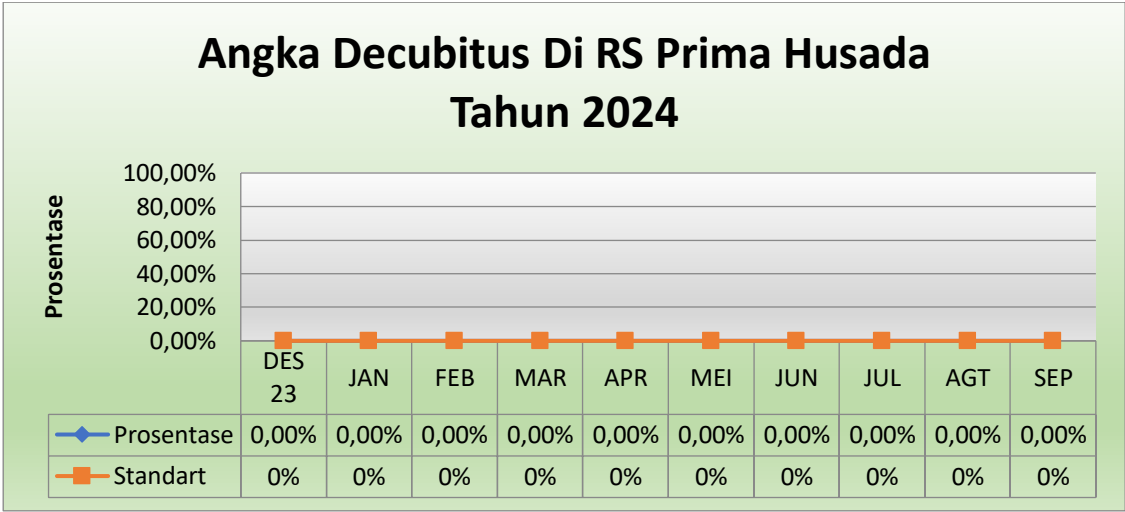
3.1.1.1.4.1 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka ISK sesuai standart seminimal mungkin. (0‰)				
DO	Monitoring pelaksanaan audit bundle ISK sesuai SPO.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 1004 hari lama pemakaian kateter pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	Kepatuhan bundle ISK tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan. 2. Monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCPN	Satu bulan

1.6.1.1.5 Decubitus

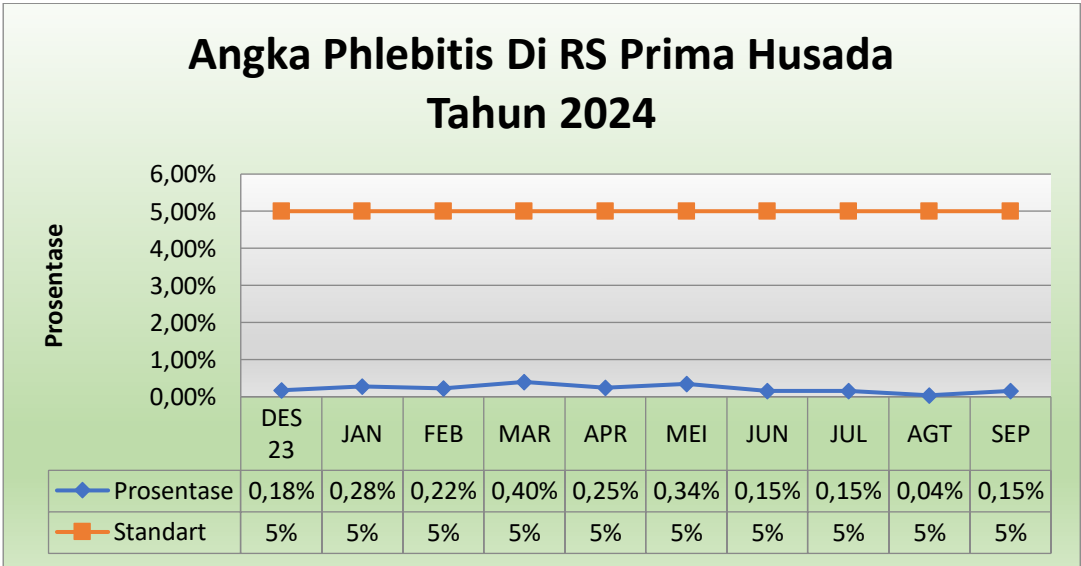
3.1.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka decubitus sesuai standart seminimal mungkin. (0%)				
DO	Monitoring pelaksanaan pencegahan decubitus pada perawatan pasien dengan tirah baring lama.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada 6 pasien tirah baring lama (>3x24 jam).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	Kepatuhan pencegahan dekubitus tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan. 2. Monitoring rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus. 4. Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 5. Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	1. Perawat /Bidan 2. Karu 3. IPCLN/PCN	Satu bulan

1.6.1.1.6 Phlebitis

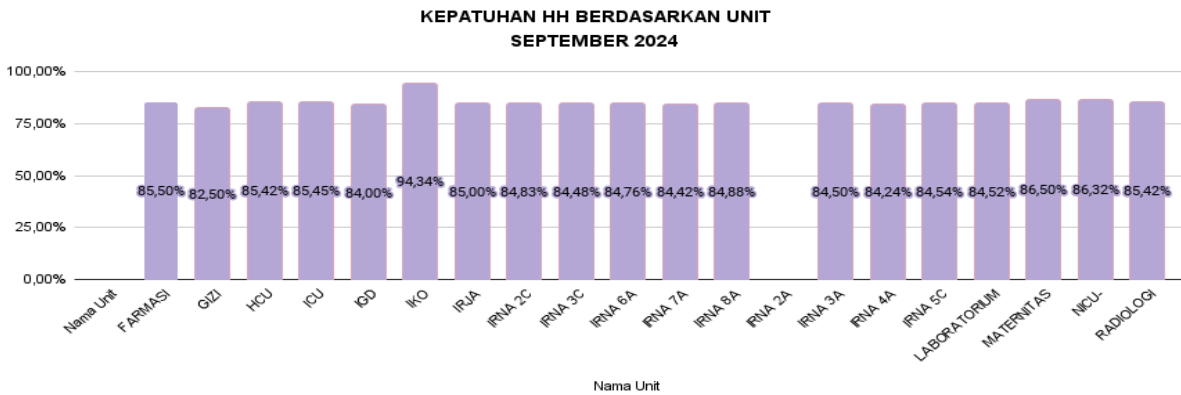
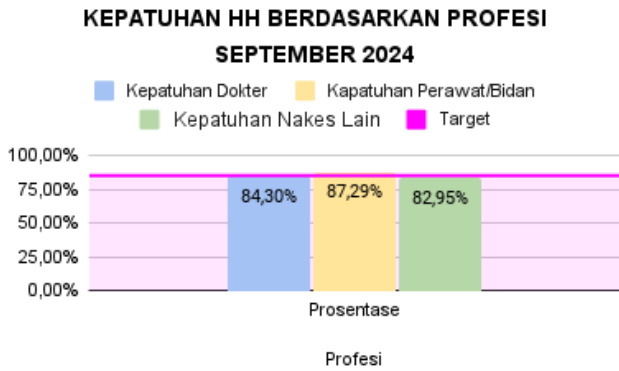
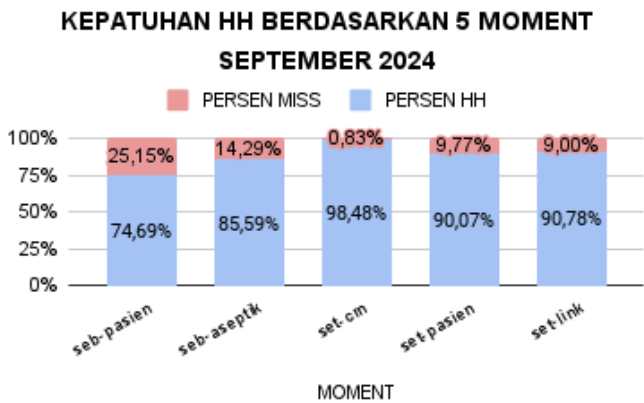
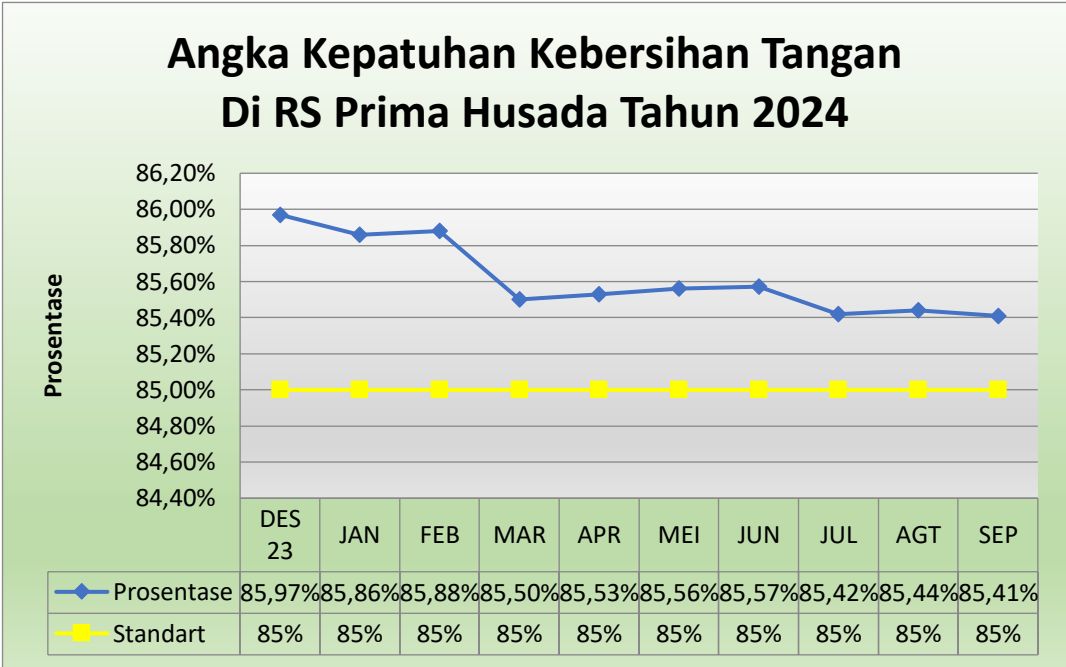
3.6.1.1.6.1 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)



PLAN	Kami berencana untuk menurunkan angka phlebitis seminimal mungkin. (0%)				
DO	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit bundle phlebitis sesuai SPO. 2. Melakukan sosialisasi kepada perawat tentang handhygiene dan pemakaian APD yang benar. 3. Berkolaborasi dengan komite keperawatan untuk melakukan supervisi berkala terkait prosedur pemasangan infus dan perawatan luka infus. 4. Monitoring pelaksanaan penyuntikan yang aman dan Teknik aseptic saat penyuntikan.				
STUDY	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2684 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,15%, masih memenuhi standar nasional. Dari data yang diperoleh, 2 pasien diantaranya mendapatkan terapi cairan pekat KCL dengan siklus berulang, 2 pasien lainnya hanya mendapatkan antibiotic biasa. Dari 5 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle phlebitis.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Kepatuhan bundle phlebitis tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan. 2. Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus. 3. Monitoring teknik aseptic dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. 4. Monitoring penyuntikan yang aman. 5. Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic. 6. Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat. 7. Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

1.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

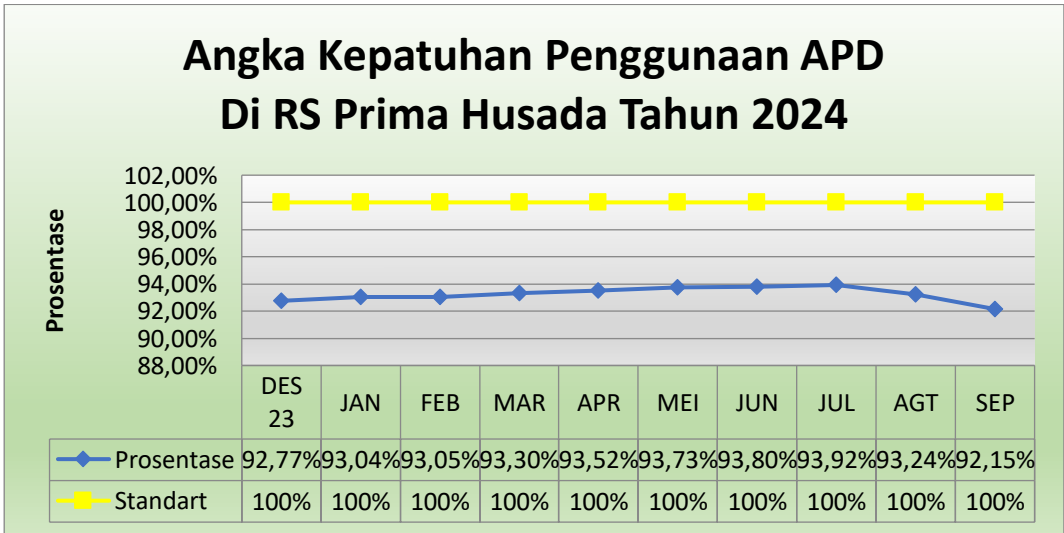
3.6.1.1.7.1 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.				
DO	1. Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit. 2. Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya. 3. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan. 4. Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan. 5. Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,41%. Jika dilihat berdasarkan profesi, masih ditemukan prosentase di bawah standart yaitu pada profesi dokter (84,30%) dan nakes lain (82,95%) dimana berdasarkan 5 moment cuci tangan, kebanyakan dari petugas tidak melakukan moment sebelum kontak dengan pasien (74,69%). Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Namun beberapa perawat sudah mengurangi penggunaan sarung tangan bedah sesuai dengan kebutuhannya saja. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi dokter.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	1. Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan. 2. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 3. Menganjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 4. Memberikan reward-pembelajaran. 5. Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 6. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

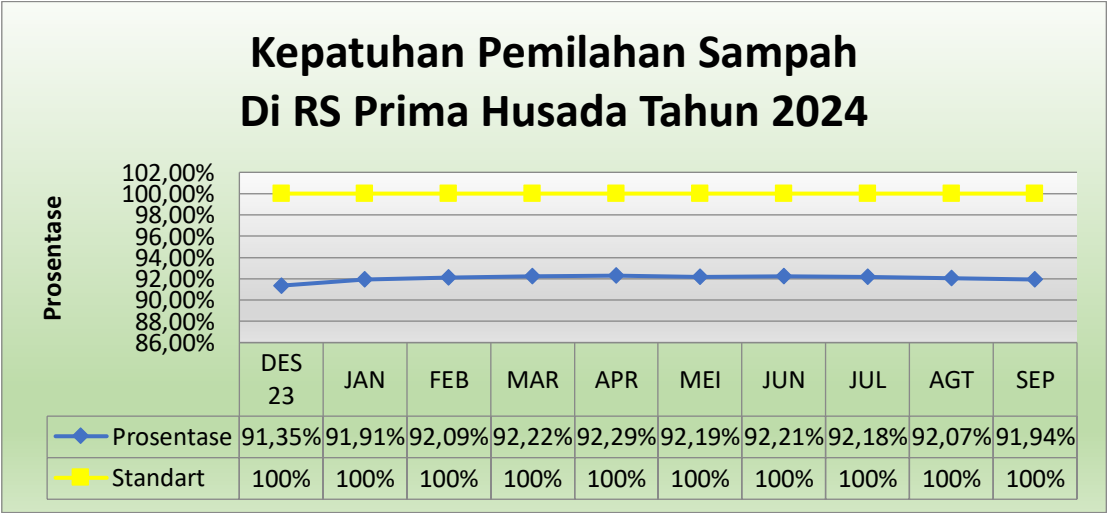
3.6.1.1.8 Kepatuhan APD

3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas



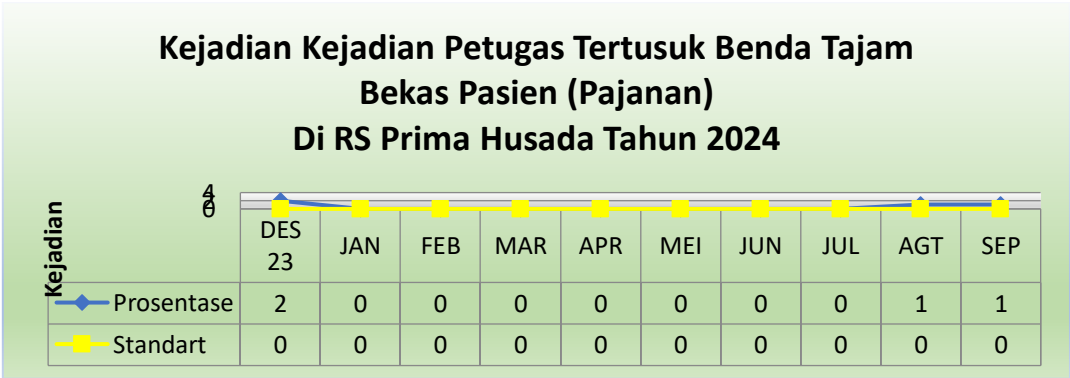
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.				
DO	1. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Menegur dan melakukan sosialisasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Menegur kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 5. Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 92,15% menurun dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, masih ditemukan petugas perawat yang memakai APD tidak sesuai dengan jenis tindakan dan transmisi penyakit, misalnya seperti injeksi lewat selang infus / hanya TTV ke pasien non infeksi namun menggunakan handscoon. Kepatuhan APD petugas dapur terutama pengolah makanan masih sangat kurang terutama penggunaan masker. Untuk petugas medis, masih ditemukan DPJP yang masih menggunakan handscoon meskipun hanya visite tidak melakukan tindakan. Ditemukan pula, petugas CS yang mengganti kantong sampah non infeksius yang penuh dan tidak memakai sarung tangan kerja.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD unit minimal meningkat 2% pada bulan berikutnya.	1. Melakukan sosialisasi antar staf tentang penggunaan APD. 2. Menegur staf yang salah dalam penggunaan APD dan memberikan metode pembelajaran dengan mendata ketidak patuhan teman-teman di unitnya. 3. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. 4. Menjadikan kebiasaan pemakaian APD sesuai dengan jenis transmisi penyakit dan tindakan yang akan dilakukan.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.9 Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius
 3.6.1.1.9.1 Grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.				
DO	1. Melakukan supervise terkait pemilahan pembuangan sampah di unit pelayanan pasien. 2. Melakukan supervise terkait pembuangan sampah di ruang TPS B3. 3. Melakukan sosialisasi pemilahan sampah yang yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Menegur langsung petugas unit dan Karu/PJ saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan dan memberitahukan pemilahan sampah yang benar.				
STUDY	Prosentase kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 91,94%, menurun dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, masih ditemukan petugas yang tidak melakukan pemilahan dengan baik saat melakukan dengan ditemukannya sampah bungkus alkes di sampah infeksius yang seharusnya dibuang di non infeksius. Selain itu, masih ditemukan di IGD, petugas membuang jarum bercampur sampan bungkus alkes lainnya jadi satu di bengkok.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Tercapainya kepatuhan pemilahan sampah unit minimal meningkat 3% pada bulan berikutnya.	1. Melakukan sosialisasi antar staf tentang pemilahan sampah. 2. Menegur langsung petugas unit saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan. 3. Menyampaikan kesalahan pembuangan unit pada kepala unit dan IPCLN unit dalam forum rapat PPI maupun grup WA. 4. Saran memindahkan sampah infeksius yang ada di area umum. 5. Memberikan sosialisasi terkait aturan pembuangan cairan infus pada wastafel/spoelhoek sebelum membuang botolnya.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.10 Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam
3.6.1.1.10.1 Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien (Pajanan)



PLAN	Kami berencana untuk menurunkan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan) seminimal mungkin (0).				
DO	1. Menginputkan laporan pada surveilans SIMRS dan kolaborasi dengan K3RS dan SDM. 2. Mengevaluasi keadaan luka pasien dan kondisi penyakit sumber pajanan. 3. Melakukan supervise terkait pengolahan benda tajam dan penyuntikan yang aman. 4. Melakukan supervise terkait penggunaan APD yang benar sesuai transmisi dan tindakan yang akan dilakukan.				
STUDY	Pada bulan ini ditemukan 1 kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan) karena kecerobohan petugas IGD yang tidak langsung membuang sampah benda tajam (jarum) setelah digunakan dan bercampur dengan sampah bungkus alkes lainnya dibengkok, sehingga mencelakakan petugas IGD lainnya di shift berikutnya yang berniat membersihkan troli tindakan dan terkena pajanan jarum yang bercampur bungkus alkes di bengkok.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Melakukan penyuntikan aman.	Mempertahankan capaian kejadian pajanan 0 kejadian.	Tercapainya standar pajanan 0 kejadian setiap bulannya.	Mempertahankan kegiatan penyuntikan yang aman karena sudah meminimalisir kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien.	Seluruh petugas	Satu bulan

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

NO	UNIT	TARGET	JUL	AGT	SEP	%	MANDOK	KETERANGAN
1	IRNA 2C	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
2	ICU HCU	8x/Bulan	50%	50%	0%	Tidak Tercapai	Ada	
3	IRNA 3C	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
4	MATERNITAS	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
5	PERINATOLOGI	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
6	IRNA 5C	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
7	IRNA 2A,3A,4A	8x/Bulan	75%	100%	100%	Tercapai	Ada	
8	IRNA 6A,7A,8A	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
9	IGD	8x/Bulan	100%	100%	75%	Tercapai	Ada	
10	FARMASI	8x/Bulan	100%	100%	75%	Menurun	Ada	
11	GIZI	8x/Bulan	75%	100%	25%	Menurun	Ada	
12	IRJA	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
13	PPI	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	

Analisis : Beberapa unit mengalami penurunan dalam melakukan edukasi kelompok di unit

Rencana Tindak Lanjut : Koordinais dengan tim pkrs untuk evaluasi penurunan dan meningkatkan kembali penyuluhan komunitas

3.6.3.2 KIE Individu

NO	UNIT	TARGET	JUL	AGT	SEP	%	KETERANGAN
1	IRNA 2C	100%	100%	100%	100%	100%	
2	ICU HCU	100%	100%	100%	100%	100%	
3	IRNA 3C	100%	100%	100%	100%	100%	
4	MATERNITAS	100%	100%	100%	100%	100%	
5	PERINATOLOGI	100%	100%	100%	100%	100%	
6	IRNA 5C	100%	100%	100%	100%	100%	
7	IRNA 2A,3A,4A	100%	100%	100%	100%	100%	
8	IRNA 6A,7A,8A	100%	100%	100%	100%	100%	
9	IGD	100%	100%	100%	100%	100%	
10	FARMASI	100%	100%	100%	100%	100%	
11	GIZI	100%	100%	100%	100%	100%	
12	IRJA	100%	100%	100%	100%	100%	

Analisis : Pelaksanaan KIE individu telah dilakukan oleh Perawat di ruangan,

kekurangan pada pengertian petugas dalam mengisi form perencanaan edukasi kurang sehingga dalam mendokumentasikan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan.

Rencana Tindak Lanjut : Sosialisasi untuk Ketertiban dalam pendokumentasian dalam DRM

3.6.3.3 Kelengkapan Dokumen Rekam Medis Edukasi (DRM) Edukasi

NO	LEMBAR DRM	JML SAMPLE	KELENGKAPAN		ISI BENAR	VERIFIKASI KE PASIEN	KET
			YA	TIDAK			
1	General Consent	8	8		Isi sesuai	Ya	Kekurangan TTD pada nama petugas
2	SBAR	8	8		Isi sesuai	Ya	Ketidaklengkapan pada penulisan nama petugas dan nama pasien yg jelas
3	Perencanaan Edukasi / Rencana Asuhan	8	6	2	Isi sesuai	Ya	Nama Petugas tidak terisi lengkap , Pengisian tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan
4	Pengkajian Kebutuhan KIE	8	8		Isi sesuai	Ya	
5	KIE Informed Consent	8	8		Isi sesuai	Ya	Nama Petugas Tidak terisi lengkap
6	CPPT	8	8		Isi sesuai	Ya	-
7	Ringkasan Pasien Pulang	8	8		Lengkap	Ya	-
8	Discharged Planning	8	8	0			
9	Edukasi kolaborasi	8	8	0	Isi sesuai	Ya	-
11	KIE Menjelang Akhir Kehidupan (Pada Pasien yang mau meninggal)	1	1	0	Isi sesuai		
12	Form AMA	1	1	0	Isi Sesuai	Ya	
13	Semua Form yang ada Pemberian Informasi Ke Pasien	8	8	0	Isi Sesuai	Ya	
14	KIE Pre OP di Lembar Pre OP	2	2	0	Isi Sesuai	Ya	

Analisis : Seluruh DRM edukasi terisi , terdapat beberapa ketidaklengkapan meliputi kekurangan pada penulisan nama petugas pemberi KIE , Kekurangan pada isi yang kurang lengkap dan tidak sesuai di perencanaan edukasi .

Rencana Tindak Lanjut : Sosialisasi kepada PPA Pelaksana untuk melengkapi DRM dengan baik dan benar

3.6.3.4 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

NO	UNIT	TARGET	KEGIATAN	JUL	AGT	SEP	%	MANDOK	KET
1	Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	50%	100%	100%	Tercapai	Ada	
			Hypnoterapi						
			KIE						

2	Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	50%	100%	100%	Tercapai	Ada	
			Hypnoterapi						
			KIE						
3	Komunitas Shirothul Jannah Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
			Karya wisata						
4	Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
5	Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	100%	Ada	
6	General Meeting Karyawan	1x/2Bulan			100%	100%		Terlaksana	
7	Pembinaan Fatayat	1X/Tahun							

3.6.3.5 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

NO	UNIT	TARGET	JUL	AGT	SEP	%	MANDOK	KETERANGAN
1	PONEK	4X/Bulan	0%	100%	0%	Menurun	-	
2	HIV	4X/Bulan	0%	100%	0%	Menurun	-	
3	STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	0%	100%	100%	Tercapai	Ada	
4	KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	
5	TB DOTS	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	

- Analisis

: PROGNAS telah memulai Kegiatan Edukasi di bulan Juli tetepi yang rutin melakukan hanya Prognas STUNTING
- Rencana Tindak Lanjut

: Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat ungtkan produktivitas Tim Prognas

3.6.4 Tim Prognas

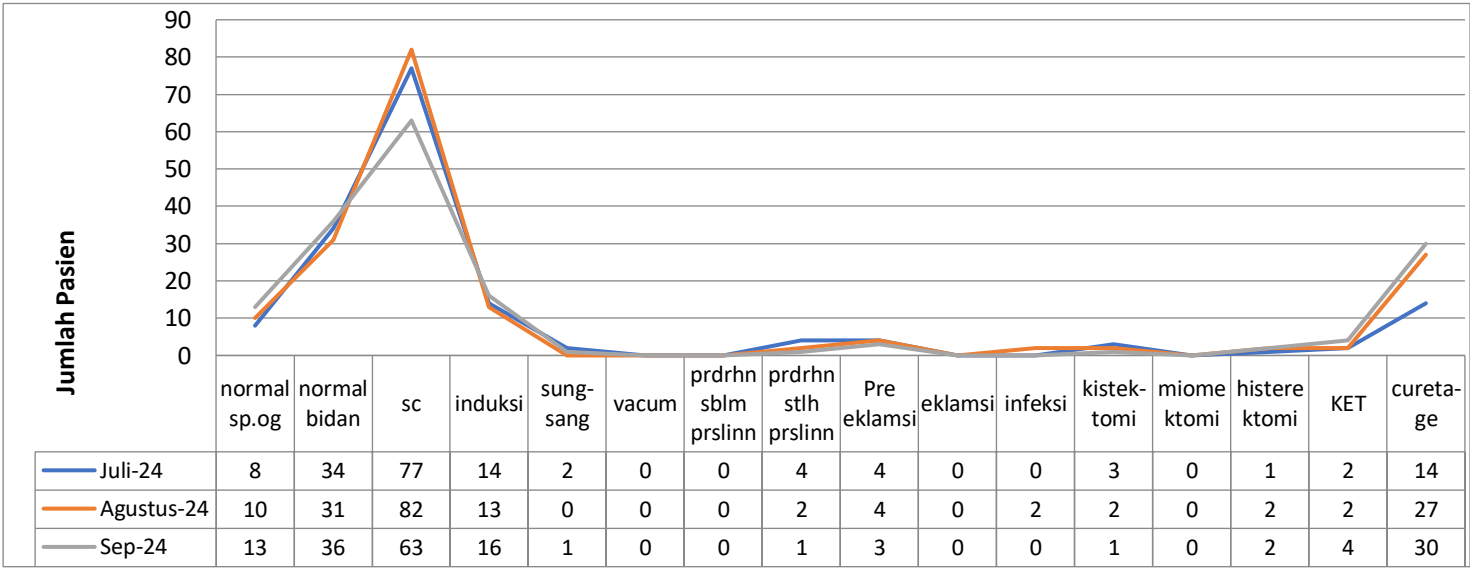
3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek September 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JULI 2024	BULAN AGT 2024	BULAN SEP 2024
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal Sp. OG	8	10	13
	b. Persalinan Normal Bidan	34	31	36
	c. <i>SectioCaesaria</i>	77	82	63
2				
	a. Induksi / Drip	14	13	16
	b. Sungsang	2	0	1
	c. Vacuum	0	0	0

3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	0	0
	b. Perdarahan setelah Persalinan	4	2	1
	c. Pre Eklamsi	4	4	3
	d. Eklamsi	0	0	0
	e. Infeksi	0	2	0
4				
	a. Curretage	14	27	30
	b. Kistektomi	3	2	1
	c. Miomektomi	0	0	0
	d. Histerectomy	1	2	2
	e. KET	2	2	4

3.6.2.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan September 2024



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan September 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 63 pasien. Dan untuk persalinan normal ditolong dokter pada bulan September 2024 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 13 pasien. Sedangkan persalinan yang ditolong oleh bidan juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 36 pasien. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu.
2. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
3. Pada persalinan dengan sungsang pada bulan September terdapat 1 pasien, sedangkan pada bulan agustus tidak ada persalinan sungsang, dan 2 pasien pada bulan Juli 2024. Untuk persalinan dengan vacum pada bulan Juli sampai dengan September 2024 tidak ada.

- Induksi Persalinan pada bulan September mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 16 pasien
- Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan September sedikit menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan terakhir, yaitu 3 pasien. Dan tidak ada kejadian eklamsi pada bulan Juli sampai dengan September 2024.
- Jenis pelayanan curretage di bulan September meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 30 pasien. *Curretage* dilakukan untuk indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynecology biasanya dengan indikasi menometroragi, hyperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

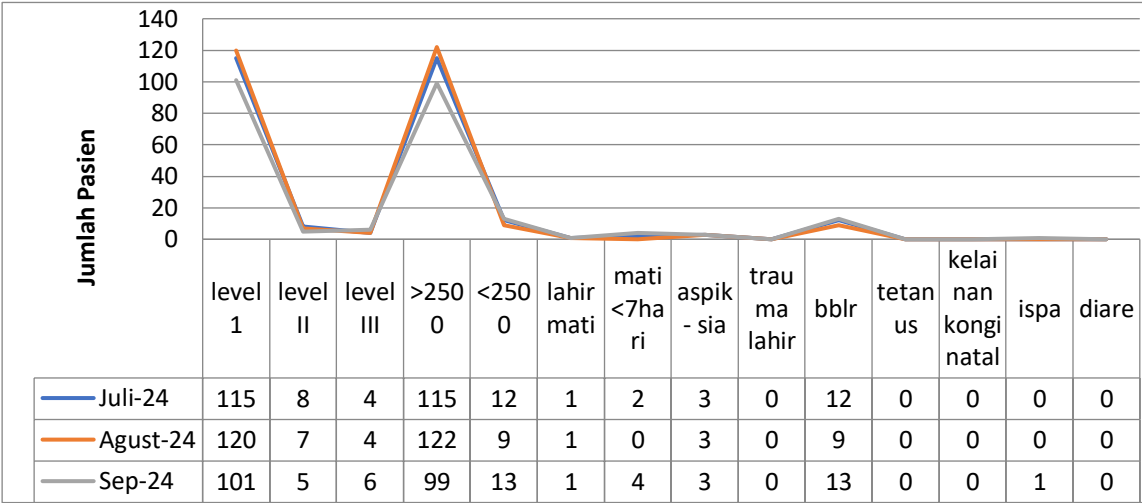
- Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
- Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
- Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

3.6.4.1.2 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.2.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponek September 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JULI 2024	BULAN AGT 2024	BULAN SEP 2024
1				
	a. Level 1	115	120	101
	b. Level II	8	7	5
	c. Level III	4	4	6
2				
	a. ≥ 2500 gram	115	122	99
	b. ≤ 2500 gram	12	9	13
3				
	a. Kelahiran Mati	1	1	1
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	2	1	4
4				
	a. Asphyxia	3	3	3
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	12	9	13
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	0	0	1
	f. ISPA	0	0	1
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

3.6.2.1.2.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Bulan September 2024



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan September 2024 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 101 bayi. Dan pada level 2 sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 5 bayi. Sedangkan pada level 3 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 6 bayi.
2. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan September 2024 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya tetap sebanyak 99 bayi.
3. Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan September 2024 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 13 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.
4. Kasus BBLR pada bulan September 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 13 bayi.
5. Kasus kelahiran mati pada bulan Juli sampai September tetap yaitu sebanyak 1 kasus
6. Kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan September meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 4 kasus kematian

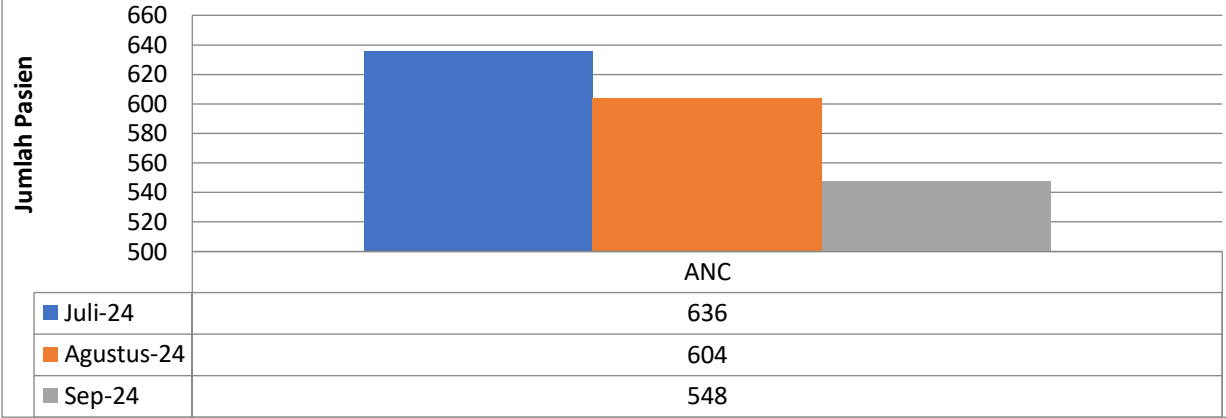
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.

3.6.2.1.2.3 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)
Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponpek September 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN JULI 2024	BULAN AGT 2024	BULAN SEP 2024
1	ANC	636	604	548

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Bulan September 2024



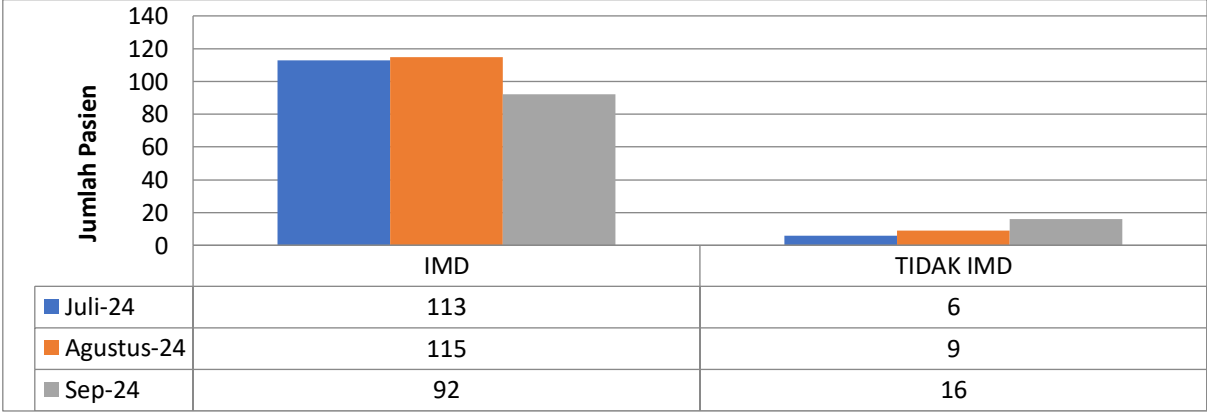
Analisis :
Pelayanan ANC pada bulan September 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 548 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

3.6.1.2.4 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) September 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JULI 2024	BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024
1	IMD	113	115	92
2	Tidak IMD	6	9	16

Grafik Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan September 2024



Analisis :

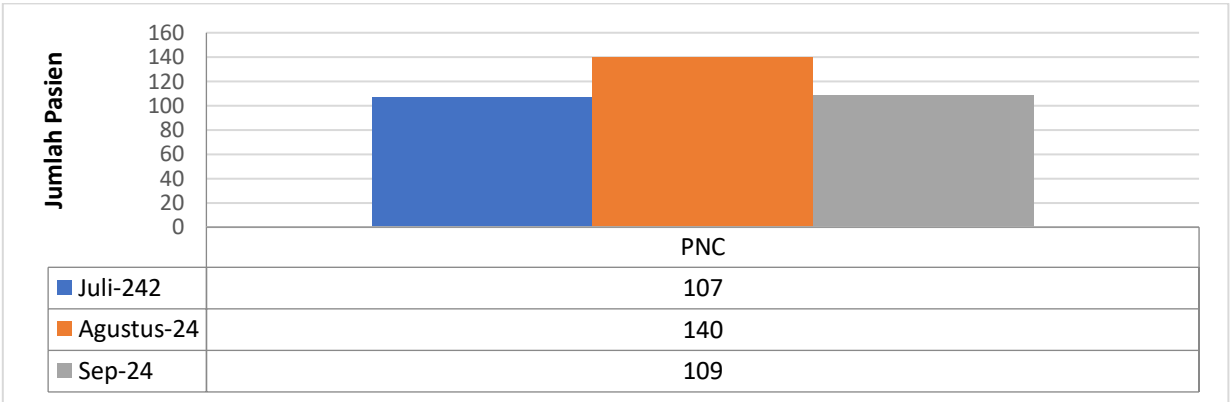
- Bayi yang dilakukan IMD pada bulan September 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 92 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
- Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan September 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 16 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
- Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusu dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak.

3.6.1.2.5 Pelayanan Post Natal Care (PNC)
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek September 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN JULI 2024	BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024
1	PNC	107	140	109

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan September 2024



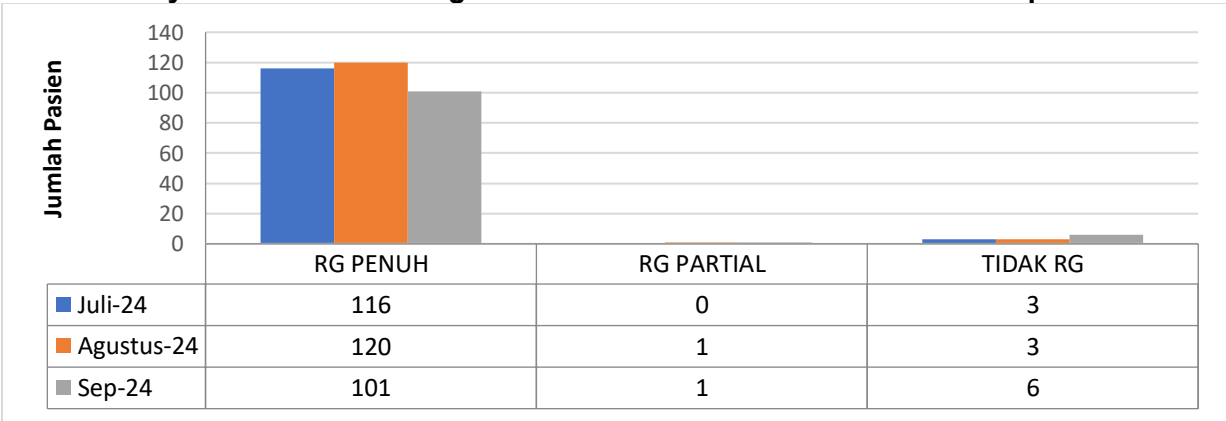
Analisis :
Pelayanan PNC pada bulan September 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 109 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponek September 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JULI 2024	BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024
1	Rawat gabung penuh	116	120	101
2	Rawat gabung partial	0	1	1
3	Tidak Rawat gabung	3	3	6

Grafik Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan September 2024



Analisis :

- 1. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan September 2024 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 101 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- 2. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan September sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 6 bayi.
Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram dan masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan.

Rencana dan Tindak Lanjut :

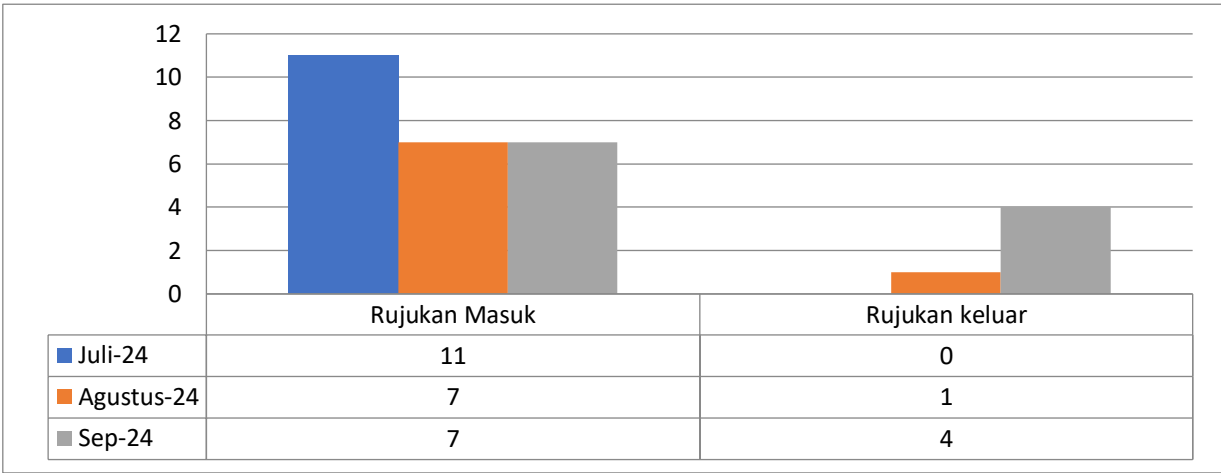
Melakukan skrining awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan

Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponек September 2024

NO	RUJUKAN	BULAN JULI 2024	BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024
1	Rujukan Masuk	11	7	7
2	Rujukan keluar	0	1	4

Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan September 2024

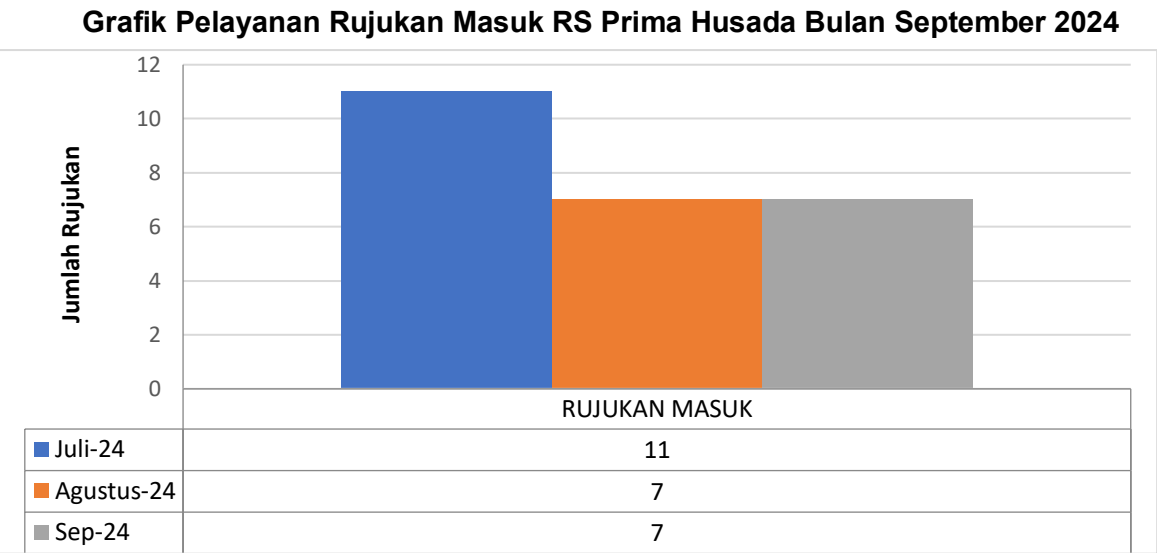


3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk

Tabel Rujukan Masuk Ponек September 2024

BULAN JULI 2024		
1	G1 P0000 Ab000 UK 37-38 mgg dg KPD	BPM Siti Rubaiyah
2	P2002 Ab000 dg Post partum H-10 + late HPP	BPM Tri Widiyawati
3	G2 P1001 Ab000 Uk 37 mgg dg KIFA	BPM Suci Astuti
4	G3 P1001 Ab100 UK 38-39 mgg dg HT	BPM Sofia Faridah
5	G1 P0000 Ab000 Uk 40-41 mgg Dg KPD + kala 2 lama	BPM Titik S
6	G3 P2002 Ab000 Uk 8 -10 mg dg Abortus Imminen + Apendicitis Akut	RS Permata bunda
7	G1 P0000 Ab000 Uk 40-41 mgg dg TPHA reaktif	PKM Singosari
8	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 mgg dg KIFL + KPD + IUGR	PKM Singosari
9	G1 P0000 Ab000 UK 39 – 40 mgg dg HT Gestasional	PKM Singosari
10	G3 P0010 Ab100 UK 11-12 mgg dg abortus Inkomplit	PKM Singosari
11	G1 P0000 Ab000 UK 37-38 mgg dg PRM + OBS Febris+ lekositosis	PKM Ardimulyo

BULAN AGUSTUS 2024		
1	G1 P0000 Ab000 UK 20-21 mgg dg KPD + PPI	PKM Singosari
2	G1 P0000 Ab000 UK 34-36 mgg dg KPD	Klinik Muslimat
3	G2 P1001 Ab000 UK 36-37 mgg dg KIFA + KPD	BPM Susmui
4	G3 P2002 Ab000 UK 38-39 mgg dg PEB + Obesitas	PKM singosari
5	G2 P1001 Ab000 UK 22-24 mgg dg IUFD	BPM Nukina
6	P2002 Ab000 dg post partum dg ruptur perineum	BPM Heni
7	Prematur + BBLSR + Asfiksia	BPM Sofia
BULAN SEPTEMBER 2024		
1	G3 P2002 Ab000 UK 20-22 mgg dg PPI	BPM Tri W
2	G3 P2002 Ab000 UK 38-39 mgg dg KPD	Poskesdes Lang-lang
3	G1 P0000 Ab000 UK 38-40 mgg dg KPD	PMB Indi
4	Intrauterin Abnormal Bleeding +anemia	Klinik Tirta Husada
5	G3 P2002 Ab000 UK 38-40 mgg dg BSC	PMB Indi
6	Abortus inkomplit	Klinik Rawat Inap Muslimat
7	G3 P2002 Ab000 UK 33-34 mgg dg PPI + Gemeli + BSC	RS Permata Bunda



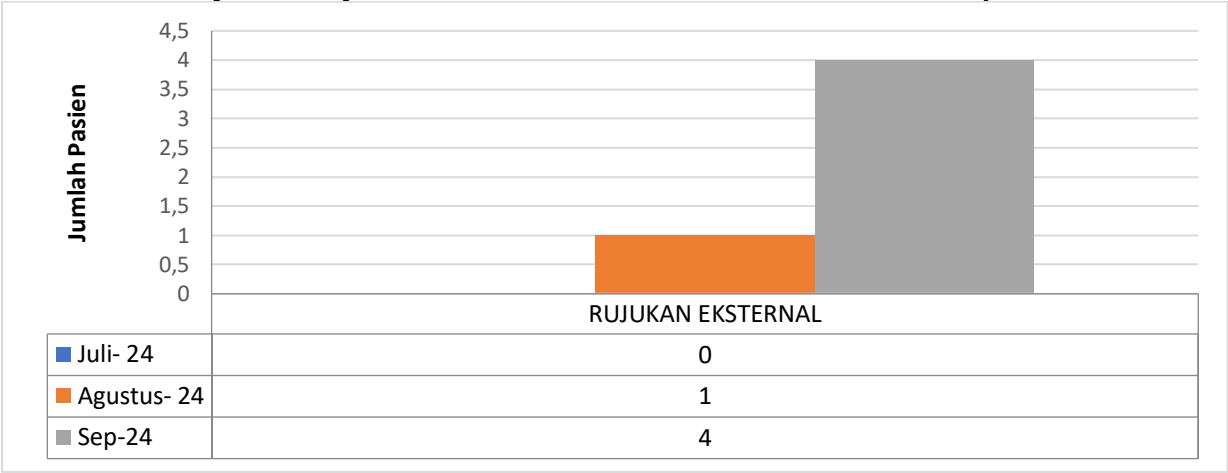
Analisis :
 Jumlah rujukan masuk pada bulan September 2024 tetap seperti bulan Agustus yaitu 7 rujukan masuk.

Rencana dan Tindak Lanjut
 Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar
 Tabel Rujukan Keluar Ponек September 2024

BULAN JULI 2024		
BULAN AGUSTUS 2024		
1	RDS + BBLR	RS Saiful Anwar
BULAN SEPTEMBER 2024		
1	Neonatal pneumonia dd MAS, Susp PJB kritis dd PPHN, Asfiksia	RS Saiful Anwar
2	BBLR + obs distress nafas + neonatal pneumonia dd RDS Ok labiognatopalatoschizis	RS Soepreoen
3	RDS Ok HMD dd neonatal pneumonia	RS Soepraoen
4	Susp PPHN	RS Saiful Anwar

Grafik Pelayanan Rujukan Eksternal di RS Prima Husada Bulan September 2024



Analisis :

Pada bulan September ada 4 pasien yang dirujuk keluar, sedangkan pada bulan Agustus 1 pasien dan tidak ada pasien yg dirujuk pada bulan Juli 2024

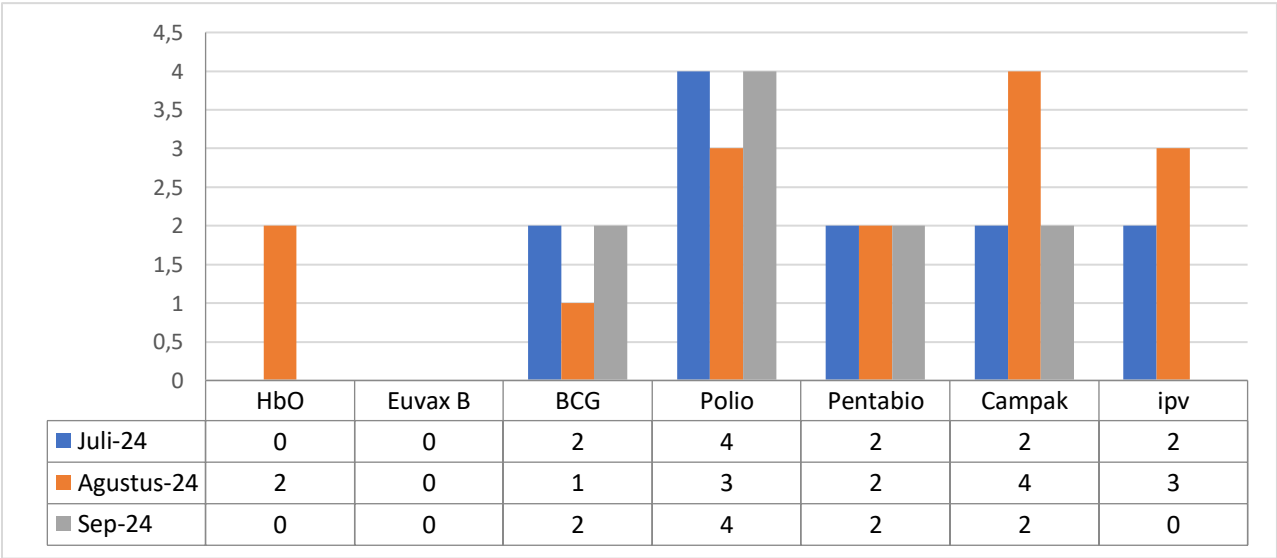
Rencana dan Tindak Lanjut :

Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponsek September 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN JULI 2024	BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024
1	HbO	0	2	0
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	2	1	2
3	Polio	4	3	4
4	Pentabio	2	2	2
5	Campak	2	4	2
6	IPV	2	3	0

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan September 2024



Analisis :

- 1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode September 2024 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga tidak menggunakan vaksin euvax B
- 2. Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan September dan Juli 2024 tidak ada, sedangkan pada Agustus 2024 sebanyak 2 bayi. Hal ini dikarenakan ketidaktersedianya vaksin HB0 di RS prima Husada malang, bayi yang baru lahir diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
- 3. Tidak ada Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan September, sedangkan pada bulan Agustus sebanyak 3 bayi, dan 2 bayi pada bulan Juli 2024
- 4. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Agustus 2024 mengalami sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 2 pasien.
- 5. Pada periode September 2024 Imunisasi Campak mengalami sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 2 bayi
- 6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan September 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 4 bayi
- 7. Jumlah pasien yg imunisasi Pentabio pada bulan September 2024 sama dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 2 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut

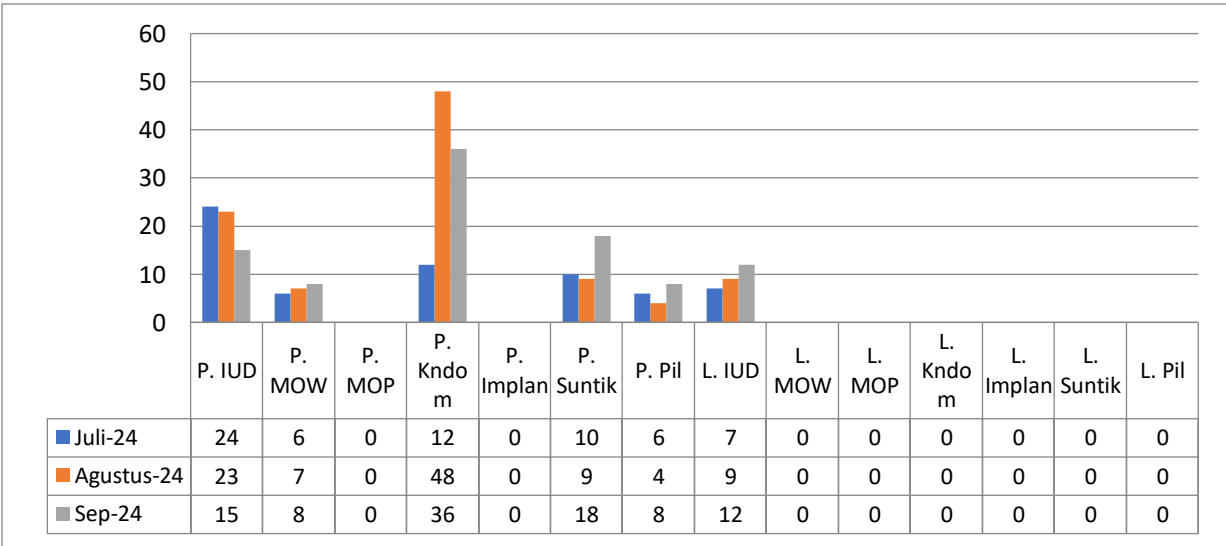
- 1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
- 2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponek September 2024

N O	JENIS	JUMLAH PASANG			JUMLAH LEPAS		
		BULAN JULI 2024	BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024	BULAN JULI 2024	BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024
1	IUD	24	23	15	7	9	12
2	MOW	6	7	8	0	0	0
3	MOP	0	0	0	0	0	0
4	Kondom	12	48	36	0	0	0
5	Implant	0	0	0	0	0	0
6	Suntikan	10	9	18	0	0	0
7	Pil	6	4	8	0	0	0

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan September 2024



Aanalisis :

- 1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan September menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 15 akseptor yang terdiri dari 10 akseptor IUD Nova T dan 5 akseptor IUD copper T
- 2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan September 2024 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 8 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder.
- 3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan September 2024 mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu 36 pengguna
- 4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan September 2024 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 8 pengguna
- 5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan September 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 18 penggunaan

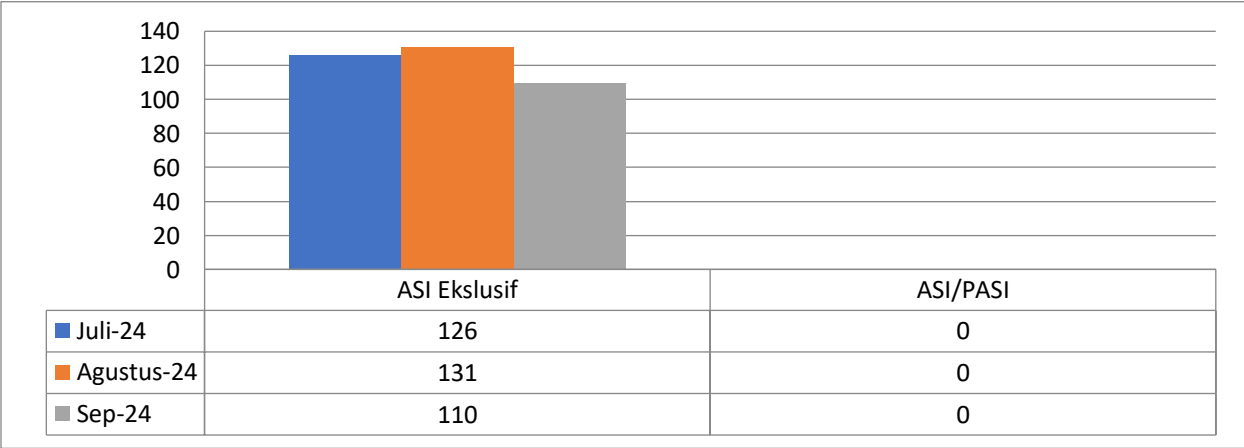
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif
Tabel 5.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Ponek September 2024

NO	PEMBERIAN ASI	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JULI 2024	BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024
1	Asi eksklusif	126	131	110
2	Asi /PASI	0	0	0

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan September 2024



Analisis :

- 1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan September 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 110 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
- 2. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

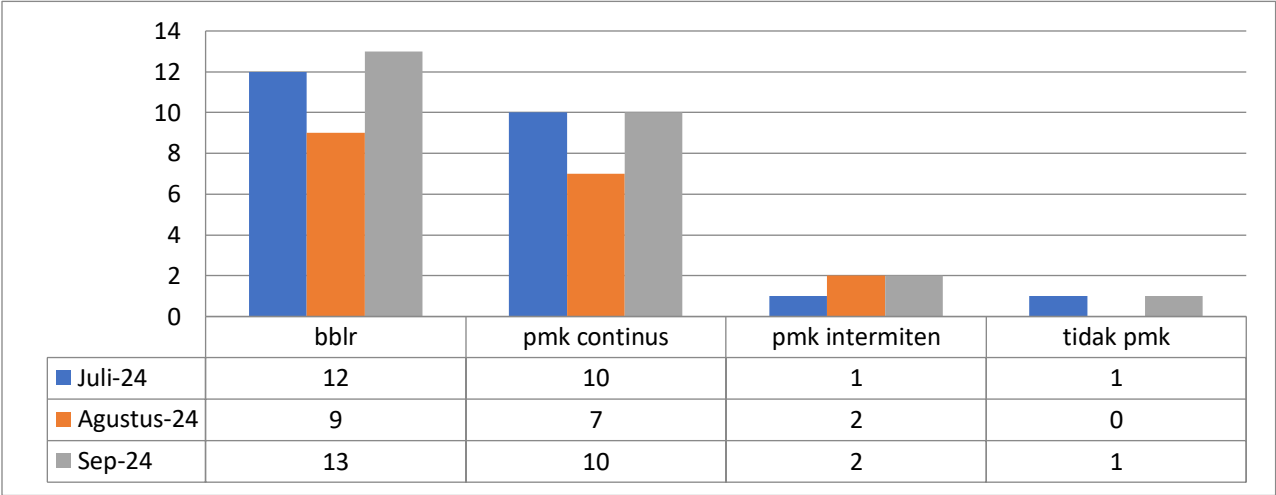
Rencana dan Tindak Lanjut :

Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR
Tabel Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponok September 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JULI 2024	BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024
1	Bayi BBLR	12	9	13
2	PMK continuos	10	7	10
3	PMK Intermiten	1	2	2
4	Tidak PMK	1	0	1

Grafik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR di RS Prima Husada
Bulan September 2024



- Analisis :**
- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
 - 2. Pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan September 2024 sama dengan bulan Agustus yaitu 2 bayi.
 - 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan September 2024 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 10 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada
 - 4. Dan ada 1 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan September 2024, sedangkan pada bulan Agustus tidak ada bayi yang tidak dilakukan PMK. hal ini dikarenakan kondisi bayi yg tidak mendukung untuk dilakukan PMK atau bayi di rujuk ke RS lain.

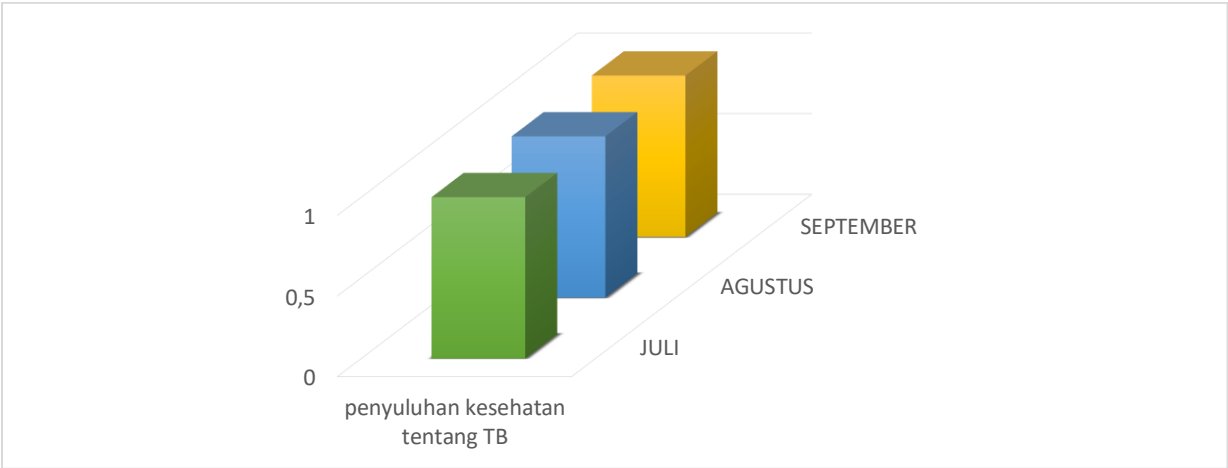
Rencana dan Tindak Lanjut
Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

1.1.2.2. TB DOT'S

3.1.2.2.1 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KEGIATAN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	1	1	1

Grafik Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan di RS Prima Husada



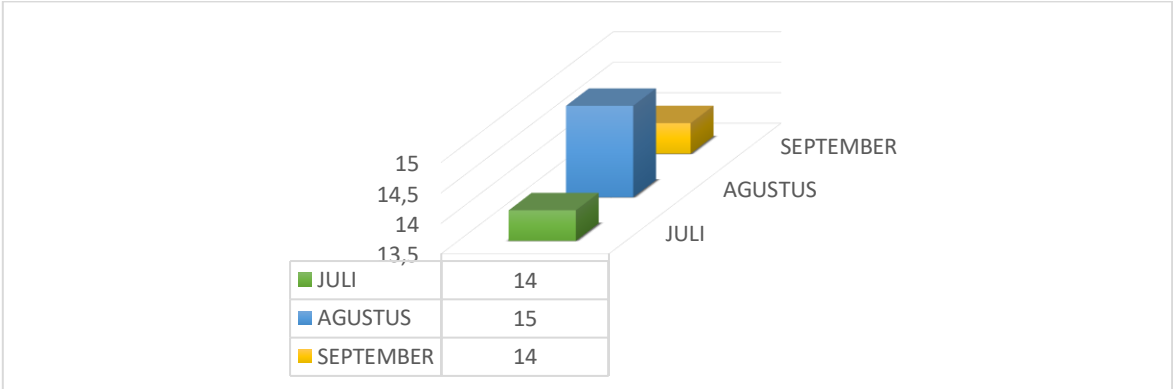
Analisis:
Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

Rencana dan Tindak Lanjut:
Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dll.

3.1.2.2.2 Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pemberian Masker	14	15	14

Grafik Jumlah Pasien Dengan Skrining Awal Pemberian Masker di RS Prima Husada



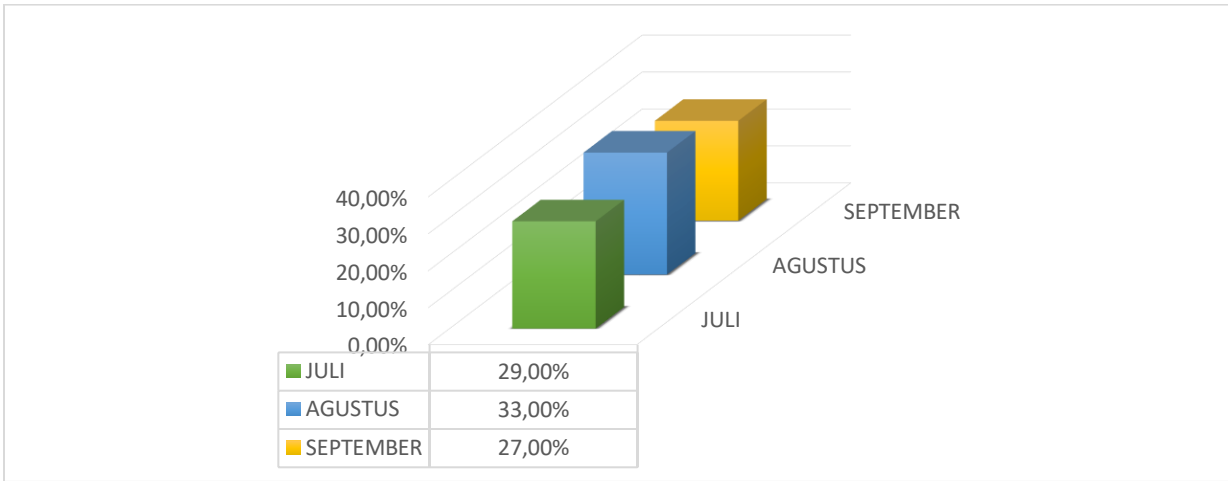
- Analisis :**
- 1. Pada bulan JULI 2024 terdapat 14 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
 - 2. Pada bulan AGUSTUS 2024 terdapat 15 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
 - 3. Pada bulan SEPTEMBER 2024 terdapat 14 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

- Rencana dan Tindak Lanjut:**
- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
 - 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.1.2.2.3 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	29	33	27

Grafik Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis di RS Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan Juli 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 29
- 2. Pada bulan Agustus 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 33
- 3. Pada bulan September 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 27

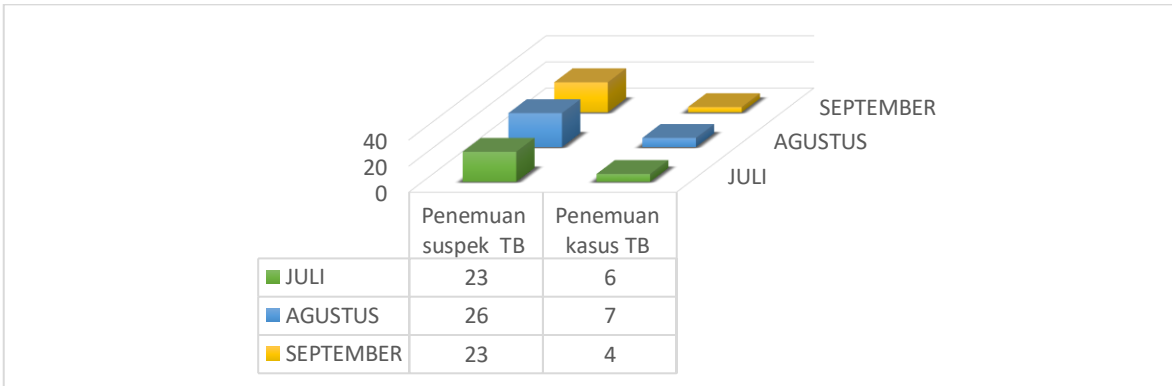
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.4 Penemuan Kasus TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Penemuan suspek TB	23	26	23
2	Penemuan kasus TB	6	7	4

Grafik Penemuan Kasus TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan Juli 2024 terdapat 23 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 6 pasien

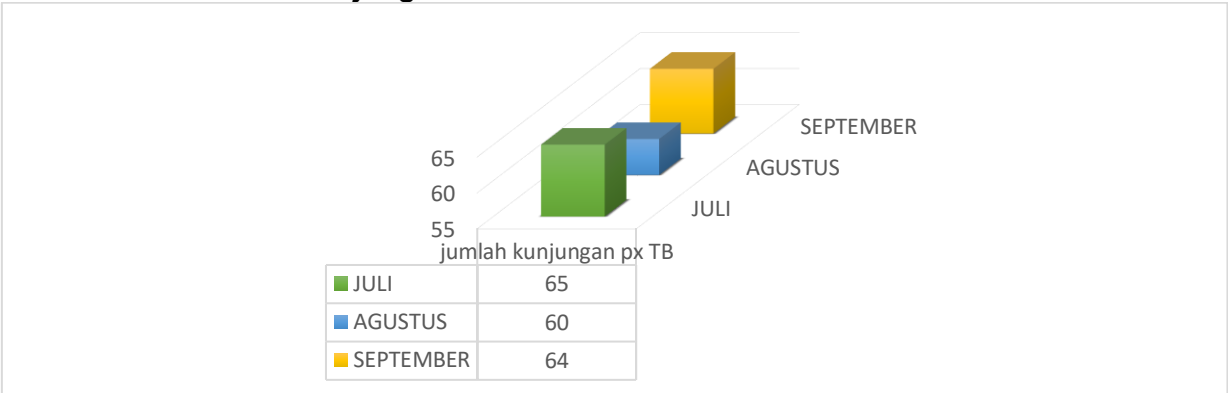
- 2. Pada bulan Agustus 2024 terdapat 23 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 6 pasien
- 3. Pada bulan September 2024 terdapat 23 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 4 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut:
Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB

3.1.2.2.5 Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pasien TB Kunjungan Keseluruhan	65	60	64

Grafik Jumlah Kunjungan Pasien TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



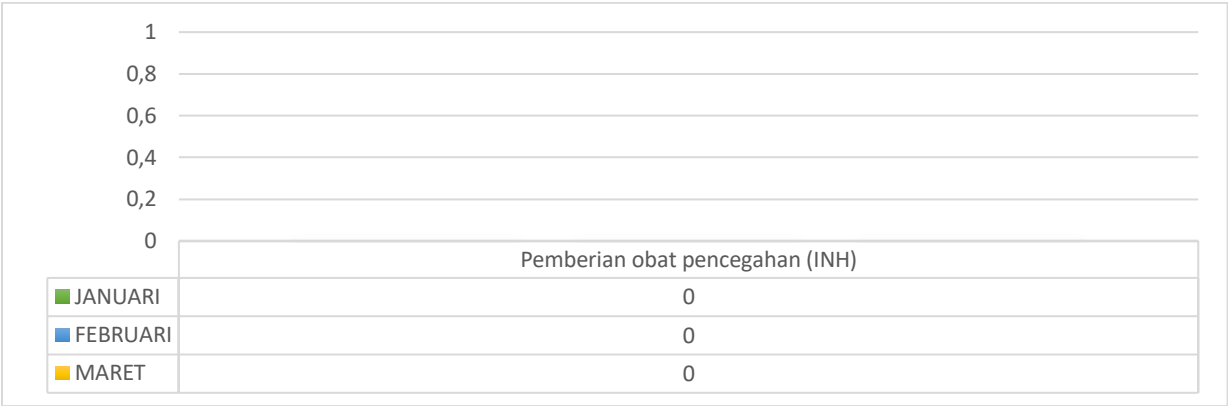
- Analisis:**
- 1. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Juli 2024 di poli pasien TBC mencapai 65 pasien.
 - 2. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Agustus 2024 di poli pasien TBC mencapai 60 pasien.
 - 3. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan September 2024 di poli pasien TBC mencapai 64 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.6 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	0	0	0

Grafik Pemberian Obat Pencegahan di Rumah Sakit Prima



Analisis :
Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

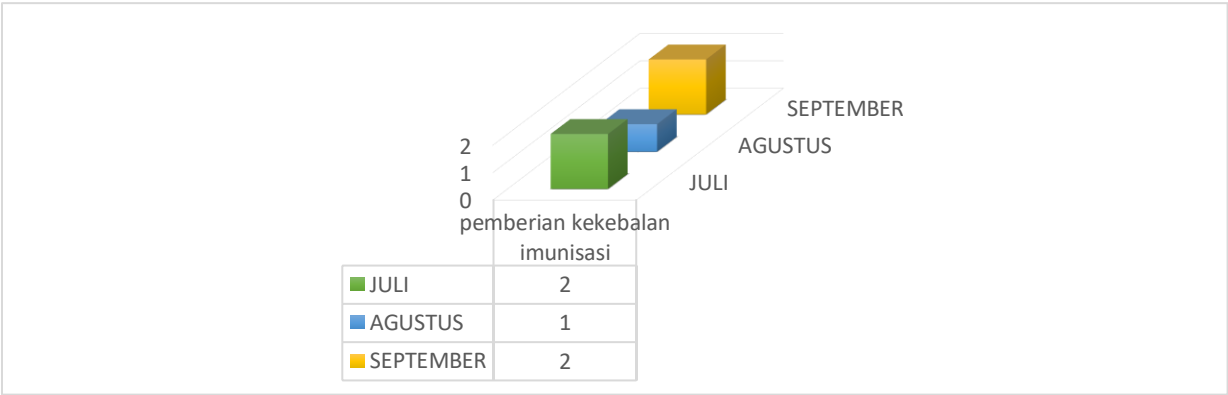
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

3.1.2.2.7 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pemberian imunisasi BCG	2	1	2

Grafik Pemberian Kekebalan Imunisasi Di RS Prima Husada



Analisis :

1. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan JULI
2. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 1 pasien yang diimunisasi pada bulan AGUSTUS
3. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan SEPTEMBER

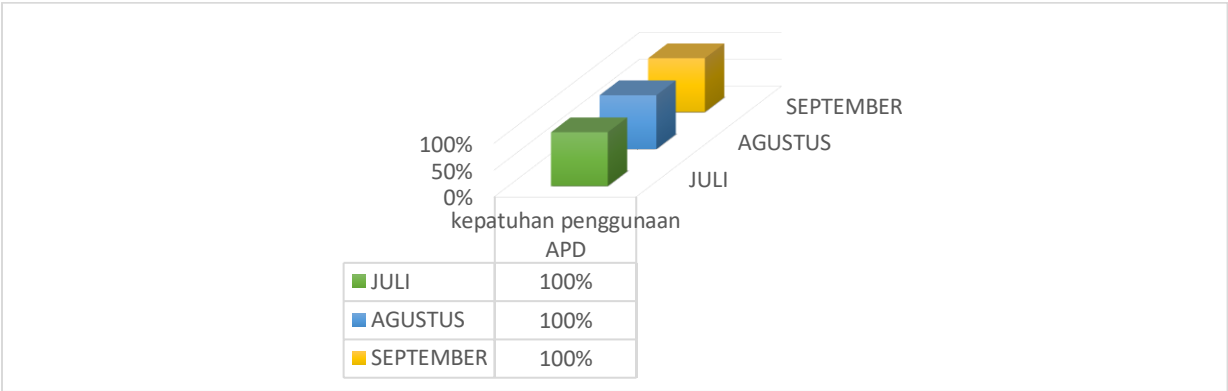
Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulany

3.1.2.2.8 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100%	100%	100%

Grafik Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APDRS Prima Husada



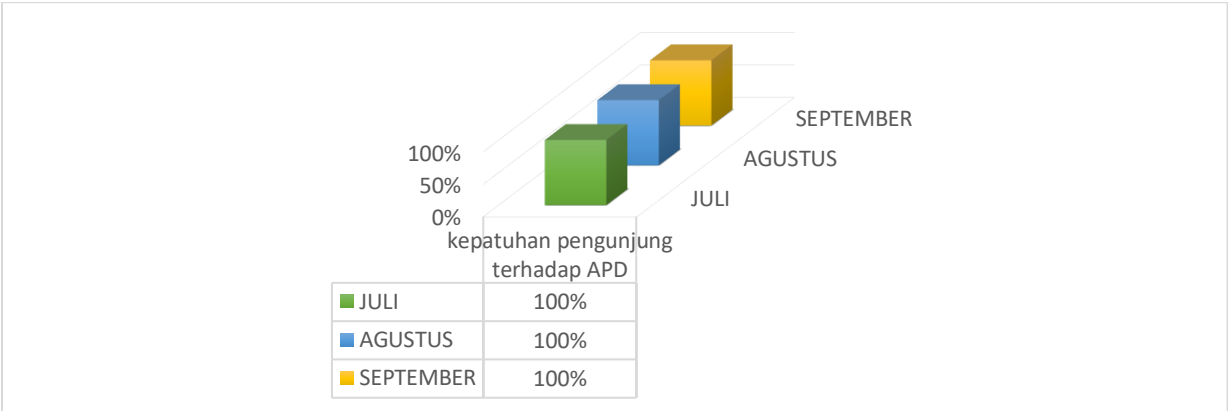
Analisis :
Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.9 Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%	100%	100%

Grafik Kepatuhan Pengunjung Terhadap APD di RS Prima Husada



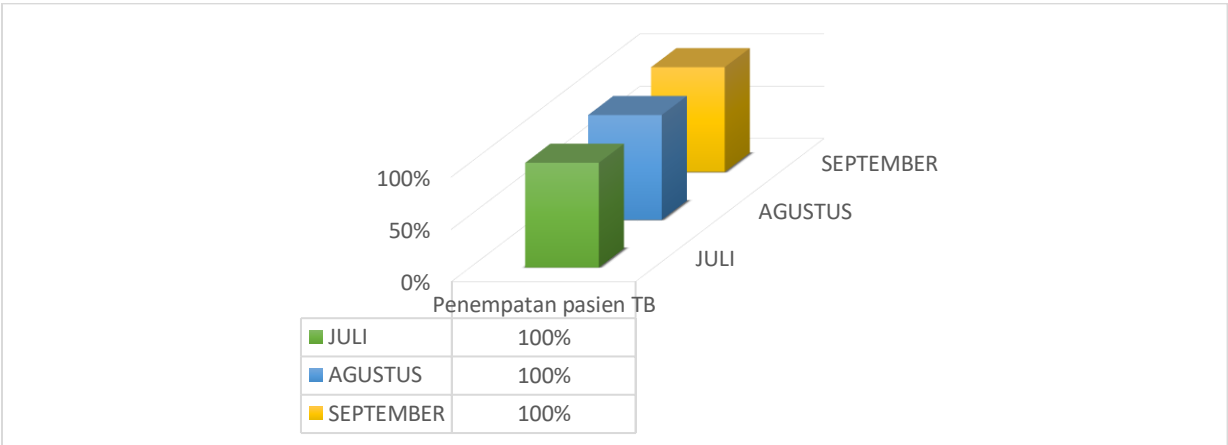
Analisis:
Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penulara.n karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi

3.1.2.2.10 Penempatan Pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Penempatan pasien TB	100%	100%	100%

Grafik Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan September 2024



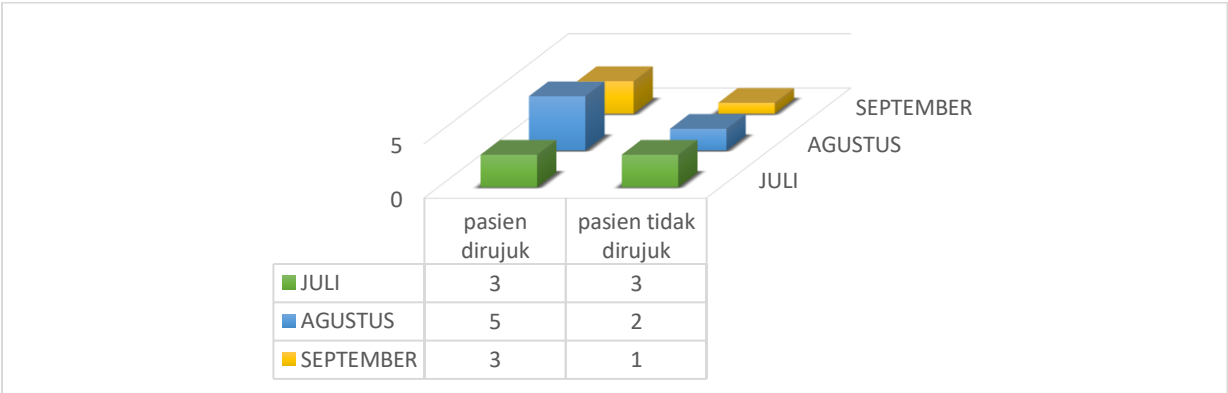
Analisis:
Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pasien TB yang dirujuk	3	5	3
2.	Pasien TB yang tidak dirujuk	3	2	1

Grafik Pasien TB yang dirujuk Di Rumah Sakit Prima Husada



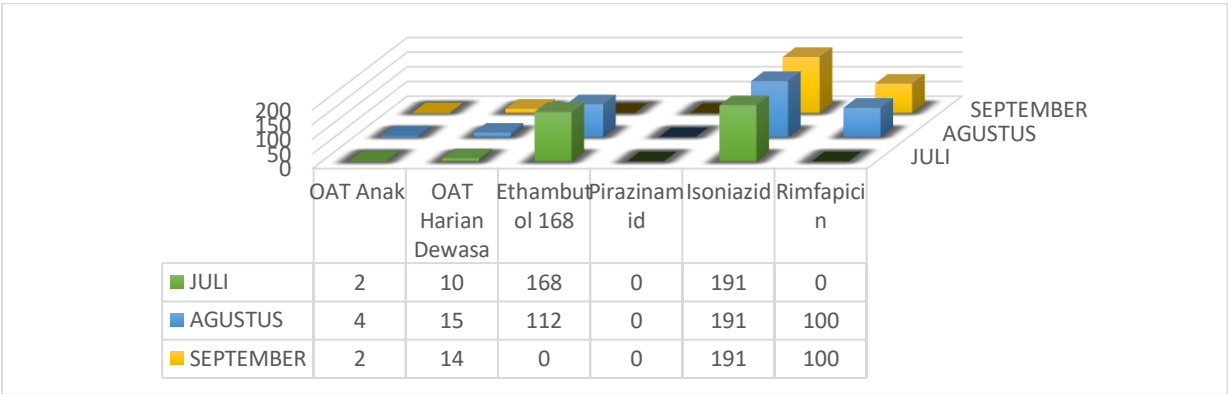
- Analisis :**
- 1. Pada bulan Juli 2024 terdapat 3 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
 - 2. Pada bulan Agustus 2024 terdapat 5 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya
 - 3. Pada bulan September 2024 terdapat 3 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	OAT Anak	2	4	2
2.	OAT Dewasa	10	15	14
3.	Kombipak	0	112	0
4.	TPT	0	0	0
5.	Ethambutol	168	191	191
6.	Pirazinamid	0	100	100
7.	Isoniazid	191	4	2
8.	Rimfapicin	0	15	14

Grafik Stok Obat TBC Di Rumah Sakit Prima Husada



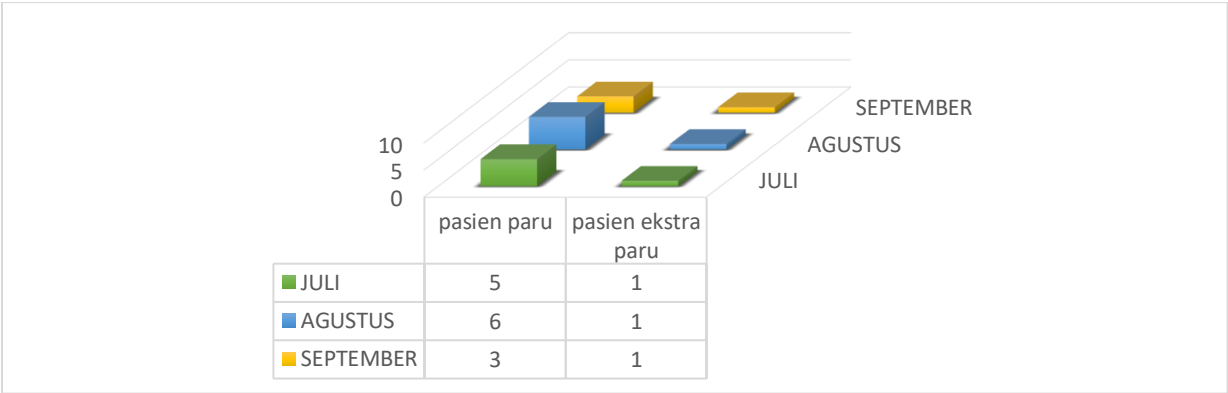
Analisis :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pasien paru	5	6	3
2.	Pasien Ekstra paru	1	1	1

Grafik Pasien Paru dan Ekstra Paru di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

- 1. Pada bulan Juli 2024 terdapat 1 pasien ekstra paru
- 2. Pada bulan Agustus 2024 terdapat 1 pasien ekstra paru
- 3. Pada bulan September 2024 terdapat 1 pasien ekstra paru

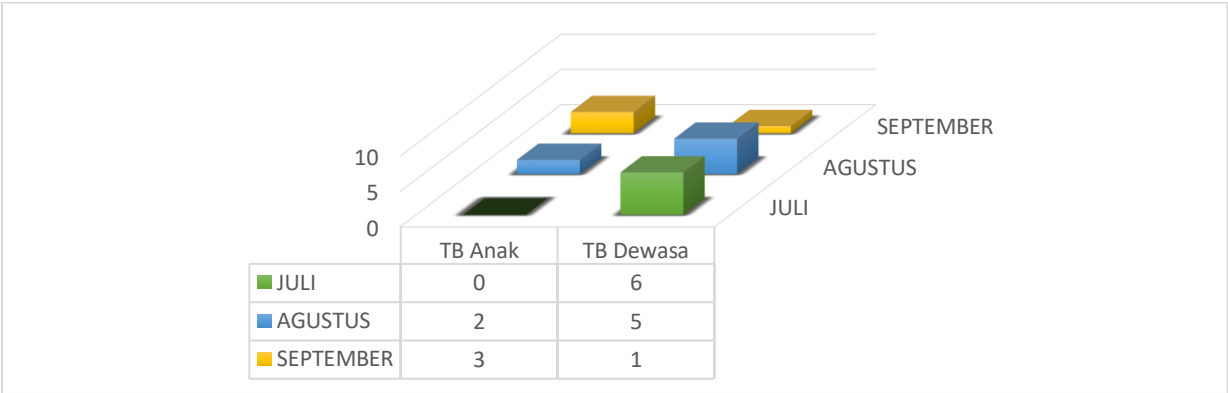
Rencana dan Tindak Lanjut :

Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama.

3.1.2.2.14 Pasien Anak Dan Pasien Dewasa TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pasien Anak	0	2	1
2.	Pasien Dewasa	6	5	3

Grafik Pasien Anak dan Pasien Dewasa di Rumah Sakit Prima



Analisis :

- 1. Pada bulan Juli terdapat 0 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 6 pasien
- 2. Pada bulan Agustus terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 5 pasien
- 3. Pada bulan September terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 5 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

3.1.2.2.15 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

NO	KEGIATAN	NAMA PASIEN	PATUH	TIDAK PATUH	ALASAN
1.	dr. Andy, Sp. P	Ny. S	V		
		Ny. I	V		
		Ny. S	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P	Tn. P	V		

3.	Dr. Yunita, Sp. P				
		Ny. S	V		

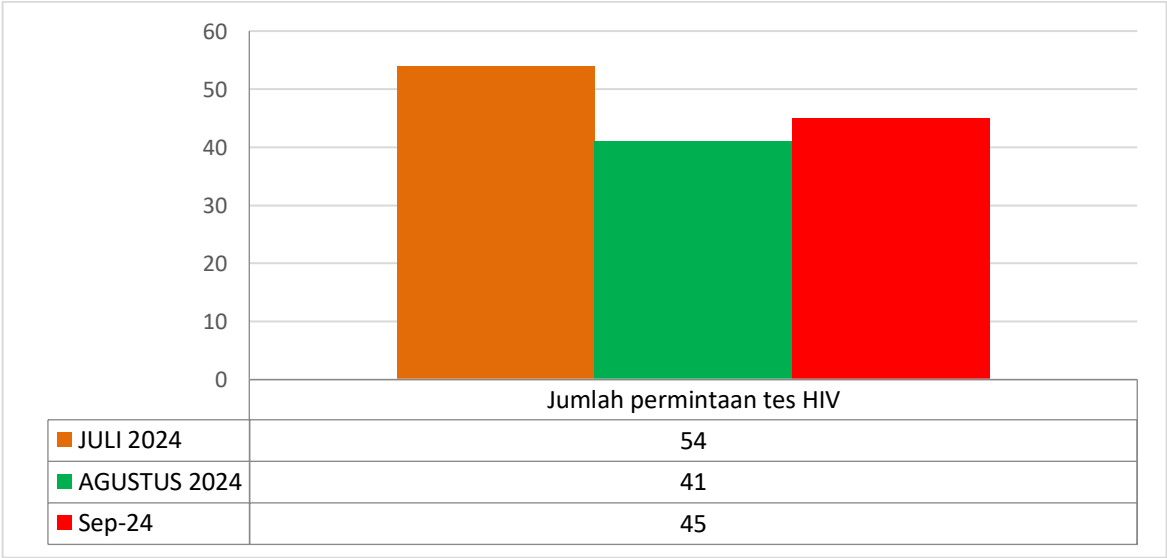
Analisis :
 Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV				
NO	URAIAN	BULAN		
		JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
1	Permintaan Test HIV	54	41	45

Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan September 2024



Analisis :
 Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan September sebanyak 45 pemeriksaan, Agustus sebanyak 41 pemeriksaan, pada bulan Juli 2024 sebanyak 54 pemeriksaan. Hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

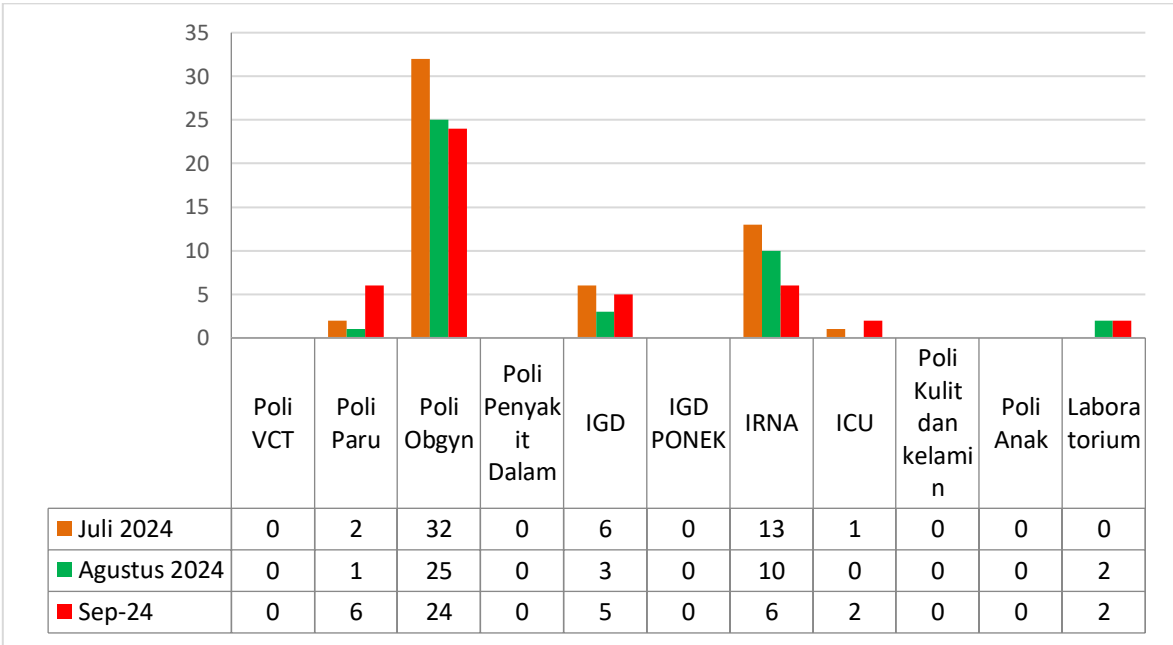
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.1.2.3.1. Asal Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	2	1	6
3	Poli Obgyn	32	25	24
4	Poli Penyakit Dalam	0	0	0
5	IGD	6	3	5
6	IGD PONEK	0	0	0
7	IRNA	13	10	6
8	ICU	1	0	2
9	Poli Kulit dan kelamin	0	0	0
10	Poli Anak	0	0	0
11	Laboratorium	0	2	2

**Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan September 2024**



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain pada bulan juli sebanyak 54 pasien. pada bulan agustus 2024 sebanyak 25 pasien. Sedangkan pada bulan September 2024 sebanyak 24 pasien. Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

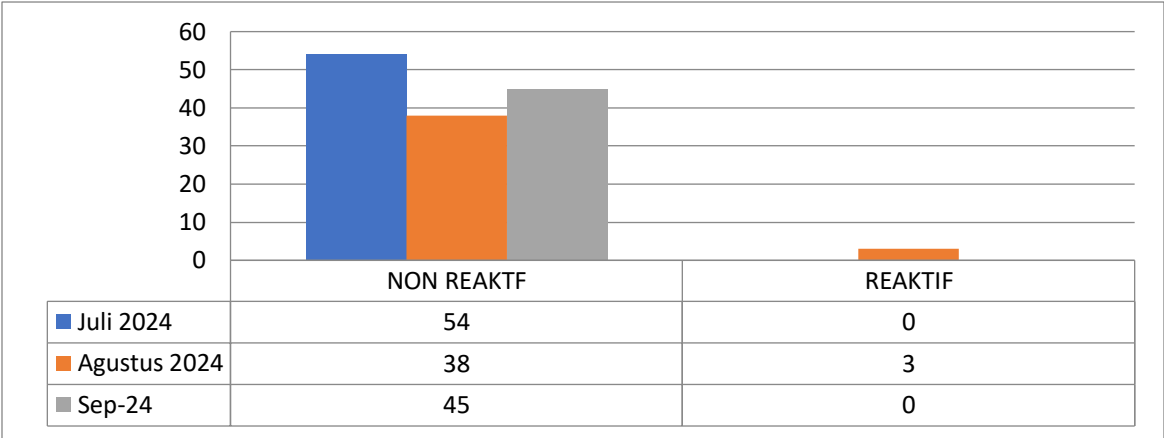
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
1	Non Reaktif	54	38	45
2	Reaktif	0	3	0

Grafik Status HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan September 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas tidak ditemukan pasien dengan status HIV reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada pada bulan September 2024.

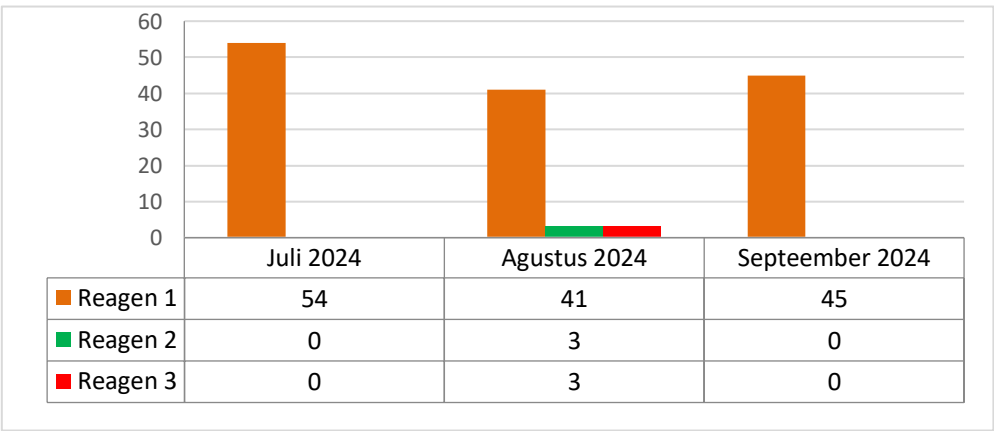
Rencana Tindak Lanjut :

Rumah Sakit Prima Husada Malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.1.2.3.3 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
1	Reagen 1	54	41	45
2	Reagen 2	0	3	0
3	Reagen 3	0	3	0

Grafik Jumlah Pemakaian Reagen di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan September 2024



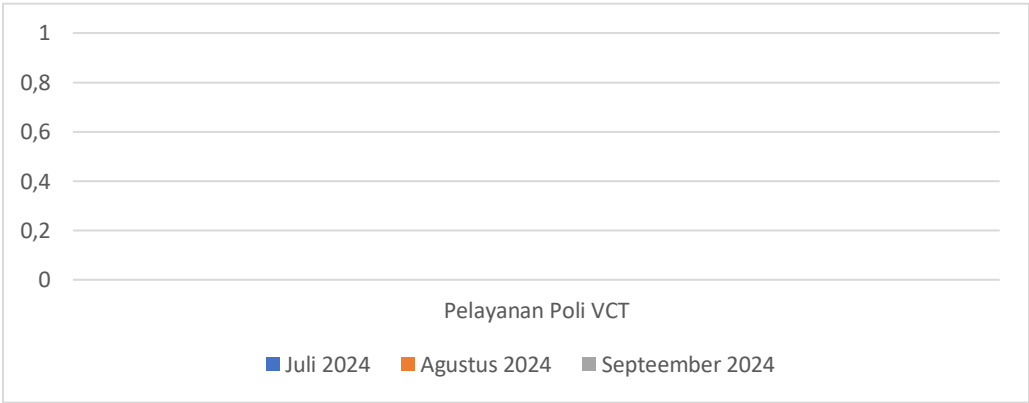
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada bulan Juli 2024 memakai reagen 1 saja. Hal ini dikarenakan pada bulan juni 2024 ditemukan pasien dengan hasil HIV Reaktif sebanyak 1 pasien. Pada bulan agustus 2024 pemakaian reagen sampai dengan reagen 3 dikarenakan pada bulan agustus 2024 ditemukan pasien dengan HIV reaktif sebanyak 3 pasien. Pada bulan September 2024 pemakaian reagen hanya sampai reagen 1 saja dikarenakan tidak ditemukan pasien dengan hasil HIV positif.

Rencana Tindak Lanjut :
Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.
Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.1.2.3.4 Pelayanan Poli Vct (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan September 2024



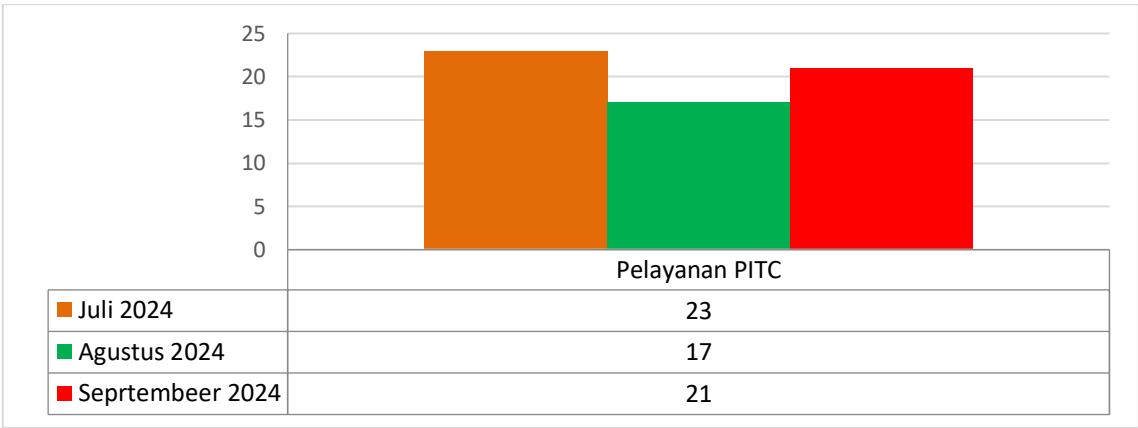
Analisis pelayanan Poli VCT
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

Rencana Tindak Lanjut
Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.1.2.3.5 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
1	Pelayanan PITC	23	17	21

Grafik Pelayanan PITC Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan September 2024



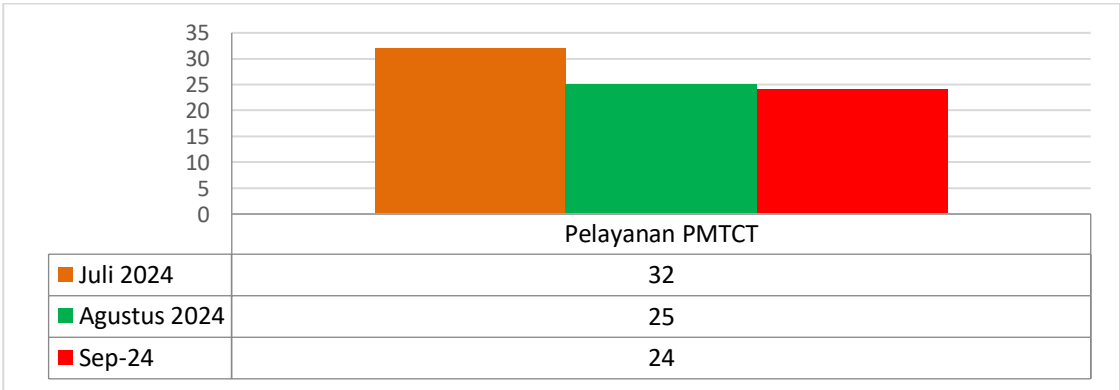
Analisis :
petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan juli 2024 sebanyak 23 pasien. pada bulan agustus 2024 sebanyak 17 pasien. Sedangkan pada bulan September sebanyak 21 pasien. Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan peningkatan terkait penjangrian pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tenytang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.1.2.3.6 Pelayanan Pmtct (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
1	Pelayanan PMTCT	32	25	24

Grafik Pelayanan PMTCT Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan September 2024



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan Juli 2024 sebanyak 32 pasien. pada bulan agustus 2024 sebanyak 25 pasien. Sedangkan pada bulan septemmber 2024 sebanyak 24 pasien.
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

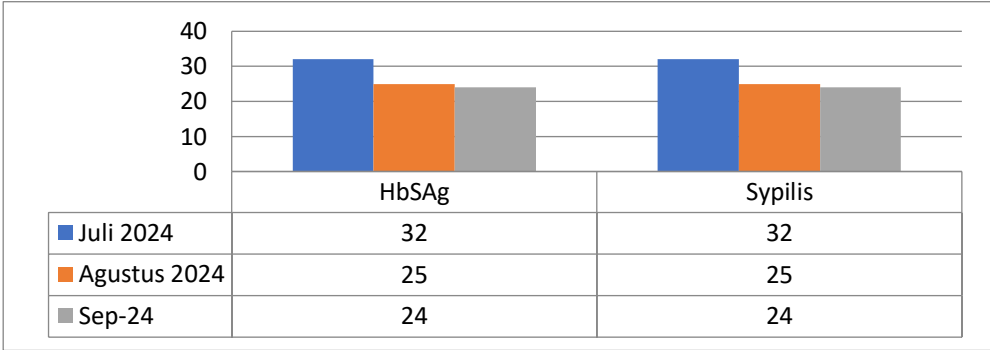
Rencana Tindak Lanjut :

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk *Prevention to Mother Of Child Transmision* bisa dilakukan.

3.1.2.3.7 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
1	HbSAg	32	25	24
2	Sypilis	32	25	24

Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Prima Husada Bulan September 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan Juli 2024 sebanyak 32 pasien, pada bulan agustus 2024 sebanyak 25 pasien. Sedangkan pada bulan September 2024 sebanyak 24 pasien. Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

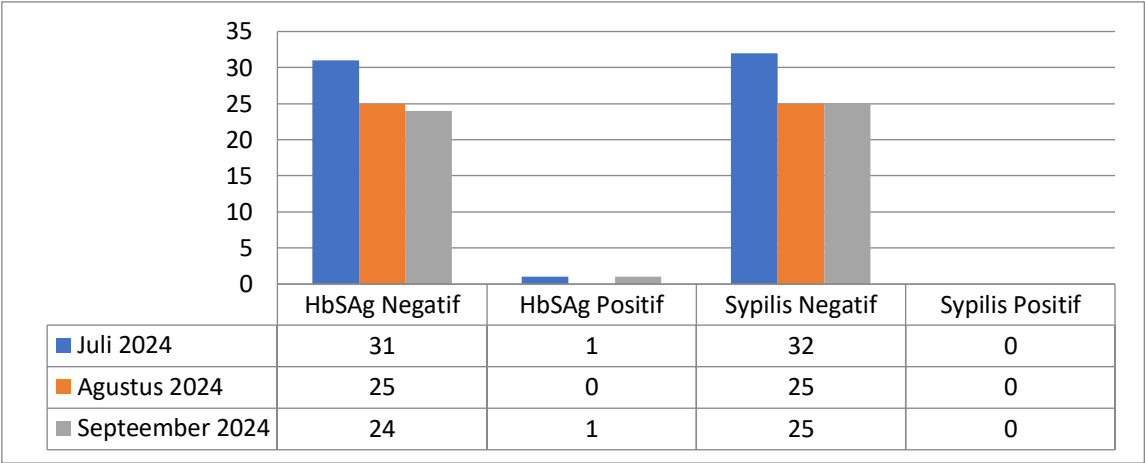
Rencana Tindak lanjut :

Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.1.2.3.8 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
1	HbSAg			
	Negatif	31	25	23
	Positif	1	0	1
2	Sypilis			
	Negatif	31	25	23
	Positif	1	0	1

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Prima Husada Bulan September 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa Pada bulan Juli 2024 ditemuka 1 pasien dengan HbSAg Positif. pada bulan agustus 2024 tidak ditemukan pasien HbSAg maupun Shypilis dengan hasil positif. Sedangkan pada bulan September 2024 ditemukan 1 pasien dengan HbSAg posiif

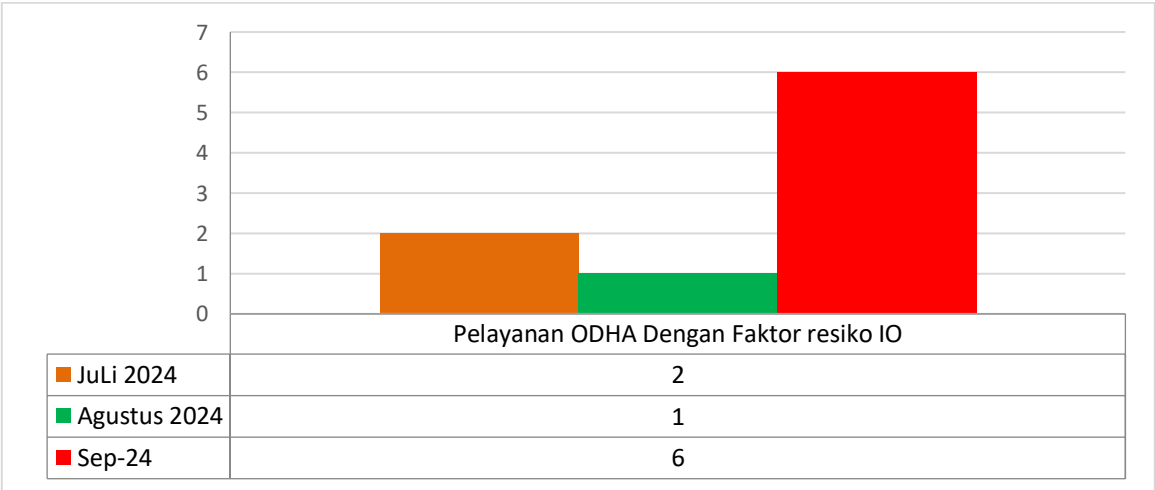
Rencana Tindak Lanjut :

1. Pada pasien HbSAg
- Saat kelahiran akan ada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
2. Pada pasien Sypilis
- Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.1.2.3.9 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

No	URAIAN	BULAN		
		JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	2	1	6

Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan September 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. Pada bulan juli di dapatkan 2 pasien. pada bulan agustus 2024 didapatkan 1 pasien. sedangkan pada bulan September 2024 didapatkan 6 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

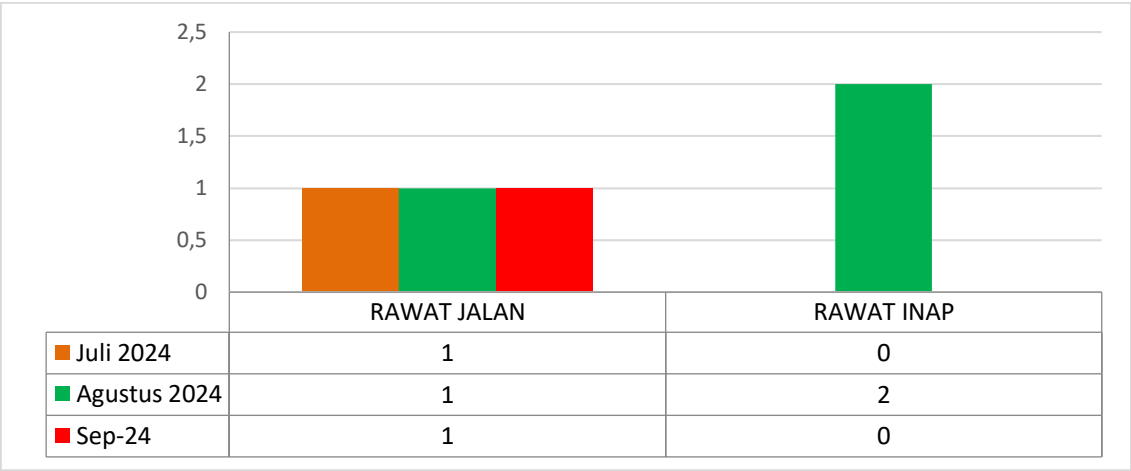
Rencana Tindak Lanjut :

Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO. Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.1.2.3.10 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
1	Rawat Jalan	1	1	1
2	Rawat Inap	2	2	0

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan Hiv/Aids Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan September 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pada bulan juli 2024 didapatkan data pasien yang dilakukan rujuk yaitu 1 pasien dari poli rawat jalan (poli kandungan) dengan pasien membawa hasil pemeriksaan sendiri dari PKM domisili pasien. pada bulan agustus 2024 terdapat 3 pasien yang dilakukan rujuk yaitu 2 dari rawat inap dan 1 dari poli IPD. Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV Sedangkan pada bulan September 2024 terdapat 1 pasien rawat jalan yang dilakukan rujuk yang berasal dari poli anak.

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

3.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting September 2024

NO	KEGIATAN POKOK SDM	PEMENUHAN RENCANA KEGIATAN
1	Kebutuhan SDM	Tidak terdapat perubahan tim stunting dan wasting pada bulan September 2024.
2	Orientasi	Tidak ada orientasi pada anggota tim penurunan prevalensi stunting dan wasting pada bulan September 2024
3	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan tentang stunting dan wasting dilakukan untuk memberikan pengetahuan mengenai stunting dan wasting serta dampak dan faktor penyebab dari stunting dan wasting dimana materi disampaikan oleh ketua tim setiap rapat bulanan. Pendidikan dan pelatihan kepada staff RS Prima Husada tentang stunting telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024. Pelatihan diberikan kepada seluruh staff ahli gizi agar lebih teliti dalam menentukan status gizi pasien balita.
4	Evaluasi Kinerja	a. Melakukan penyuluhan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan berkaitan dengan intervensi spesifik dan pencegahan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pasien dan keluarga pasien tentang stunting dan wasting. b. Melakukan beberapa intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit yaitu promosi tentang program 1000 HPK, Suplementasi tablet besi folat, Pemberian PMT pada ibu hamil, promosi konseling IMD dan ASI eksklusif, Pemberian makanan bayi dan anak, pemantauan pertumbuhan, dan pemberian makanan tambahan balita gizi kurang. c. ASI Eksklusif - Edukasi Pemberian ASI eksklusif sudah terlaksana dengan baik, - Dibentuknya Grup pendukung ASI eksklusif d. Senam Hamil - Senam Hamil dilaksanakan 2x dalam 1 bulan secara rutin - Pemberian edukasi seputar kesehatan atau perawatan - perawatan yang dibutuhkan ibu hamil. e. Merujuk pasien stunting kepada puskesmas wilayah tempat tinggal balita stunting dan wasting untuk evaluasi pertumbuhan dan perkembangan balita melalui whatsapp dan aplikasi eppgbm

- Analisis
1.

Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di rumah sakit.
2.

Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2 Kinerja Produktivitas

Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1
Suplement asi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang penting nya	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall	1	1	1

	konsum si asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat		gedung baru lantai 5			
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	IRNA Anak	-	2	0	0
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0

	mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A					
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	0	2	0
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

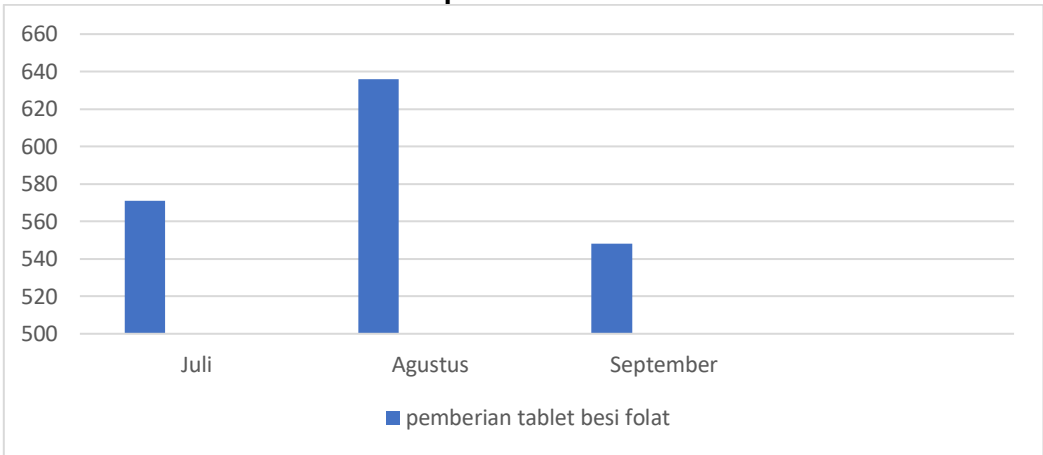
Analisis :
 Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas. Sehingga jika ada pasien teridentifikasi wasting pihak RS baru mendapat distribusi dari puskesmas wilayah balita tersebut tinggal.

Rencana Tindak Lanjut :
 Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil
Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	571	636	548

Grafik Jumlah Pemberian Tablet Besi Folat Pada Ibu Hamil Di RS Prima Husada Bulan September 2024



Analisis :
Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat menurun pada bulan September yaitu 548 ibu hamil yang mendapat tablet besi folat.

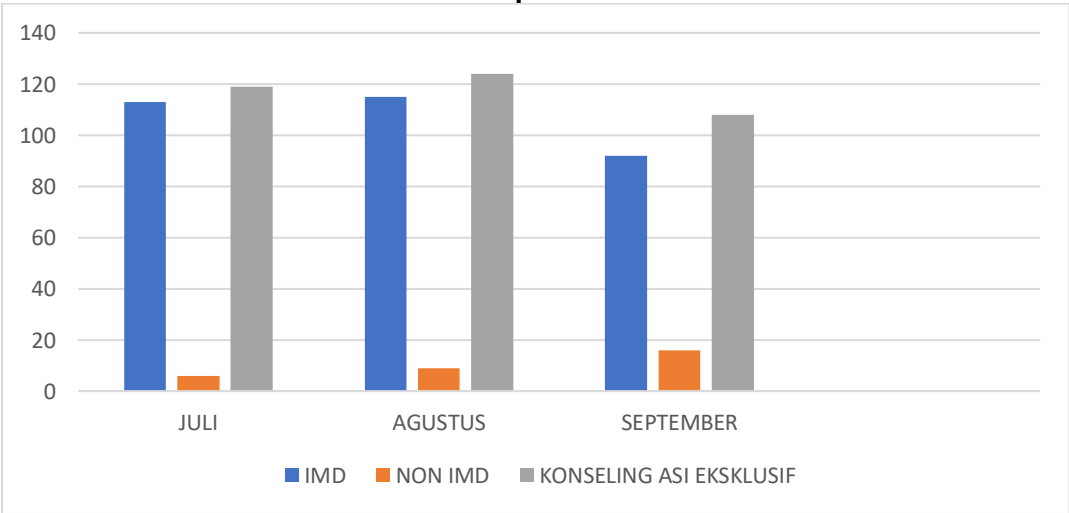
- Rencana Tindak Lanjut:**
- 1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 - 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JULI 2024	BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024
1	IMD	113	115	92
2	Tidak IMD	6	9	16
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	119	124	108

Grafik Pelayanan IMD dan Konseling ASI Eksklusif di RS Prima Husada Bulan September 2024



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan September 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu 92 bayi.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan September 2024 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 16 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
- 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif menurun pada bulan September 2024 yaitu sebanyak 108 pasien.

Rencana Tindak Lanjut:

Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN JULI 2024	BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024
1	HbO	0	2	0
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	2	1	2
3	Polio	4	3	4
4	Pentabio	2	2	2
5	Campak	2	4	2
6	IPV	2	3	0

Analisis:

- 1. Tidak ada Imunisasi Hbo pada bulan Agustus dikarenakan ketidakterSEDIAnya vaksin HB0 di RS prima Husada malang, bayi yang baru lahir diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
- 2. Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Agustus sedikit meningkat pada bulan Juli yaitu 3 bayi.
- 3. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Agustus 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 1 pasien.
- 4. Pada periode Agustus 2024 terdapat bayi yang melakukan Imunisasi Campak yaitu 4 bayi.
- 5. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Agustus 2024

Rencana Tindak Lanjut :

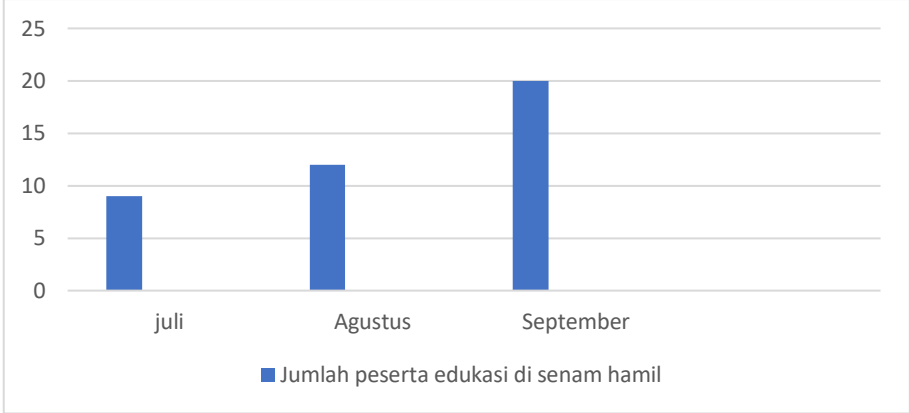
Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi

Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
Ruang Pojok Laktasi	1	1	1
Senam Hamil	9	12	20
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1

Grafik Senam Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan September 2024



Analisis :

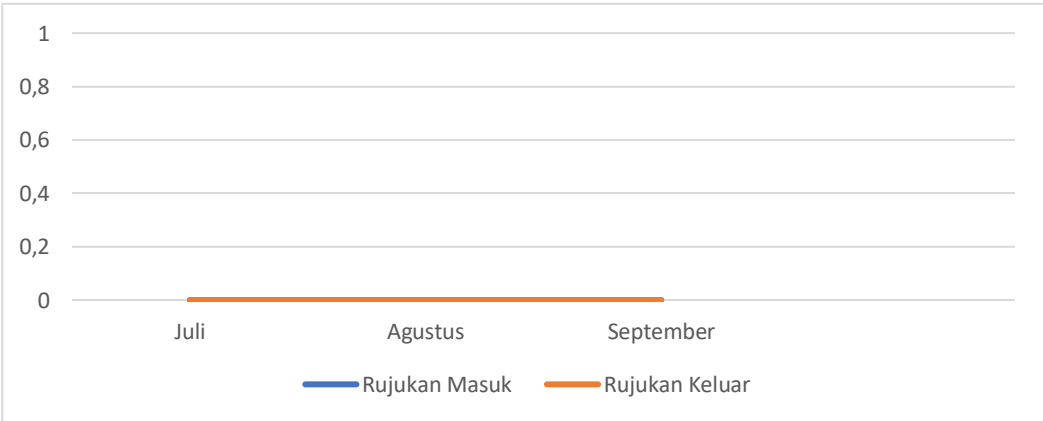
- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah Rumah Sakit Prima Husada Malang.
- 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
- 3. Jumlah peserta edukasi meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yaitu sebanyak 12 orang

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

RUJUKAN MASUK				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-
RUJUKAN KELUAR				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-



Analisis :

Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS

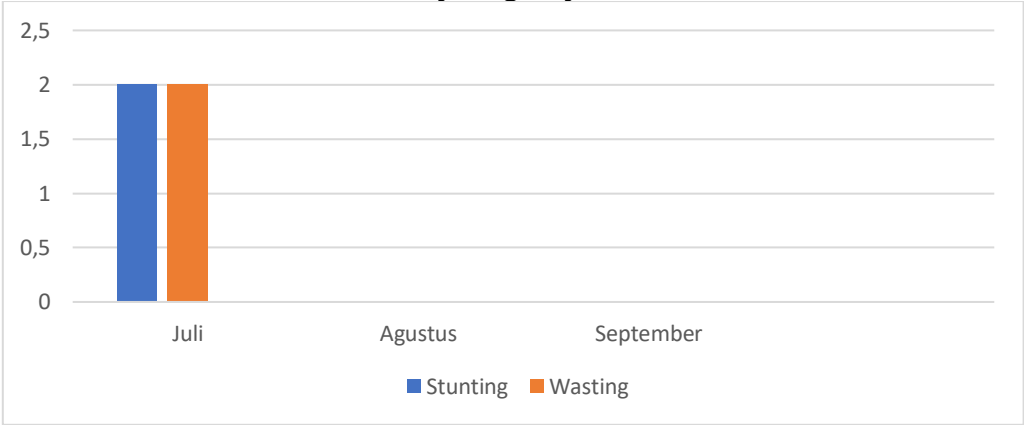
Rencana Tindak Lanjut:
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjaring pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
Jumlah Pasien Stunting	2	0	0
Jumlah Pasien Wasting	2	0	0

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisis :
Terdapat 2 pasien stunting dan wasting pada bulan Juli. Hal tersebut berkaitan dengan pola makan pasien yang terbilang kurang yaitu 2x sehari dan jumlah asupan makan sekali makan terbilang kurang yaitu 2 sdm tiap makan.

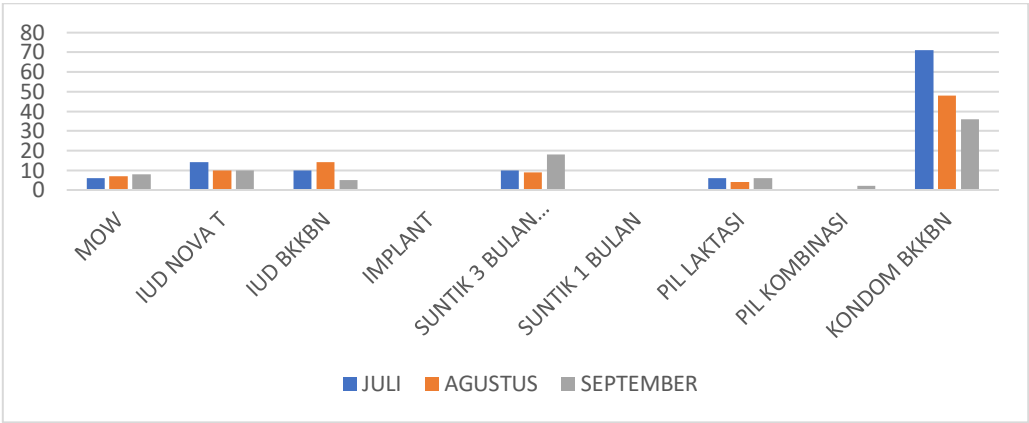
Rencana Tindak Lanjut :
Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada memberikan terapi dengan bekerja sama dengan dokter spesialis anak untuk memberikan vitamin dan antibiotik yang dibutuhkan untuk mengatasi infeksi yang diderita pasien. Selain itu tim SW juga bekerjasama dengan cara melaporkan pasien stunting kepada petugas Gizi Puskesmas wilayah pasien tinggal untuk melakukan pemantauan lebih lanjut dan pemberian intervensi lanjutan kepada balita stunting dan wasting tersebut.

3.1.2.5 KBRs
3.1.2.6 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JULI 2024	BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024
1	MOW	6	7	8
2	IUD Nova T	14	10	10
3	IUD BKKBN	10	14	5
4	IMPLANT	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN BKKBN	10	9	18

6	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0
7	PIL KOMBINASI	0	0	2
8	PIL LAKTASI	6	4	6
9	KONDOM BKKBN	72	48	36

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi



Evaluasi :

1. Peserta MOW pada bulan Juli (6) Agustus naik (7) September naik (8)
2. Peserta IUD Nova T pada bulan Juli (14) Agustus (10) September (10)
3. Peserta IUD BKKBN, pada bulan Juli (10) meningkat agustus (14) menurun September (5)
4. Peserta KB suntik 3 bulan, pada bulan Juli (10) Agustus (9) meningkat September (18)
5. Peserta KB pil kombinasi karena stok kosong Gudang bkkbn Juli (0) Agustus (0) September (2),Pil KB laktasi Juli (6) Agustus (4) September (6)
6. Peserta KB Kondom pada bulan Juli (72) Agustus (48) Septemebr (36)

Analisis :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

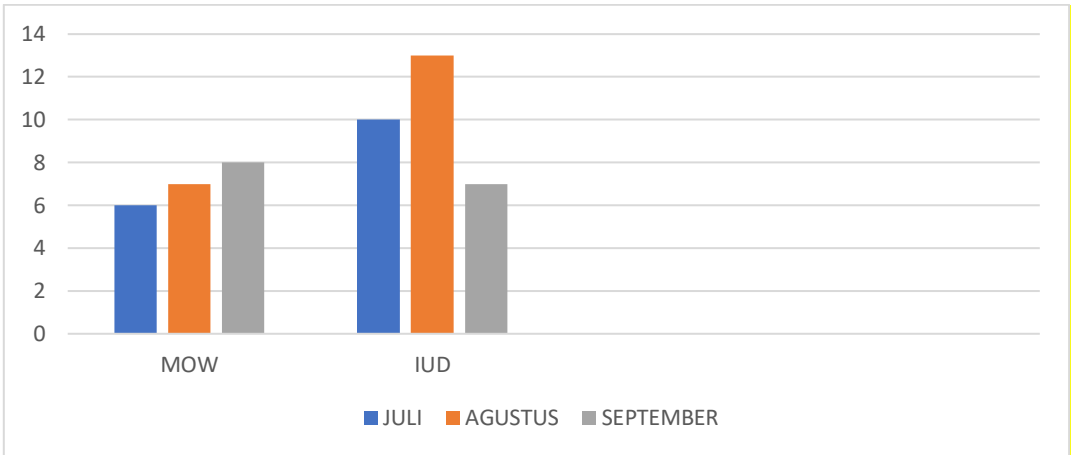
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran

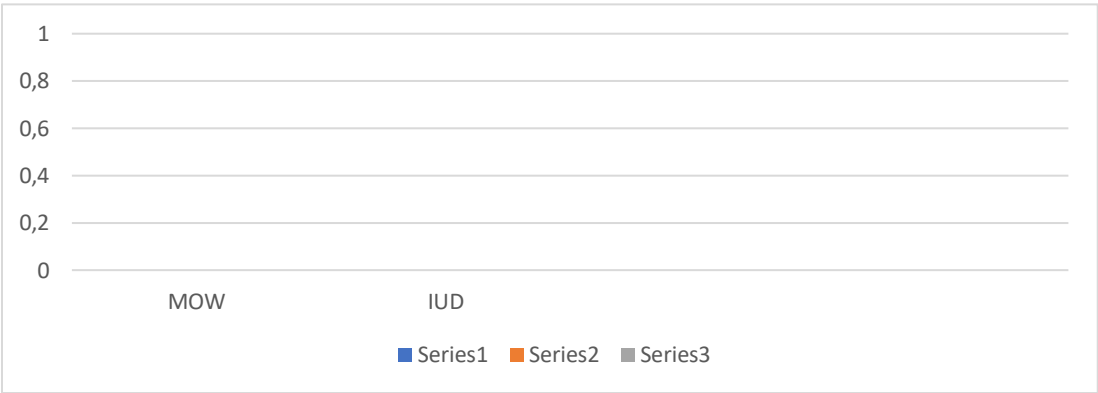
NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JULI 2024	BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024
1	MOW	6	7	8
2	IUD	10	13	7

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JULI 2024	BULAN AGUSTUS 2024	BULAN SEPTEMBER 2024
1	MOW	0	0	0
2	IUD	0	0	0

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

- 1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan Juli-Agustus-September meningkat
- 2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan Juli-Agustus-September menetap

Analisis

- 1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
- 2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan III Tahun 2024

3.2.3.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Juli 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Ngatemin	L/76	dr. Heri, Sp.PD	080191	Syok Hipokalemi	25/06/2024	03/07/2024	9	Ceftiaxone	2	2x1	2	2	1
									Cefixime		2x0,1	1,4	0,4	3,5
2	Dian Nuriana	P/37	dr. Anton, Sp.B	216048	Acute Appendicitis	27/06/2024	01/07/2024	5	Ceftriaxone	3	2x1	4	2	2
									Ceftriaxone		3x1	9	2	4,5
									Metronidazole po		3x0,25	2,25	2	1,125
3	Asmat	L/46	dr. Andy, Sp.P	216224	Dyspnea	30/06/2024	04/07/2024	5	Ceftriaxone	3	2x1	6	2	3
									Azitromycin po		2x0,5	1	0,3	3,33
									Levofloxacin inf		1x0,5	1	0,5	2
4	Rihat Rico	L/29	dr. Zaki, Sp.B	216335	Ulcus Diabeticum	02/07/2024	05/07/2024	4	Cefoperazone sodium	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftiaxone		2x1	7	2	3,5
5	Roberto Bagio	L/21	dr. Yunita, Sp. P	169390	Obs Dyspneu dd Athsma dd COPD	03/07/2024	05/07/2024	3	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1,5	2	0,75
6	Agus Wahyudi	L/36	dr. Ardhi, Sp.PD	083488	Gastroneocitis	08/07/2024	12/07/2024	5	Ceftiaxone	2	2x1	8	2	4
									Ciprofloxacin po		2x0,5	5	1	5
7	Ernawati	P/44	dr. Vika, Sp.K	192126	Anogenital	09/07/2024	11/07/2024	3	Dohixat	1	2x0,1	0,6	0,1	6
8	Iwan Darsoni	L/39	dr. Yunita, Sp. P	208370	Dyspnea	09/07/2024	13/07/2024	5	Levofloxacin inf	1	1x0,75	3,75	0,5	7,5
9	Meirul Wahyu	L/21	dr. Kuntadi, Sp.OT	216664	Fingertrip Injury	10/07/2024	12/07/2024	3	Ceftiaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
10	Kasiadi	L/48	dr. Yoga, Sp.JP	216773	DM Type 2	12/07/2024	18/07/2024	7	Ceftiaxone	2	2x1	14	2	7
									Levofloxacin po		1x0,5	1,5	0,5	3

11	Ngatemi	P/63	dr. Ardhi, Sp.PD	198384	DM Type 2	15/07/2024	18/07/2024	4	Ceftiaxone	2	2x1	8	2	4
									Levofloxacin inf		1x0,5	2	0,5	4
12	Suwarni	P/64	dr. Heri, Sp.PD	216944	DM Type 2	15/07/2024	20/07/2024	6	Ceftriaxone	3	2x1	9	2	4,5
									Metronidazole inf		3x0,5	1,5	1,5	1
									Asam pipemidat		2x0,4	1,6	0,8	2
13	Ngatemin	L/77	dr. Heri, Sp.PD	080191	Abdomal Pain	16/07/2024	18/07/2024	3	Ceftriaxone	2	2x1	5	2	2,5
									Sulfasalazine		2x0,5	2,5	2	1,25
14	Ren Wijayanti	P/46	dr. Anton, Sp.B	216962	Necrotizing Faciitis	16/07/2024	18/07/2024	4	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
15	Ibrahim Muhammad	L/63	dr. Heri, Sp.PD	184234	DF	18/07/2024	21/07/2024	4	Ceftriaxone	2	2x1	3	2	1,5
									Levofloxacin inf		1x0,75	2,25	0,5	4,5
16	Suyono	L/59	dr. Ardhi, Sp.PD	130971	Colic Abdomen	22/07/2024	25/06/2024	4	Ceftiaxone	2	2x1	6	2	3
									Asam Pipemidat		2x0,4	2	0,8	2,5
17	Suli'ati	P/43	dr. Humaira, Sp.OG	130746	Cervix uteri	24/07/2024	25/07/2024	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicillin po		3x0,5	1,5	1,5	1
18	Munirotul K	P/43	dr. Andi, Sp. B	217219	TU Mamae (S)	24/07/2024	26/07/2024	3	Cefoperazone sodium	1	1x2	2	4	0,5
19	Ngatminah	P/45	dr. Anton, Sp.B	217296	Soft Tissue of Thorax	24/07/2024	26/07/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
20	Rizki Wulandari S	P/28	dr. Aida, Sp.OG	171126	SC	24/07/2024	26/07/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1

3.2.2.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Agustus 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Siti Rubaiyah	P/47	dr. Heri, Sp.PD	174600	Volume Depletion	29/07/2024	02/08/2024	5	Asam Pipemidate	2	2x0,4	2,8	0,8	3,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
2	Alfiyah	P/64	dr. Heri, Sp.PD	068249	DM Type 2	30/07/2024	05/08/2024	5	Asam Pipemidate	2	2x0,4	2,8	0,8	3,5
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5
3	Etik Supriatin	P/64	dr. Anton, Sp.B	217659	Necrotizing	31/07/2024	02/08/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,75	2	0,875
4	Siti Lutfiyah	P/48	dr. Zaki, Sp.B	060461	Post of Debridement	02/08/2024	04/08/2024	3	Ceftriaxone	2	2x1	3	2	1,5
									Metronidazole inf		3x0,5	1,5	1,5	1
5	Syafira Widya	P/19	dr. Anton, Sp.B	217481	Ganglion Elbow (D)	02/08/2024	04/08/2024	3	Ceftizoxime	3	1x2	2	4	0,5
									Ceftizoxime		1x1	1	4	0,25
									Cefixime		2x0,1	0,4	2	0,2
6	Sudjilah	P/75	dr. Miryanti, Sp.JP	185511	Chest Pain	03/08/2024	04/08/2024	2	Meropenem	1	2x1	3	3	1
7	Nining Nur Wahyu	P/33	dr. Aida, Sp.OG	122283	SC	03/08/2024	05/08/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
8	Siti Qomariah	P/22	dr. Zora, Sp. PD	124748	GEA + Volume Depletion	03/08/2024	05/08/2024	3	Ciprofloxacin inf	1	2x0,2	1	0,8	1,25
9	Masudah	P/47	dr. Zora, Sp.PD	174600	Unspecified renal colic	06/08/2024	09/08/2024	4	Asam Pipemidate	2	2x0,4	2,8	0,8	3,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
10	Siaman	L/59	dr. Arianto, Sp.OT	136807	Injury to the foot due to infection	08/08/2024	10/08/2024	3	Ceftraixone	2	1x1	4	2	2
									Metronidazole inf		1x0,5	1,5	1,5	1
11	Azizah Aprila	P/22	dr. Anton, Sp.B	210157	Nectrotizing Facitis Pedis	11/08/2024	13/08/2024	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftiaxone		2x1	5	2	2,5
12		P/37	dr. Aida, Sp.OG	218352	PEB	13/08/2024	14/08/2024	2	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67

	Yunita Indrayana								Metronidazole inf		1x0,5	1	1,5	0,67
13	Wiwit Triani	P/52	dr. Anton, Sp.B	217659	Limpadenopathy Inguinal	16/08/2024	18/08/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,75	2	0,875
14	Syaiful Yuniasih	L/38	dr. Andy, Sp.P	218504	Dyspnea	17/08/2024	19/08/2024	3	Ceftiaxone	2	2x1	5	2	3,5
									Levofloxacin inf		1x0,75	2,25	0,5	4,5
15	Samiaty	P/65	dr. Yoga, Sp.JP	218531	DOC, Syok Cardiogenic	18/08/2024	21/08/2024	4	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4
									Levofloxacin inf		1x0,5	2	0,5	4
16	Musdalifah	P/53	dr. Arianto, Sp.PD	148673	Ganglion	19/08/2024	21/08/2024	3	Cepoferazone	2	1x2	2	4	0,5
									Cepoferazone		2x1	2	4	0,5
17	Nisa Tri Y	P/35	dr. Humaira, Sp.OG	097429	SC	21/08/2024	23/08/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
18	Boby Juli	L/26	dr. Zaki, Sp.B	218719	Appendicitis	21/08/2024	25/08/2024	5	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	6	12	3
19	Sunarmi	P/63	dr. Miryanti, Sp.JP	109487	CHF	21/08/2024	26/08/2024	6	Ceftriaxone	2	2x1	10	2	5
									Levofloxacin inf		1x0,75	3,75	0,5	7,5
20	Bunga Perdana P	P/36	dr. Humaira, Sp.OG	209242	Oligohydramnios	29/08/2024	30/08/2024	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicillin		2x0,5	1	1,5	0,67

3.2.2.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan September 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Sutik	L/68	dr. Heri, Sp. Pd	219077	DM Type 2	30/08/2024	01/09/2024	3	Ceftriaxone	2	2x1	5	2	2,5
									Azitromycin po		1x0,5	1,5	0,3	5
2	Moch Lutfi	L/46	dr. Andy, Sp. P	175773	Acute respiratory failure	30/08/2024	07/09/2024	9	Ceftriaxone	3	2x1	5	2	0,5
									Cefoperazone sodium		2x1	5	4	1,25
									Meropenem		2x1	6	3	2
3	Joni Arifin	L/56	dr. Anton, Sp. B	218906	Other Hydrocele	03/09/2024	05/09/2024	3	Ceftizoxime	2	1x1	1	4	0,25
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
4	Arsita Fadillah	P/22	dr. Heri, Sp. Pd	185265	Gastroenteritis and colitis	03/09/2024	05/09/2024	3	Asam Pipemidat	1	2x1	2,4	0,8	3
5	Riyani	P/49	dr. Ardhi, Sp. Pd	201139	DM Hyperglikemi	04/09/2024	07/09/2024	4	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4
									Ciprofloxacin po		2x0,5	2	1	2
6	Sugeng Suyanto	L/57	dr. Anton, Sp.B	085988	Necrotizing fasciitis	06/09/2024	08/09/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
7	Muhammad Alif	L/18	dr. Zaki, Sp. B	114182	Abd. Pain	08/09/2024	10/09/2024	3	Cefoperazone sodium	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
8	Yusnia Kosi P	P/29	dr. Aida, Sp. OG	118463	SC	09/09/2024	11/09/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
9	Moch Yusron	L/70	dr. Anton, Sp.B	219561	With peripheral circulatory	10/09/2024	12/09/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		3x1	7	2	3,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
10	Vicky Octavianto	L/28	dr. Anton, Sp.B	219500	Fistula perianal	11/09/2024	13/09/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Gentamycin		3x0,08	0,24	0,24	1
									Metronidazole po		3x0,25	1,75	2	0,875

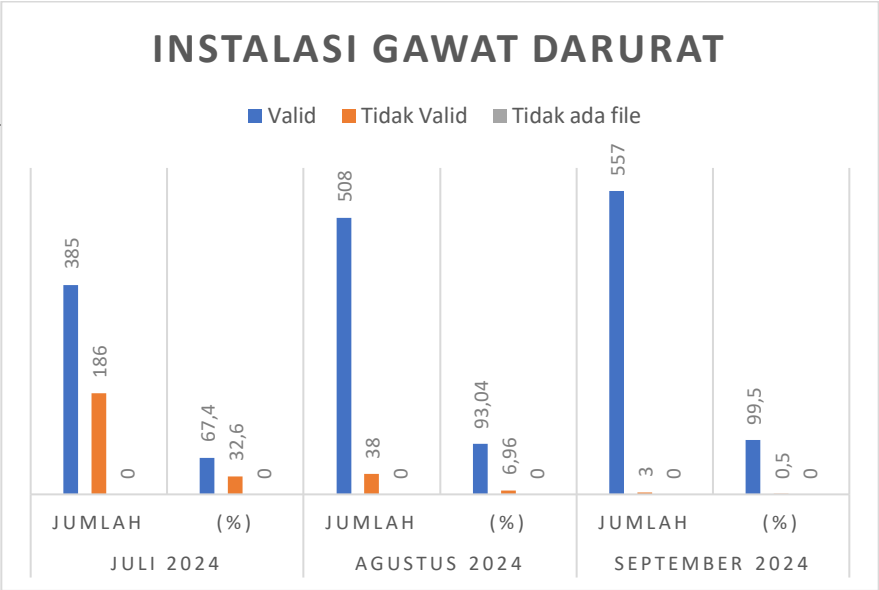
11	Daseno	L/57	dr. Heri, Sp. Pd	219685	Febris H-14	12/09/2024	15/09/2024	4	Levofloxacin po	1	1x0,75	2,25	0,5	4,5
12	Supriadi	L/71	dr. Andy, Sp. P	219809	COPD AE	15/09/2024	19/09/2024	5	Azithromycin	1	1x0,5	2,5	0,3	8,3
13	M Agus Salim	L/53	dr. Heri, Sp. Pd	219813	Sepsis	16/09/2024	21/09/2024	6	Ceftriaxone	3	2x1	7	2	3,5
									Metronidazole inf		3x0,5	8,5	1,5	5,6
									Levofloxacin inf		1x0,75	2,25	0,5	4,5
14	Suning	P/53	dr. Zora, Sp.Pd	125963	DM Hiperglikemi	16/09/2024	23/09/2024	8	Ceftraixone	2	2x2	24	2	12
									Metronidazole inf		3x0,5	1,5	1,5	1
15	M. Hadyan	L/16	dr. Edi, Sp. U	217145	Scrotal varices	17/09/2024	19/09/2024	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
16	Siti Nurrohmah	P/54	dr. Ardhi, Sp.Pd	160161	DM Type 2	23/09/2024	27/09/2024	5	Ceftraixone	2	2x1	8	2	4
									Metronidazole inf		3x0,5	1,5	1,5	1
17	Badariyah	P/54	dr. Yunita, Sp.P	220134	Obs Dyspneu + Pneumoni CAP	23/09/2024	28/08/2024	6	Levofloxacin inf	3	1x0,75	2,25	0,5	4,5
									Levofloxacin po		1x0,75	1,5	0,5	3
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
18	Dina Asma'ul	P/26	dr. Zora, Sp.Pd	220223	TF	24/09/2024	26/09/2024	3	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1	0,5	2
19	Yuni Anisa C	P/22	dr. Humairi, Sp. OG	220187	Prematur Rupture	24/09/2024	26/09/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
20	Teddi Hendrawan	L/49	dr. Oka, Sp.OT	220254	Dislocation of Wrist	25/09/2024	27/09/2024	3	Cefoperazone sodium	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

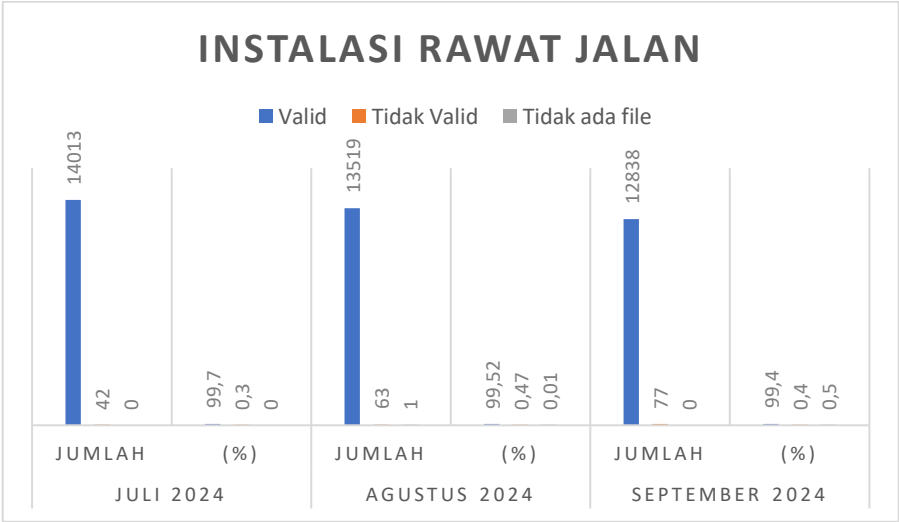
3.6.6.1 Tabel Validasi Data E-RM Bulan Juli-September 2024

NO	UNIT	KUALIFIKASI	BULAN					
			JULI 2024		AGUSTUS 2024		SEPTEMBER 2024	
			JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)
1.	IGD	Valid	385	67,4	508	93,04	557	99,5
		Tidak Valid	186	32,6	38	6,96	3	0,5
		Tidak ada file	0	0	0	0	0	0
Total			571		546		560	
2.	IRJA/POLI	Valid	14013	99,7	13519	99,52	12838	99,4
		Tidak Valid	42	0,3	63	0,47	74	0,4
		Tidak ada file	0	0	1	0,01	0	0,5
Total			14055		13583		12912	

3.6.6.2 Validasi data E-RM di IGD Bulan Juli-September 2024



3.6.6.3 Validasi data E-RM di IRJA/Poli Bulan Juli-September 2024



Analisis :

1. Tidak terjadi kenaikan yang signifikan pada data valid di IGD sebanyak 560 Data E-RM dari 557 Data E-RM atau sebesar 99.5%, hal ini disebabkan adanya perubahan alur penyeteroran data kunjungan pasien per hari ke Instalasi Rekam Medis oleh Karu IGD, sehingga memperbaiki angka capaian validasi data, meskipun belum mencapai 100%.

- Masih ditemukan 0.5% Data E-RM tidak valid di IGD, hal ini disebabkan masih ditemui form yang belum sinkron antara form IGD dan rekam medis, setelah ditelusur sudah pengkajian awal IGD sudah diisi lengkap tetapi tidak terbaca, system bermasalah.
- Pada Bulan September 2024 tidak ditemukan tarikan data yang tidak ada file, yaitu 0%.

Masalah :

- Pengkajian awal medis gigi tidak bisa terbuka oleh rekam medis, sedangkan fitur tersebut muncul di SIMRS perawat.
- Permasalahan di IGD tidak bisa diperbaiki langsung karena tidak bisa batal kunjungan, pembatalan harus melalui PT.
- Berikut link permasalahan yang ditemui
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcmJm9ucywizoiEdYqeEaCRxvhVWeLLC7eKe8NQ_D_k/edit#gid=1732600455

Rencana Tindak Lanjut :

Ketidaklengkapan ERM sudah membaik dari pada bulan sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan alur terkait penyetoran berkas pasien per hari, yaitu :

- Alur sebelumnya perawat menyetor berkas casemix ke kasir jaminan, mulai awal Bulan Juni 2024 perawat menyetor berkas ke rekam medis untuk dilakukan cek kelengkapan ERM oleh tim rekam medis.
- Petugas rekam medis menandatangani lembar casemix sebagaibukti bahwa sudah dilakukan pengecekan dan dinyatakan lengkap dan valid.
- Setelah selesai dilakuan validasi oleh petugas rekam medis, perawat meyetorkan berkas ke kasir jaminan.

3.7 Permasalahan Rumah Sakit

3.7.1 Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Big kass masih sering kehabisan	P	Mengusulkan menambah stok big kass
		D	Menginformasikan ke bagian cssd untuk menambah stok big kass
		S	Dalam operasi malam masih sering kehabisan big kass
		A	Kolaborasi dengan cssd jika kehabisan stok kasa
B. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
2	Lampu IKO masih belum di ganti	P	Mengganti lampu IKO
		D	Follow up Pengadaan barang yang belum datang
		S	Barang dari vendor masih belum datang
		A	Follow up berkala

3.7.2 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Masih ada masalah di ERM yang tidak sesuai dengan rekam medis	P	Melakukan telusur penyebab ketidaksesamaan antara ERM IGD dan ERM yang muncul di unit RM
		D	Koordinasi dengan programmer
		S	ERM dari IGD sudah diisi dengan lengkap namun tidak muncul di RM artinya terdapat kesalahan sistem

		A	Meminta programmer untuk memperbaiki system
2	Petugas IGD masih kesulitan menaikan pasien di karenakan petugas irna masih banyak alasan,seperti makan,istirahat	P	Melakukan telusur lantai mana yang seperti di katakan IGD
		D	Koordinasi dengan kbid keperawatan oknum oknum petugas perawat irna yang sulit menerima pasien OB
		S	Banyak kasus irna yang masih alasan istirahat makan dan istirahat
		A	Mencatat oknum yang sulit menerima pasien baru di IGD dan melakukan teguran lisan
B. Permasalahan Dari Kbid/ Komite Terhadap Unit			
1	Dokter IGD kurang lengkap dalam pengisian ERM yang ada di IGD	S	ERM dari IGD sudah diisi dengan lengkap namun tidak muncul di RM artinya terdapat kesalahan sistem
		A	Meminta programmer untuk memperbaiki system
		S	Beberapa rekam medis yang tidak lengkap di data dan di laporkan ke dr IGD secara langsung
		A	Melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap dr IGD untuk pengisian rekam medis

3.7.3 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Dokter anastesi sudah tidak sesuai dengan paket SC dalam pemberian obat	P	Koordinasi dengan kbid pelayanan untuk kolaborasi dengan dr anastesi
		D	Bertemu dengan dr anastesi membahas pakets SC
		S	Terdapat banyak kasus advice dr anastesi beda dengan paket sc
		A	Mengadakan rapat dan harus ada kesepakatan untuk obat paket sc
2	Banyaknya marketing obat/alat ke ruangan irna	P	Telusur terlebih dahulu marketing ke irna
		D	Koordinasi dengan kbid umum untuk penjagaan satpam yang ada di bawah sehingga tidak ada marketing obat yang ke irna
		S	Ada beberapa kasus marketing ke irna anak,icu dan neo
		A	Koordinasi dengan pengadaan PT untuk melarang marketing masuk ke ruangan rawat inap
3	Petugas IGD saat memindahkan ke ruangan ICU masih sering lupa membawah foto thorak basahannya	P	Rapat antara kepala IGD dan ICU serta kbid dalam kesepakatan
		D	Membuat kesepakatan antara ruangan ICU dan IGD memindahkan dengan foto thorak basanya
		S	Dalam 1 bulan ini ada 2 kasus memindahkkan pasien ke ICU tidak membawah foto thorak
		A	Menjalankan sesuai dengan kesepakatan anantara kepala ruangan dan di sosialisasikan kepada perawat pelaksana

3.7.4 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Masih sering kekosongan obat di depo farmasi	P	Lapor kabid penunjang untuk solusi di farmasi
		D	Menambah stok obat di depo farmasi
		S	Beberapa kasus dpjp yang komplain saat depo farmasi kekosongan obat
		A	Komunikasi dengan kains farmasi jika ada kekosongan obat dpjp di beritakan
2	Dokter mata komplain terkait obat akilen yang membuat dr mata terkena proporsi	P	Berkoordinasi dengan kains dan pengadaan PT terkait obat tersebut
		D	Memfollowup bagian kains farmasi untuk pergantian zylaven
		S	Adanya kasus dr mata yang terkena proporsi terkait harga obat akilen
		A	Berkoordinasi dengan pengadaan untuk order zylaven jika obat akilen habis

3.7.5 Permasalahan Instalasi Farmasi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) yang masih manual dan membuat waktu obat jadi lama. Prosentase waktu tunggu obat non racikan 76.95% dan waktu tunggu obat racikan 59.54%	P	Menggunakan KPO digital dalam pelayanan resep.
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk membuat fitur KPO digital di SIMRS yang bisa diakses oleh DPJP dan Apoteker.
		S	Penulisan KPO masih manual sehingga memakan waktu dan penulisan yang tidak baku dan tidak terbaca. Komplain pasien akibat pasien tidak membawa KPO.
		A	2. Follow up ke Programmer. 3. Mendata KPO tertinggal sebagai bukti kuat bahwa KPO manual resiko hilang.
2.	Penulisan kartu stok tidak lengkap, baik di Depo Farmasi maupun di Depo IKO.	P	Memperbaiki supervise petugas farmasi.
		D	Menentukan PJ supervise setiap unit, yaitu Asharul Fahrizi (PJ Rawat Inap), Diryati Barin (PJ Rawat Jalan), Fadilah Maulana (PJ Depo IKO).
		S	1. Supervisi petugas farmasi dalam melakukan pelayanan (barang masuk dan keluar) dengan tetap menuliskan pada kartu stok. 2. Petugas lebih teliti ketika menghitung pemasukan atau pengeluaran.
		A	Semua staff farmasi sudah mendapatkan teguran lisan dan membuat surat pernyataan komitmen penulisan kartu stok.
3.	Pending Resep meningkat dikarenakan ada hutang obat yang diakibatkan dari kekosongan obat.	P	Mengajukan substitusi obat.
		D	Melakukan koordinasi dengan DPJP dan Pengadaan terkait substitusi obat dan pelayanan resep.
		S	DPJP meminta obat tetap diberikan sehingga resep yang sudah masuk

			tetap dilayani, dan obat yang belum ready menjadi hutang farmasi sampai barang datang.
		A	1. Kolaborasi dengan Pengadaan PT untuk mencari ke seluruh distributor. 2. Membuatkan SE kekosongan obat dan dishare kepada seluruh DPJP. 3. Mengajukan pengadaan sediaan obat paten yang memiliki kandungan sama dengan obat yang kosong dan tidak ada substitusi, seperti spinorolactone.
4.	Retur penjualan obat yang tidak diambil pasien, di retur ke Gudang farmasi di fitur penerimaan hibah lainnya namun resep kronis tidak di hapus di apotek online, dan tidak dihapus di Penjualan Farmasi	P	Memperbaiki alur retur penjualan obat yang tidak diambil pasien.
		D	Koordinasi dengan Kabid, Keuangan, Verifikator dan Managemen PT DPM kesepakatan alur retur penjualan obat yang tidak diambil pasien.
		S	1. Selama ini di input penerimaan farmasi lain namun hanya menambah stok Gudang retur tapi tidak menghapus data penjualan. Sehingga ketika retur diganti obat selesai maka data tidak akan muncul di tim verif (Berkas obat kronis). 2. Tidak ada laporan tarikan data pasien khusus BPJS kesehatan karena berkaitan dengan data pasien yang akan di hapus datanya di apotek online. 3. Obat belum direturn ke apotek online beserta racikannya. Hasil keputusan PT racikan di anggap kerugian maka racikan tetap di retur tapi dihapus dari penjualan.
		A	Hasil kesepakatan antara Manajemen RS, Keuangan, Verifikator dan Managemen PT DPM, sbb : 1. Pengambilan obat maksimal 3x24 jam. 2. Jika obat tidak diambil dalam batas waktu yang dilakukan maka dilakukan retur dalam waktu seminggu. 3. Petugas melakukan reture penjualan dan menghapus resep di Apotek Online.
5.	Waktu tunggu pelayanan farmasi rawat jalan lama sehingga banyak complain pasien.	P	Mengurangi waktu tunggu di Farmasi. Mendisiplinkan DPJP dalam penginputan e-resep per pasien (tidak dilakukan rapel).
		D	Koordinasi dengan Kabid Pelayanan untuk mengedukasi DPJP.
		S	Jumlah pasien rawat jalan per kunjungan tidak ada batasan sehingga terjadi penumpukan pasein di Poli sampai menunggu di Farmasi.

		A	1. Pasien ditawarkan PRIMANTARA agar tidak menunggu obat lama. 2. Resep obat diinput per pasien oleh DPJP.
6.	Terjadi kekosongan obat amitriptilin, haloperidol 5 mg, spironolakton 100 mg, Asam Salicylad, ,Myllacid Susp 60ml.	P	Melakukan pengadaan menggunakan e-katalog.
		D	Pengajuan akun e-purchasing dan koordinasi dengan pengadaan terkait e-purchasing.
		S	1. Kekosongan obat terjadi karena kosong distributor dan pabrik. 2. RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis. 3. Koordinasi dengan DPJP terkait substitusi obat.
		A	Menunggu approve dari Kemenkes.
7.	Ruangan LAF tidak sesuai standar.	P	Mengajukan ruang LAF sesuai dengan pedoman dasar dispensing sediaan steril.
		D	Melakukan list pengajuan perpindahan ruangan dan ditujukan ke PT.
		S	Pedoman dasar dispensing sediaan steril.
		A	Dalam proses mengajukan perpindahan ruangan.
8.	Packaging repack tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak sesuai dengan master.	P	Mengajukan wadah sesuai dengan kebutuhan dan master barang di SIMRS.
		D	Pengajuan kebutuhan ke Pengadaan PT.
		S	Kebutuhan asam asetat per pasien hanya 20ml (sesuai SIMRS), sedangkan sediaan wadah 100ml, sehingga DPJP meresepkan asam asetat 5x supaya sesuai dengan barang yang keluar. Resiko proporsi.
		A	Menemui DPJP dan follow up kesediaan barang permintaan ke Pengadaan PT.
9.	Sediaan vaksin yang tidak segera digunakan oleh pasien sejak tahun 2023, barang ada di Kulkas Depo Farmasi.	P	Memperbaiki pencatatan keluar masuknya inden vaksin. Meperbaiki kebijakan inden vaksin dari Poli Spesialis.
		D	Kolaborasi dengan Kains Farmasi, Gudang Farmasi, MOD, Kasir dan Karu IRJA.
		S	Pemesanan vaksin hexaxim an An Yahya Hermawan sejak Juli 2023 belum digunakan, inden vaksin menggunakan jaminan Asuransi.
		A	10. Membuat spreadsheet pemesanan vaksin dengan keterangan jadwal vaksin dan ED vaksin untuk memudahkan MOD menginformasikan kepada pasien. 11. Membuat kebijakan pembayaran penuh untuk inden vaksin meskipun jaminan asuransi, uang akan

			direture jika pasien datang untuk pelaksanaan vaksin. 12. Menghubungi pasien-pasien yang tidak datang sesuai jadwal untuk kepastian jadwal pelaksanaan, jika tidak ada DP maka dialihkan kebutuhannya untuk pasien lain.
--	--	--	--

3.7.6 Permasalahan Laboratorium

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	LIS belum berjalan karena menunggu bridging SIMRS	P	Membuat target pelaksanaan LIS di Labortaorium RSPH Malang.
		D	Mengingatkan programmer untuk segera menyelesaikan bridging.
		S	LIS belum bisa diaplikasikam dikarenakan belum bridging dengan SIMRS.
		A	Follow up berkala ke Programmer.
2.	Pengadaan BDRS belum berjalan.	P	Membuat target pelaksanaan BDRS di Labortaorium RSPH Malang.
		D	Follow up ke Pengadaan PT.
		S	BDRS belum berjalan dikarenakan masih menunggu penawaran vendor.
		A	Follow up berkala ke Pengadaan PT.
3.	Hasil bacaan trombosit tidak stabil.	P	Kolaborasi dengan IPSRS dan Vendor untuk mencari akar permasalahan.
		D	Konsultasi dengan Kains yaitu dr Ari, Sp.PK mengenai hasil dan melakukan arahan yang diberikan.
		S	Setelah dilakukan cek oleh IPSRS, tidak ditemukan grounding yang tertanam.
		A	1. Menghubungi Vendor, alat tidak bermasalah. 2. Koordinasi dengan IPSRS untuk pengajuan grounding.
4.	Reagen kadaluarsa dan datang terlambat.	P	Memperbaiki pengadaan reagen di Laboratorium.
		D	Melakukan analisa keterlambatan. Koordinasi dengan Kabid Pelayanan..
		S	Terdapat reagen yang kosong nasional seperti CKMB, DPJP memutuskan untuk menggunakan pemeriksaan Troponin.
		A	1. Melakukan perbaikan penataan FIFO FEFO pada kulkas Laboratorium. 2. Menjalankan kartu stok. 3. Menentukan stok minimal untuk order reagen.

3.7.7 Permasalahan Rekam Medis

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Ketidaksesuaian antara fitur e-rm poli dengan rekam medis.	P	Memperbaiki fiture e-rm poli dan rekam medis.
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk meminimalisir data yang tidak valid akibat ketidaksesuaian fitur.
		S	Mencatat temuan permasalahan e-rm dan dilaporkan kepada Programmer.
		A	Melakukan koordinasi dengan Programmer setiap ditemuka masalah e-rm.

3.7.8 Permasalahan CSSD

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Kebutuhan mesin steam plasma belum terpenuhi.	P	Mengajukan kebutuhan mesin ke PT.
		D	Koordinasi dengan Vendor dan DPJP terkait kebutuhan mesin steam plasma.
		S	Instrument bedah saraf memerlukan perlakuan khusus terkait cara dekontaminasi dan sterilisasinya.
		A	1. Membuat telaah terkait mesin yang saat ini digunakan dan yang dianjurkan. 2. Koordinasi dengan DPJP (dr Fachri, Sp.BS) bahwa sterilisasi alat bedah saraf menggunakan autoclave dengan cara alat dikemas satu persatu.

3.7.9 Permasalahan Laundry

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Hasil pencucian membuat kain terkena bercak putih.	P	Memperbaiki alur pencucian.
		D	Menerapkan alur baru.
		S	Monitoring dan evaluasi alur baru, mencari penyebab kerusakan.
		A	1. Melakukan pemilahan baju dan linen dari unit menggunakan handscoon baru (tidak terkena zak kimia). 2. Melakukan pemisahan pencucian antara linen dan baju IKO.
2.	Pencatatan jumlah linen tidak valid	P	Memperbaiki pencatatan menggunakan digital.
		D	Pencatatan jumlah linen menggunakan google spreadsheet.
		S	Pencatatan manual beresiko angka tidak terbaca dengan baik sehingga jumlah linen tidak valid.
		A	Pencatatan digital akan dimulai di Bulan September 2024. Rencana dilakukan stok opname setiap bulan.

3.8 Profil SDM

3.8.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	0	1	0
2	Kabid Pelayanan Medis	Dokter Umum	1	1	0	1	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
7	Dokter Ruangan	Dokter Umum	1	1	0	1	0
8	Farmasi	S1 Apoteker	43	14	0	14	0
		S1 Farmasi		4	0	4	0
		S1 Analis Farmasi		1	0	1	0
		D3 Farmasi		16	4	12	0
		SMK		7	0	7	0
		S1 Akuntansi		1	0	1	0

9	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	11	1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	0	8	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		1	1	0	0
10	CSSD	D3 Keperawatan	5	2	1	1	0
		D3 Farmasi		1	0	1	0
		SMK		2	1	1	0
11	Fisioterapi	D3 Fisioterapi	5	4	1	2	1
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	1
12	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	0	2	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	0	2	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		2	2	0	0
13	Humas & Marketing	Profesi Ners	2	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	0	1	0
14	ICU dan HCU	Profesi Ners	11	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		7	0	7	0
15	IGD	Profesi Ners	26	11	1	10	0
		D3 Keperawatan		10	0	10	0
		D4 Kebidanan		3	0	3	0
		D3 Kebidanan		2	0	2	0
16	IKO	Profesi Ners	12	7	2	5	0
		D3 Keperawatan		4	1	3	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
17	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
18	IPSRs	S1 Tenik Elektro	6	1	0	1	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	0	1	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	0	3	0
19	IRJA	Profesi Ners	27	6	3	3	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		16	6	10	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
20	IRNA 2C	Profesi Ners	7	4	1	3	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		2	0	2	0
21	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	20	16	1	15	0
		D3 Keperawatan		4	0	4	0
22	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	16	6	0	6	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		8	0	8	0
		D3 Kebidanan		1	0	1	0
23	IRNA 5C Anak	Profesi Ners	9	2	0	2	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0

		D3 Keperawatan		6	0	6	0
24	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	24	8	0	8	0
		D4 Keperawatan		4	0	4	0
		D3 Keperawatan		12	0	12	0
25	Maternitas	Profesi Kebidanan	12	2	0	2	0
		D4 Kebidanan		2	0	2	0
		D3 Kebidanan		8	0	8	0
26	Neonatologi	Profesi Ners	8	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	1	4	0
		D3 Kebidanan		1	0	1	0
27	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	3	3	0	0
		S1 Akuntansi		2	1	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		3	3	0	0
		SMA		1	0	1	0
28	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	10	2	0	2	0
		D3 Analisis Kesehatan		8	0	8	0
29	Laundry	SMK	5	1	0	1	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		1	0	1	0
30	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	10	10	4	6	0
31	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	18	1	1	0	0
		S1 Ilmu Sosial		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	0	1	0
		D4 Destinasi Wisata		1	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	2	4	0
		SMK		5	0	5	0
		SMA		1	1	0	0
32	PIPP & MPP	Profesi Ners	6	2	1	1	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		2	1	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
33	PMKP	Profesi Ners	1	1	0	1	0
34	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	0	7	0
35	SDM	S1 Psikologi	2	2	0	2	0
36	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	0	1	0
37	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	0	3	0
38	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
39	Cleaning Service	SMK	45	25	5	20	0
		SMA		15	0	15	0
40	Security	SMK	12	7	4	3	0
		SMA		5	2	3	0
41	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	0	1	0

		SMA		2	0	2	0
		SMP		2	0	2	0
42	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
43	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
44	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
45	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
46	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
47	Dokter Spesialis Bedah Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
66	Dokter Umum	Pendidikan Profesi Dokter	8	8	1	7	0
Total			470				

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarananya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikarenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalam pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan September 2024 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada bulan September 2024, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 09 Oktober 2024
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN

NO	INSTANSI	NAMA PKS	NOMOR RS	NOMOR INSTANSI	MASA BERLAKU	KETERANGAN
1	PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017	12 Desember 2017	Berlaku
2	PT. Global Asistensi Manajemen Indonesia (GAMI)	Perjanjian Layanan Kesehatan Rawat Jalan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019	26 Agustus 2019	Berlaku
3	PT. Fullerton Health Indonesia	Perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan		640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019	26 Agustus 2019	Berlaku
4	PT Prudential Life Insurance	Surat Kesepakatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan		3143/PMN-PA/IV/2020	13 April 2020	Berlaku
5	PT AIA Financial	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	069/DPM/E-PKS/DIR/X/2020	639/AIA-DPM/XI/2020	4 November 2020	Berlaku
6	PT. Medlinx Asia Teknologi (Medlinx)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	150/ PKS-RSPRIMAHUSADA-MAT/DIR/XI/2016		28 November 2016	Berlaku
7	PT. Asuransi AA Internasional	Pelayanan Kesehatan	-	AAII/RS/E-384/PKS/Feb/2015	19 September 2019	Berlaku
8	PT. Suprima Mitra Adihusada	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan		640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019	26 agustus 2019	Berlaku
9	PT. Equity Life IND-Corporate	Perjanjian Pelayanan Kesehatan		091/ELI/LGL/X/19	14 Oktober 2019	Berlaku
10	PT. Axa Services Indonesia	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan	-	067/AGR-Leg/ASI/VII/2013	15 Agustus 2013	Berlaku
11	PT. Asuransi Jiwa	Perjanjian	-	063/PKS - AJSMSIG-Rs / IX/ 2012	9 Oktober 2012	Berlaku

	Sinarmas Msig	Kerjasama Pelayanan Kesehatan				
12	PT. Asuransi Jiwa Sinarmas	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	010/DPM/E-PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019	9 April 2019	Berlaku
13	PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan	-	0088/HLI-GH/ PKS-RS/03-2015	16 Maret 2015	Berlaku
14	PT. Equity Life IND-Cassles	Perjanjian Pelayanan Kesehatan		090/ELI/LGL/X/19	14 Oktober 2019	Berlaku
15	PT. Asuransi Adira Dinamika	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	PH/E-IKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013	24 Oktober 2013	Berlaku
16	PT. Prima Sarana Jasa	Pelayanan Kesehatan	735/E-PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018	17 September 2018	Berlaku
17	PT. BNI Life Insurance	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	082/RSPH/E-IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716	24 Juli 2019	Berlaku
18	Administrasi Medika (Admedika)	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	025/RSPH/E-PKS/DIR/IV/2015	141/PKS/ADMEDIKA/IV/2015	28 April 2018	Berlaku
19	Asuransi Jiwa Generali	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	070/DPM/E-PKS/DIR/IX/2019	109/GI/OPS/Prov-SK/IX/2019	10 Oktober 2019	Berlaku
20	PT. Aplikanusa Lintasarta (Owlexa Healthcare)	Nota Kesepakatan Layanan Pemeriksaan Kesehatan	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MoU/00300/2015	25 Februari 2015	Berlaku
21	PT. Asuransi Takaful Keluarga	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	508/RSPH/E-IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/II/2017	02 Januari 2017	Berlaku
22	PT. Asuransi Jiwa	Perjanjian	017/DPM/E-PKS/DIR/XI/2019	045-02/EB-CONT/2020	2 Maret 2020	Berlaku

	Manulife Indonesia	Pelayanan Kesehatan Peserta Individu				
23	PT. AJ Central Asia Raya (CAR)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	795/E-ADD/DIR/XI/2019	DIR/PKS-ADD/RS/154/XI/2019	29 November 2019	Berlaku
24	PT. Java Smartindo	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C	21 Agustus 2020	Berlaku
25	PT PLN Insurance	Asuransi Pelayanan Kesehatan	612/RSPHS/E-PKS/DIR/X/2019	300/PKS/TKI/X/2019	30 Oktober 2019	Berlaku
26	PT. Asuransi Jasa Indonesia	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	PKS.031/GHASKES/157-1/2020	053/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2020	28 Agustus 2020	Berlaku
27	PT. Asuransi Reliance Indonesia	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	490/RSPH/I-IKS/DIR/XI/2016	930.01/UM/ARI-RS/XI2016	7 September 2020	Berlaku
28	PT. Pan Pacific Insurance	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan	017/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS-PHMS/VIII/2020	31 Agustus 2020	Berlaku
29	PT. Jasindo Health Care	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan	-	-	4 Januari 2014	Berlaku
30	PT. International Services Pacific Cross	Asuransi Pelayanan Kesehatan	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022	10 maret 2022	Berlaku
31	PT. Asuransi Jiwa BCA	Asuransi Pemberian Pelayanan Kesehatan	149/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	286/PKS/BCAL-PHMS/2023	10 Oktober 2023	Berlaku
32	Klinik Husada Asih YPAC	Kerja sama Penunjang			11 September 2012	Berlaku
33	PT HM Sampoerna Tbk	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	-	55/Perj/HMS/IX/2014	1 Juni 2014	Berlaku
34	PT Adonai Manajemen Kesehatan	Perjanjian Kerja Sama		055/PKS-PF/AMK/VIII/2019	26 Agustus 2019	Berlaku

		Pemeriksaan Medicak Chek Up				
35	PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory	Pelayanan Kesehatan			1 April 2013	Berlaku
36	PT. Ajinomoto Sales Indonesia	Pelayanan Pengobatan dan Perawatan Kesehatan	008/PERS/RSPH-I/2012	LEG/ASI/120510-85	5 Januari 2012	Berlaku
37	PT. Coca Cola Distribution Indonesia	PELAYANAN KESEHATAN	573/I-PKS/PMS/IV/2019	004/Perjanjian/HRSEJ/IX/2019	9 Januari 2019	Berlaku
38	PT. Indolakto Pandaan	Jasa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja (PPK)			1 Oktober 2014	Berlaku
39	PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory	Perjanjian Pelayanan Kesehatan			20 Maret 2015	Berlaku
40	Harris Hotel & Convensions Malang	Rujuka Pelayanan Kesehatan	308/E-PKS/PMS/V/2018	001/IKS/HR/V/2018	14 Oktober 2019	Berlaku
41	PT. Duha Mulya Abadi	Penyediaan paket BHP Operasi Katarac			11 Januari 2019	Berlaku
42	RS Sahabat Pasuruan	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	1097.1/E.PKS/DIR/VIII/2021		2 Desember 2016	Berlaku
43	PT. Asuransi Dayin Mitra TBK		003/MKT/HLT/PKS/II/2015	PH/IKS/269/XII/2014	1 Mei 2015	Berlaku
44	PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang)	Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022	4 Juli 2022	Berlaku
45	PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang) (ADENDUM)	Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan			7 Februari 2023	Berlaku

		Penumpang Angkitan Umum dan Lalu Lintas Jalan				
46	Klinik Pratama Rawat Jalan Mawar Waskitha Husada	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024		23 Januari 2024	Berlaku
47	Klinik Losari Medika	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024		6 Februari 2024	Berlaku
48	PT. Samator	Operasional Pasokan Produk		DISTRIBUTIONAGREEMENT_LGL_1850	1 September 2022	Berlaku
49	RS Persada	Pelayanan Kesehatan, Rujukan, Laboratorium dan Radiolog	152.42/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.Hs/MOU/X/PH.2022	10 Oktober 2022	Berlaku
50	PT. Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	103.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	358/KBM-DPM/PKS/VI/2023	26 Juni 2023	Berlaku
51	ASABRI	PELAYANAN PENGOBATAN DAN PERAWATAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PESERTA ASABRI AKTIF	1902/E-PKS/DIR/XII/2023	PERJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023	13 Desember 2023	Berlaku
52	Klinik Rawat Inap Muslimat Singosari	Rujukan Asuhan Pasien	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023	15 April 2023	Berlaku
53	Klinik Tirto Husada	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023	18 September 2023	Berlaku
54	Klinik BLKI Singosari	Rujukan Asuhan Pasien	108.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	150/0187B00/IV/23	24 April 2023	Berlaku
55	Klinik Brawijaya Lawang	Rujukan Asuhan Pasien	144.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PKS/115/VII/2023	3 Juli 2023	Proses di Pihak Kedua

56	Klinik Jantung Hasna Medika Malang	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR/HMMALANG/XII/2023	1 Desember 2023	Berlaku
57	Klinik Rawat Inap Wijaya Husada	Rujukan Asuhan Pasien	001/PKS/15/4/2023	113.2/DPM/E-PKS/DIR/V/2023	15 April 2023	Berlaku
58	Klinik Endisa Husada	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	148.3/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH	21 Juli 2023	Berlaku
59	Klinik Siaga Medika	Rujukan Pelayanan Kesehatan	188/DPM/E-PKS/DIR/X/2023	14.30/KSM/VII/2023	3 Oktober 2023	Berlaku
60	Klinik Garuda	Pelayanan Kesehatan	131.2/DPM/E-PKS/DIR/V/2023	B/25/VI/2023	31 Mei 2023	Berlaku
61	Laboratorium Panglima Sudirman	Pelayanan Rujukan Laboratorium	135.2/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	Q.0150/LKPS.VI/25.2023	5 Juni 2023	Berlaku
62	PT. Sumber Alfaria	Pelayanan Kesehatan	142.1/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	0002/SDM-MLG/VI/2023	22 Juni 2023	Berlaku
63	Solaris Hotel	Rujukan Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/XI/2023	108/HRD/SHM/X/2023	1 November 2023	Berlaku
64	PT. Arthawena Sakti Gemilang	Pelayanan Rujukan kesehatan	138.3/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	-	15 Juni 2023	Berlaku
65	Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	Kerjasama dalam proses akreditasi rumah sakit			22 April 2022	Berlaku
66	CV. Aumireta Anggun	Rujukan Pelayanan Kesehatan	164.1/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	-	28 Agustus 2023	Berlaku
67	RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan	220.1/DPM/E-PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023	30 Oktober 2023	Berlaku
68	RS Islam Unisma Malang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah	222.11/DPM/E- PKS/DIR/XI/2023	MENUNGGU SEKRETARIAT	1 Januari 2024	Berlaku
69	RS Puri Bunda	Rujukan	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/I/2024	6 Februari 2024	Berlaku

		Pelayanan Kesehatan dan Penunjang				
70	RSUD Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	245.1/E-PKS/DIR/II/2024	074.3/35.07.302.102/2024	1 Maret 2024	Berlaku
71	Avrist Assurance	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	951/PKS/PROV/IPOP/AVR-1494/VII/2023		24 Agustus 2023	Berlaku
72	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Pelayanan Kesehatan & pelayanan obat	028.2/DPM/E-PKS/DIR/II/2023	0.32/AJII/KOP-SBY/PKS/0123	30 Januari 2023	Berlaku
73	BPM Inung Indah sari	Rujukan Asuhan Pasien	004.1/DPM/E-PKS/DIR/I/2022	-	10 Januari 2022	Berlaku
74	Klinik Dokter 24 Jam	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang			2 Agustus 2022	Berlaku
75	Klinik Mutiara Sehat	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	200.11/DPM/I-PKS/DIR/I/2022		5 Januari 2022	Berlaku
76	Klinik 24 Jam	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	112.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2022	138/MOU/VIII/CSH.2022	2 Agustus 2022	Berlaku
77	PT. Jaya Obayashi	Rujukan Pelayanan Kesehatan	360/DPM/I-PKS/VIII/2020		1 Juli 2020	Berlaku
78	PT. Malang Intermedia Pers	Pelayanan Kesehatan	025/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020	1 Juli 2020	Berlaku
79	PT. Pancamas Elite	Rujukan Pelayanan Kesehatan	032/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020		1 Juli 2020	Berlaku
80	PT. Yamaha Musical Product Indonesia	PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP BAGI KARYAWAN DAN KELUARGA	004/DPM/E-PKS/III/2020	452/YMPI/II/PKS/III/2020	1 Juni 2022	Berlaku
81	PT. Tirta Investama	PELAYANAN			31 Agustus 2020	Berlaku

		KESEHATAN KARYAWAN & KELUARGA				
82	PT. TASPEN	Perawatan Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E-PKS/DIR/2023	JAN-01/DIR/2023	1 Januari 2023	Berlaku
83	PT. Kemas Super Indonesia (KSI)	Pelayanan Kesehatan				Berlaku
84	PT. Nayaka Era Husada	Pelayanan Kesehatan	143.1/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	PKS/106/072023	30 Mei 2023	Berlaku
85	PMI Kabupaten Malang	Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi lainnya	768/E-PKS/DIR/V/2023	#REF!	1 Juni 2023	Berlaku
86	PMI Kota Malang	Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi lainnya	1790/E-PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023	20 November 2023	Berlaku
87	RS Lavalette	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	155.2/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	RSL-KONTR-PKS/VII/23.124	10 Agustus 2023	Berlaku
88	RS Prima Husada Sukorejo	Rujukan Asuhan Pasien	213/E-PKS/DIR/III/2019	126/RSPHS/E-PKS/III 2019	21 Februari 2022	Berlaku
89	RS Panti Nirmala	Kerjasama Pelayanan Rujukan	152.44/DPM/E-PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022	7 Oktober 2022	Berlaku
90	PT Kimberly Clark	Pasokan produk		106/KCS-PNS/MOU/II/2023	1 Januari 2024	BERLAKU
91	PT. Lippo General Insurance	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	267/RSPHS/E-PKS/DOR/VI/2019	1502/LI-HOSPT/VI/2019	18 September 2019	Berlaku
92	PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk (Asuransi MAG)	Fasilitas Rawat Inap dan Rawat Jalan	015/DPM/E-PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2	28 Januari 2020	Perpanjang Otomatis
93	BPJS KESEHATAN	Pelayanan Penjamin Rujukan Tingkat Lanjutan	1879/E-PKS/DIR/XII/2023	602/KTR/VII-05/1223	1 Januari 2024	Berlaku

		Bagi Peserta Program JKN				
94	BPJS KETENAGAKERJAAN	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan	1571/E-PKS/DIR/XII/2022	PER/60/102022	1 Januari 2023	Berlaku
95	BPM Silvian Wulandari	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	031/DPM/E-PKS/DIR/III/2022		10 Maret 2021	Progres Pihak Kedua
96	Klinik Idamamuk	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	347/DPM/I-PKS/DIR/VII/2021	005/VI/2021	16 Juni 2021	Progres Pihak Kedua
97	PT. Etercon Pharma	Sponsorship Maternity Kit Free untuk pasien Maternitas	132.1/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	039/ETC-CBX/PKS/VII/2023	1 Juni 2023	Proses Pihak Kedua
98	PT. Kasoem Hearing	Pelayanan Pemasangan Alat Bantu Mendengar (ABM)	339.6/E-PKS/DIR/III/2022	002/KHC/KSO-SMAD/III/2022	1 Maret 2022	Proses Review Kabid
99	PT. Kencana Tiara Gemilang (KTG)	Pelayanan Kesehatan	174.1/DPM/E- PKS/DIR/XII/2021	017/KTG/HRGA.06/XII/2021	12 Desember 2021	Berlaku
100	PT. Rentokil	Pengendalian Hama dengan Program General Pest (GP)- Non Station	173.1/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	003/PT.RI/MLG-37/52400326/IX/2023	11 September 2023	Berlaku
101	PT. Pillar Utama Cortindo	Vendor Pelayanan Pemeliharaan Peralatan Elevator	-	KS/PUCCSBY-1216/VII/2023	1 Juni 2023	Progres di PT
102	PT. Global Trans Jaya Mulia & PT Global Enviro Nusa	Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	115/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	044/SPK-T/DPM-GTJM/GEN/IV/2024	15 April 2024	Berlaku

103	PT. Uniplastindo Interbuana	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	302/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	001/PKS-IU-HRD/VI/2021	8 Juni 2023	Proses TTD Pihak Kedua
104	RSUD Dr. Saiful Anwar Malang	Rujukan Asuhan Pasien	1562.1/e-pks/dir/xi/2022	116/302/2019	1 November 2022	Berlaku
105	RS. TK.II dr. SOEPRAOEN (RST)	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	152.40/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	PKS/173/IX/2022	16 September 2022	Berlaku
106	RS Siti Miriam Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah	151.1/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	810/HMS/RSSM/X/2022	4 Oktober 2022	Berlaku
107	RS Dr. SYAIFUL ANWAR (RSSA)	Rujukan Pekayanan Penunjang	234/DPM/E-PKS/VIII/2024	400.14.5/7499.1/102.7/2024	1 November 2024	Berlaku
108	RSU Muhammadiyah (RSUMM)	Pelayanan Rujukan Kesehatan, Laboratorium dan Radiologi	159.1/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	100/SK_PKS/RSU-UMM/VII/2023	21 Agustus 2023	Disposisi SIMRS
109	DINKES Kabupaten Malang	Pelaksanaan Kegiatan Skrining Tuberkulosis Pada Penyandang Diabetes Melitus Dengan Metode Radiologis	1183/E-PKS/DIR/VII/2023	415.4/61/35.07.103/2023		PROSES PERMOHONAN
110	PT. TSSA dan PT. Tenang Sejahtera	Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			23 Februari 2024	Berlaku
111	PT. Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan				PROSES TTD DILUAR

112	Asuransi Jiwa Generali	PKS Asuransi Kesehatan				PROSES DISPOSISI SIM
113	PT Teknologi Pamadya Analitika (Meditap)	Asuransi Pelayanan Keshatan				PROSES PERPANJANGAN/PEMBAHARUAN PKS
114	BKKBN	pelayanan keluarga berencana iud dan implant	294/E-PKS/DIR/I/2024		17 Januari 2024	Berlaku
115	CV. Galaxy Mulia Cahaya	PKS Alat Proteesa Ortesa				PROSES DISPOSISI SIM
116	PT Pesta Pora Abadi	Rujukan Pelayanan Kesehatan	158/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024			Review Pihak kedua
117	Batas Media 99	Rujukan Pelayanan Kesehatan			5 Juni 2024	Berlaku
118	PT Yamaha Electronic Manufacturing Indonesia	Rujukan Pelayanan Kesehatan				TTD Dir PT
119	PT Tentrem Sejahtera	Rujukan Pelayanan Kesehatan			Review Pihak kedua	
120	Klinik Utana Rawat Jalan Akasia	Rujukan Pelayanan Kesehatan	25 April 2024		Berlaku	
121	PT Ustegra	Rujukan Pelayanan Kesehatan			Review Pihak kedua	
122	PT Pancamas Elite	Rujukan Pelayanan Kesehatan	12 Juni 2024		Berlaku	
123	PT Unggul Anugerah Sejahtera	Rujukan Pelayanan Kesehatan	4 Juni 2024		Berlaku	
124	PT Bestari Murni Anugerah	Rujukan Pelayanan Kesehatan	4 Juni 2024		Berlaku	
125	PT Indonesian Marine	Rujukan				Review Pihak kedua

		Pelayanan Kesehatan					
126	PT Randi Cones Indonesia	Rujukan Pelayanan Kesehatan					Review Pihak kedua
127	PT Indonesian Tobacco	Rujukan Pelayanan Kesehatan					Review Pihak kedua
128	PT Tonggak Ampuh	Rujukan Pelayanan Kesehatan					Review Pihak kedua
129	Klinik Beauty Medika	Rujukan Pelayanan Kesehatan	145/DPM/E-PKS/DIR/V/2024	001/PKS/12/2004	25 Mei 2024		Berlaku
130	Ibazz Aesthetic and Medical Center	Rujukan Pelayanan Kesehatan	180/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024		14 Juni 2024		Berlaku
131	RS Universitas Brawijaya	Rujukan Pelayanan Kesehatan	178/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024				Review Pihak kedua
132	PT Citra Karsa Dinamika	Rujukan Pelayanan Kesehatan					Proses TTD Pihak Kedua
133	PT Moor Sukses Internasional	Rujukan Pelayanan Kesehatan	200/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	001/MSI/VI/2024	8 Juli 2024		Berlaku
134	BPM Nia Irawati	Rujukan Pelayanan Kesehatan	081/DPM/E-PKS/DIR/III/2024		7 Februari 2024		Berlaku
135	Instruktur Zumba	Instruktur Zumba			23 Februari 2024		Berlaku
136	Klinik Esweje	Rujukan Pelayanan Kesehatan	079/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	9120200211338	1 Maret 2024		Berlaku
137	PT Alfiza Medika Utama	Rujukan Pelayanan Kesehatan	090/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	018/MOU/KAMU/07/III/2024	7 Maret 2024		Berlaku
138	PT Medilink Digital Medika	Rujukan Pelayanan Kesehatan	09/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024	22 Maret 2024		Berlaku

139	BPM Riza Khutmi	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak kedua
140	BPM Indah Maharany	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak kedua
141	PT Indostar Building Material	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak kedua
142	Rajawali Plastik	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Proses TTD Pihak Kedua
143	Green Mountain Natural Foods	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak kedua
144	PT Indonusa Algaemas Prima	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak Kedua
145	RSUD Bangil	Rujukan Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024	22 Juli 2024	Berlaku